

Bunga Rampai

ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT PANDUAN KOMPREHENSIF BERBASIS *EVIDENCE-BASED PRACTICE*

Utari Yunie Atrie • Daniel Suranta Ginting • Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini
Friska Ernita Sitorus • Hamdan Nur • Anses Warman
Amatus Yudi Ismanto • Innani Wildania Husna • Ika Ifitri
Arnetty

Editor: Eny Susyanti



BUNGA RAMPAI

ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: PANDUAN KOMPREHENSIF BERBASIS EVIDENCE- BASED PRACTICE

Penulis:

Utari Yunie Atrie, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.
Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.
Friska Ernita Sitorus, S.Kep., Ns., M.Kep.
Hamdan Nur.S.Kep., Ns., M.Kes.
Drg. Anses Warman, MM.
Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep., An., PhD.NS.
Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.
drg. Ika Ifitri, MDSc.
Drg Arnetty, M.Kes.

Editor:

Ns. Eny Susyanti, S.Kep., M.Kep.



BUNGA RAMPAI ASUHAN KEPERAWATAN GAWAT DARURAT: PANDUAN KOMPREHENSIF BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE

Penulis: Utari Yunie Atrie, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.
Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.
Friska Ernita Sitorus, S.Kep., Ns., M.Kep.
Hamdan Nur.S.Kep., Ns., M.Kes.
Drg. Anses Warman, MM.
Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep., An., PhD.NS.
Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.
drg. Ika Ifitri, MDSc.
Drg Arnetty M.Kes.

Editor: Ns. Eny Susyanti, S.Kep.,M.Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7294-90-6

Cetakan Pertama : September, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku yang berjudul "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" ini dapat kami selesaikan dengan baik. Buku ini merupakan buah pemikiran serta kolaborasi intensif dari berbagai pihak yang memiliki perhatian khusus dalam pengembangan ilmu dan praktik keperawatan gawat darurat. Kami berharap buku ini mampu memberikan sumbangsih nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan yang responsif, akurat, dan berbasis bukti ilmiah terkini.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di bidang kesehatan, pelayanan gawat darurat menuntut profesionalisme tinggi serta penguasaan keterampilan yang terus diperbarui. Tenaga keperawatan sebagai garda terdepan dalam penanganan kondisi kritis harus mampu mengambil keputusan cepat dan tepat dalam situasi penuh tekanan. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan pendekatan bunga rampai yang mengintegrasikan berbagai sudut pandang, keahlian, serta pengalaman klinis para ahli dan praktisi keperawatan yang berpengalaman.

Setiap bab dalam buku ini didesain secara seksama dan detail untuk memberikan panduan praktis sekaligus teoritis mengenai berbagai aspek dalam asuhan keperawatan gawat darurat. Penekanan pada prinsip Evidence-Based Practice (EBP) menjadikan buku ini sangat relevan sebagai sumber referensi dalam memastikan bahwa setiap tindakan keperawatan yang diberikan kepada pasien didasarkan pada hasil penelitian yang valid dan terkini. Dengan demikian, setiap intervensi yang dilakukan dapat meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat proses penyembuhan, serta mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Buku ini tidak hanya menyajikan konsep-konsep dasar, tetapi juga mencakup berbagai strategi aplikatif yang dapat langsung diterapkan di lapangan. Berbagai kasus nyata, ilustrasi, serta contoh praktik terbaik yang dipaparkan dalam buku ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran nyata mengenai situasi klinis yang sering dihadapi para perawat gawat darurat. Diharapkan, melalui pendekatan tersebut, tenaga keperawatan akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan klinis yang semakin kompleks.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik serta saran konstruktif dari para pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Dengan penuh kerendahan hati, kami sampaikan rasa terima kasih yang mendalam

kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat secara luas, tidak hanya bagi kalangan akademisi dan mahasiswa keperawatan, tetapi juga praktisi keperawatan yang setiap harinya bertugas memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan segera dalam kondisi gawat darurat.

Agustus, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
CHAPTER 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT	1
Utari Yunie Atrie, S.Kep., Ns., M.Kep.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan Gawat Darurat.....	2
C. Peran dan Tanggung Jawab Perawat Gawat Darurat.....	4
D. Komunikasi Efektif dalam Kondisi Gawat Darurat	7
E. Pengkajian Pasien dalam Kondisi Gawat Darurat.....	9
F. Manajemen Nyeri dalam Situasi Kegawatdaruratan	11
G. Simpulan.....	13
H. Referensi	14
I. Glosarium	15
CHAPTER 2 PROTOKOL TRIASE DI INSTALASI GAWAT DARURAT	17
Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.	17
A. Pendahuluan/Prolog	17
B. Prinsip dan Tujuan Triase di Instalasi Gawat Darurat.....	19
C. Klasifikasi Triase Pasien di Instalasi Gawat Darurat.....	21
D. Sistem dan Metode Triase yang Digunakan di Instalasi Gawat Darurat	24
E. Langkah-langkah Pelaksanaan Triase di Instalasi Gawat Darurat.....	26
F. Kompetensi Perawat dalam Melakukan Triase di Instalasi Gawat Darurat	29
G. Komunikasi Efektif selama Proses Triase di Instalasi Gawat Darurat.....	31
H. Aspek Etik dan Legal dalam Pelaksanaan Triase di Instalasi Gawat Darurat	34
I. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Protokol Triase di Instalasi Gawat Darurat.....	37
J. Simpulan.....	39
K. Referensi	41
L. Glosarium	42

CHAPTER 3 KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN KARDIOVASKULAR	45
Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.	45
A. Pendahuluan/Prolog	45
B. Deteksi Dini Infark Miokard Akut (IMA)	46
C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien dengan Gagal Jantung Akut.....	50
D. Manajemen Pasien Hipertensi Emergensi di IGD	55
E. Dokumentasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan Kardiovaskular	61
F. Simpulan.....	65
G. Referensi	66
H. Glosarium	67
 CHAPTER 4 PENANGANAN PASIEN DENGAN TRAUMA AKUT.....	71
Friska Ernita Sitorus, S.Kep., Ns., M.Kep.	71
A. Pendahuluan/Prolog	71
B. Mekanisme dan Klasifikasi Trauma	73
C. Prinsip Umum Penanganan Trauma Akut	76
D. Penatalaksanaan Cedera Spesifik pada Trauma Akut	78
E. Penatalaksanaan Nyeri pada Pasien Trauma Akut.....	81
F. Manajemen Psikologis Pasien Trauma Akut.....	84
G. Peran Tim Multidisiplin dalam Penanganan Trauma Akut.....	86
H. Tantangan dalam Implementasi Standar Penanganan Trauma Akut di Indonesia	89
I. Simpulan.....	93
J. Referensi	94
K. Glosarium	95
 CHAPTER 5 ASUHAN KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN RESPIRASI	99
Hamdan Nur.S.Kep., Ns., M.Kes.	99
A. Pendahuluan/Prolog	99
B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan.....	100
C. Patofisiologi dan Klasifikasi Kegawatdaruratan Respirasi.....	102
D. Penilaian Cepat dan Identifikasi Kegawatdaruratan Respirasi.....	104
E. Intervensi Keperawatan pada Kondisi Kegawatdaruratan Respirasi.....	106
F. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi.....	108
G. Pemantauan dan Evaluasi Pasien Pasca-Intervensi.....	110
H. Pendidikan dan Konseling Pasien serta Keluarga.....	112
I. Tantangan dan Isu Terkini dalam Praktik Keperawatan Kegawatdaruratan Respirasi.....	114
J. Simpulan.....	116

K. Referensi	118
J. Glosarium	119

CHAPTER 6 PENATALAKSANAAN NYERI AKUT DI INSTALASI GAWAT

DARURAT	123
Drg. Anses Warman, Mm.	123
A. Pendahuluan/Prolog	123
B. Prinsip Dasar Penilaian Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat	125
C. Pendekatan Multimodal dalam Penatalaksanaan Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat	127
D. Intervensi Farmakologi dalam Penanganan Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat.....	129
E. Intervensi Nonfarmakologi dalam Manajemen Nyeri Akut	132
F. Penatalaksanaan Nyeri Akut pada Kondisi Klinis Khusus	134
G. Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Nyeri di IGD.....	136
H. Pemantauan dan Evaluasi Respons Nyeri Pasca-Intervensi.....	139
I. Tantangan dan Isu Terkini dalam Penatalaksanaan Nyeri di Instalasi Gawat Darurat (IGD)	141
J. Simpulan.....	144
K. Referensi	145
K. Glosarium	147

CHAPTER 7 KEPERAWATAN ANAK DALAM SITUASI

KEGAWATDARURATAN	151
Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep., An., PhD.NS.	151
A. Pendahuluan/Prolog	151
B. Penilaian Awal dan Triage pada Pasien Anak.....	153
C. Kondisi Gawat Darurat yang Sering Dijumpai pada Anak.....	155
D. Manajemen Nyeri Akut pada Pasien Anak dalam Situasi Kegawatdaruratan.....	158
E. Prosedur dan Teknik Khusus dalam Keperawatan Gawat Darurat Pediatrik.....	161
F. Dukungan Psikososial Anak dan Keluarga dalam Situasi Gawat Darurat	163
G. Kolaborasi Interprofesional dalam Situasi Kegawatdaruratan Pediatrik.....	166
H. Tantangan Etik dan Legal dalam Keperawatan Gawat Darurat Anak.....	168
I. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Intervensi Kegawatdaruratan pada Anak	171
J. Simpulan.....	174
K. Referensi	175

CHAPTER 8 PENATALAKSANAAN PASIEN DENGAN KERACUNAN DAN GIGITAN HEWAN BERBISA	177
Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.....	177
A. Pendahuluan/Prolog	177
B. Keracunan Akut.....	178
C. Gigitan Hewan Berbisa	181
D. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Keracunan dan Gigitan Hewan Berbisa	183
E. Tatalaksana Komplikasi pada Pasien dengan Keracunan dan Gigitan Hewan Berbisa	186
F. Pencegahan dan Pengendalian Keracunan serta Gigitan Hewan Berbisa.....	189
G. Simpulan.....	191
H. Referensi	192
I. Glosarium	194
 CHAPTER 9 KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT	197
drg. Ika Ifitri, MDSc.....	197
A. Pendahuluan/Prolog	197
B. Prinsip-Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Gawat Darurat.....	199
C. Tantangan Komunikasi dalam Situasi Gawat Darurat	201
D. Strategi Efektif dalam Komunikasi Terapeutik di Unit Gawat Darurat	203
E. Implementasi Komunikasi Terapeutik dalam Kasus-Kasus Spesifik.....	206
F. Etika dalam Komunikasi Terapeutik di Pelayanan Gawat Darurat.....	208
G. Strategi Pengembangan Kompetensi Komunikasi bagi Petugas Gawat Darurat.....	210
H. Simpulan.....	213
I. Referensi	214
J. Glosarium	216
 CHAPTER 10 STUDI KASUS KEPERAWATAN GAWAT DARURAT BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE.....	219
Drg Arnetty M.Kes.	219
A. Pendahuluan/Prolog	219
B. Prinsip-Prinsip Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat	221
C. Tahapan Implementasi Evidence-Based Practice dalam Studi Kasus Keperawatan Gawat Darurat	223

D. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Kegawatdaruratan Medis	225
E. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Kegawatdaruratan Trauma.....	228
F. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Gawat Darurat Non-Trauma Lainnya.....	230
G. Tantangan dalam Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) pada Keperawatan Gawat Darurat	232
H. Strategi Optimalisasi Implementasi Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat	235
I. Evaluasi dan Monitoring Keberhasilan Studi Kasus Berbasis Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat	237
J. Simpulan.....	239
K. Referensi	240
L. Glosarium	241
PROFIL PENULIS	243

CHAPTER 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN GAWAT DARURAT

Utari Yunie Atrie, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keperawatan gawat darurat merupakan suatu bidang khusus dalam profesi keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan terhadap pasien dengan kondisi medis akut yang mengancam nyawa atau memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bidang ini menuntut respons yang cepat, tepat, dan akurat dalam menghadapi berbagai situasi kritis yang tidak terduga. Pasien yang datang ke unit gawat darurat biasanya memiliki berbagai kondisi, mulai dari trauma fisik seperti kecelakaan lalu lintas, luka bakar, hingga kondisi medis akut seperti serangan jantung, stroke, gangguan pernapasan akut, atau syok. Oleh karena itu, perawat gawat darurat harus memiliki kompetensi klinis tinggi serta keterampilan khusus dalam mengelola kondisi pasien secara efisien dan efektif.

Ruang lingkup keperawatan gawat darurat mencakup berbagai aspek mulai dari pengkajian cepat (*rapid assessment*), triase pasien berdasarkan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan, hingga implementasi intervensi keperawatan kritis yang didasarkan pada prinsip ABCDE (*Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Exposure*). Selain itu, peran perawat gawat darurat juga meliputi komunikasi efektif antar tenaga kesehatan, koordinasi interprofesional dalam tim multidisiplin, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarganya mengenai kondisi yang dialami serta dokumentasi keperawatan secara jelas dan lengkap. Keselamatan pasien dan pengendalian infeksi menjadi bagian integral dalam praktik sehari-hari di unit gawat darurat, mengingat tingginya risiko infeksi nosokomial dan kesalahan medis di area tersebut.

Sejarah perkembangan keperawatan gawat darurat bermula dari kebutuhan untuk memberikan pelayanan cepat terhadap korban perang atau bencana. Pada masa Perang Dunia II, perawat mulai ditempatkan di garis depan untuk memberikan pertolongan awal terhadap tentara yang mengalami cedera parah. Setelah perang, konsep ini kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih terstruktur dan profesional dengan berdirinya fasilitas unit gawat darurat khusus di berbagai rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan tenaga perawat yang terlatih secara khusus dalam bidang kegawatdaruratan semakin meningkat sejalan dengan

pertumbuhan populasi, peningkatan angka kecelakaan lalu lintas, kejadian bencana alam, serta semakin kompleksnya kasus medis darurat yang terjadi di masyarakat.

Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, khususnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, perawatan darurat mulai mendapatkan perhatian besar dengan berdirinya Emergency Nurses Association (ENA), organisasi profesional yang mendorong peningkatan kualitas pelayanan keperawatan gawat darurat melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan advokasi. Sejak saat itu, keperawatan gawat darurat terus mengalami kemajuan signifikan baik dari segi kurikulum pendidikan maupun praktik klinisnya. Berbagai standar kompetensi dan panduan praktik berbasis bukti (evidence-based practice) mulai dikembangkan guna memastikan perawat gawat darurat mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dengan pendekatan yang holistik.

Di Indonesia sendiri, keperawatan gawat darurat mulai berkembang pesat pada akhir abad ke-20, seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan yang responsif dan efektif terhadap berbagai situasi darurat medis maupun bencana. Sejak saat itu, pendidikan dan pelatihan khusus bagi perawat di bidang kegawatdaruratan semakin ditingkatkan, termasuk melalui berbagai program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan. Kini, perawat gawat darurat tidak hanya bertugas di rumah sakit umum, tetapi juga terlibat aktif dalam tim bencana nasional, tanggap darurat, dan berbagai layanan medis pra-rumah sakit (prehospital care), menunjukkan semakin luasnya peran dan tanggung jawab profesi ini dalam upaya menyelamatkan nyawa pasien.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan Gawat Darurat

Dalam praktik keperawatan gawat darurat, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami dan diterapkan dengan baik oleh perawat maupun tenaga medis. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan efektif dalam menyelamatkan nyawa pasien, meminimalkan komplikasi, serta mempercepat pemulihan kondisi pasien. Tiga prinsip dasar yang menjadi inti dalam penanganan pasien gawat darurat meliputi prinsip ABCDE, triase pasien di unit gawat darurat, serta kemampuan untuk memberikan respons cepat dan pengambilan keputusan dalam situasi kritis.

Prinsip pertama adalah prinsip ABCDE dalam penanganan kegawatdaruratan. Prinsip ABCDE merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan dalam penilaian dan pengelolaan pasien yang mengalami kondisi gawat darurat, terutama pasien dengan gangguan yang mengancam jiwa. ABCDE adalah singkatan dari Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (gangguan neurologis), dan Exposure/Environment (paparan atau lingkungan

sekitar). Pendekatan ini mengutamakan pemeriksaan secara terstruktur untuk segera mengidentifikasi dan mengatasi kondisi yang paling membahayakan nyawa pasien terlebih dahulu.

Pada aspek Airway, tenaga kesehatan pertama kali memastikan bahwa jalan napas pasien bebas dari hambatan. Hambatan jalan napas bisa disebabkan oleh aspirasi benda asing, sekret, pembengkakan, atau trauma wajah dan leher. Penanganan segera terhadap gangguan jalan napas sangat penting, seperti pemasangan alat bantu napas, melakukan manuver tertentu untuk membuka jalan napas, atau intubasi endotrakeal.

Tahapan berikutnya adalah Breathing, yakni evaluasi terhadap kualitas, frekuensi, dan kedalaman pernapasan pasien. Pasien yang mengalami kesulitan bernapas atau gagal napas perlu diberikan dukungan segera, seperti pemberian oksigen tambahan, ventilasi buatan, atau intervensi medis lainnya. Evaluasi ini penting karena hipoksia dapat dengan cepat menyebabkan kematian sel-sel vital.

Pada tahap Circulation, tenaga medis mengevaluasi kondisi sirkulasi darah pasien, termasuk denyut nadi, tekanan darah, dan kondisi perdarahan. Penanganan kondisi ini bertujuan untuk menjaga perfusi jaringan yang optimal, sehingga organ vital mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Intervensi yang mungkin dilakukan meliputi resusitasi cairan, pemberian obat vasopresor, hingga transfusi darah jika diperlukan.

Selanjutnya, tahap Disability berhubungan dengan pemeriksaan status neurologis pasien, menggunakan skala Glasgow Coma Scale (GCS) atau pemeriksaan neurologis sederhana seperti respons pupil dan motorik. Evaluasi neurologis ini penting untuk mengetahui kondisi kesadaran pasien dan deteksi dini cedera otak atau stroke, sehingga tindakan medis lebih lanjut bisa segera dilakukan.

Tahap terakhir adalah Exposure/Environment, yang berarti tenaga kesehatan perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tubuh pasien dengan membuka atau menyingkap pakaian pasien untuk memastikan tidak ada cedera lain yang terlewatkan. Selain itu, tahap ini juga memperhatikan lingkungan tempat pasien berada, memastikan suhu tubuh pasien stabil, serta menjaga privasi dan kenyamanan pasien semaksimal mungkin selama penanganan.

Prinsip kedua adalah triase pasien di unit gawat darurat. Triase merupakan proses evaluasi yang dilakukan di awal ketika pasien tiba di unit gawat darurat, bertujuan untuk menentukan prioritas penanganan berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien. Proses triase ini menjadi sangat penting terutama dalam situasi di mana terdapat banyak pasien yang datang secara bersamaan, seperti pada saat kecelakaan massal, bencana alam, atau kondisi gawat darurat yang ramai di unit kesehatan. Triase dilakukan oleh perawat atau tenaga medis yang terlatih, yang akan

mengklasifikasikan pasien ke dalam beberapa kategori berdasarkan urgensi kondisinya. Kategori ini biasanya mencakup pasien dengan kondisi mengancam nyawa yang membutuhkan penanganan segera (emergency), pasien dengan kondisi serius namun masih stabil (urgent), serta pasien dengan kondisi yang tidak terlalu serius (non-urgent). Keputusan yang tepat dalam triase akan memastikan sumber daya kesehatan digunakan secara efisien, dengan tujuan utama menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa dan mengurangi komplikasi akibat terlambatnya penanganan.

Prinsip ketiga adalah respons cepat dan pengambilan keputusan dalam situasi kritis. Prinsip ini menegaskan pentingnya peran perawat atau tenaga medis dalam mengenali tanda-tanda vital yang abnormal, perubahan status klinis pasien, atau kondisi yang memburuk secara cepat. Respons cepat sangat krusial karena dalam situasi kritis, penundaan sedikit pun bisa berdampak fatal. Kemampuan perawat dalam melakukan observasi secara terus-menerus, identifikasi dini terhadap perubahan klinis, dan pengambilan keputusan cepat berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi kondisi pasien sangat menentukan keberhasilan intervensi medis. Dalam hal ini, perawat harus mampu bekerja dalam tekanan tinggi, memiliki kemampuan klinis yang tinggi, dan mampu berkomunikasi efektif dengan seluruh anggota tim medis dalam menentukan langkah penanganan selanjutnya. Pengambilan keputusan dalam situasi kritis tidak hanya mengandalkan intuisi semata, tetapi juga didasarkan pada pengetahuan klinis yang kuat, pengalaman praktis, dan panduan atau protokol yang sudah ditetapkan oleh unit kesehatan.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip dasar keperawatan gawat darurat ini menjadi landasan utama dalam pemberian asuhan keperawatan berkualitas tinggi, dengan tujuan akhir menyelamatkan nyawa pasien, meningkatkan efektivitas penanganan kegawatdaruratan, serta meminimalkan risiko komplikasi yang mungkin timbul selama perawatan pasien.

C. Peran dan Tanggung Jawab Perawat Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan, perawat yang bertugas di unit gawat darurat memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting dan krusial. Peran perawat gawat darurat tidak hanya sebatas pada tugas-tugas klinis semata, tetapi juga mencakup aspek profesional, kolaboratif, serta tanggung jawab dalam ranah etik dan legal yang menyertai setiap keputusan klinis yang diambil. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perawat gawat darurat untuk memahami dan menguasai dengan baik kompetensi dan keterampilan yang esensial, serta mampu bekerja sama dalam tim multidisiplin dan selalu bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat berdasarkan landasan etik dan hukum yang berlaku.

Pertama-tama, perawat gawat darurat dituntut untuk memiliki kompetensi dan keterampilan esensial yang mencakup berbagai kemampuan klinis, keterampilan teknis, serta keterampilan interpersonal dan komunikasi yang kuat. Kompetensi klinis yang esensial meliputi kemampuan melakukan penilaian cepat terhadap kondisi pasien secara akurat dengan menerapkan prinsip ABCDE, mengenali tanda-tanda vital yang kritis, mengelola kondisi pasien dalam situasi darurat seperti gagal napas, gangguan sirkulasi, trauma berat, hingga kegagalan sistem organ akut. Selain itu, perawat gawat darurat juga dituntut mampu melakukan tindakan-tindakan invasif yang mendukung kehidupan seperti resusitasi jantung paru (RJP), pemasangan akses intravena, pemberian terapi obat secara cepat dan tepat, serta tindakan emergensi lainnya.

Keterampilan teknis seorang perawat gawat darurat meliputi penguasaan terhadap penggunaan alat medis canggih yang sering digunakan dalam situasi darurat seperti defibrilator, ventilator mekanik, pompa infus, monitor pasien, serta peralatan khusus yang dibutuhkan dalam situasi kritis lainnya. Penguasaan keterampilan ini harus dilakukan secara profesional agar tindakan yang diberikan aman, efektif, dan efisien serta tidak menambah risiko terhadap keselamatan pasien.

Di sisi lain, keterampilan interpersonal dan komunikasi juga menjadi bagian penting dalam kompetensi seorang perawat gawat darurat. Perawat dituntut mampu berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya dalam situasi yang serba cepat dan penuh tekanan. Mereka harus bisa memberikan informasi yang jelas, singkat, dan efektif, serta mampu memberikan dukungan psikologis kepada pasien maupun keluarga yang sedang menghadapi situasi kritis. Kemampuan ini sangat penting dalam menjaga ketenangan, mencegah kepanikan, serta membangun kepercayaan pasien terhadap tim medis.

Selain kompetensi teknis dan interpersonal, perawat di unit gawat darurat juga memiliki peran penting dalam tim multidisiplin. Unit gawat darurat merupakan lingkungan kerja yang kompleks dan dinamis, di mana kolaborasi antar-profesional merupakan kunci keberhasilan pelayanan pasien. Perawat gawat darurat bekerja sama dengan dokter spesialis emergensi, dokter umum, tenaga medis lain seperti radiografer, farmasis, ahli laboratorium, serta tenaga kesehatan lainnya. Perawat bertindak sebagai penghubung antar-profesi yang memastikan kelancaran komunikasi, koordinasi, serta kesinambungan pelayanan pasien.

Dalam kolaborasi ini, perawat gawat darurat seringkali berperan sebagai koordinator awal yang mengatur prioritas tindakan melalui proses triase, serta memberikan laporan klinis pasien kepada anggota tim medis yang lain. Mereka juga bertanggung jawab dalam memastikan kelengkapan dan akurasi dokumentasi medis, seperti pencatatan tanda-tanda vital, riwayat kesehatan, tindakan yang telah

diberikan, dan respon pasien terhadap tindakan tersebut. Fungsi koordinatif ini sangat vital, karena ketepatan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh perawat akan menentukan kualitas keputusan medis yang diambil oleh tim multidisiplin secara keseluruhan.

Selain kompetensi klinis dan kolaborasi antar profesi, seorang perawat gawat darurat juga memiliki tanggung jawab etik dan legal yang melekat dalam setiap aktivitas profesionalnya. Dalam situasi gawat darurat, perawat seringkali dihadapkan pada dilema etik yang menuntut kemampuan mengambil keputusan secara cepat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip moral dan profesional, seperti menghargai otonomi pasien, prinsip non-malefisien (tidak membahayakan pasien), prinsip benefisien (melakukan yang terbaik untuk pasien), serta keadilan dalam pelayanan kesehatan. Perawat harus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan klinis didasarkan pada standar profesi, kode etik keperawatan, serta prinsip-prinsip moral universal.

Secara legal, perawat gawat darurat bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien. Setiap tindakan harus didasarkan pada kompetensi yang dimiliki dan dilakukan dengan persetujuan (informed consent) yang jelas dari pasien atau keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat tertentu di mana tindakan penyelamatan nyawa mendesak dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu. Perawat harus paham dan patuh terhadap batasan kewenangan yang diatur oleh regulasi pemerintah dan kebijakan internal di unit gawat darurat. Ketaatan terhadap aturan legal ini bertujuan untuk melindungi pasien dari risiko malapraktik sekaligus melindungi perawat dari implikasi hukum yang dapat timbul dari tindakan yang tidak sesuai prosedur.

Dalam praktiknya, tanggung jawab etik dan legal seorang perawat gawat darurat juga mencakup dokumentasi yang akurat dan lengkap dari setiap tindakan dan intervensi yang diberikan kepada pasien. Hal ini penting tidak hanya untuk kepentingan klinis, tetapi juga sebagai alat bukti hukum apabila terjadi gugatan atau permasalahan di kemudian hari.

Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab perawat gawat darurat mencakup kompetensi klinis yang tinggi, kemampuan kerja sama dan kolaborasi yang efektif dalam tim multidisiplin, serta kesadaran dan kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip etik dan legal. Dengan menjalankan peran ini secara optimal, perawat gawat darurat dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyelamatan nyawa pasien, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta mendukung profesionalisme dalam pelayanan kesehatan di unit gawat darurat.

D. Komunikasi Efektif dalam Kondisi Gawat Darurat

Dalam unit gawat darurat, situasi kritis merupakan suatu kondisi yang sering ditemui, di mana setiap detik sangat berharga dalam menentukan keberhasilan tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan situasi darurat adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi efektif merupakan kunci utama dalam memaksimalkan hasil pelayanan kesehatan, karena setiap informasi yang jelas dan akurat sangat menentukan ketepatan tindakan medis serta keselamatan pasien. Komunikasi efektif dalam kondisi gawat darurat mencakup komunikasi antar profesional, komunikasi dengan pasien dan keluarga, serta dokumentasi yang tepat dan akurat.

Komunikasi antar profesional di unit gawat darurat sangat penting dilakukan dengan baik, jelas, dan terstruktur. Dalam kondisi kritis yang penuh tekanan, setiap tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, petugas laboratorium, radiografer, maupun tenaga kesehatan lainnya, harus mampu menyampaikan informasi secara singkat, jelas, dan tidak ambigu. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguasaan terhadap berbagai teknik komunikasi yang terbukti efektif dalam situasi kritis, seperti penggunaan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode SBAR adalah teknik komunikasi terstruktur yang membantu para profesional kesehatan menyampaikan informasi secara ringkas dan jelas dengan mengikuti empat komponen penting, yaitu mendeskripsikan situasi terkini pasien (Situation), memberikan latar belakang klinis pasien yang relevan (Background), menyampaikan hasil penilaian atau observasi terbaru (Assessment), dan memberikan rekomendasi atau saran tindakan yang perlu dilakukan (Recommendation).

Dengan menerapkan teknik komunikasi SBAR, kesalahan dalam transmisi informasi dapat diminimalisasi, meningkatkan kecepatan dan akurasi respons tim medis dalam situasi darurat. Selain itu, dalam komunikasi antar profesional, kemampuan mendengarkan secara aktif juga sangat esensial. Mendengarkan aktif memastikan setiap anggota tim benar-benar memahami instruksi atau informasi yang diberikan, serta mampu mengklarifikasi setiap ketidakjelasan secara langsung sehingga risiko kesalahan dapat dikurangi secara signifikan. Selain metode SBAR, perawat dan tim medis juga dapat menggunakan teknik komunikasi "closed-loop" atau komunikasi tertutup, di mana setiap pesan atau instruksi penting selalu diulang kembali oleh penerima informasi untuk memastikan pesan tersebut benar-benar dipahami dan akan segera dilaksanakan secara tepat.

Selain komunikasi antar profesional, komunikasi dengan pasien dan keluarganya juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam situasi darurat. Dalam kondisi gawat darurat, pasien dan keluarga sering mengalami kecemasan,

kepanikan, ketakutan, atau kebingungan karena situasi yang dihadapi sangat tidak terduga. Oleh karena itu, perawat gawat darurat harus mampu menggunakan komunikasi yang empatik, jelas, tenang, dan informatif untuk menenangkan pasien dan keluarganya. Penting untuk menyampaikan informasi secara jujur namun tetap memperhatikan sensitivitas psikologis pasien dan keluarganya. Dalam situasi darurat, komunikasi yang digunakan harus langsung dan lugas, namun tetap sopan dan penuh penghormatan. Perawat harus mampu memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi, tindakan medis apa yang dilakukan, mengapa tindakan tersebut perlu segera dilakukan, serta prognosis atau harapan yang dapat diantisipasi dalam kondisi tersebut.

Di samping itu, perawat juga harus memahami pentingnya mendengarkan kekhawatiran pasien dan keluarga, serta menjawab setiap pertanyaan yang muncul dengan sabar dan empati. Komunikasi ini penting untuk membangun kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap tim medis, sehingga memudahkan proses persetujuan tindakan medis (informed consent) serta meminimalkan kemungkinan konflik yang muncul akibat salah paham atau kurangnya informasi. Dalam kondisi tertentu, perawat juga bertugas sebagai mediator komunikasi antara keluarga dan tim medis lainnya, sehingga keterampilan komunikasi yang efektif sangat menentukan kelancaran penanganan pasien di unit gawat darurat.

Aspek lain yang tidak boleh diabaikan dalam komunikasi efektif di unit gawat darurat adalah dokumentasi yang tepat dan akurat. Dokumentasi medis merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam situasi gawat darurat, karena dokumentasi menjadi rekam jejak klinis pasien yang sangat penting untuk kontinuitas perawatan, evaluasi tindakan, maupun sebagai bukti hukum jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dokumentasi yang baik harus dilakukan secara tepat waktu, lengkap, jelas, dan akurat, mencakup data identitas pasien, riwayat kejadian, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik, tindakan medis yang telah diberikan, respons pasien terhadap tindakan tersebut, dan rencana perawatan selanjutnya.

Perawat gawat darurat harus mampu mendokumentasikan seluruh tindakan dan observasi dengan bahasa yang jelas dan profesional, serta menghindari penggunaan singkatan yang ambigu atau istilah yang tidak umum tanpa disertai penjelasan yang jelas. Dokumentasi medis harus dilakukan sesegera mungkin setelah tindakan diberikan, sehingga informasi yang dicatat tetap akurat dan tidak hilang atau terlupakan. Selain itu, dokumentasi juga harus mengikuti standar format dokumentasi yang berlaku di institusi masing-masing, baik secara elektronik maupun manual.

Dalam situasi gawat darurat yang seringkali berlangsung cepat dan penuh tekanan, disiplin dalam dokumentasi menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu,

perawat harus memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya dokumentasi ini dan berusaha tetap konsisten melakukannya walaupun situasi sangat sibuk. Dokumentasi yang tepat dan akurat akan sangat membantu tim medis lain dalam memberikan pelayanan lanjutan, serta memberikan perlindungan hukum baik kepada pasien maupun kepada tenaga kesehatan jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Secara keseluruhan, komunikasi efektif di unit gawat darurat yang mencakup komunikasi antar profesional yang jelas dan terstruktur, komunikasi empatik dan informatif dengan pasien serta keluarga, serta dokumentasi medis yang akurat dan tepat waktu, sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif ini, perawat dapat secara optimal mendukung tim medis dalam memberikan asuhan yang cepat, tepat, aman, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada pasien dan keluarga di tengah situasi kritis yang mereka alami.

E. Pengkajian Pasien dalam Kondisi Gawat Darurat

Dalam praktik keperawatan di unit gawat darurat, pengkajian pasien merupakan langkah pertama sekaligus langkah yang paling menentukan dalam keberhasilan penanganan pasien yang mengalami kondisi kritis. Pengkajian pasien secara cepat, terstruktur, dan komprehensif akan membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi permasalahan pasien secara akurat, menetapkan prioritas tindakan, serta menentukan intervensi yang paling tepat dalam situasi darurat. Secara garis besar, pengkajian pasien dalam kondisi gawat darurat mencakup pengkajian cepat (rapid assessment), pengkajian primer dan sekunder, serta identifikasi tanda-tanda vital kritis yang menjadi acuan dalam menentukan prioritas intervensi yang harus segera dilakukan.

Langkah awal dalam pengkajian pasien di situasi darurat adalah pengkajian cepat atau sering disebut sebagai rapid assessment. Pengkajian cepat adalah metode evaluasi awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesaat setelah pasien tiba di unit gawat darurat. Tujuan utama pengkajian ini adalah mengidentifikasi secara segera apakah pasien mengalami kondisi yang mengancam jiwa dan membutuhkan intervensi langsung dalam hitungan detik atau menit. Pengkajian cepat ini biasanya berlangsung dalam waktu singkat, sekitar kurang dari satu menit, dengan mengamati secara visual serta mendengarkan keluhan utama pasien atau laporan singkat dari pengantar pasien atau petugas ambulans.

Dalam pengkajian cepat, perawat akan melihat secara cepat tanda-tanda bahaya utama seperti gangguan pernapasan, perdarahan hebat, kondisi kesadaran yang menurun, ataupun tanda-tanda cedera serius yang tampak jelas. Informasi ini

digunakan untuk memutuskan apakah pasien memerlukan tindakan resusitasi segera atau tindakan penyelamatan nyawa lainnya tanpa menunggu pemeriksaan lebih detail. Misalnya, jika ditemukan pasien yang mengalami henti napas atau henti jantung, perawat harus segera memulai tindakan resusitasi jantung paru (RJP) tanpa menunda waktu untuk pemeriksaan tambahan.

Setelah pengkajian cepat dilakukan, perawat selanjutnya akan melakukan pengkajian yang lebih mendalam melalui pengkajian primer dan sekunder. Pengkajian primer merupakan tahap penilaian yang sistematis dan terstruktur, mengikuti prinsip ABCDE yang telah dijelaskan sebelumnya. Tujuan utama dari pengkajian primer adalah untuk secara langsung mengidentifikasi gangguan-gangguan vital pada pasien yang perlu segera ditangani untuk mempertahankan hidup pasien. Langkah-langkah pengkajian primer ini meliputi pengecekan airway (jalan napas), breathing (pernapasan), circulation (sirkulasi), disability (kesadaran/neurologis), serta exposure atau lingkungan sekitar pasien.

Pada tahap airway, perawat harus memastikan jalan napas pasien benar-benar terbuka dan bebas hambatan. Tahap breathing menuntut perawat untuk mengevaluasi secara rinci kondisi pernapasan pasien, seperti frekuensi pernapasan, pola napas, penggunaan otot bantu pernapasan, hingga adanya suara napas abnormal. Tahap circulation dilakukan dengan mengecek nadi pasien, mengukur tekanan darah, mengamati tanda-tanda perdarahan hebat, serta kondisi perfusi jaringan. Pada tahap disability, pemeriksaan status neurologis pasien menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS) atau pemeriksaan neurologis sederhana untuk menilai tingkat kesadaran pasien. Tahap terakhir dari pengkajian primer adalah exposure, yaitu mengekspos tubuh pasien secara menyeluruh guna mengidentifikasi adanya cedera tambahan atau masalah lain yang tidak tampak secara langsung pada awal pengkajian.

Setelah pengkajian primer selesai dan kondisi pasien relatif stabil, perawat melanjutkan dengan pengkajian sekunder. Pengkajian sekunder merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kondisi pasien. Pengkajian ini mencakup anamnesis atau wawancara yang lebih mendetail tentang riwayat kesehatan pasien, riwayat kejadian yang menyebabkan kondisi gawat darurat, keluhan-keluhan tambahan yang dialami pasien, hingga pemeriksaan fisik yang lebih terinci dari kepala hingga ujung kaki (head-to-toe examination).

Pada tahap ini, tenaga kesehatan akan mencari tanda-tanda tambahan seperti luka kecil, memar, fraktur, nyeri tekan pada daerah tertentu, dan kelainan lain yang mungkin tidak terlihat dalam pengkajian primer. Selain itu, tahap pengkajian sekunder juga dapat mencakup pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan

laboratorium, radiologi, atau tindakan diagnostik lainnya yang membantu tenaga medis dalam memperjelas diagnosis serta menentukan rencana terapi lanjutan.

Selama proses pengkajian, perawat juga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda vital kritis yang menjadi indikator kondisi pasien yang memburuk atau mengancam jiwa. Tanda vital kritis biasanya meliputi gangguan pernapasan seperti pernapasan yang sangat cepat atau lambat, penurunan saturasi oksigen, hipotensi berat, denyut nadi yang tidak teratur atau hilang, perubahan drastis pada tingkat kesadaran, hingga suhu tubuh yang sangat tinggi atau sangat rendah. Tanda-tanda ini memerlukan respons segera dan intervensi prioritas untuk mencegah kegagalan organ atau bahkan kematian pasien.

Prioritas intervensi dalam situasi ini biasanya mencakup tindakan yang langsung memperbaiki gangguan vital, seperti pemberian oksigen tambahan atau ventilasi buatan jika pasien mengalami gagal napas, pemberian cairan atau transfusi darah jika pasien mengalami syok, atau pemberian obat-obatan emergensi yang bertujuan untuk menstabilkan hemodinamik pasien. Penetapan prioritas ini harus didasarkan pada hasil pengkajian yang sistematis dengan tetap memperhatikan kondisi pasien secara holistik.

Dengan demikian, pengkajian pasien dalam kondisi gawat darurat yang mencakup pengkajian cepat, pengkajian primer dan sekunder, serta identifikasi tanda-tanda vital kritis, menjadi aspek krusial yang harus dikuasai dengan baik oleh tenaga kesehatan di unit gawat darurat. Penguasaan terhadap tahapan pengkajian ini memungkinkan tenaga medis untuk mengambil keputusan klinis yang tepat, melakukan intervensi medis secara efektif, dan memastikan penanganan pasien berjalan optimal untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan tindakan medis serta keselamatan pasien secara keseluruhan.

F. Manajemen Nyeri dalam Situasi Kegawatdaruratan

Dalam praktik keperawatan gawat darurat, manajemen nyeri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Nyeri akut yang dialami oleh pasien dalam kondisi kegawatdaruratan dapat menimbulkan stres fisiologis dan psikologis, memperburuk kondisi klinis pasien, serta memperlambat proses pemulihan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip dasar penanganan nyeri akut, pendekatan farmakologis maupun non-farmakologis dalam manajemen nyeri, serta evaluasi efektivitas terapi nyeri pada pasien kritis menjadi elemen penting yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat di unit gawat darurat.

Secara prinsip, penanganan nyeri akut dalam situasi gawat darurat berfokus pada pengendalian nyeri secepat dan seefektif mungkin guna mencegah komplikasi

lebih lanjut serta mempercepat pemulihan pasien. Prinsip dasar yang utama adalah bahwa setiap pasien memiliki hak fundamental untuk bebas dari nyeri, sehingga manajemen nyeri harus menjadi bagian integral dari pelayanan kegawatdaruratan. Penanganan nyeri yang tepat dan cepat tidak hanya memperbaiki kualitas hidup pasien selama di unit gawat darurat, tetapi juga berkontribusi dalam menurunkan angka morbiditas akibat nyeri yang tidak tertangani dengan baik.

Salah satu prinsip dasar lainnya adalah pentingnya melakukan pengkajian nyeri yang akurat sebelum menentukan tindakan manajemen nyeri. Pengkajian ini mencakup intensitas nyeri menggunakan skala yang valid seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), atau Faces Pain Rating Scale untuk pasien tertentu seperti anak-anak atau lansia. Selain intensitas, perawat juga harus mengidentifikasi karakteristik nyeri, seperti lokasi, durasi, frekuensi, pola nyeri, serta faktor pencetus maupun pembeda nyeri yang dialami pasien. Informasi ini penting untuk menentukan strategi manajemen nyeri yang paling tepat dan individual bagi setiap pasien.

Dalam menangani nyeri pada kondisi darurat, tenaga kesehatan biasanya menggunakan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis secara bersamaan atau kombinasi, disesuaikan dengan kondisi klinis pasien. Pendekatan farmakologis mencakup penggunaan obat-obatan analgetik yang diberikan secara cepat untuk menurunkan intensitas nyeri pasien. Obat-obatan ini meliputi analgetik non-opioid seperti parasetamol atau antiinflamasi non-steroid (NSAID), serta analgetik opioid seperti morfin, fentanyl, dan tramadol yang lebih kuat efek analgesiknya. Dalam situasi kegawatdaruratan, terutama nyeri berat atau nyeri yang intens, penggunaan opioid sering menjadi pilihan utama karena kemampuannya yang cepat dalam mengurangi intensitas nyeri. Meskipun demikian, pemilihan obat harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi klinis pasien, riwayat alergi, interaksi obat, serta potensi efek samping yang mungkin muncul.

Selain pendekatan farmakologis, pendekatan non-farmakologis juga memiliki peran penting dalam manajemen nyeri akut pada situasi gawat darurat. Teknik non-farmakologis mencakup intervensi fisik, psikologis, dan terapeutik yang membantu menurunkan persepsi nyeri pasien. Contohnya adalah penggunaan terapi dingin (kompres es) untuk cedera akut seperti fraktur atau memar yang membantu mengurangi inflamasi serta rasa nyeri secara lokal. Teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, distraksi atau pengalihan perhatian, dan teknik imagery juga dapat digunakan untuk membantu pasien mengelola nyeri secara psikologis. Selain itu, komunikasi terapeutik, edukasi tentang kondisi pasien, serta dukungan emosional yang diberikan oleh perawat mampu mengurangi kecemasan dan

ketegangan pasien, yang pada gilirannya akan turut menurunkan persepsi nyeri yang dirasakan.

Setelah manajemen nyeri diberikan, tahap penting selanjutnya yang harus dilakukan adalah evaluasi efektivitas terapi nyeri pada pasien kritis. Evaluasi ini penting dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa nyeri benar-benar terkontrol dan pasien merasa nyaman selama dalam perawatan. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan menilai kembali intensitas nyeri menggunakan skala nyeri yang sama sebelum terapi diberikan, mengobservasi respon pasien seperti penurunan tanda vital yang sebelumnya meningkat akibat nyeri (misalnya denyut jantung, tekanan darah, dan frekuensi napas), serta pengamatan terhadap perubahan ekspresi wajah maupun perilaku pasien sebagai indikator keberhasilan terapi nyeri.

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa nyeri pasien belum terkontrol secara adekuat, maka perawat harus segera berkoordinasi dengan tim medis untuk mengevaluasi kembali dosis atau jenis obat yang digunakan, atau mempertimbangkan intervensi tambahan baik farmakologis maupun non-farmakologis untuk memastikan bahwa nyeri dapat teratasi dengan optimal. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi adanya efek samping atau komplikasi dari terapi nyeri yang diberikan, seperti sedasi berlebihan, mual, muntah, atau gangguan pernapasan akibat opioid yang memerlukan penyesuaian terapi lanjutan.

Secara keseluruhan, manajemen nyeri dalam situasi kegawatdaruratan merupakan aspek yang integral dalam pelayanan keperawatan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi pasien, mempercepat proses penyembuhan, dan mengurangi dampak psikologis serta fisiologis akibat nyeri akut yang tidak terkontrol. Dengan memahami prinsip dasar penanganan nyeri akut secara tepat, menerapkan pendekatan farmakologis dan non-farmakologis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta melakukan evaluasi efektivitas secara terus-menerus, perawat gawat darurat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan holistik bagi pasien di tengah kondisi kritis yang mereka alami.

G. Simpulan

Keperawatan gawat darurat merupakan bidang khusus dalam profesi keperawatan yang berperan vital dalam menyelamatkan nyawa pasien dalam kondisi medis akut dan kritis. Dalam pelaksanaannya, perawat dituntut untuk memiliki kompetensi klinis tinggi serta keterampilan teknis dan interpersonal yang mumpuni guna memastikan asuhan keperawatan yang optimal. Prinsip ABCDE, triase pasien, serta respons cepat dalam mengambil keputusan merupakan landasan utama dalam penanganan pasien di unit gawat darurat. Penguasaan prinsip-prinsip

tersebut memastikan setiap intervensi dilakukan secara sistematis dan efektif, dengan prioritas utama menangani kondisi yang paling mengancam nyawa terlebih dahulu.

Perawat gawat darurat juga memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam tim multidisiplin, tidak hanya dalam aspek klinis tetapi juga dalam koordinasi antarprofesional. Peran ini meliputi komunikasi efektif antar tenaga medis, pasien, serta keluarga pasien, dengan menggunakan teknik komunikasi yang terstruktur dan jelas seperti metode SBAR. Komunikasi yang baik juga mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat dan akurat, serta memfasilitasi persetujuan tindakan medis dari pasien dan keluarganya. Di samping itu, tanggung jawab etik dan legal juga menjadi bagian integral yang harus selalu dipatuhi oleh perawat dalam setiap situasi darurat, guna melindungi pasien maupun profesional kesehatan dari konsekuensi hukum.

Pengkajian pasien dalam kondisi kegawatdaruratan merupakan langkah krusial yang menentukan keberhasilan intervensi keperawatan. Metode pengkajian yang dilakukan meliputi pengkajian cepat, primer, dan sekunder, serta identifikasi tanda-tanda vital kritis untuk menentukan intervensi yang harus segera dilakukan demi menyelamatkan nyawa pasien. Dalam pengelolaan nyeri akut pada pasien gawat darurat, perawat menerapkan pendekatan farmakologis seperti penggunaan obat analgesik, serta pendekatan non-farmakologis berupa terapi fisik dan psikologis untuk menurunkan persepsi nyeri. Evaluasi berkala terhadap efektivitas manajemen nyeri penting untuk memastikan kenyamanan pasien serta mencegah komplikasi lebih lanjut akibat nyeri yang tidak tertangani dengan baik.

Secara keseluruhan, implementasi konsep dasar keperawatan gawat darurat yang komprehensif ini memungkinkan perawat memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, responsif, aman, efektif, dan manusiawi, sehingga memberikan kontribusi besar dalam penyelamatan nyawa dan peningkatan kualitas hidup pasien dalam situasi kritis.

H. Referensi

- American Heart Association. (2020). Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) Provider Manual. American Heart Association.
- Bickley, L. S., & Szilagyi, P. G. (2021). Bates' Guide to Physical Examination and History Taking (13th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Emergency Nurses Association (ENA). (2018). Emergency Nursing Core Curriculum (7th ed.). Saunders Elsevier.
- Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D., & Rosenau, A. M. (2020). Emergency Severity Index

(ESI): A Triage Tool for Emergency Department Care (Version 4, Implementation Handbook). Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).

Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2021). Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing (15th ed.). Wolters Kluwer Health.

International Council of Nurses. (2021). The ICN Code of Ethics for Nurses. International Council of Nurses.

Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P. A., & Hall, A. M. (2020). Fundamentals of Nursing (10th ed.). Elsevier Mosby.

Smith, S. F., Duell, D. J., & Martin, B. C. (2019). Clinical Nursing Skills: Basic to Advanced Skills (10th ed.). Pearson Education.

Tintinalli, J. E., Ma, O. J., Yealy, D. M., Meckler, G. D., & Stapczynski, J. S. (2020). Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Urden, L. D., Stacy, K. M., & Lough, M. E. (2021). Critical Care Nursing: Diagnosis and Management (9th ed.). Elsevier Mosby.

World Health Organization. (2020). Patient Safety Curriculum Guide: Multi-professional Edition. World Health Organization.

Yoost, B. L., & Crawford, L. R. (2020). Fundamentals of Nursing: Active Learning for Collaborative Practice (2nd ed.). Elsevier.

Zimmerman, P. G., & Herr, R. D. (2021). Triage Nursing Secrets (2nd ed.). Elsevier Health Sciences.

I. Glosarium

Asuhan Keperawatan

Rangkaian tindakan perawatan yang dilakukan oleh perawat kepada pasien berdasarkan penilaian kebutuhan pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien secara optimal.

Triage

Proses evaluasi awal yang digunakan untuk mengklasifikasikan pasien berdasarkan tingkat kegawatannya, dengan tujuan menetapkan prioritas penanganan agar sumber daya medis digunakan secara efektif, terutama pada situasi darurat massal.

ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure)

Pendekatan sistematis dalam evaluasi pasien kritis untuk memastikan identifikasi dan penanganan gangguan vital secara prioritas, yang mencakup jalan napas, pernapasan, sirkulasi, status neurologis, dan evaluasi menyeluruh terhadap tubuh pasien.

Rapid Assessment

Pengkajian cepat yang dilakukan segera setelah pasien tiba di unit gawat darurat dengan tujuan mengidentifikasi secara singkat dan cepat kondisi yang mengancam nyawa serta membutuhkan intervensi darurat.

Komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Teknik komunikasi terstruktur yang digunakan oleh tenaga medis untuk menyampaikan informasi tentang kondisi pasien secara ringkas dan jelas guna meningkatkan ketepatan tindakan dalam kondisi kritis.

Closed-loop Communication

Teknik komunikasi di mana penerima informasi mengulang kembali pesan atau instruksi yang diterimanya untuk memastikan informasi tersebut telah diterima secara akurat dan jelas, guna menghindari kesalahan dalam tindakan medis.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Alat ukur standar yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien, khususnya yang mengalami cedera kepala atau gangguan neurologis, dengan penilaian yang mencakup respons mata, verbal, dan motorik.

Intervensi Farmakologis

Penanganan kondisi medis dengan menggunakan obat-obatan yang bertujuan mengurangi gejala atau gangguan pada pasien, misalnya pemberian analgesik dalam manajemen nyeri.

Intervensi Non-farmakologis

Penanganan gejala atau gangguan kesehatan yang tidak melibatkan pemberian obat, seperti kompres dingin, relaksasi, distraksi, dan dukungan emosional untuk mengurangi persepsi nyeri pasien.

Infeksi Nosokomial

Infeksi yang didapat oleh pasien selama menjalani perawatan di fasilitas kesehatan, yang biasanya muncul 48 jam setelah masuk rumah sakit, sering kali akibat tindakan medis, prosedur invasif, atau transmisi antar pasien atau petugas kesehatan.

CHAPTER 2

PROTOKOL TRIASE DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Dalam dunia medis, khususnya pada lingkungan Instalasi Gawat Darurat (IGD), kecepatan dan ketepatan dalam memberikan pelayanan merupakan kunci utama dalam menyelamatkan nyawa pasien. Salah satu sistem penting yang diterapkan untuk memastikan pelayanan medis yang efektif di IGD adalah triase. Triase merupakan suatu proses penilaian awal yang sistematis dan terstruktur terhadap kondisi pasien yang tiba di unit gawat darurat. Tujuan utama dari pelaksanaan triase ini adalah untuk mengelompokkan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi medisnya, sehingga pasien dapat segera menerima pelayanan yang sesuai dengan tingkat kegawatan dan kebutuhannya.

Istilah "triase" sendiri berasal dari kata Prancis "trier" yang berarti memilah atau memilih. Konsep ini pertama kali diterapkan dalam dunia medis pada masa perang, ketika tenaga medis dihadapkan pada banyaknya korban yang datang secara bersamaan dengan kondisi cedera yang bervariasi. Dalam situasi tersebut, tenaga medis harus segera membuat keputusan cepat tentang pasien mana yang harus segera mendapatkan pertolongan, pasien mana yang dapat ditunda sementara waktu, serta pasien yang memiliki kemungkinan kecil untuk diselamatkan. Seiring waktu, konsep ini kemudian berkembang dan mulai digunakan secara luas dalam kondisi non-perang, terutama di Instalasi Gawat Darurat rumah sakit, tempat di mana pasien dengan berbagai kondisi kritis datang secara terus-menerus dan tidak terduga.

Secara umum, triase di Instalasi Gawat Darurat merupakan proses awal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan—biasanya seorang perawat atau tenaga medis yang terlatih khusus dalam bidang triase—untuk mengevaluasi kondisi klinis pasien sesaat setelah pasien tiba di IGD. Dalam proses ini, tenaga kesehatan akan melakukan penilaian cepat terhadap keluhan utama pasien, tanda-tanda vital, kondisi kesadaran, serta potensi gangguan yang mengancam nyawa pasien. Berdasarkan hasil penilaian ini, pasien kemudian dikategorikan menurut tingkat prioritas dan urgensi penanganannya. Kategori triase ini secara umum terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu pasien dengan kondisi mengancam jiwa yang membutuhkan tindakan medis segera (emergency), pasien yang kondisinya serius

namun masih stabil sehingga dapat menunggu dalam batas waktu tertentu (urgent), dan pasien dengan kondisi ringan yang tidak memerlukan tindakan medis segera (non-urgent).

Pentingnya triase di Instalasi Gawat Darurat tidak dapat diabaikan. Keberhasilan pelayanan di unit gawat darurat sangat bergantung pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya medis yang terbatas, seperti tenaga medis, peralatan, dan ruang perawatan. Dengan adanya triase yang terstruktur dan efektif, sumber daya yang tersedia di unit gawat darurat dapat dialokasikan secara tepat kepada pasien yang paling membutuhkannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko terjadinya kematian atau komplikasi akibat terlambatnya penanganan pasien dengan kondisi yang kritis.

Selain itu, triase juga memberikan manfaat penting dari aspek psikologis baik kepada pasien maupun keluarga pasien. Dengan adanya proses triase yang jelas, pasien dan keluarganya akan lebih memahami mengapa beberapa pasien mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien lain. Hal ini membantu mengurangi rasa cemas, frustrasi, atau kebingungan yang sering timbul akibat tidak adanya informasi atau penjelasan yang jelas mengenai sistem penanganan di IGD. Di sisi lain, tenaga medis juga terbantu oleh sistem triase karena mampu membuat keputusan klinis yang lebih objektif dan transparan, sehingga mengurangi potensi konflik atau ketidakpuasan dari pasien atau keluarganya.

Implementasi protokol triase juga merupakan standar wajib dalam akreditasi rumah sakit dan pelayanan medis. Rumah sakit yang menerapkan sistem triase yang baik dan terstandar biasanya memiliki kinerja pelayanan gawat darurat yang lebih optimal dan efektif dibandingkan dengan rumah sakit yang tidak menggunakan sistem triase secara konsisten. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan tentang protokol triase menjadi sangat esensial untuk dimiliki oleh seluruh tenaga kesehatan, terutama mereka yang bertugas di unit gawat darurat.

Dengan demikian, triase bukan hanya sekadar proses administratif semata, tetapi merupakan suatu sistem vital dalam pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat yang memastikan pasien mendapatkan penanganan medis yang tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan. Mengingat pentingnya sistem ini, maka sangat penting bagi setiap Instalasi Gawat Darurat untuk memiliki protokol triase yang jelas, terstruktur, dan mudah diaplikasikan dalam situasi apa pun demi terciptanya pelayanan kesehatan yang maksimal dan berorientasi pada keselamatan pasien.

B. Prinsip dan Tujuan Triase di Instalasi Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), triase merupakan salah satu proses penting yang wajib diterapkan dengan baik agar pasien dapat segera memperoleh penanganan yang tepat sesuai dengan tingkat kegawatannya. Untuk dapat menjalankan triase secara optimal, maka tenaga medis harus memahami prinsip dasar pelaksanaan triase serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya.

1. Prinsip Dasar Pelaksanaan Triase

Dalam praktiknya, pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan bagi tenaga medis saat melakukan penilaian terhadap pasien. Prinsip pertama adalah prinsip keseimbangan antara kebutuhan pasien dan sumber daya medis yang tersedia. Prinsip ini menekankan pentingnya menilai kondisi pasien dengan cermat, kemudian menentukan urutan prioritas berdasarkan tingkat keparahan kondisi medisnya. Hal ini bertujuan agar sumber daya yang terbatas seperti tenaga medis, alat medis, obat-obatan, dan ruang perawatan, dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk menangani pasien dengan kondisi yang paling kritis terlebih dahulu.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan. Triase harus dijalankan dengan adil, transparan, objektif, dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, usia, ras, agama, atau faktor-faktor lain di luar kondisi medis pasien. Setiap pasien yang datang ke unit gawat darurat memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat, sesuai dengan kebutuhan medisnya. Implementasi prinsip ini memastikan bahwa keputusan klinis yang diambil oleh tenaga medis benar-benar didasarkan pada kondisi medis objektif, bukan berdasarkan preferensi pribadi atau subjektivitas tertentu.

Prinsip berikutnya adalah prinsip ketepatan dan kecepatan. Dalam situasi kegawatdaruratan, waktu adalah faktor yang sangat menentukan bagi keselamatan pasien. Penilaian terhadap pasien dalam proses triase harus dilakukan dengan cepat, akurat, dan efektif agar pasien tidak kehilangan kesempatan emas (golden period) dalam mendapatkan pertolongan medis. Oleh karena itu, petugas triase harus memiliki keterampilan klinis yang baik, pengalaman yang cukup, serta mampu bekerja dengan cepat di bawah tekanan yang tinggi.

Selain itu, prinsip dasar yang tidak kalah penting adalah prinsip konsistensi. Pelaksanaan triase harus konsisten dalam menggunakan standar dan protokol yang telah ditentukan. Dengan konsistensi ini, akan diperoleh hasil yang dapat

dipercaya serta meminimalkan risiko kesalahan atau kekeliruan dalam menentukan prioritas pasien. Tenaga medis yang bertugas di area triase juga harus memiliki pengetahuan tentang berbagai metode triase seperti Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage System (MTS), atau Australasian Triage Scale (ATS) yang telah diakui secara internasional. Konsistensi ini juga memudahkan evaluasi dan audit terhadap proses triase di masa mendatang.

Terakhir, prinsip dasar pelaksanaan triase adalah prinsip kolaborasi dan komunikasi yang efektif antar tenaga kesehatan. Keberhasilan triase sangat bergantung pada komunikasi yang lancar antara petugas triase, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang terlibat. Informasi yang diperoleh selama triase harus segera dikomunikasikan secara jelas dan akurat agar tindakan medis lanjutan dapat segera dilakukan secara terkoordinasi dengan baik.

2. Tujuan Umum dan Khusus dalam Protokol Triase

Tujuan utama dari pelaksanaan protokol triase di Instalasi Gawat Darurat secara umum adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan medis di IGD, sehingga pasien yang paling membutuhkan pertolongan darurat dapat segera diidentifikasi dan mendapatkan penanganan yang tepat waktu. Triase juga bertujuan untuk mencegah penundaan yang tidak perlu dalam penanganan pasien, sehingga menurunkan risiko kematian atau komplikasi serius akibat keterlambatan pemberian tindakan medis.

Secara lebih spesifik, tujuan khusus dalam pelaksanaan protokol triase mencakup beberapa aspek penting. Pertama, triase bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pasien (patient safety) dengan cara mengidentifikasi secara cepat pasien-pasien yang kondisinya mengancam jiwa sehingga dapat segera memperoleh tindakan medis penyelamatan yang efektif. Dengan demikian, angka mortalitas dan morbiditas di unit gawat darurat dapat ditekan serendah mungkin.

Tujuan khusus kedua adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya di IGD. Dalam situasi darurat, jumlah tenaga medis dan peralatan medis seringkali terbatas dibandingkan dengan jumlah pasien yang membutuhkan. Dengan adanya triase, sumber daya yang tersedia akan lebih mudah dialokasikan sesuai dengan prioritas kegawatan kondisi pasien, sehingga tidak terjadi pemborosan atau penggunaan sumber daya secara tidak tepat sasaran.

Tujuan khusus lainnya adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi tim medis. Protokol triase yang jelas akan membantu tenaga medis dalam berkomunikasi dengan sesama anggota tim dengan lebih efektif. Informasi mengenai kategori triase pasien dapat segera disampaikan kepada dokter,

perawat, atau tenaga medis lain yang bertugas, sehingga mereka dapat langsung menentukan tindakan selanjutnya tanpa menunda waktu.

Selain itu, triase juga memiliki tujuan khusus untuk memberikan rasa tenang dan kepercayaan bagi pasien serta keluarganya. Dengan adanya protokol triase yang transparan dan jelas, pasien dan keluarganya akan merasa lebih nyaman karena mereka mengetahui bahwa pelayanan dilakukan berdasarkan standar medis yang objektif dan bukan subjektif. Hal ini akan membantu mengurangi kecemasan, ketakutan, dan kebingungan yang mungkin dirasakan oleh pasien atau keluarganya dalam situasi yang penuh tekanan seperti IGD.

Terakhir, tujuan khusus yang juga penting adalah memfasilitasi proses dokumentasi yang terstandar dan tertib di Instalasi Gawat Darurat. Dengan adanya protokol triase yang baku, dokumentasi terhadap hasil triase dapat dilakukan secara konsisten dan akurat. Dokumentasi ini penting tidak hanya sebagai catatan klinis tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kegawatdaruratan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, pelaksanaan triase yang berlandaskan prinsip-prinsip dasar yang tepat serta tujuan-tujuan yang jelas akan membantu Instalasi Gawat Darurat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, efektif, aman, serta berpihak kepada keselamatan pasien. Implementasi protokol triase ini harus selalu didukung dengan pelatihan berkelanjutan dan evaluasi berkala agar kinerja triase senantiasa optimal dan terus mengalami perbaikan kualitas di masa depan.

C. Klasifikasi Triase Pasien di Instalasi Gawat Darurat

Salah satu langkah penting dalam pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat adalah proses klasifikasi pasien. Tujuan utama dari proses klasifikasi ini adalah untuk menetapkan prioritas pelayanan medis kepada pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisinya. Dengan klasifikasi yang jelas, tenaga medis mampu mengidentifikasi secara cepat pasien mana yang membutuhkan penanganan segera dan pasien mana yang dapat menunggu dalam periode tertentu. Klasifikasi ini memastikan pelayanan medis yang diberikan sesuai dengan kondisi pasien sehingga sumber daya yang terbatas di unit gawat darurat dapat digunakan secara efisien.

Secara umum, klasifikasi triase di Instalasi Gawat Darurat terbagi dalam tiga kategori utama, yaitu kategori Emergent, Urgent, dan Non-Urgent. Setiap kategori ini memiliki karakteristik klinis dan penanganan medis yang berbeda, sehingga petugas triase perlu memiliki keterampilan yang memadai untuk dapat secara akurat menentukan kategori yang sesuai untuk masing-masing pasien.

1. Kategori Emergent (Kondisi Gawat Darurat yang Mengancam Nyawa)

Kategori Emergent merupakan kategori tertinggi dalam sistem klasifikasi triase. Pasien dalam kategori ini adalah pasien yang mengalami kondisi medis kritis yang langsung mengancam nyawa dan membutuhkan penanganan segera dalam waktu sesingkat mungkin. Keterlambatan dalam penanganan terhadap pasien kategori emergent dapat berakibat fatal, menyebabkan kematian atau kecacatan permanen.

Beberapa contoh kondisi yang termasuk dalam kategori emergent antara lain serangan jantung (infark miokard akut), henti napas atau henti jantung (cardiac arrest), syok akibat perdarahan berat atau syok anafilaksis, gangguan pernapasan akut yang parah (seperti gagal napas atau status asmatikus), trauma kepala berat, luka bakar yang luas, stroke akut dengan penurunan kesadaran, serta kondisi medis lainnya yang menyebabkan gangguan signifikan pada fungsi vital pasien.

Penanganan terhadap pasien kategori emergent membutuhkan respons yang sangat cepat, sering kali dalam hitungan detik atau menit setelah pasien tiba di unit gawat darurat. Pasien-pasien ini biasanya langsung dibawa ke ruang resusitasi atau ruang kritis di mana tim medis melakukan tindakan penyelamatan segera seperti pemasangan akses jalan napas (intubasi endotrakeal), resusitasi cairan, pemberian obat emergensi, atau tindakan resusitasi jantung paru (RJP). Tim medis yang terlibat dalam penanganan pasien kategori ini biasanya terdiri dari dokter spesialis emergensi, perawat terlatih, serta tenaga kesehatan lain yang mampu memberikan tindakan intervensi tingkat lanjut.

2. Kategori Urgent (Kondisi Serius tetapi Tidak Mengancam Nyawa)

Kategori berikutnya adalah kategori Urgent. Pasien dalam kategori ini adalah pasien yang memiliki kondisi medis serius dan memerlukan penanganan medis segera, tetapi kondisi tersebut tidak secara langsung mengancam nyawa dalam waktu singkat. Artinya, pasien masih memiliki waktu untuk menunggu sebentar sebelum mendapat penanganan medis, namun tetap memerlukan perhatian yang intensif dan tidak boleh diabaikan dalam waktu lama.

Kondisi yang masuk dalam kategori urgent ini antara lain patah tulang tertutup, luka terbuka yang cukup dalam namun perdarahan tidak aktif atau tidak berat, nyeri perut akut dengan kondisi vital stabil, serangan asma yang tidak berat namun memerlukan terapi nebulisasi segera, nyeri dada dengan kondisi stabil (tanpa gangguan vital yang parah), atau kondisi medis lain yang masih stabil tetapi berpotensi memburuk jika tidak segera mendapat perawatan dalam kurun waktu tertentu.

Pasien dengan kategori ini umumnya akan ditangani setelah pasien kategori emergent selesai mendapatkan tindakan stabilisasi. Pasien kategori urgent biasanya dipantau ketat kondisinya sembari menunggu penanganan medis. Petugas triase memastikan bahwa kondisi pasien tidak mengalami perburukan selama menunggu, dan pasien tetap mendapat evaluasi ulang secara periodik agar kondisinya tetap stabil hingga mendapat penanganan medis definitif.

3. Kategori Non-Urgent (Kondisi Ringan atau Stabil)

Kategori terakhir dalam klasifikasi triase adalah kategori Non-Urgent. Pasien dalam kategori ini adalah mereka yang datang dengan kondisi medis ringan atau stabil yang tidak memerlukan tindakan medis segera. Kondisi ini tidak berbahaya atau tidak menyebabkan komplikasi serius meskipun ditunda penanganannya dalam waktu relatif lebih lama dibanding kategori sebelumnya.

Contoh kondisi yang termasuk dalam kategori non-urgent ini antara lain flu ringan, batuk biasa, demam ringan tanpa komplikasi, nyeri otot ringan, luka lecet kecil atau luka ringan tanpa perdarahan aktif, cedera terkilir ringan, atau kondisi medis lain yang stabil dan tidak menunjukkan tanda bahaya segera.

Pasien dalam kategori ini biasanya ditempatkan dalam antrean dengan waktu tunggu lebih lama karena kondisi mereka tidak membutuhkan penanganan prioritas. Petugas triase biasanya memberikan edukasi kepada pasien atau keluarga mengenai waktu tunggu yang harus dijalani serta alasan mengapa mereka perlu menunggu, agar pasien atau keluarganya tidak merasa cemas atau frustrasi. Pasien kategori ini umumnya diperlakukan di ruang tunggu umum atau ruang observasi yang tidak membutuhkan pengawasan intensif, kecuali jika terdapat perubahan kondisi yang memerlukan evaluasi ulang oleh petugas triase.

4. Pentingnya Ketepatan Klasifikasi Triase Pasien

Ketepatan klasifikasi triase sangat penting, karena hal ini sangat menentukan efektivitas pelayanan medis di unit gawat darurat. Kesalahan atau ketidaktepatan dalam menentukan kategori triase pasien dapat berakibat pada keterlambatan pemberian tindakan medis yang diperlukan, terutama pada pasien kategori emergent yang kondisinya sangat kritis. Sebaliknya, klasifikasi yang tepat memastikan bahwa sumber daya medis dapat dialokasikan dengan efisien, memberikan pertolongan prioritas bagi pasien yang sangat membutuhkan, sekaligus tetap memberikan kenyamanan bagi pasien dengan kondisi yang tidak serius.

Untuk memastikan klasifikasi triase berjalan optimal, petugas triase harus memiliki pelatihan yang baik, pengetahuan klinis yang luas, serta pengalaman praktis dalam melakukan penilaian cepat kondisi pasien di situasi yang penuh

tekanan. Selain itu, protokol triase yang baku harus diterapkan secara konsisten dan terus dievaluasi secara berkala untuk memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.

Dengan penerapan klasifikasi triase yang tepat dan konsisten, Instalasi Gawat Darurat dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, yakni menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa pasien, memberikan pelayanan yang adil dan efisien, serta menciptakan sistem pelayanan medis yang lebih efektif, aman, dan berpihak kepada keselamatan pasien secara keseluruhan.

D. Sistem dan Metode Triase yang Digunakan di Instalasi Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), pelaksanaan triase merupakan tahapan penting yang sangat menentukan keberhasilan penanganan pasien. Untuk menjalankan proses triase ini secara efektif, diperlukan suatu metode atau sistem standar yang jelas dan telah terbukti secara klinis dapat membantu tenaga medis dalam menentukan prioritas pasien berdasarkan kondisi kegawatannya. Beberapa sistem triase telah dikembangkan dan diadopsi secara luas di berbagai negara, antara lain Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage System (MTS), dan Australasian Triage Scale (ATS). Masing-masing dari metode ini memiliki kelebihan dan kekhususan dalam penerapannya serta menjadi standar internasional yang sering digunakan sebagai acuan dalam praktik sehari-hari di berbagai IGD.

Salah satu metode yang paling banyak digunakan di dunia, terutama di Amerika Serikat dan sejumlah negara lainnya, adalah Emergency Severity Index (ESI). ESI merupakan suatu sistem triase berbasis algoritma yang memiliki keunggulan dalam kesederhanaan namun tetap menjaga tingkat akurasi yang tinggi. Metode ini mengelompokkan pasien ke dalam lima level atau kategori berdasarkan dua kriteria utama, yaitu tingkat keparahan kondisi pasien (severity) dan jumlah sumber daya medis yang diperkirakan dibutuhkan untuk penanganannya (resource allocation).

Pada sistem ESI, kategori tertinggi adalah level 1, yang berarti pasien memiliki kondisi medis yang mengancam jiwa secara langsung dan memerlukan tindakan penyelamatan segera, misalnya pasien dengan henti jantung atau gagal napas akut. Selanjutnya, pasien level 2 merupakan pasien yang memiliki kondisi medis serius, seperti nyeri dada berat atau stroke akut, yang memerlukan evaluasi dokter segera. Pasien dalam kategori level 3 hingga level 5 memiliki kondisi medis yang bervariasi dari kondisi serius tapi stabil hingga kondisi ringan yang dapat menunggu lebih

lama dan membutuhkan lebih sedikit sumber daya. Kelebihan utama dari ESI adalah mampu memperkirakan secara efektif kebutuhan sumber daya medis yang dibutuhkan untuk setiap pasien, sehingga memudahkan alokasi sumber daya di IGD. Selain itu, sistem ini relatif cepat untuk diterapkan, karena didasarkan pada kriteria sederhana yang jelas dan mudah digunakan oleh petugas triase.

Metode kedua yang juga sangat populer digunakan di berbagai fasilitas kesehatan, khususnya di wilayah Inggris dan sejumlah negara Eropa lainnya adalah Manchester Triage System (MTS). MTS merupakan sistem triase yang berbasis algoritma klinis dengan pendekatan berbasis keluhan pasien (complaint-based system). Petugas triase akan melakukan penilaian awal berdasarkan keluhan utama pasien dan gejala yang menyertai, kemudian menggunakan algoritma yang tersedia dalam panduan MTS untuk menentukan kategori prioritas pasien tersebut.

Sistem Manchester ini juga membagi pasien ke dalam lima kategori yang dibedakan oleh warna khusus yang merepresentasikan tingkat prioritas penanganan. Kategori warna merah (red) menunjukkan kondisi sangat kritis yang memerlukan penanganan segera tanpa penundaan. Warna oranye (orange) untuk kondisi serius yang memerlukan penanganan dalam waktu singkat (kurang dari 10 menit). Warna kuning (yellow) digunakan untuk pasien yang kondisinya mendesak tetapi dapat menunggu hingga 60 menit. Warna hijau (green) menunjukkan kondisi ringan yang dapat menunggu lebih lama (hingga 120 menit), sedangkan warna biru (blue) menunjukkan kondisi yang sangat ringan dengan waktu tunggu hingga 240 menit. Salah satu kelebihan utama dari MTS adalah pendekatannya yang terstruktur secara jelas berdasarkan gejala klinis dan algoritma baku, sehingga memudahkan petugas triase untuk mengambil keputusan secara objektif. Selain itu, visualisasi warna pada sistem MTS memudahkan staf medis lain untuk segera memahami tingkat urgensi kondisi pasien secara cepat.

Sistem triase lain yang banyak digunakan di negara-negara seperti Australia dan Selandia Baru adalah Australasian Triage Scale (ATS). ATS adalah sistem yang juga membagi pasien dalam lima kategori berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan penanganan medis yang dibutuhkan pasien. ATS mengutamakan waktu tunggu maksimal yang diperbolehkan sebelum pasien menerima penanganan medis. Kategori ATS dimulai dari kategori 1 yang merupakan kondisi sangat kritis, mengancam nyawa dan memerlukan penanganan segera dalam waktu kurang dari dua menit setelah kedatangan pasien di IGD. Kategori berikutnya (kategori 2) adalah pasien dengan kondisi darurat tetapi tidak langsung mengancam nyawa dan harus ditangani dalam waktu kurang dari 10 menit, contohnya nyeri dada berat atau gangguan napas berat.

Pasien kategori 3 adalah kondisi mendesak yang stabil namun harus mendapatkan evaluasi medis dalam waktu kurang dari 30 menit, contohnya patah tulang terbuka yang stabil atau nyeri perut akut dengan tanda vital stabil. Kategori 4 adalah pasien dengan kondisi semi-urgensi yang dapat ditangani dalam waktu kurang dari 60 menit seperti cedera ringan, luka kecil, atau gejala flu berat. Sedangkan kategori 5 adalah kondisi non-urgensi yang dapat menunggu hingga 120 menit atau lebih, contohnya nyeri otot ringan atau batuk biasa.

ATS memiliki keunggulan utama dalam mengutamakan waktu tunggu maksimal yang jelas dan tegas untuk setiap kategori, sehingga menjadikan pelayanan medis di IGD terukur dan efektif. Sistem ini juga memudahkan rumah sakit dalam melakukan evaluasi kinerja pelayanan IGD berdasarkan indikator waktu tunggu pasien yang telah ditetapkan dalam standar ATS.

Dalam memilih sistem triase yang tepat untuk digunakan di Instalasi Gawat Darurat, perlu mempertimbangkan beberapa aspek seperti karakteristik pasien, jumlah kunjungan pasien, jumlah tenaga medis yang tersedia, serta infrastruktur rumah sakit. Misalnya, ESI sangat efektif digunakan di IGD yang memiliki sumber daya yang terbatas dan membutuhkan efisiensi tinggi dalam alokasi sumber daya medis. MTS sesuai untuk rumah sakit yang memerlukan pendekatan berbasis gejala klinis yang terstandar, sementara ATS cocok digunakan di lingkungan klinis yang membutuhkan pengaturan waktu tunggu yang ketat dan terstruktur.

Setiap rumah sakit biasanya menetapkan sistem triase yang paling sesuai dengan kebutuhan lokal serta melakukan modifikasi tertentu untuk menyesuaikan dengan karakteristik pasien dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, pelatihan berkelanjutan terhadap petugas triase menjadi kunci utama keberhasilan implementasi dari sistem dan metode triase yang dipilih agar selalu berjalan efektif dan efisien.

Dengan penerapan salah satu atau kombinasi dari sistem-sistem triase ini, Instalasi Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, lebih terstruktur, serta memastikan bahwa pasien yang paling membutuhkan tindakan darurat segera memperoleh penanganan yang optimal, sesuai dengan tingkat kegawatannya masing-masing.

E. Langkah-langkah Pelaksanaan Triase di Instalasi Gawat Darurat

Pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan rangkaian kegiatan yang sistematis dan terstruktur untuk menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi medisnya. Dalam proses triase ini, petugas kesehatan—biasanya seorang perawat terlatih secara khusus atau tenaga medis yang kompeten—harus mengikuti langkah-langkah secara berurutan untuk

memastikan pasien menerima pelayanan medis yang tepat waktu dan efektif. Langkah-langkah ini meliputi tahap pengkajian cepat (rapid assessment), identifikasi prioritas pasien, serta dokumentasi hasil triase secara terperinci.

Tahapan pertama dalam pelaksanaan triase adalah tahap pengkajian cepat atau rapid assessment. Tahap ini merupakan proses penilaian awal yang dilakukan secara singkat dan segera setelah pasien tiba di IGD. Tujuan utama dari tahap pengkajian cepat ini adalah untuk secara dini mengidentifikasi apakah pasien berada dalam kondisi yang secara langsung mengancam nyawa atau memerlukan tindakan medis segera tanpa penundaan. Dalam tahap ini, petugas triase akan melakukan penilaian visual secara cepat terhadap kondisi pasien, mengobservasi secara singkat tanda-tanda vital seperti pola napas, denyut jantung, tekanan darah, suhu tubuh, dan tingkat kesadaran pasien.

Selain itu, petugas juga secara cepat akan mengidentifikasi keluhan utama pasien serta melakukan wawancara singkat kepada pasien atau keluarga yang mendampingi pasien mengenai riwayat kejadian dan gejala yang dialami pasien. Waktu yang digunakan dalam rapid assessment biasanya sangat singkat—hanya beberapa menit saja—karena tujuan utamanya adalah untuk menentukan apakah pasien membutuhkan tindakan darurat segera seperti resusitasi, ventilasi buatan, atau intervensi lain yang bersifat life-saving. Pasien yang teridentifikasi mengalami kondisi kritis yang langsung mengancam nyawa akan segera dibawa ke ruang resusitasi tanpa penundaan lebih lanjut.

Setelah tahap rapid assessment selesai dilakukan, petugas triase akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu tahap identifikasi prioritas pasien. Pada tahap ini, petugas triase menggunakan hasil pengkajian cepat yang telah dilakukan sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan kategori atau level triase pasien. Identifikasi prioritas pasien dilakukan dengan menggunakan berbagai sistem triase yang telah terstandardisasi seperti Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage System (MTS), atau Australasian Triage Scale (ATS). Dalam tahap ini, petugas triase akan mengklasifikasikan pasien ke dalam kategori emergent (kondisi kritis yang mengancam nyawa), urgent (kondisi serius namun tidak langsung mengancam nyawa), atau non-urgent (kondisi ringan atau stabil).

Petugas triase diharuskan memiliki pengetahuan klinis yang luas dan pengalaman praktis yang cukup, sehingga mampu menentukan prioritas secara cepat, akurat, dan obyektif. Proses identifikasi ini sangat penting karena akan berdampak langsung pada kecepatan dan ketepatan pelayanan medis yang diterima pasien. Pasien dengan kategori emergent akan memperoleh prioritas tertinggi dan harus segera mendapatkan penanganan di ruang kritis atau resusitasi tanpa ditunda. Pasien dengan kategori urgent akan mendapatkan prioritas

berikutnya dengan waktu tunggu yang terbatas, sedangkan pasien kategori non-urgent akan diarahkan ke ruang tunggu dengan waktu tunggu lebih lama namun tetap berada di bawah pengawasan petugas triase.

Tahap ketiga dalam pelaksanaan triase di IGD adalah dokumentasi hasil triase secara terperinci. Dokumentasi merupakan tahap penting yang wajib dilakukan segera setelah proses identifikasi prioritas pasien selesai dilaksanakan. Dokumentasi triase mencakup pencatatan yang rinci dan jelas tentang kondisi pasien, hasil pengkajian cepat, kategori atau level triase yang telah ditentukan, serta rekomendasi atau tindakan medis awal yang telah diberikan selama proses triase berlangsung. Dokumentasi ini biasanya dilakukan pada formulir atau lembar triase khusus yang telah disediakan oleh rumah sakit, atau melalui sistem pencatatan elektronik yang sudah terintegrasi.

Dokumentasi hasil triase memiliki beberapa tujuan penting. Pertama, dokumentasi ini digunakan sebagai panduan bagi tenaga medis lain yang akan melanjutkan perawatan pasien di ruang tindakan atau ruang perawatan selanjutnya. Dengan dokumentasi yang baik, dokter atau perawat lain dapat dengan mudah memahami kondisi pasien, tingkat kegawatan, dan kebutuhan medis pasien tersebut secara cepat tanpa harus mengulangi pengkajian awal.

Kedua, dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti medis yang sah dan resmi terkait pelayanan yang diberikan kepada pasien di IGD. Jika di kemudian hari muncul permasalahan medis atau keluhan hukum dari pasien atau keluarganya, dokumentasi ini dapat menjadi alat bukti yang sangat penting mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh petugas triase pada saat pasien tiba di IGD.

Ketiga, dokumentasi triase juga digunakan sebagai alat untuk evaluasi kinerja pelayanan di IGD. Dokumentasi ini memungkinkan rumah sakit melakukan audit klinis secara berkala untuk memastikan bahwa protokol triase yang berlaku dijalankan dengan tepat dan konsisten oleh semua petugas triase.

Untuk memastikan bahwa dokumentasi hasil triase efektif, petugas triase harus memastikan pencatatan dilakukan dengan jelas, detail, akurat, dan menggunakan istilah-istilah medis yang standar serta mudah dimengerti oleh tenaga kesehatan lainnya. Petugas triase juga harus mencatat waktu dengan tepat dan lengkap terkait waktu kedatangan pasien, waktu pelaksanaan triase, serta waktu rekomendasi atau tindakan awal yang diberikan.

Dengan mengikuti ketiga langkah pelaksanaan triase ini secara berurutan dan disiplin, Instalasi Gawat Darurat dapat menjalankan fungsi triase secara efektif dan efisien, memastikan bahwa pasien dengan kondisi kritis memperoleh penanganan segera, dan pasien lain mendapat pelayanan sesuai dengan tingkat urgensinya masing-masing. Pelaksanaan triase yang optimal akan meningkatkan keselamatan

pasien, efisiensi pelayanan IGD, serta kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

F. Kompetensi Perawat dalam Melakukan Triase di Instalasi Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD), peran perawat yang bertugas sebagai petugas triase sangat krusial dalam menentukan prioritas pelayanan medis kepada pasien. Oleh karena pentingnya tugas tersebut, perawat triase harus memiliki kompetensi khusus yang meliputi kualifikasi pendidikan, pelatihan khusus, keterampilan klinis esensial, serta kemampuan mengatasi tantangan yang dihadapi selama melaksanakan proses triase.

Salah satu aspek penting yang mendasari kompetensi seorang perawat dalam melakukan triase adalah kualifikasi pendidikan dan pelatihan khusus. Secara umum, seorang perawat yang menjalankan peran sebagai petugas triase minimal harus memiliki kualifikasi pendidikan dasar sebagai perawat terdaftar (Registered Nurse) yang telah menyelesaikan pendidikan keperawatan formal dan memiliki izin praktik keperawatan yang sah. Namun, untuk menjalankan fungsi triase secara efektif, perawat juga harus mengikuti pelatihan khusus dalam bidang kegawatdaruratan dan triase yang diselenggarakan oleh institusi yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut.

Pelatihan khusus triase biasanya mencakup materi tentang prinsip dasar triase, sistem atau metode triase yang digunakan secara internasional seperti Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage System (MTS), atau Australasian Triage Scale (ATS), serta keterampilan klinis dalam melakukan penilaian cepat (rapid assessment) terhadap kondisi pasien. Selain itu, pelatihan ini juga meliputi simulasi praktik klinis dalam situasi kegawatdaruratan, evaluasi kecepatan dan akurasi penilaian, serta komunikasi efektif dalam tim medis dan dengan pasien atau keluarganya. Pelatihan khusus triase yang intensif tersebut memungkinkan perawat memiliki kemampuan klinis dan pengetahuan teoretis yang mendalam untuk menentukan prioritas pasien secara tepat, cepat, dan obyektif.

Selain kualifikasi pendidikan dan pelatihan khusus, perawat triase juga wajib memiliki berbagai keterampilan esensial yang mendukung tugasnya secara optimal. Keterampilan klinis yang harus dimiliki oleh perawat triase antara lain kemampuan melakukan pengkajian cepat kondisi pasien, termasuk kemampuan menilai tanda-tanda vital seperti tekanan darah, denyut jantung, frekuensi napas, tingkat kesadaran, dan suhu tubuh secara cepat dan akurat. Perawat triase juga dituntut untuk mampu mengenali tanda-tanda bahaya klinis, seperti gangguan pernapasan berat, perdarahan aktif hebat, perubahan kesadaran mendadak, atau gejala khas serangan jantung dan stroke akut.

Di samping keterampilan klinis, keterampilan lain yang juga sangat penting bagi perawat triase adalah keterampilan komunikasi interpersonal yang kuat. Perawat harus mampu berkomunikasi secara jelas, efektif, empatik, dan menenangkan dengan pasien dan keluarganya yang datang dalam kondisi cemas, bingung, atau panik akibat situasi darurat. Komunikasi yang baik sangat membantu dalam mengumpulkan informasi klinis penting dari pasien atau keluarganya dengan cepat serta memastikan pasien dan keluarganya tetap tenang selama proses triase berlangsung. Keterampilan komunikasi juga penting dalam berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter, perawat lain, atau tenaga pendukung medis yang terlibat dalam penanganan pasien, sehingga koordinasi tim medis dapat berjalan lancar dan efisien.

Perawat triase juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat di bawah tekanan tinggi (decision-making skills). Proses triase sering kali berlangsung dalam situasi penuh tekanan, dengan jumlah pasien yang banyak datang secara bersamaan dan masing-masing pasien membutuhkan perhatian segera. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam mengambil keputusan klinis secara cepat, berdasarkan data yang terbatas tetapi relevan, sangat menentukan keselamatan pasien dan efektivitas proses triase secara keseluruhan. Di samping itu, kemampuan dokumentasi yang baik juga menjadi keterampilan esensial bagi perawat triase, di mana mereka harus mampu mendokumentasikan hasil triase secara lengkap, akurat, dan tepat waktu agar informasi penting dapat diteruskan kepada tim medis selanjutnya.

Meskipun perawat triase telah memiliki kualifikasi pendidikan, pelatihan khusus, serta keterampilan esensial yang dibutuhkan, dalam pelaksanaan triase di IGD terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang sering dihadapi oleh perawat. Salah satu tantangan utama yang paling sering muncul adalah tingginya beban kerja (high workload) yang terjadi karena lonjakan pasien yang tiba-tiba datang dalam jumlah besar pada waktu bersamaan, terutama dalam kondisi darurat massal seperti kecelakaan lalu lintas atau bencana alam. Beban kerja yang tinggi ini dapat menimbulkan tekanan psikologis yang berat bagi perawat triase, meningkatkan risiko kesalahan dalam menentukan prioritas pasien, dan menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang signifikan.

Tantangan lain yang kerap dihadapi adalah keterbatasan sumber daya di IGD, baik berupa tenaga medis yang terbatas, peralatan medis yang kurang memadai, maupun ruang perawatan yang terbatas dibandingkan jumlah pasien yang membutuhkan pelayanan. Keterbatasan sumber daya ini menyebabkan dilema klinis bagi perawat triase dalam menentukan prioritas pasien, terutama ketika beberapa pasien yang datang secara bersamaan memiliki kondisi sama kritisnya. Dalam

kondisi seperti ini, perawat triase harus mampu menggunakan kebijakan klinis yang cermat serta berkomunikasi efektif dengan tim medis untuk mengatur strategi terbaik dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Di samping itu, hambatan lain yang cukup signifikan adalah kurangnya pemahaman pasien atau keluarga mengenai proses triase. Pasien atau keluarga yang kurang memahami prinsip dan prosedur triase sering kali merasa tidak puas, frustrasi, atau marah karena merasa pelayanan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan mereka, terutama jika mereka merasa waktu tunggu yang terlalu lama atau merasa tidak diperhatikan secara cepat. Oleh karena itu, perawat triase harus mampu memberikan edukasi atau penjelasan yang efektif kepada pasien dan keluarga tentang proses triase yang dilakukan, sehingga pasien dan keluarganya lebih memahami alasan di balik setiap keputusan klinis yang dibuat oleh perawat.

Tantangan terakhir yang penting diperhatikan adalah aspek etik dan legal dalam proses triase. Dalam kondisi tertentu, perawat triase dapat menghadapi dilema etik di mana mereka harus menentukan prioritas pelayanan medis yang berpotensi memengaruhi keselamatan pasien. Di sinilah peran penting dari kompetensi etik dan kesadaran hukum sangat diperlukan, agar perawat triase dapat mengambil keputusan klinis yang tepat tanpa melanggar standar etik profesi atau ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, perawat triase perlu mendapatkan pelatihan khusus secara berkala tentang isu etik dan legal terkait dengan proses triase.

Secara keseluruhan, kompetensi perawat dalam melakukan triase di Instalasi Gawat Darurat mencakup berbagai aspek penting mulai dari kualifikasi pendidikan dan pelatihan khusus, keterampilan klinis dan interpersonal yang esensial, hingga kemampuan menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin terjadi. Dengan memiliki kompetensi ini, perawat triase dapat memberikan pelayanan yang optimal, efektif, dan efisien bagi pasien yang datang ke IGD, serta turut berkontribusi secara signifikan dalam upaya penyelamatan nyawa pasien di tengah kondisi kegawatdaruratan.

G. Komunikasi Efektif selama Proses Triase di Instalasi Gawat Darurat

Komunikasi efektif merupakan aspek yang sangat penting dalam pelaksanaan triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Proses triase yang dilakukan dalam situasi kegawatdaruratan membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan kejelasan dalam menyampaikan maupun menerima informasi. Komunikasi yang efektif dalam triase tidak hanya penting untuk memastikan kelancaran koordinasi antar petugas kesehatan, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman bagi pasien maupun keluarganya selama berada di IGD. Dalam praktiknya,

komunikasi efektif selama proses triase mencakup dua aspek utama, yakni komunikasi antara perawat triase dengan pasien dan keluarganya, serta komunikasi antar tenaga kesehatan yang bertugas di IGD.

Komunikasi pertama yang sangat vital dalam proses triase adalah komunikasi antara perawat triase dengan pasien dan keluarganya. Pasien yang datang ke IGD biasanya mengalami berbagai kondisi medis, dari ringan hingga kondisi serius atau kritis. Kondisi tersebut sering kali membuat pasien dan keluarganya berada dalam situasi cemas, panik, ketakutan, atau kebingungan. Oleh karena itu, perawat triase sebagai garda terdepan dalam pelayanan IGD harus mampu menggunakan keterampilan komunikasi interpersonal yang baik, yang tidak hanya sebatas menyampaikan informasi tetapi juga mampu menenangkan pasien dan keluarganya.

Dalam situasi darurat, perawat triase harus menggunakan komunikasi yang lugas, jelas, singkat, namun tetap empatik dan sopan. Informasi yang disampaikan kepada pasien dan keluarga harus mudah dipahami dan tidak menggunakan istilah medis yang terlalu teknis atau rumit. Sebaliknya, jika memang harus menggunakan istilah medis tertentu, perawat triase harus memberikan penjelasan sederhana yang mudah dipahami pasien atau keluarga. Penjelasan ini penting karena dapat mengurangi kecemasan atau kepanikan yang dirasakan pasien atau keluarganya serta memberikan gambaran jelas tentang kondisi yang sedang dialami pasien maupun tindakan medis yang akan diberikan.

Dalam proses triase, perawat triase juga harus mampu mendengarkan secara aktif setiap informasi yang disampaikan oleh pasien atau keluarganya. Mendengarkan aktif melibatkan perhatian penuh terhadap apa yang dikatakan pasien maupun keluarganya, memperhatikan bahasa tubuh serta ekspresi wajah mereka, dan memberikan respons yang sesuai. Dengan mendengarkan secara aktif, perawat triase dapat lebih cepat dan akurat dalam memahami keluhan utama, riwayat kejadian, gejala-gejala tambahan yang dialami pasien, serta riwayat kesehatan penting yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas pasien. Keterampilan mendengarkan aktif ini juga membuat pasien dan keluarganya merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga lebih kooperatif selama proses triase berlangsung.

Selain itu, perawat triase perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk mengelola ekspektasi pasien dan keluarganya. Misalnya, jika pasien diklasifikasikan dalam kategori non-urgent, perawat triase harus dapat menjelaskan dengan baik mengapa pasien tersebut harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien lain dengan kondisi lebih serius. Penjelasan ini harus dilakukan secara sopan, empatik, namun tetap tegas dan jelas. Dengan demikian, pasien dan keluarganya

dapat memahami dan menerima keputusan klinis tersebut tanpa merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil. Kemampuan perawat triase dalam memberikan informasi yang transparan dan edukatif ini sangat penting untuk mencegah potensi konflik, keluhan, atau ketidakpuasan dari pasien dan keluarganya.

Aspek kedua dalam komunikasi efektif selama proses triase adalah komunikasi antar tenaga kesehatan yang bertugas di IGD. Komunikasi antar petugas kesehatan, seperti antara perawat triase dengan dokter jaga, dokter spesialis emergensi, perawat lainnya, petugas radiologi, farmasi, maupun tenaga kesehatan lainnya, sangat menentukan kelancaran koordinasi dan efektivitas pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Dalam kondisi IGD yang sering kali sibuk dan penuh tekanan, komunikasi antar tenaga kesehatan harus dilakukan dengan jelas, terstruktur, efisien, dan tepat waktu.

Salah satu metode komunikasi antar profesional yang umum digunakan dalam situasi kritis di IGD adalah metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Metode SBAR membantu petugas kesehatan untuk menyampaikan informasi pasien secara sistematis, singkat, dan jelas. Dalam metode ini, petugas kesehatan terlebih dahulu mendeskripsikan situasi terkini yang sedang dihadapi pasien (Situation), memberikan latar belakang klinis atau riwayat yang relevan (Background), menyampaikan hasil penilaian atau observasi terbaru yang telah dilakukan (Assessment), serta memberikan rekomendasi atau saran tindakan medis yang perlu segera dilaksanakan (Recommendation). Penggunaan metode SBAR ini dapat membantu mengurangi kesalahan informasi, meningkatkan kecepatan respons tim medis, serta memastikan setiap tenaga kesehatan yang menerima informasi memiliki pemahaman yang sama tentang kondisi pasien.

Selain metode SBAR, teknik komunikasi lain yang juga sangat efektif digunakan di IGD adalah komunikasi tertutup atau closed-loop communication. Dalam teknik ini, setiap pesan atau instruksi yang disampaikan oleh satu petugas kesehatan harus diulang kembali oleh petugas lain yang menerima informasi tersebut. Misalnya, ketika dokter memberikan instruksi untuk pemberian obat tertentu kepada pasien, perawat yang menerima instruksi tersebut akan mengulang instruksi tersebut secara singkat untuk memastikan bahwa pesan yang diterima sudah tepat dan jelas. Teknik ini sangat efektif untuk memastikan bahwa setiap instruksi kritis dipahami dengan baik, serta segera dilaksanakan secara tepat dan akurat oleh petugas terkait.

Komunikasi antar petugas kesehatan di IGD juga harus dilakukan secara profesional dan saling menghormati. Dalam situasi penuh tekanan, penting bagi setiap anggota tim medis untuk menjaga suasana kerja yang kolaboratif, positif, dan saling mendukung. Menghindari penggunaan bahasa atau sikap yang tidak sopan, menjaga kejelasan instruksi, serta saling membantu dalam menyampaikan informasi

penting adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam menjaga komunikasi yang baik dalam tim. Dengan komunikasi yang efektif, jelas, dan saling mendukung, tim medis di IGD dapat bekerja lebih harmonis dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Secara keseluruhan, komunikasi efektif selama proses triase di IGD sangat menentukan keberhasilan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Komunikasi yang baik antara perawat triase dengan pasien dan keluarganya membantu menciptakan rasa aman, nyaman, serta membangun kepercayaan pasien terhadap tim medis. Sementara itu, komunikasi antar tenaga kesehatan yang jelas, sistematis, dan saling mendukung membantu memastikan koordinasi yang baik, mempercepat proses pengambilan keputusan klinis, serta meningkatkan efisiensi dalam penanganan pasien dalam situasi kegawatdaruratan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif ini, pelayanan di IGD dapat berjalan lebih optimal, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan memastikan keselamatan pasien secara maksimal.

H. Aspek Etik dan Legal dalam Pelaksanaan Triase di Instalasi Gawat Darurat

Proses triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak hanya menuntut kecakapan klinis dan keterampilan teknis dari perawat atau tenaga medis yang melaksanakannya, tetapi juga melibatkan aspek-aspek penting yang berkaitan dengan pertimbangan etik dan tanggung jawab hukum. Kedua aspek ini sangat penting karena keputusan yang diambil selama proses triase memiliki dampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan bahkan kehidupan pasien yang datang ke IGD. Oleh karena itu, perawat atau tenaga medis yang bertugas sebagai petugas triase harus memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etik dalam pelayanan kesehatan serta mengetahui dengan jelas tanggung jawab hukum yang menyertai setiap keputusan klinis yang diambil selama proses triase berlangsung.

Pertama-tama, aspek etik dalam proses triase berhubungan erat dengan pertimbangan moral yang mendasari setiap keputusan yang diambil oleh perawat atau tenaga medis dalam menentukan prioritas pelayanan pasien. Dalam situasi kegawatdaruratan di IGD, tidak jarang perawat triase dihadapkan pada kondisi di mana jumlah pasien yang datang secara bersamaan sangat banyak, dengan berbagai tingkat kegawatan yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, perawat triase harus mengambil keputusan cepat untuk menentukan pasien mana yang harus ditangani terlebih dahulu berdasarkan prinsip etik yang berlaku dalam praktik pelayanan kesehatan.

Salah satu prinsip etik dasar yang paling penting dalam pelaksanaan triase adalah prinsip keadilan (justice). Prinsip ini mengharuskan perawat triase memberikan pelayanan medis yang adil dan merata berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan berdasarkan status sosial, latar belakang ekonomi, jenis kelamin, usia, atau faktor lainnya yang tidak relevan secara medis. Prinsip keadilan ini sangat penting, terutama ketika jumlah sumber daya yang tersedia di IGD terbatas dibandingkan dengan jumlah pasien yang memerlukan bantuan medis segera. Dalam kondisi ini, perawat harus memastikan bahwa pasien dengan kondisi medis paling serius, yang membutuhkan intervensi segera untuk menyelamatkan nyawa, mendapatkan prioritas utama dibandingkan pasien dengan kondisi medis yang lebih ringan.

Selain prinsip keadilan, perawat triase juga harus mempertimbangkan prinsip beneficence (melakukan tindakan terbaik untuk pasien) dan non-maleficence (tidak melakukan tindakan yang merugikan pasien). Dalam proses triase, prinsip beneficence berarti bahwa perawat harus melakukan tindakan yang secara aktif bermanfaat bagi keselamatan pasien, seperti memberikan tindakan penyelamatan nyawa secepat mungkin kepada pasien dalam kondisi kritis. Sebaliknya, prinsip non-maleficence menuntut perawat untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil tidak merugikan pasien. Dalam konteks triase, ini berarti bahwa perawat harus memastikan bahwa keputusan prioritas pelayanan tidak menyebabkan pasien lain mengalami kondisi yang lebih buruk atau membahayakan nyawa mereka karena kelalaian atau kesalahan dalam menentukan prioritas pasien.

Selain kedua prinsip tersebut, prinsip otonomi juga perlu diperhatikan dalam proses triase, yaitu menghormati hak pasien untuk menerima informasi yang jelas mengenai kondisi medisnya, termasuk alasan di balik keputusan prioritas pelayanan yang diberikan kepadanya. Dalam situasi tertentu, pasien dan keluarganya mungkin menuntut penjelasan mengenai mengapa mereka harus menunggu lebih lama dibandingkan pasien lain yang datang belakangan tetapi mendapatkan prioritas lebih tinggi. Dalam situasi tersebut, perawat triase harus memberikan penjelasan yang transparan, sopan, empatik, namun tetap jelas, agar pasien dan keluarganya dapat memahami keputusan klinis tersebut serta merasa dihargai hak-haknya sebagai pasien.

Kedua, aspek hukum atau legal dalam pelaksanaan triase di IGD berhubungan erat dengan tanggung jawab perawat atau tenaga medis terhadap setiap keputusan dan tindakan klinis yang diambil selama proses triase. Secara hukum, setiap tenaga medis yang melaksanakan triase memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan yang kompeten, profesional,

berdasarkan pengetahuan klinis yang kuat, dan sesuai dengan standar pelayanan medis yang berlaku.

Dalam konteks hukum, perawat atau tenaga medis yang bertugas melakukan triase di IGD harus memahami bahwa setiap keputusan yang mereka buat berpotensi menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari jika terjadi keluhan atau gugatan dari pasien atau keluarganya. Untuk itu, petugas triase harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang diambil berdasarkan protokol triase yang sudah ditetapkan oleh institusi kesehatan, memiliki dasar klinis yang jelas, serta terdokumentasi dengan baik. Dokumentasi ini menjadi alat bukti yang sah secara hukum apabila suatu saat terjadi sengketa atau gugatan terkait keputusan klinis yang diambil selama proses triase.

Selain dokumentasi, aspek informed consent (persetujuan tindakan medis) juga menjadi penting dalam aspek hukum di proses triase. Dalam kondisi kegawatdaruratan, pasien mungkin datang dalam kondisi kritis atau tidak sadarkan diri sehingga tidak memungkinkan petugas triase mendapatkan informed consent secara langsung dari pasien. Dalam kondisi tersebut, keputusan penyelamatan nyawa dapat diambil tanpa persetujuan terlebih dahulu dengan dasar kedaruratan medis. Namun, setelah kondisi darurat berhasil diatasi, perawat atau tenaga medis harus segera memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarganya mengenai tindakan medis yang telah diberikan serta alasan medis di balik tindakan tersebut. Dengan demikian, hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas tetap terpenuhi, dan potensi sengketa hukum akibat tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan pasien dapat diminimalisir.

Perawat atau tenaga medis yang bertugas melakukan triase juga harus memahami batas-batas kewenangan hukum yang mereka miliki. Mereka harus menyadari bahwa setiap keputusan klinis yang diambil harus sesuai dengan kompetensi profesional mereka. Melakukan tindakan yang melampaui kewenangan atau kompetensi yang dimiliki dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk risiko tuntutan hukum atas dasar malapraktik atau kelalaian medis. Oleh karena itu, sangat penting bagi petugas triase untuk selalu bertindak sesuai dengan kompetensi klinisnya dan mengacu pada protokol serta regulasi hukum yang berlaku di institusi kesehatan masing-masing.

Dalam praktiknya, tantangan etik dan hukum dalam pelaksanaan triase sering kali muncul secara bersamaan. Misalnya, dalam situasi bencana atau kejadian dengan korban massal, perawat triase dapat mengalami dilema antara memenuhi prinsip etik untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa pasien dengan sumber daya yang terbatas, sementara di sisi lain menghadapi tekanan hukum yang tinggi akibat potensi keluhan atau gugatan dari keluarga pasien yang merasa dirugikan

akibat keputusan klinis yang diambil. Dalam situasi tersebut, sangat penting bagi perawat triase untuk mendapatkan pelatihan berkelanjutan tentang manajemen etik dan hukum dalam kondisi darurat, serta mendapatkan dukungan penuh dari institusi tempat mereka bekerja agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, kompeten, dan aman dari risiko hukum.

Secara keseluruhan, aspek etik dan legal dalam pelaksanaan triase di IGD merupakan elemen penting yang harus selalu diperhatikan oleh setiap perawat atau tenaga medis yang bertugas sebagai petugas triase. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip etik secara tepat, serta menyadari tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap keputusan klinis yang diambil, petugas triase dapat memberikan pelayanan yang optimal, profesional, adil, serta aman bagi pasien, sekaligus menjaga dirinya sendiri dari potensi risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugasnya.

I. Monitoring dan Evaluasi Efektivitas Protokol Triase di Instalasi Gawat Darurat

Monitoring dan evaluasi merupakan bagian integral dari implementasi protokol triase di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pelaksanaan triase tidak hanya sekadar menentukan urutan pasien yang memerlukan penanganan medis segera, tetapi juga memastikan bahwa protokol yang digunakan efektif dan efisien dalam mendukung penyelamatan nyawa pasien serta pengelolaan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi setiap institusi kesehatan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas protokol triase yang mereka gunakan, dengan berpedoman pada indikator keberhasilan yang jelas dan evaluasi yang dilakukan secara berkala serta sistematis.

Salah satu komponen penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi protokol triase adalah adanya indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator keberhasilan ini merupakan parameter atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah pelaksanaan protokol triase di IGD sudah mencapai tujuan yang diharapkan, seperti meningkatkan ketepatan identifikasi kondisi pasien, mengurangi waktu tunggu pasien dengan kondisi kritis, memperbaiki tingkat keselamatan pasien, serta memastikan efisiensi sumber daya di unit gawat darurat.

Beberapa indikator keberhasilan triase yang dapat digunakan meliputi waktu tunggu pasien (patient waiting time), ketepatan kategori triase (triage accuracy), waktu respons tim medis dalam menangani pasien kategori emergent, angka mortalitas pasien di IGD, kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan triase, serta jumlah kejadian sentinel (sentinel events) seperti pasien yang memburuk atau mengalami komplikasi karena keterlambatan dalam penanganan akibat kesalahan penilaian prioritas pasien.

Waktu tunggu pasien menjadi salah satu indikator utama karena menggambarkan efisiensi triase dalam menentukan prioritas pelayanan. Pasien dengan kategori emergent, yang berada dalam kondisi kritis, harus ditangani segera setelah mereka tiba di IGD. Jika pasien kategori emergent memiliki waktu tunggu yang sangat singkat (dalam hitungan menit atau bahkan detik), hal tersebut menunjukkan bahwa sistem triase berjalan efektif. Sebaliknya, jika pasien kategori emergent mengalami waktu tunggu yang lama, ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pelaksanaan protokol triase yang harus segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Ketepatan kategori triase juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas triase. Indikator ini mengevaluasi seberapa akurat petugas triase dalam mengklasifikasikan kondisi pasien sesuai dengan tingkat kegawatan medisnya. Jika petugas triase mampu secara konsisten mengklasifikasikan pasien dalam kategori yang tepat, maka penanganan medis yang diberikan akan tepat sasaran, dan risiko komplikasi yang tidak diinginkan dapat dikurangi. Sebaliknya, kesalahan dalam mengklasifikasikan pasien, seperti menempatkan pasien yang seharusnya kategori emergent ke dalam kategori urgent atau non-urgent, dapat menyebabkan konsekuensi medis serius, bahkan fatal.

Selain indikator-indikator klinis tersebut, indikator kepuasan pasien dan keluarga terhadap layanan triase juga perlu diperhatikan. Kepuasan pasien mencakup aspek komunikasi, informasi yang diberikan selama proses triase, serta sikap petugas triase dalam memberikan pelayanan. Jika pasien dan keluarganya merasa puas terhadap layanan triase yang diberikan, ini menunjukkan bahwa komunikasi dan pendekatan interpersonal petugas triase berjalan efektif. Sebaliknya, jika ditemukan tingkat ketidakpuasan yang tinggi, maka institusi harus mengevaluasi kembali komunikasi yang dilakukan oleh petugas triase agar layanan lebih optimal dan dapat diterima oleh pasien maupun keluarganya.

Untuk memastikan bahwa indikator-indikator tersebut dapat digunakan secara efektif dalam menilai protokol triase, institusi kesehatan harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas sistem triase yang diterapkan di IGD. Evaluasi berkala ini biasanya dilakukan melalui audit klinis atau kajian retrospektif terhadap data pelayanan triase yang telah berlangsung selama periode waktu tertentu, misalnya tiga bulan, enam bulan, atau tahunan. Dalam proses evaluasi ini, institusi akan meninjau kembali data-data klinis pasien, rekam medis, dokumentasi hasil triase, serta laporan terkait kejadian sentinel atau insiden yang berhubungan dengan pelaksanaan triase.

Evaluasi berkala ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci kekuatan, kelemahan, peluang perbaikan, serta potensi ancaman yang ada dalam sistem triase

yang sedang diterapkan. Misalnya, dari hasil evaluasi dapat terungkap bahwa pasien kategori emergent tidak selalu mendapatkan pelayanan dalam waktu ideal yang telah ditentukan oleh standar protokol, atau petugas triase sering melakukan kesalahan klasifikasi pada kondisi tertentu. Informasi semacam ini menjadi dasar penting untuk melakukan tindakan perbaikan sistem, seperti pelatihan ulang bagi petugas triase, penyesuaian protokol, penambahan jumlah tenaga triase, atau bahkan modifikasi fasilitas yang mendukung proses triase.

Evaluasi sistem triase juga mencakup pemeriksaan kepatuhan petugas kesehatan terhadap protokol yang telah ditetapkan oleh institusi. Kepatuhan petugas triase terhadap protokol penting untuk memastikan konsistensi pelayanan. Evaluasi ini biasanya melibatkan observasi langsung, wawancara terhadap petugas triase, serta analisis dokumen atau rekam medis untuk memastikan bahwa setiap langkah triase dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

Selain evaluasi internal, institusi kesehatan juga dapat melakukan evaluasi eksternal, seperti benchmarking atau membandingkan hasil triase mereka dengan institusi lain yang memiliki karakteristik dan layanan yang sejenis. Evaluasi eksternal ini memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practice) dari institusi lain yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas sistem triase mereka sendiri.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini harus diikuti dengan tindakan konkret dan rekomendasi yang jelas untuk perbaikan berkelanjutan dalam implementasi protokol triase. Institusi harus memiliki mekanisme tindak lanjut yang efektif agar setiap temuan evaluasi tidak hanya bersifat informatif tetapi juga ditindaklanjuti secara nyata. Pelatihan berkala, review reguler terhadap protokol, serta diskusi tim multidisiplin menjadi kegiatan yang sangat penting dalam rangka menjaga efektivitas protokol triase di IGD.

Pada akhirnya, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang sistematis dan konsisten terhadap protokol triase akan membantu institusi kesehatan dalam memastikan bahwa pelayanan kegawatdaruratan di IGD berjalan optimal. Dengan melakukan evaluasi terhadap indikator keberhasilan yang relevan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, institusi kesehatan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepercayaan pasien dan keluarga, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

J. Simpulan

Triase merupakan komponen penting dalam pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang bertujuan memastikan setiap pasien memperoleh penanganan

medis sesuai tingkat kegawatan kondisinya secara tepat waktu, adil, dan efisien. Protokol triase dijalankan dengan prinsip dasar seperti keseimbangan antara kebutuhan pasien dan sumber daya yang tersedia, keadilan, kecepatan, ketepatan, konsistensi, serta kolaborasi efektif antar tenaga kesehatan.

Dalam pelaksanaannya, pasien diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama: emergent (kondisi kritis mengancam nyawa yang harus segera ditangani), urgent (kondisi serius namun tidak langsung mengancam nyawa), dan non-urgent (kondisi ringan yang dapat menunggu). Sistem triase yang banyak digunakan antara lain Emergency Severity Index (ESI), Manchester Triage System (MTS), dan Australasian Triage Scale (ATS), yang masing-masing memiliki kelebihan dalam menilai urgensi berdasarkan gejala klinis, tingkat keparahan, serta waktu maksimal tunggu pelayanan.

Proses triase terdiri dari pengkajian cepat, identifikasi prioritas pasien, serta dokumentasi hasil triase yang detail dan akurat. Untuk menjalankan proses ini, perawat triase harus memiliki kompetensi khusus yang mencakup kualifikasi pendidikan, pelatihan triase, keterampilan klinis dan komunikasi, serta kemampuan pengambilan keputusan yang cepat dalam tekanan tinggi. Tantangan utama yang dihadapi perawat dalam triase meliputi beban kerja tinggi, keterbatasan sumber daya, serta potensi konflik dengan pasien atau keluarga yang tidak memahami prosedur triase.

Komunikasi efektif antara perawat dengan pasien, keluarga, serta antar tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan proses triase, menggunakan teknik seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) dan closed-loop communication untuk mengurangi risiko kesalahan informasi. Selain itu, aspek etik dan legal dalam triase sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil secara objektif, adil, transparan, serta sesuai dengan tanggung jawab hukum dan profesional yang berlaku.

Monitoring dan evaluasi terhadap protokol triase secara berkala menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa implementasi sistem triase berjalan optimal, efisien, dan mampu mencapai indikator keberhasilan yang jelas seperti waktu tunggu pasien, ketepatan klasifikasi, angka mortalitas, serta kepuasan pasien. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi perbaikan terus-menerus terhadap sistem triase, melalui pelatihan ulang, penyesuaian protokol, serta peningkatan fasilitas di IGD.

Dengan implementasi protokol triase yang terstruktur, kompetensi perawat yang optimal, komunikasi yang efektif, serta kesadaran penuh terhadap aspek etik dan legal, pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dapat berjalan secara maksimal

untuk meningkatkan keselamatan pasien, efisiensi pelayanan, serta kepuasan pasien dan keluarganya.

K. Referensi

- Australasian College for Emergency Medicine. (2023). Guidelines on the Implementation of the Australasian Triage Scale in Emergency Departments. ACEM. Retrieved from <https://acem.org.au/>
- Considine, J., Lucas, E., Payne, R., Kropman, M., Stergiou, H. E., & Chiu, H. (2015). The reliability of the Australasian Triage Scale: A meta-analysis. *Australasian Emergency Nursing Journal*, 18(2), 62–71. <https://doi.org/10.1016/j.aenj.2015.02.003>
- Coupland, R. M. (2006). Evolution of triage systems. *Emergency Medicine Journal*, 23(2), 154–155. <https://doi.org/10.1136/emj.2005.030270>
- Cronin, J. (2004). The introduction of the Manchester Triage Scale to an emergency department in the Republic of Ireland. *Accident and Emergency Nursing*, 11(3), 121–125. [https://doi.org/10.1016/S0965-2302\(03\)00039-1](https://doi.org/10.1016/S0965-2302(03)00039-1)
- Gilboy, N., Tanabe, P., Travers, D. A., Rosenau, A. M., & Eitel, D. R. (2005). Emergency Severity Index (ESI): A Triage Tool for Emergency Department Care, Version 4—Implementation Handbook (AHRQ Publication No. 05-0046-2). Agency for Healthcare Research and Quality. Retrieved from <https://www.ahrq.gov/>
- Hocking, P. M. (2006). "To afford the wounded speedy assistance": Dominique Jean Larrey and Napoleonic triage. *World Journal of Surgery*, 30(8), 1359–1364. <https://doi.org/10.1007/s00268-005-0179-6>
- Mackway-Jones, K., Marsden, J., & Windle, J. (Eds.). (1997). *Emergency Triage* (Manchester Triage Group). BMJ Publishing Group.
- Mackway-Jones, K., Marsden, J., & Windle, J. (2004). The Australasian Triage Scale: Descriptors for Categories. Emergency Triage Education Kit. Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Retrieved from <https://www.safetyandquality.gov.au/>
- Tanabe, P., Gimbel, R., Yarnold, P. R., Kyriacou, D. N., & Adams, J. G. (2004). Reliability and validity of scores on the Emergency Severity Index version 3. *Academic Emergency Medicine*, 11(1), 1–7. <https://doi.org/10.1197/j.aem.2003.06.013>
- Travers, D. A., Waller, A. E., Bowling, J. M., Flowers, D., & Tintinalli, J. (2002). Five-level triage system more effective than three-level in tertiary emergency department. *Journal of Emergency Nursing*, 28(5), 395–400. <https://doi.org/10.1067/men.2002.127184>
- Wuerz, R., Milne, L. W., Eitel, D. R., Travers, D., & Gilboy, N. (2000). Reliability and validity of a new five-level triage instrument. *Academic Emergency Medicine*, 7(3), 236–242. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2000.tb01066.x>

Wuerz, R., Travers, D., Gilboy, N., Eitel, D., Rosenau, A., & Yazhari, R. (2001). Implementation and refinement of the Emergency Severity Index. *Academic Emergency Medicine*, 8(2), 170–176. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2001.tb01283.x>

L. Glosarium

Australasian Triage Scale (ATS)

Sistem triase dengan klasifikasi lima level berdasarkan waktu tunggu maksimal pasien untuk mendapatkan pelayanan medis di IGD, umum digunakan di Australia dan Selandia Baru.

Closed-loop Communication

Teknik komunikasi tertutup di mana penerima pesan mengulangi pesan dari pengirim untuk memastikan instruksi diterima dan dipahami secara akurat.

Dokumentasi Triase

Pencatatan hasil pengkajian awal kondisi pasien secara terperinci, mencakup kondisi klinis, kategori triase, tindakan awal, serta waktu pelaksanaan, sebagai panduan lanjutan dan bukti medis.

Emergency Severity Index (ESI)

Sistem triase berbasis algoritma yang mengklasifikasikan pasien menjadi lima kategori berdasarkan tingkat keparahan dan kebutuhan sumber daya medis; banyak digunakan di Amerika Serikat.

Emergent

Kategori triase tertinggi untuk pasien dengan kondisi medis kritis yang langsung mengancam nyawa dan memerlukan penanganan medis segera.

Golden Period

Waktu kritis sesaat setelah pasien mengalami cedera atau kondisi darurat medis yang jika segera ditangani dapat meningkatkan peluang keselamatan pasien.

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Unit pelayanan medis yang khusus menangani pasien dengan kondisi kegawatdaruratan, membutuhkan pelayanan cepat dan tepat.

Kategori Triase

Pengelompokan pasien berdasarkan tingkat kegawatan medisnya menjadi emergent, urgent, dan non-urgent untuk menentukan prioritas pelayanan.

Manchester Triage System (MTS)

Sistem triase berbasis keluhan utama pasien dengan lima kategori warna yang merepresentasikan tingkat urgensi kondisi pasien; banyak digunakan di Eropa, terutama Inggris.

Non-urgent

Kategori triase untuk pasien dengan kondisi medis ringan atau stabil yang tidak memerlukan tindakan medis segera dan dapat menunggu lebih lama.

Patient Safety (Keselamatan Pasien)

Upaya dan tindakan pelayanan medis yang bertujuan mencegah terjadinya cedera atau komplikasi pada pasien selama proses pelayanan kesehatan berlangsung.

Rapid Assessment (Pengkajian Cepat)

Penilaian awal secara singkat yang dilakukan oleh petugas triase untuk segera mengidentifikasi kondisi pasien yang mengancam nyawa saat tiba di IGD.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Metode komunikasi antar tenaga kesehatan yang terstruktur, mencakup situasi terkini, latar belakang, hasil observasi, dan rekomendasi tindakan medis.

Sentinel Event (Kejadian Sentinel)

Kejadian atau komplikasi serius yang tidak diharapkan yang menyebabkan kematian atau cedera serius pada pasien, biasanya akibat kesalahan atau keterlambatan dalam penanganan medis.

Triase

Proses penilaian awal terhadap kondisi pasien secara sistematis dan terstruktur di IGD untuk menentukan tingkat prioritas pelayanan medis berdasarkan tingkat keparahan kondisi pasien.

Triage Accuracy (Ketepatan Triase)

Keakuratan dalam menentukan kategori triase yang sesuai dengan kondisi klinis pasien, mempengaruhi efektivitas pelayanan di IGD.

Urgent

Kategori triase untuk pasien dengan kondisi medis serius namun tidak secara langsung mengancam nyawa dalam waktu singkat; membutuhkan perhatian medis segera tetapi bisa menunggu sebentar.

Workload (Beban Kerja)

Jumlah tugas atau pekerjaan yang harus diselesaikan oleh petugas triase, terutama saat terjadi lonjakan jumlah pasien di IGD, yang dapat menyebabkan kelelahan dan risiko kesalahan.

CHAPTER 3

KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN KARDIOVASKULAR

Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S.Kep., Ns., MNS.

A. Pendahuluan/Prolog

Kegawatdaruratan kardiovaskular merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) di seluruh dunia. Pada tahun 2019, diperkirakan 17,9 juta orang meninggal akibat kegawatdaruratan kardiovaskular, yang menyumbang 32% dari total kematian global. Dari jumlah tersebut, 85% disebabkan oleh kejadian kardiovaskular akut. Lebih dari tiga perempat kematian akibat CVD terjadi di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, dan 38% dari 17 juta kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular terkait dengan kegawatdaruratan kardiovaskular (Geneş & Deveci, 2024; World Health Organization, 2024). Gangguan pada sistem kardiovaskular seperti infark miokard akut, gagal jantung akut, dan hipertensi emergensi dapat terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan penanganan segera, tepat, dan terstandarisasi untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa (Klemet et al., 2024). Dalam konteks ini, perawat gawat darurat memainkan peran sentral sebagai penyedia intervensi awal yang menentukan keberhasilan penatalaksanaan secara keseluruhan. Kemampuan perawat dalam melakukan deteksi dini terhadap infark miokard akut (IMA) menjadi krusial, mengingat IMA termasuk sindrom koroner akut yang memerlukan intervensi dalam waktu cepat "*golden period*" untuk menyelamatkan miokard dari nekrosis permanen. Penghematan waktu dianggap sebagai "penyelamatan nyawa," sebuah filosofi yang diadopsi oleh layanan darurat, artinya kelangsungan hidup seseorang bergantung pada kecepatan dan ketepatan waktu Tindakan (Agustini et al., 2024). Pemeriksaan EKG 12 sadapan secara cepat, pengkajian nyeri dada dengan pendekatan sistematis (seperti PQRST), serta inisiasi terapi awal berbasis protokol seperti mnemonik "MONA" (Morfin, Oksigen, Nitroglycerin, dan Aspirin) dan terapi suportif lainnya menjadi tanggung jawab awal perawat dalam menjalankan fungsi interdependen yang tidak dapat ditunda (de Alencar Neto & De Alencar, 2018; Sharp & Webster, 2025).

Selain IMA, penatalaksanaan gagal jantung akut juga menjadi tantangan tersendiri di IGD. Pasien sering datang dengan gejala sesak berat, edema paru, dan tanda-tanda hipoperfusi. Perawat diharapkan mampu mengidentifikasi klasifikasi hemodinamik (*warm/cold & wet/dry*), memberikan intervensi seperti pemberian

oksigen, diuretik, serta melakukan monitoring status cairan dan hemodinamik secara ketat. Tak kalah penting, hipertensi emergensi merupakan kondisi krisis yang dapat menimbulkan kerusakan organ target secara cepat, termasuk stroke, gagal jantung, dan diseksi aorta. Keberhasilan manajemen kondisi ini sangat bergantung pada kemampuan perawat dalam menilai tekanan darah ekstrem, mengidentifikasi gejala kerusakan organ, dan melakukan kolaborasi dalam pemberian terapi antihipertensi intravena yang sesuai standar klinis.

Dalam keseluruhan proses tersebut, dokumentasi dan evaluasi asuhan keperawatan kardiovaskular menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Dokumentasi yang akurat dan sistematis bukan hanya berfungsi sebagai alat komunikasi lintas profesi, tetapi juga sebagai bukti legal dan alat evaluasi mutu pelayanan keperawatan. Evaluasi asuhan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas intervensi yang diberikan serta untuk mengidentifikasi kebutuhan tindakan lanjutan atau modifikasi rencana keperawatan. Dengan pendekatan *Evidence-Based Practice* (EBP), bab ini disusun untuk memberikan panduan komprehensif bagi perawat gawat darurat dalam menangani kasus-kasus kardiovaskular kritis. Seluruh konten sub-bab dilandasi oleh pedoman klinis terkini dari lembaga internasional seperti *European Society of Cardiology (ESC)*, *American Heart Association (AHA)*, dan praktik terbaik dari jurnal-jurnal keperawatan terkemuka. Diharapkan, chapter ini dapat menjadi rujukan akademik dan praktis bagi perawat dalam meningkatkan kualitas asuhan keperawatan kardiovaskular di area gawat darurat secara aman, efektif, dan profesional.

B. Deteksi Dini Infark Miokard Akut (IMA)

Infark Miokard Akut (IMA) adalah kondisi kegawatdaruratan kardiovaskular yang memerlukan penanganan cepat dan tepat untuk menurunkan angka kematian dan komplikasi. Deteksi dini oleh perawat gawat darurat memiliki peran krusial dalam penentuan diagnosis dan inisiasi terapi segera. IMA terjadi ketika aliran darah ke bagian otot jantung terhambat, biasanya akibat trombus pada arteri koroner. Jika tidak segera ditangani, jaringan miokard mengalami iskemia dan nekrosis dalam waktu singkat (golden period <90 menit untuk reperfusi) (American Heart Association, 2020). Klasifikasi infark miokard (MI) telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh kemajuan dalam pemahaman patogenesis koroner. Secara historis, MI dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan temuan elektrokardiogram (EKG); infark Q-gelombang dan infark non-Q-gelombang. MI gelombang Q dikaitkan dengan kerusakan miokardium yang lebih luas dan dianggap sebagai pertanda hasil klinis yang lebih buruk, sementara MI non-gelombang Q dianggap mewakili bentuk yang kurang

parah. Namun, metode klasifikasi sederhana ini terbukti tidak memadai untuk mengarahkan keputusan terapeutik seiring dengan kemajuan pemahaman tentang penyakit jantung iskemik. Kerangka historis ini kemudian digantikan oleh paradigma saat ini, menggunakan istilah infark miokard dengan elevasi segmen ST (STEMI) dan infark miokard tanpa elevasi segmen ST (NSTEMI). Pergeseran ini didasarkan pada pemahaman bahwa elevasi segmen ST merupakan penanda kunci dari obstruksi arteri koroner akut dan lengkap, yang menandakan kebutuhan mendesak untuk revaskularisasi guna memulihkan aliran darah dan membatasi kerusakan otot miokardium. NSTEMI umumnya disebabkan oleh obstruksi parsial atau penurunan aliran darah, yang kadang-kadang memungkinkan pendekatan pengobatan yang lebih konservatif. Perkembangan dalam klasifikasi MI ini telah membantu menentukan waktu yang tepat untuk strategi pengobatan pada pasien dengan sindrom koroner akut (ACS) (Ayyad et al., 2025).

1. Definisi

Infark Miokard Akut (IMA) merupakan kondisi iskemia miokard yang disebabkan oleh oklusi total atau subtotal arteri koroner, yang mengakibatkan nekrosis otot jantung. IMA termasuk dalam sindrom koroner akut dan merupakan penyebab kematian utama di dunia.

2. Tanda dan Gejala Klinis

- a. Nyeri dada retrosternal tumpul, menekan, menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, atau punggung
- b. Keringat dingin (diaforesis), mual, muntah
- c. Sesak napas, gelisah, pusing
- d. Pada lansia dan pasien diabetes, gejala bisa atipikal (kelelahan, pingsan)

3. Pemeriksaan Penunjang

- a. EKG 12 sadapan (elevasi segmen ST, gelombang Q patologis)
- b. Penanda jantung: Troponin I/T, CK-MB
- c. Rontgen dada
- d. Ekokardiografi (*wall motion abnormality*)

4. Algoritma Tindakan Deteksi Dini IMA

- a. Pengenalan Gejala Klinis
 - 1) Nyeri dada > 20 menit, menjalar ke lengan kiri/rahang/punggung
 - 2) Sesak napas, keringat dingin, mual/muntah
 - 3) Palpitasi, kelelahan ekstrem, atau pingsan
- b. Penilaian Primer (Triase) Cepat (ABCDE)
 - 1) **A**: Airway terbuka?
 - 2) **B**: Pernapasan cepat/distress?
 - 3) **C**: Nadi cepat/lemah, kulit pucat?

- 4) **D**: Kesadaran menurun?
- 5) **E**: Tanda tambahan (sianosis, nyeri tekan)
- c. Monitoring Vital Signs dan 12 Lead ECG
 - 1) Pasang monitor jantung
 - 2) Lakukan EKG 12 sadapan dalam 10 menit pertama
 - 3) Perhatikan ST-segment elevation, T-inversi, Q abnormal
- d. Pemeriksaan Penunjang dan Rujukan
 - 1) Cek troponin T/I (bila tersedia)
 - 2) Pasang jalur IV
 - 3) Ambil darah awal: GDA, elektrolit, glukosa, ureum kreatinin
 - 4) Oksigen jika saturasi < 90%
 - 5) Berikan aspirin 160–325 mg dikunyah (*atas indikasi medis*)
 - 6) Nitrogliserin sublingual jika tidak hipotensi
 - 7) Hubungi Dokter IGD / PCI Center / Tim Jantung
- e. Koordinasi dan Dokumentasi
 - 1) Catat waktu onset gejala, waktu EKG pertama
 - 2) Dokumentasikan semuatindakan dan respon
 - 3) Komunikasikan dengan tim jantung, UGD, atau ICU
- f. Evaluasi dan Re-Evaluasi
 - 1) Monitor terus EKG, nyeri dada, saturasi O₂, tekanan darah
 - 2) Ulang EKG jika nyeri dada berlanjut
 - 3) Evaluasi kemungkinan komplikasi: aritmia, syok kardiogenik, edema paru

5. Peran Perawat dalam Deteksi Dini IMA

- a. Pengkajian Cepat dan Akurat
Menggunakan pendekatan *PQRST*:
 - 1) **P**rovoking/Palliating: apa yang memicu/meredakan nyeri?
 - 2) **Q**uality: tumpul, tajam, terbakar?
 - 3) **R**egion/Radiation: lokasi dan penyebaran
 - 4) **S**everity: skala nyeri 0–10
 - 5) **T**ime: durasi, waktu mulai
- b. Pemasangan EKG 12 Sadapan
 - 1) Waktu kritis: lakukan dalam 10 menit
 - 2) Evaluasi ST Elevasi, gelombang Q, inversi T
- c. Monitoring dan Intervensi Awal
 - 1) Pemberian oksigen jika SpO₂ < 94%
 - 2) Kolaborasi pemberian aspirin, nitrat, morfin
 - 3) Pantau TTV, nyeri, dan status neurologis

d. Koordinasi Multidisiplin

- 1) Komunikasi SBAR kepada dokter jaga
- 2) Aktivasi *code STEMI* atau protokol rujukan

6. Standar Prosedur Operasional (SOP) Keperawatan: Deteksi dan Penatalaksanaan Awal Infark Miokard Akut

Tujuan:

Melakukan identifikasi dini dan intervensi awal pada pasien dengan dugaan IMA untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas

Langkah-langkah tindakan:

a. Triase Awal:

- 1) Identifikasi keluhan nyeri dada
- 2) Observasi tanda vital dan level kesadaran

b. Pengkajian Nyeri Dada:

- 1) Gunakan pendekatan PQRST
- 2) Catat durasi, intensitas, dan karakter nyeri

c. Pemeriksaan EKG:

- 1) Pasang EKG 12 sadapan dalam ≤ 10 menit
- 2) Interpretasikan hasil (ST elevasi, gelombang Q)

d. Intervensi Awal:

- 1) Berikan oksigen jika $SpO_2 < 94\%$
- 2) Kolaborasi pemberian aspirin 160–325 mg
- 3) Kolaborasi pemberian nitrat sublingual
- 4) Pemberian morfin IV jika nyeri berat

e. Koordinasi dan Dokumentasi:

- 1) Hubungi DPJP/kardiolog untuk aktivasi PCI
- 2) Dokumentasikan semua tindakan dan hasil observasi

7. Format Dokumentasi SOAP

S: Pasien mengeluh nyeri dada sejak 1 jam lalu, skala 9/10, menjalar ke lengan kiri.

O: TD 140/90 mmHg, HR 108x/mnt, RR 22x/mnt, SpO_2 95%. EKG menunjukkan ST elevasi di lead II, III, aVF.

A: Risiko penurunan perfusi miokard terkait IMA.

P: Pemasangan EKG, pemberian aspirin, nitrat, aktivasi protokol STEMI, rujuk ke unit cath lab.

C. Penatalaksanaan Keperawatan Pasien dengan Gagal Jantung Akut

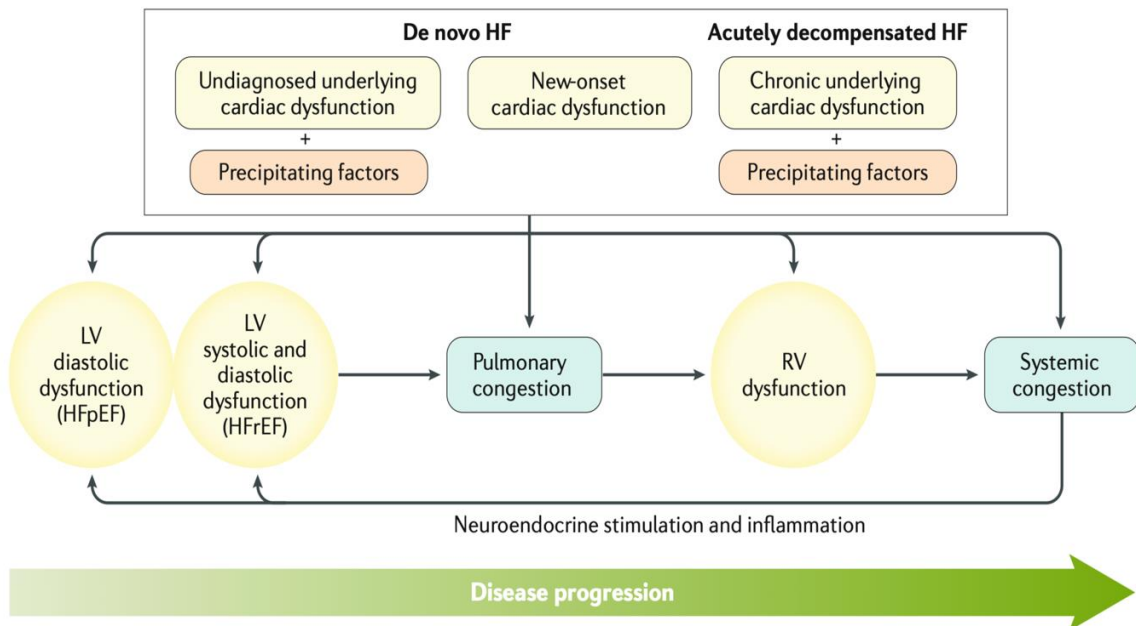
Gagal jantung akut (GJA) merupakan kondisi gawat darurat medis yang ditandai oleh gangguan mendadak fungsi jantung dalam memompa darah, mengakibatkan penumpukan cairan di paru-paru dan/atau jaringan perifer. Kondisi ini sering muncul di IGD sebagai sesak napas berat, edema paru akut, hipotensi, dan syok kardiogenik. Penatalaksanaan yang tepat, cepat, dan sistematis oleh perawat gawat darurat berperan penting dalam mencegah mortalitas dan memperbaiki hasil klinis pasien.

1. Definisi dan Patofisiologi

Gagal jantung (HF), yang juga dikenal sebagai gagal jantung kongestif (CHF)/ gagal jantung akut (AHF), adalah sindrom klinis kompleks yang ditandai dengan ketidakmampuan jantung untuk memompa darah secara efektif akibat gangguan struktural atau fungsional. Penyebab paling umum dari HF adalah penyakit jantung iskemik, tetapi faktor lain seperti hipertensi, penyakit katup jantung, dan miokarditis juga berkontribusi pada perkembangannya. HF diklasifikasikan berdasarkan fraksi ejeksi ventrikel kiri (LVEF) dan stadium klinis. Gejala umum HF meliputi sesak napas, kelelahan, retensi cairan, dan edema. Kursus ini membahas kompleksitas seputar etiologi yang luas, penilaian, klasifikasi, dan stadium HF. Aktivitas ini dirancang untuk tenaga kesehatan profesional guna meningkatkan kompetensi peserta dalam mengidentifikasi HF, melakukan penilaian multifaset yang direkomendasikan, dan menerapkan pendekatan interdisipliner yang tepat dalam mengelola kondisi ini, yang esensial untuk meningkatkan hasil pengobatan dan kualitas hidup pasien (American Heart Association, 2020).

Gagal jantung akut (HF) disebabkan oleh kombinasi antara disfungsi jantung yang mendasar namun baru didiagnosis dan faktor pemicu, atau munculnya disfungsi jantung baru (HF de novo) atau kombinasi antara disfungsi jantung kronis yang mendasar dan satu atau lebih faktor pemicu (gagal jantung akut yang tidak stabil (ADHF), yaitu dekompensasi dari gagal jantung kronis). Faktor pemicu dapat secara langsung mempengaruhi fungsi ventrikel kiri (LV) atau ventrikel kanan (RV) (misalnya, iskemia miokard dan aritmia) atau dapat berkontribusi pada perkembangan kongesti (misalnya, infeksi, hipertensi, dan ketidakpatuhan terhadap rekomendasi pengobatan yang dianjurkan). Disfungsi LV (disfungsi diastolik pada HF dengan fraksi ejeksi yang terjaga (HFpEF) atau disfungsi diastolik dan sistolik pada HF dengan fraksi ejeksi yang berkurang (HFrEF)) menyebabkan kongesti paru, yang pada gilirannya berkontribusi pada disfungsi RV dan kongesti sistemik. Kongesti sistemik, aktivasi neurohumoral, dan

peradangan secara negatif mempengaruhi fungsi ventrikel dan semakin berkontribusi pada kongesti yang berkelanjutan (Mattia et al., 2020).

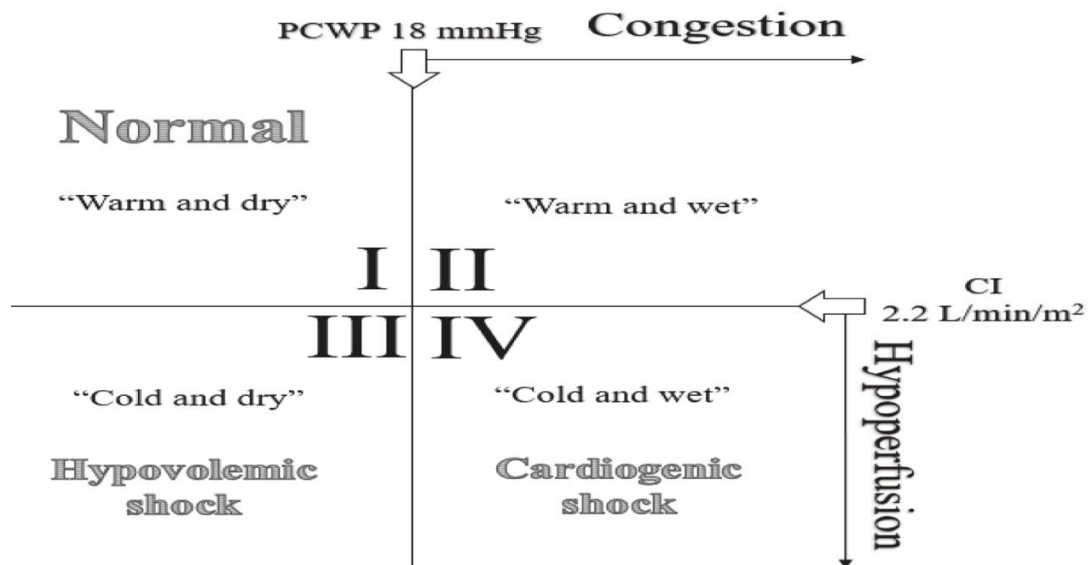


Gambar 3.1. Representasi skematis mekanisme patofisiologis pada AHF

2. Klasifikasi Klinis

Mengacu pada sistem profil hemodinamik (warm/cold dan wet/dry):

Profil	Perfusi	Kongesti	Contoh Klinis
Warm & Wet	Baik	Ya	Gagal jantung dekompensasi akut
Cold & Wet	Buruk	Ya	Syok kardiogenik
Cold & Dry	Buruk	Tidak	Hipoperfusi tanpa overload cairan
Warm & Dry	Baik	Tidak	Kompensasi jantung stabil, responsif terhadap terapi



Gambar 2. Klasifikasi klinis gagal jantung akut (Fraser et al., 2024)

3. Tanda dan Gejala

- Sesak napas akut (orthopnea, PND)
- Edema perifer, peningkatan JVP, hepatomegali
- Bunyi napas ronki basah, bunyi jantung gallop (S3)
- Hipotensi, takikardi, penurunan saturasi oksigen, oliguria
- Penurunan kesadaran pada kasus berat

4. Intervensi Keperawatan

- Posisi semi-Fowler
- Pemberian oksigen 4-6 L/menit (hindari hipoksia)
- Monitoring ketat TTV, I/O, EKG
- Pemberian diuretik (furosemid), vasodilator (nitrat IV jika TD > 90 mmHg), inotropik (dopamin/dobutamin) atas indikasi medis (jika perfusi menurun)
- Edukasi dan dukungan psikologis pasien dan keluarga
- Kolaborasi dengan tim medis untuk stabilisasi hemodinamik

5. Pemeriksaan Penunjang

- EKG → disritmia, iskemia
- Rontgen thoraks → edema paru
- Echocardiography → EF <40% (jika tersedia)
- NT-proBNP → meningkat

6. Peran Perawat dalam Penatalaksanaan GJA di IGD

- Stabilisasi Awal:
 - 1) Pasang monitor TTV dan EKG
 - 2) Posisi semi-Fowler

- 3) Berikan oksigen sesuai kebutuhan (target $\text{SpO}_2 \geq 94\%$)
- b. Kolaborasi Farmakologis:
 - 1) Diuretik IV (Furosemid 20–40 mg bolus)
 - 2) Nitrat IV atau SL (jika tidak hipotensi)
 - 3) Inotropik jika tanda-tanda syok
- c. Pemantauan Intensif:
 - 1) Input-output cairan
 - 2) Monitor elektrolit dan fungsi ginjal
 - 3) Observasi mental dan status hemodinamik tiap 15–30 menit
- d. Dukungan Psikologis:
 - 1) Reduksi kecemasan dengan edukasi singkat
 - 2) Dampingan pada pasien dengan dispnea berat

7. Algoritma Tindakan Keperawatan Gagal Jantung Akut

- a. Identifikasi Tanda dan Gejala Klinis
 - 1) Sesak napas mendadak, ortopnea, dispnea nokturna
 - 2) Edema perifer, peningkatan berat badan cepat
 - 3) Kelelahan, pusing, nadi cepat, tekanan darah menurun
 - 4) Ronki paru, bunyi jantung tambahan (S3)
- b. Penilaian Primer Cepat (ABCDE)
 - 1) A: Jalan napas terbuka?
 - 2) B: Tanda-tanda distress respirasi?
 - 3) C: Nadi cepat/lemah, tekanan darah rendah, perfusi buruk?
 - 4) D: Kesadaran menurun?
 - 5) E: Edema, sianosis, asites
- c. Monitoring dan Stabilitas Hemodinamik
 - 1) Monitor EKG, SpO_2 , tekanan darah, frekuensi napas
 - 2) Pasang jalur IV, pertahankan oksigenasi (O_2 nasal/masker)
 - 3) Pertimbangkan diuretik (furosemid) sesuai instruksi dokter
- d. Intervensi Keperawatan Awal
 - 1) Posisikan semi-fowler untuk meringankan sesak
 - 2) Berikan O_2 jika $\text{SpO}_2 < 92\%$
 - 3) Kolaborasi pemberian vasodilator dan diuretik
 - 4) Observasi ketat cairan masuk/keluar
- e. Evaluasi Respons Terhadap Terapi
 - 1) Pantau penurunan sesak, peningkatan SpO_2
 - 2) Pantau TTV, EKG, dan tanda overload cairan
 - 3) Dokumentasi perubahan kondisi pasien secara berkala

f. Edukasi dan Rujukan

- 1) Edukasi pasien dan keluarga tentang tanda perburukan
- 2) Persiapkan rujukan ke ICU jika tidak stabil
- 3) Dokumentasi dan koordinasi dengan tim medis

8. SOP Keperawatan: Penatalaksanaan Awal Keperawatan pada Pasien Gagal Jantung Akut

Tujuan:

Meningkatkan perfusi jaringan dan menurunkan kongesti paru dengan intervensi cepat, aman, dan kolaboratif.

Langkah-langkah Tindakan:

a. Pengkajian Awal:

- 1) TTV, bunyi napas, tanda kongesti
- 2) Gunakan skala dyspnea (NYHA) jika memungkinkan

b. Stabilisasi:

- 1) Posisi semi-Fowler
- 2) Oksigen 4–6 L/mnt
- 3) Pemasangan EKG dan monitor jantung

c. Pemberian Terapi:

- 1) Kolaborasi furosemid IV bolus
- 2) Nitrat jika tekanan darah stabil
- 3) Inotropik jika terdapat hipotensi atau hipoperfusi

d. Monitoring & Evaluasi:

- 1) Input-output tiap 1–2 jam
- 2) TTV tiap 15–30 menit
- 3) Observasi efek samping terapi

e. Dokumentasi:

- 1) Nyeri, TTV, intervensi, dan respons pasien
- 2) Komunikasi antar tim dalam format SBAR

9. Format Dokumentasi Keperawatan

S: Pasien sesak berat sejak 2 jam lalu, tidak bisa tidur terlentang, skala dyspnea 4/4

O: RR 32x/mnt, SpO₂ 89% RA, TD 130/90, HR 112x/mnt, ronki basah seluruh paru

A: Gangguan pertukaran gas r/t kongesti paru

P: Posisi semi-fowler, Oksigen 5 L/mnt, kolaborasi furosemid IV, monitoring TTV 30 menit, input-output per jam

D. Manajemen Pasien Hipertensi Emergensi di IGD

Hipertensi emergensi merupakan krisis hipertensif yang ditandai oleh peningkatan tekanan darah mendadak ($\geq 180/120$ mmHg) disertai dengan kerusakan organ target akut. Kondisi ini membutuhkan penurunan tekanan darah secara cepat namun terkontrol untuk mencegah komplikasi yang mengancam jiwa seperti stroke, edema paru, atau gagal ginjal akut. Penanganan hipertensi emergensi merupakan prioritas tinggi di instalasi gawat darurat (IGD), dan perawat memiliki peran kunci dalam deteksi, pemantauan, dan kolaborasi tindakan farmakologis. Darurat hipertensi (HE) didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah (TD) yang cepat dengan nilai sistolik lebih dari 180 mmHg dan/atau nilai diastolik lebih dari 120 mmHg, seringkali disertai dengan kerusakan neurologis, kardiovaskular, atau ginjal. Keterlibatan organ ini saat ini dikenal sebagai kerusakan organ yang dimediasi oleh hipertensi akut (A-HMOD). Namun, ambang batas yang lebih rendah dapat terkait dengan keadaan darurat hipertensi dalam kasus peningkatan tekanan darah yang cepat dari nilai dasar yang lebih rendah. Tekanan darah yang tinggi saja tidak mendefinisikan HE, terlepas dari seberapa tinggi nilainya, kecuali jika disertai dengan kerusakan organ akut, yang memerlukan intervensi penurunan tekanan darah segera untuk membatasi kerusakan yang sedang berlangsung [2]. Kerusakan organ target baru atau yang memburuk dapat terjadi pada sistem saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, renovaskular, dan oftalmologi. Magnitude peningkatan tekanan darah dan nilai tekanan darah absolut penting dari perspektif prognosis dan terapeutik, dengan pengenalan dini yang krusial. Presentasi klinis paling umum dari HE adalah stroke (38% dari semua kasus HE), diikuti oleh edema paru (35%) dan sindrom koroner (25%), yang menyoroti fakta bahwa hipertensi yang tidak terkontrol merupakan faktor risiko utama untuk semua hasil kardiovaskular utama [8]. Pengenalan dan pengobatan HE yang segera, oleh karena itu, wajib dilakukan. Meskipun data yang menunjukkan bahwa pengobatan HE dapat mengurangi angka kematian masih terbatas [4], jika tidak diobati, angka kematian satu tahun pada pasien dengan HE melebihi 79%. Pilihan strategi terapeutik, termasuk kelas obat antihipertensi serta jadwal penurunan tekanan darah, bervariasi tergantung pada jenis A-HMOD, komorbiditas sebelumnya, farmakokinetik obat tertentu, atau reaksi adverse terhadap obat tertentu (Balahura et al., 2022).

1. Definisi

Hipertensi emergensi adalah kondisi peningkatan tekanan darah secara signifikan, yaitu **>180/120 mmHg**, yang disertai dengan kerusakan organ target akut. Organ yang paling sering terkena dampak meliputi otak, jantung, ginjal, dan pembuluh darah besar. Hipertensi emergensi merupakan darurat medis yang memerlukan penanganan segera untuk menurunkan tekanan darah secara

terkendali guna mencegah kerusakan organ lebih lanjut atau kematian (Miller et al., 2024). Pasien dalam keadaan hipertensi emergensi umumnya menunjukkan tanda dan gejala kerusakan organ target, antara lain:

- a. Ensefalopati hipertensif
- b. Perdarahan intrakranial
- c. Stroke iskemik
- d. Infark miokard akut
- e. Gagal ventrikel kiri dengan edema paru
- f. Angina pektoris tidak stabil
- g. Diseksi atau ruptur aneurisma aorta
- h. Gagal ginjal akut
- i. Eklampsia

Sebaliknya, hipertensi urgensi ditandai dengan tekanan darah sangat tinggi tanpa kerusakan organ target, dan dapat ditangani secara bertahap.

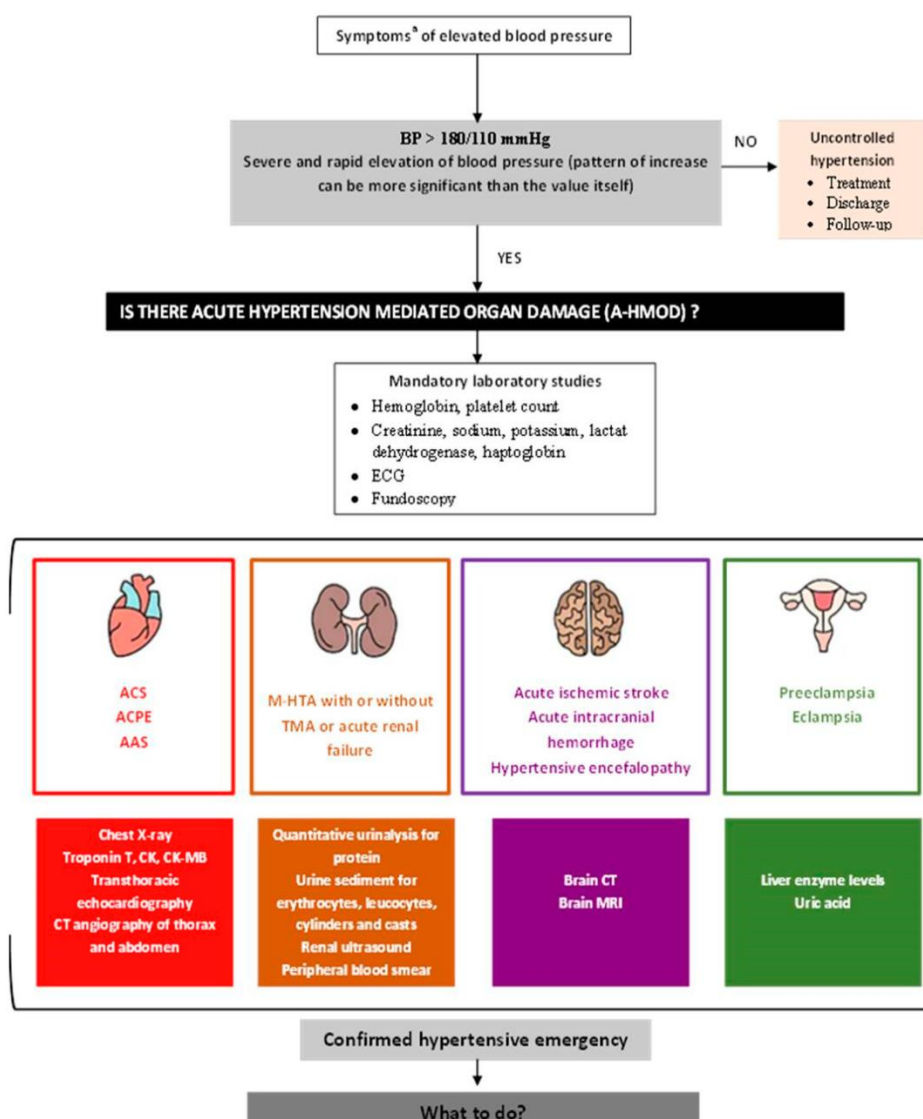
2. Tanda Klinis

- a. Nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan
- b. Perubahan status mental
- c. Nyeri dada, sesak napas
- d. Hematuria, penurunan kesadaran

3. Prinsip Manajemen

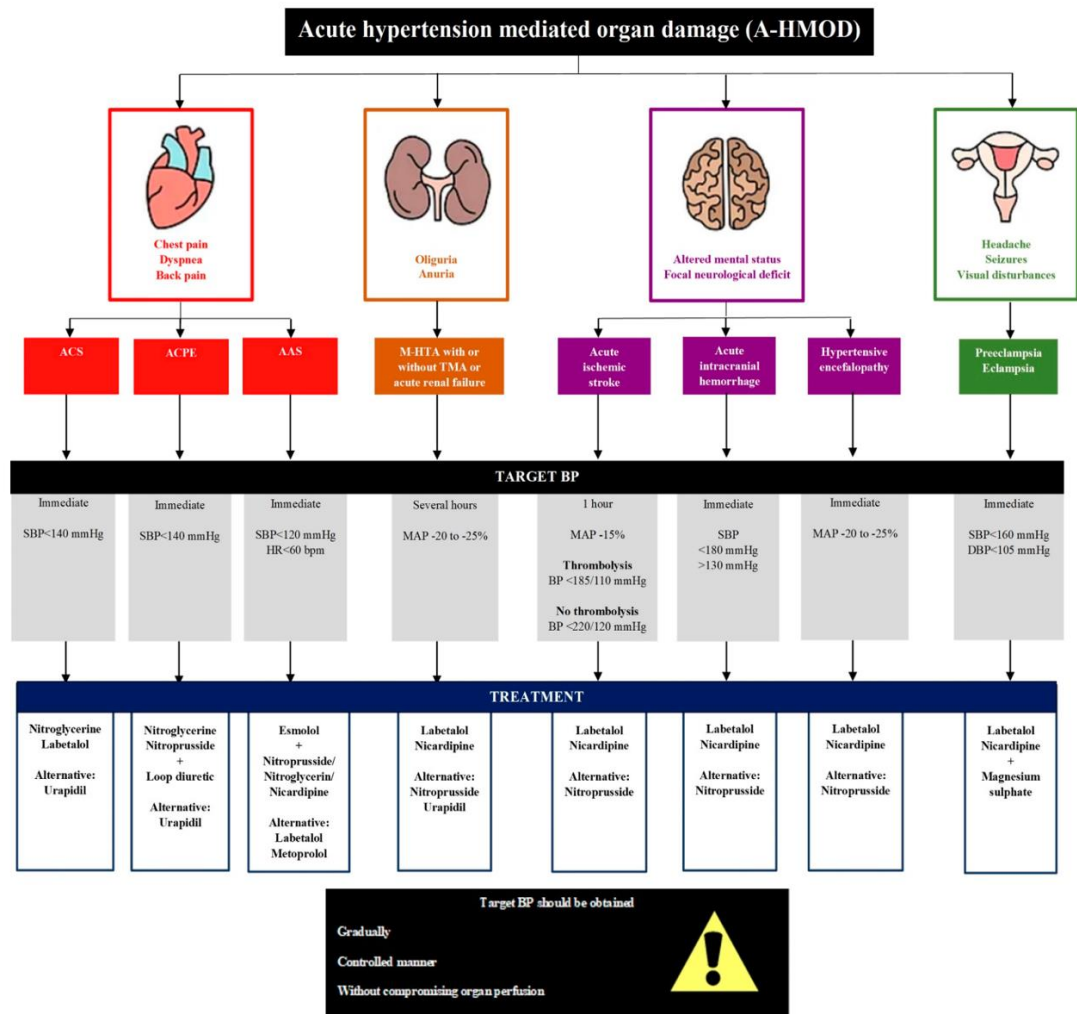
- a. Penurunan tekanan darah secara bertahap dalam 1 jam pertama (tidak lebih dari 25%)
- b. Tidak boleh normotensi secara tiba-tiba
- c. Obat IV: Nitroprusside, Labetalol, Nicardipine sesuai indikasi
- d. Pengawasan ketat tekanan darah dan fungsi organ target

Possible hypertensive emergency?



Gambar 3.3. Algoritma diagnostik kemungkinan keadaan darurat hipertensi

Tekanan darah (BP); EKG — EKG — elektrokardiografi; ACS — Sindrom koroner akut; ACPE — Edema paru kardiogenik akut elektrokardiografi; ACS — Sindrom koroner akut; ACPE — Edema paru kardiogenik akut; AAS Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; CK — Kreatin kinase; Edema paru kardiogenik akut; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; CK — Kreatin kinase; CK-MB — Kreatin kinase-MB; CT — Tomografi komputer; MRI — Pencitraan resonansi magnetik. CK-MB — Kreatin kinase-MB; CT — Tomografi komputer; MRI — Pencitraan resonansi magnetik.



Gambar 3.4 Penanganan darurat hipertensi berdasarkan kerusakan organ akut yang disebabkan oleh hipertensi akut (A-HMOD)

ACS — Sindrom koroner akut; ACPE — Edema paru kardiogenik akut; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; TMA — Edema paru; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; TMA — Edema paru; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA ACS — Sindrom koroner akut; ACPE — Edema paru kardiogenik akut; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; TMA — edema paru; AAS — Sindrom aorta akut; M-HTA — Hipertensi maligna; TMA — Mikroangiopati trombotik; BP — Tekanan darah; SBP — Tekanan darah sistolik; DBP — Tekanan darah Mikroangiopati trombotik; BP — Tekanan darah; SBP — Tekanan darah sistolik; DBP — Tekanan darah diastolik; HR — Irama jantung; MAP — Tekanan arteri rata-rata. Diastolik; HR — Irama jantung; MAP — Tekanan arteri rata-rata.

4. Peran Perawat

- a. Deteksi kerusakan organ target
- b. Monitoring ketat tekanan darah tiap 5–15 menit
- c. Pemasangan jalur IV, pemberian obat sesuai protokol
- d. Edukasi pasien terkait pentingnya kontrol tekanan darah pasca krisis

5. Kriteria Hipertensi Emergensi

- a. TD $\geq$ 180/120 mmHg
- b. Tanda kerusakan organ target:
 - 1) Neurologis: stroke, ensefalopati hipertensif, kejang
 - 2) Kardiak: nyeri dada, gagal jantung, diseksi aorta
 - 3) Ginjal: oliguria, peningkatan kreatinin
 - 4) Mata: papiledema, gangguan penglihatan akut

6. Algoritma Tindakan Hipertensi Emergensi

- a. Identifikasi Gejala dan Tanda Klinis
 - 1) Tekanan darah $\geq$ 180/120 mmHg dengan atau tanpa gejala end-organ damage
 - 2) Gejala: nyeri dada, sesak napas, gangguan penglihatan, pusing berat, penurunan kesadaran
- b. Penilaian Primer dan Vital Sign
 - 1) Monitor tekanan darah setiap 5-15 menit
 - 2) Pantau nadi, pernapasan, dan tingkat kesadaran (GCS)
 - 3) Evaluasi gejala end-organ damage seperti EKG, fungsi ginjal, dan status neurologis
- c. Intervensi Awal
 - 1) Pastikan jalur IV terbuka
 - 2) Berikan oksigen jika SpO₂ < 92%
 - 3) Kolaborasi pemberian antihipertensi intravena (nitroprusside, labetalol, nicardipine) sesuai instruksi medis
- d. Pemantauan Intensif
 - 1) Observasi tanda vital setiap 15 menit
 - 2) Evaluasi efek samping terapi (hipotensi mendadak, bradikardia, dll)
 - 3) Pantau urine output, status neurologis, dan tanda perbaikan kondisi
- e. Edukasi dan Dokumentasi
 - 1) Edukasi keluarga/pasien tentang bahaya hipertensi emergensi
 - 2) Dokumentasi lengkap: waktu kejadian, intervensi, respon pasien
 - 3) Siapkan rujukan ke ICU atau ruang rawat khusus bila diperlukan

7. Peran dan Tindakan Keperawatan

- a. Pengkajian Awal:

- 1) Cek tekanan darah dengan teknik yang benar
- 2) Identifikasi tanda kerusakan organ target
- 3) Kaji status neurologis dan perfusi perifer
- b. Monitoring Intensif:
 - 1) TD tiap 5–15 menit
 - 2) Status kesadaran (GCS), urine output, EKG
 - 3) Observasi efek samping terapi antihipertensi
- c. Intervensi Kolaboratif:
 - 1) Persiapan dan pemberian obat IV sesuai instruksi medis
 - 2) Posisi semi-Fowler jika sesak
 - 3) Edukasi singkat pada pasien dan keluarga
- d. Dukungan Psikologis:
 - 1) Reduksi kecemasan karena TD tinggi dapat dipengaruhi stres
 - 2) Hindari stimulasi emosional tambahan

8. SOP Keperawatan: Manajemen Hipertensi Emergensi

Tujuan:

Menurunkan tekanan darah secara aman untuk mencegah komplikasi organ target.

Langkah-langkah Tindakan:

- a. Pengkajian Awal:
 - 1) Ukur TD kedua lengan
 - 2) Identifikasi gejala neurologis, nyeri dada, sesak, gangguan visual
- b. Persiapan:
 - 1) Pasang monitor jantung, jalur IV, dan oksigen bila perlu
 - 2) Siapkan obat antihipertensi IV sesuai protokol
- c. Pemberian Terapi:
 - 1) Nicardipine IV: 5–15 mg/jam (titrasi)
 - 2) Labetalol IV bolus atau infus
 - 3) Nitroprusside IV untuk kasus berat seperti diseksi aorta
- d. Pemantauan & Evaluasi:
 - 1) TD tiap 5–15 menit selama 1 jam pertama
 - 2) Cek kesadaran, urine output
 - 3) Evaluasi gejala target organ
- e. Dokumentasi:
 - 1) TD awal, terapi yang diberikan, respons klinis
 - 2) Komunikasi lintas profesi (SBAR)

9. Dokumentasi Keperawatan (SOAP)

S: Pasien mengeluh sakit kepala berat dan penglihatan kabur sejak 2 jam lalu.

O: TD 210/120 mmHg, HR 92x/mnt, RR 20x/mnt, SpO₂ 97%, GCS 15, kreatinin meningkat.

A: Risiko perfusi serebral tidak efektif r/t peningkatan tekanan darah akut

P: Pasang monitor, kolaborasi Labetalol IV, observasi GCS dan TD tiap 15 menit, dokumentasi reaksi pasien

E. Dokumentasi dan Evaluasi Asuhan Keperawatan Kardiovaskular

Dalam praktik keperawatan profesional, dokumentasi dan evaluasi merupakan dua komponen utama dari proses keperawatan yang tidak hanya menunjukkan kontinuitas asuhan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan klinis dan bukti pertanggungjawaban praktik. Dokumentasi keperawatan yang akurat dan sistematis berfungsi sebagai catatan komunikasi antar tim kesehatan, alat untuk memantau perkembangan kondisi pasien, serta sumber data untuk evaluasi mutu pelayanan. Sementara itu, evaluasi memungkinkan perawat untuk menilai efektivitas intervensi yang telah diberikan, mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan rencana tindakan, serta mengarahkan perencanaan keperawatan berikutnya secara lebih tepat. Dalam konteks gangguan kardiovaskular, dokumentasi dan evaluasi memiliki peran penting dalam mendeteksi perubahan klinis secara dini yang dapat menyelamatkan nyawa pasien. Misalnya, pencatatan data vital seperti tekanan darah, laju napas, denyut nadi, saturasi oksigen, dan EKG secara berkala memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi tanda-tanda dekompensasi jantung atau aritmia secara cepat. Selain itu, evaluasi terhadap respon pasien terhadap terapi, seperti: pemberian oksigen, diuretik, atau manuver posisi, juga harus didokumentasikan secara sistematis agar dapat memberikan gambaran progresif terhadap kondisi pasien.

1. Tujuan Dokumentasi Keperawatan

- Mencatat kronologis kejadian dan intervensi
- Menjamin kontinuitas asuhan secara multidisiplin
- Menjadi bukti legal dalam penanganan kegawatdaruratan
- Menyediakan data untuk evaluasi, audit, dan penelitian klinis

2. Prinsip Dokumentasi Berbasis Evidence-Based

- Lengkap, akurat, objektif, tepat waktu
- Menggunakan format SOAP/SOAPIE/NANDA-NOC-NIC

3. Elemen Dokumentasi Penting

- TTV dan hasil pemantauan berkala (EKG, saturasi, urine output)
- Respons terhadap intervensi (misalnya respons nyeri pasca nitrat)

- c. Kolaborasi tindakan medis dan keperawatan
- d. Komunikasi antar profesi yang terdokumentasi

4. Evaluasi Keberhasilan Asuhan

- a. Parameter klinis: stabilisasi hemodinamik, penurunan nyeri dada, perbaikan saturasi
- b. Parameter laboratorium: normalisasi troponin, penurunan kreatinin, dsb.
- c. Evaluasi kepuasan pasien dan keluarga
- d. Refleksi keperawatan untuk perbaikan mutu layanan

5. Format Dokumentasi yang Direkomendasikan

Berikut adalah format dokumentasi berbasis pendekatan ilmiah dan praktik klinis:

- a. Format SOAP/SOAPIE
 - **S (Subjective):** Keluhan pasien (misal: nyeri dada, sesak)
 - **O (Objective):** Hasil pemeriksaan (TTV, EKG, saturasi)
 - **A (Assessment):** Diagnosa keperawatan (misal: perfusi jaringan tidak efektif)
 - **P (Plan):** Rencana dan tindakan intervensi
 - **I (Intervention):** Tindakan nyata yang diberikan
 - **E (Evaluation):** Respons pasien terhadap intervensi
- b. Format DAR (Data – Action – Response)

Alternatif untuk pencatatan progres keperawatan secara real time.

6. Komponen Penting Dokumentasi Kardiovaskular

Komponen	Contoh Catatan Klinis
Keluhan utama	"Nyeri dada menjalar ke lengan kiri sejak 1 jam lalu"
TTV lengkap	TD 160/100 mmHg, HR 110 x/mnt, RR 24 x/mnt, SpO ₂ 92%
EKG & Penunjang	"ST elevasi pada lead II, III, aVF. Troponin I: 2.1 ng/mL"
Intervensi	"Berikan oksigen 4L/min, kolaborasi aspirin 160 mg PO"
Evaluasi	"Nyeri turun jadi skala 3/10, pasien tampak lebih tenang"

7. Algoritma Evaluasi Keberhasilan Asuhan

- a. Langkah 1: Identifikasi Tujuan Asuhan (Expected Outcomes / NOC)

Tujuan keperawatan harus spesifik, terukur, realistis, dan terbatas waktu, misalnya:

"Setelah 8 jam intervensi, pasien menunjukkan saturasi oksigen > 94%."

"Setelah 2 hari, edema ekstremitas berkurang (+1), BB stabil."
- b. Langkah 2: Kumpulkan Data Hasil (Data Evaluasi)

Bandingkan data objektif & subjektif dengan kriteria hasil (NOC):

Data objektif: vital sign, EKG, auskultasi jantung, BB, I/O cairan.

Data subjektif: keluhan sesak, nyeri, kelelahan, kecemasan pasien.

Apakah data menunjukkan perbaikan sesuai tujuan?

YA → Lanjut ke Langkah 3a

TIDAK atau hanya sebagian → Lanjut ke Langkah 3b

c. Langkah 3a: Tujuan Tercapai (Evaluasi Positif)

Dokumentasikan keberhasilan secara jelas dan lengkap:

"Tujuan keperawatan tercapai: RR 20x/menit, SPO2 96%, pasien tampak nyaman."

Tindakan Selanjutnya:

- 1) Pertahankan intervensi yang efektif
- 2) Mulai terminasi/pelepasan intervensi secara bertahap
- 3) Dokumentasikan keberhasilan di format evaluasi (SOAP-E / DAPIE)

d. Langkah 3b: Tujuan Tidak Tercapai / Sebagian

Identifikasi penyebab ketidaktercapaian:

- 1) Apakah intervensi tidak tepat?
- 2) Apakah ada perubahan kondisi medis mendadak?
- 3) Apakah pasien tidak kooperatif atau kurang edukasi?

e. Tindakan Selanjutnya:

- 1) Revaluasi diagnosa keperawatan
- 2) Modifikasi rencana keperawatan (intervensi dan waktu)
- 3) Lakukan edukasi tambahan jika perlu
- 4) Kolaborasi lanjutan dengan tim medis
- 5) Kembali ke **Langkah 2** setelah intervensi disesuaikan

f. Langkah 4: Dokumentasi Akhir

Gunakan format evaluasi yang sistematis (misal: SOAPIE, DAPE, atau evaluasi berbasis NOC):

S: Pasien menyatakan sesak berkurang.

O: RR 20x/menit, SPO2 95%, edema (+1).

A: Tujuan tercapai sebagian.

P: Intervensi dilanjutkan dengan penyesuaian.

I: Posisi semi-Fowler, edukasi diet, kolaborasi diuretik.

E: Evaluasi selanjutnya 6 jam ke depan.

Catatan Penting:

- 1) Evaluasi dilakukan berulang dan berbasis waktu.
- 2) Keberhasilan asuhan ditentukan oleh kesesuaian hasil terhadap tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Evaluasi bersifat dinamis, menyesuaikan perubahan kondisi pasien.

8. SOP Keperawatan: Dokumentasi dan Evaluasi Kardiovaskular

Tujuan:

Memastikan tercatatnya seluruh intervensi dan respons pasien secara sistematis untuk menjamin mutu dan kontinuitas layanan.

Langkah-langkah:

- a. Persiapan:
 - 1) Pastikan alat dokumentasi (rekam medis manual/digital) siap
 - 2) Gunakan format yang telah distandardisasi (SOAP/SOAPIE/DAR)
- b. Pengisian Data:
 - 1) Catat waktu, keluhan, dan hasil pengkajian awal
 - 2) Dokumentasikan hasil EKG, lab, dan penilaian klinis
- c. Catatan Intervensi dan Respons:
 - 1) Tindakan yang dilakukan, obat yang diberikan, kolaborasi
 - 2) Respons pasien terhadap tindakan (misal: nyeri berkurang)
- d. Evaluasi dan Tindak Lanjut:
 - 1) Bandingkan kondisi pre dan post-intervensi
 - 2) Dokumentasikan jika perlu tindakan tambahan atau rujukan
- e. Handover dan Pelaporan:
 - 1) Gunakan format SBAR untuk komunikasi tim
 - 2) Pastikan dokumentasi lengkap saat serah terima jaga

9. Contoh Dokumentasi Keperawatan (SOAPIE)

S: Pasien mengeluh sesak dan nyeri dada skala 8/10.

O: TD 180/100 mmHg, HR 120x/mnt, RR 28x/mnt, SpO₂ 91%. EKG: ST elevasi di V2–V4.

A: Risiko perfusi jaringan tidak efektif

P: Pasang oksigen, kolaborasi pemberian aspirin 160 mg, nitrat SL

I: Tindakan dilakukan sesuai protokol MONA

E: Nyeri berkurang jadi 3/10, SpO₂ naik jadi 96%, pasien tampak lebih tenang

10. Peran Perawat dalam Evaluasi Kardiovaskular

- a. Menilai efektivitas tindakan dan memutuskan keberlanjutan terapi
- b. Menyampaikan perkembangan pasien secara tertulis dan verbal
- c. Menjadi jembatan antara data objektif dan klinis untuk DPJP

F. Simpulan

Kegawatdaruratan kardiovaskular, seperti infark miokard akut (IMA), gagal jantung akut (GJA), dan hipertensi emergensi, merupakan kondisi kritis yang menjadi penyebab utama kematian mendadak dan memerlukan penanganan segera, tepat, dan sistematis di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ketiga kondisi ini ditandai oleh gangguan mendadak pada sistem kardiovaskular yang, jika tidak ditangani dengan cepat, dapat menyebabkan kerusakan organ permanen bahkan kematian.

Perawat gawat darurat memiliki peran vital dalam mendeteksi dini dan melakukan intervensi awal berdasarkan protokol klinis berbasis bukti (Evidence-Based Practice). Dalam kasus IMA, perawat dituntut melakukan pengkajian nyeri dada dengan pendekatan PQRST, melakukan EKG 12 sadapan dalam waktu kurang dari 10 menit, serta menginisiasi terapi awal seperti aspirin, nitrogliserin, dan oksigen bila diperlukan. Klasifikasi STEMI dan NSTEMI memandu keputusan terapeutik berdasarkan tingkat obstruksi arteri koroner.

Sementara itu, pada gagal jantung akut, perawat harus mampu mengenali profil hemodinamik pasien (warm/cold dan wet/dry), memberikan intervensi seperti posisi semi-Fowler, pemberian oksigen, diuretik, vasodilator, serta melakukan monitoring ketat terhadap tanda vital dan status cairan. Kolaborasi dengan tim medis dalam pemberian inotropik dan terapi lanjutan menjadi bagian integral dari penatalaksanaan.

Hipertensi emergensi memerlukan pengenalan cepat terhadap tanda-tanda kerusakan organ target dan penurunan tekanan darah secara terkendali menggunakan obat-obatan intravena seperti labetalol atau nicardipine. Monitoring tekanan darah setiap 5–15 menit, pengkajian neurologis, dan dukungan psikologis turut menjadi aspek penting dalam asuhan keperawatan pasien dengan kondisi ini.

Di seluruh rangkaian penatalaksanaan tersebut, dokumentasi dan evaluasi merupakan fondasi penting. Dokumentasi akurat dan sistematis menggunakan format seperti SOAP atau DAR menjadi alat komunikasi antarprofesi, bukti legal, dan sumber evaluasi mutu pelayanan. Evaluasi asuhan keperawatan yang dilakukan secara berkala berdasarkan indikator klinis (misalnya, stabilisasi hemodinamik, penurunan nyeri dada, peningkatan saturasi oksigen) memastikan keberhasilan intervensi dan memberikan dasar kuat untuk modifikasi tindakan ke depan.

Dengan pemahaman menyeluruh, keterampilan teknis, dan koordinasi multidisiplin yang baik, perawat gawat darurat dapat memberikan kontribusi besar dalam menurunkan mortalitas, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien dengan gangguan kardiovaskular akut. Bab ini sekaligus menjadi pedoman praktis dan akademik yang memperkuat

profesionalisme perawat dalam menghadapi tantangan klinis di lini terdepan pelayanan kesehatan darurat.

G. Referensi

- Agustini, N. L. P. I. B., Budiarsana, I. P., Artawan, I. K., & Dewi, N. P. A. R. (2024). Influence of High-Fidelity Manikin-Based Simulation on Nursing Students' Basic Cardiac Life Support Ability and Motivation. *Babali Nursing Research*, 5(2), 334-345. <https://doi.org/https://doi.org/10.37363/bnr.2024.52364>
- American Heart Association. (2020). 2020 AHA Guidelines for cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. *Circulation*, 142, S357-S966.
- Ayyad, M., Albandak, M., Gala, D., Alqeeq, B., Baniowda, M., Pally, J., & Allencherril, J. (2025). Reevaluating STEMI: The Utility of the Occlusive Myocardial Infarction Classification to Enhance Management of Acute Coronary Syndromes. *Current Cardiology Reports*, 27(1), 1-12. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11886-025-02217-8>
- Balahura, A.-M., Moroi, Ş.-I., Scafa-Udrişte, A., Weiss, E., Japie, C., Bartoş, D., & Bădilă, E. (2022). The Management of Hypertensive Emergencies—Is There a “Magical” Prescription for All? *Journal of clinical medicine*, 11(11), 3138. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/jcm11113138>
- de Alencar Neto, J. N., & De Alencar, J. N. (2018). Morphine, oxygen, nitrates, and mortality reducing pharmacological treatment for acute coronary syndrome: an evidence-based review. *Cureus*, 10(1). <https://doi.org/DOI:10.7759/cureus.2114>
- Fraser, M., Barnes, S. G., Barsness, C., Beavers, C., Bither, C. J., Boettger, S., Hallman, C., Keleman, A., Leckliter, L., & Mcilvennan, C. K. (2024). Nursing care of the patient hospitalized with heart failure: A scientific statement from the American Association of Heart Failure Nurses. *Heart & Lung*, 64, e1-e16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hrtlng.2024.01.007>
- Geniş, M., & Deveci, B. (2024). A Clinical Evaluation of Cardiovascular Emergencies: A Comparison of Responses from ChatGPT, Emergency Physicians, and Cardiologists. *Diagnostics*, 14(23), 2731. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/diagnostics14232731>

- Klemet, D., Grahf, D. C., & Vohra, T. T. (2024). Blood pressure management in cardiovascular emergencies: an evidence-based approach. *AME Medical Journal*, 9. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.21037/amj-23-19>.
- Mattia, A., Mariell, J., Wilfried, M., Nosheen, R., Shah, A. M., Sliwa, K., & Alexandre, M. (2020). Acute heart failure (Primer). *Nature Reviews. Disease Primers*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41572-020-0151-7>
- Miller, J. B., Hrabec, D., Krishnamoorthy, V., Kinni, H., & Brook, R. D. (2024). Evaluation and management of hypertensive emergency. *bmj*, 386. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1136/bmj.2023.077205>
- Sharp, C., & Webster, C. A. (2025). Prehospital pharmacological interventions in acute coronary syndrome. *Journal of Paramedic Practice*, 17(4), 152-157. <https://doi.org/https://doi.org/10.12968/jpar.2025.001>
- World Health Organization. (2024). Cardiovascular Diseases (CVDs) 2024. Retrieved 27 Juli from [https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-\(cvds\)](https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds))

H. Glosarium

Istilah	Definisi
Angina Pektoris	Nyeri dada akibat iskemia miokard karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen jantung.
Aritmia	Gangguan irama jantung, dapat berupa irama yang terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur.
Asidosis Metabolik	Penurunan pH darah akibat peningkatan asam atau kehilangan bikarbonat, sering terjadi pada kondisi syok.
Bradikardia	Irama jantung yang lebih lambat dari normal, yakni di bawah 60 denyut per menit.
Cardiac Output	Volume darah yang dipompa jantung per menit; dihitung dari denyut jantung × volume sekuncup.
CPR (Resusitasi Jantung Paru)	Tindakan penyelamatan hidup berupa kompresi dada dan bantuan napas buatan untuk menangani henti jantung.

Istilah	Definisi
Defibrilasi	Prosedur memberikan kejutan listrik ke jantung untuk mengembalikan irama normal, biasanya pada fibrilasi ventrikel.
Diseksi Aorta	Robekan pada lapisan dalam aorta yang memungkinkan darah masuk ke dinding aorta, menyebabkan nyeri hebat dan risiko kematian tinggi.
Edema Paru Akut	Akumulasi cairan di paru-paru akibat gagal jantung kiri, menyebabkan sesak napas berat dan mendadak.
Ejection Fraction	Persentase darah yang dipompa dari ventrikel kiri setiap kontraksi; indikator penting fungsi pompa jantung.
Fibrilasi Ventrikel	Irama jantung yang kacau dan cepat dari ventrikel, menyebabkan henti jantung mendadak bila tidak segera diatasi.
Gagal Jantung Kongestif	Ketidakmampuan jantung memompa darah secara efektif, menyebabkan kongesti di paru dan jaringan.
Henti Jantung	Keadaan ketika jantung berhenti memompa darah secara efektif, sehingga mengancam jiwa secara langsung.
Hipertensi Emergensi	Kenaikan tekanan darah $\geq 180/120$ mmHg disertai kerusakan organ target, seperti otak, ginjal, atau jantung.
Iskemia Miokard	Kondisi kekurangan oksigen pada otot jantung akibat penyempitan atau sumbatan arteri koroner.
Kateterisasi Jantung	Prosedur invasif untuk melihat struktur dan aliran darah jantung menggunakan kateter yang dimasukkan melalui pembuluh darah.
MI (Infark Miokard)	Kematian jaringan otot jantung akibat sumbatan arteri koroner, dikenal sebagai serangan jantung.
NSTEMI	Infark miokard tanpa elevasi segmen ST pada EKG, namun dengan peningkatan enzim jantung.
Oksigenasi	Proses penyaluran dan peningkatan oksigen dalam darah untuk mendukung fungsi sel.
Perikarditis	Peradangan pada lapisan perikardium yang menyelubungi jantung, dapat menyebabkan nyeri dada.

Istilah	Definisi
Respon Cepat	Tindakan cepat oleh tim medis untuk merespons penurunan tanda vital pasien sebelum terjadi henti jantung.
STEMI	Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST pada EKG; menunjukkan sumbatan total arteri koroner.
Syok Kardiogenik	Syok akibat gangguan pompa jantung, biasanya setelah infark miokard masif.
Takikardia Ventrikel	Irama jantung cepat yang berasal dari ventrikel, dapat mengancam jiwa jika tidak segera dikoreksi.
Tamponade Jantung	Tekanan berlebih dari cairan di ruang perikardium yang menghambat fungsi jantung dan mengancam jiwa.
Triage	Proses penentuan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatan klinis.
Vasopressor	Obat-obatan yang digunakan untuk meningkatkan tekanan darah dengan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah.

CHAPTER 4

PENANGANAN PASIEN DENGAN TRAUMA AKUT

Friska Ernita Sitorus, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Trauma akut merupakan kondisi cedera fisik yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga, yang disebabkan oleh berbagai mekanisme seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, benturan keras, tindakan kekerasan, maupun bencana alam. Trauma akut umumnya mengakibatkan kerusakan jaringan atau organ tubuh, yang jika tidak segera mendapatkan penanganan medis, dapat menyebabkan komplikasi serius, kecacatan permanen, bahkan kematian. Kondisi trauma akut dapat melibatkan berbagai organ dan sistem tubuh, seperti sistem saraf, kardiovaskuler, respirasi, muskuloskeletal, maupun gastrointestinal. Hal ini menyebabkan manajemen trauma akut menjadi kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin serta terstruktur untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan penanganan yang optimal sesuai kebutuhan medisnya.

Secara konseptual, trauma akut berbeda dari kondisi trauma kronis yang biasanya berkembang secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Trauma akut memiliki ciri khas berupa onset cedera yang mendadak, dengan kondisi klinis yang cenderung berubah cepat dalam waktu singkat. Oleh karena itu, penanganan trauma akut harus dilakukan sesegera mungkin setelah pasien mengalami cedera. Konsep utama dalam penanganan trauma akut didasarkan pada pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan terstandarisasi, seperti yang telah disusun dalam protokol Advanced Trauma Life Support (ATLS). Pendekatan ini meliputi tahapan-tahapan utama yaitu survei primer dan sekunder, resusitasi awal, serta penilaian dan tindakan medis lanjutan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pasien dapat ditangani secara komprehensif dan efisien.

Di Indonesia, trauma akut menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan, yang memberikan kontribusi besar terhadap angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Menurut data epidemiologi terbaru, trauma akut merupakan salah satu penyebab utama kematian pada kelompok usia produktif, terutama akibat kecelakaan lalu lintas yang menempati urutan tinggi sebagai penyebab cedera. Selain itu, kejadian trauma akut di Indonesia juga dipengaruhi oleh tingginya angka kecelakaan kerja, jatuh dari ketinggian, kekerasan fisik, serta bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa angka kejadian trauma akut terus meningkat setiap tahun seiring dengan

bertambahnya jumlah kendaraan, intensitas aktivitas fisik masyarakat, serta kurangnya kesadaran akan keselamatan dalam berbagai kegiatan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mengelola trauma akut secara efektif. Tingginya insiden trauma akut menyebabkan beban pelayanan kesehatan menjadi semakin berat, terutama di instalasi gawat darurat (IGD) rumah sakit. Hal ini menuntut penyedia layanan kesehatan di Indonesia, khususnya tenaga medis seperti dokter dan perawat, untuk selalu meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam menangani pasien dengan trauma akut. Di sisi lain, keterbatasan sarana dan prasarana, jumlah tenaga medis yang tidak merata, serta sistem rujukan yang belum optimal turut memperberat tantangan dalam pengelolaan trauma akut di Indonesia.

Dalam penanganan trauma akut, waktu adalah faktor yang sangat menentukan. Konsep "golden period" atau periode emas dalam trauma akut menekankan pentingnya pemberian tindakan medis segera dalam waktu kurang dari satu jam sejak terjadinya cedera. Penanganan cepat dan tepat selama periode emas ini terbukti secara signifikan mampu meningkatkan peluang hidup pasien, mencegah komplikasi serius, serta mengurangi risiko kecacatan permanen. Dalam kondisi trauma akut yang parah, keterlambatan penanganan dalam hitungan menit saja dapat menjadi perbedaan antara hidup dan mati. Oleh karena itu, kesiapan tenaga medis dalam melakukan evaluasi awal serta kemampuan mereka dalam mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat menjadi kunci utama dalam keberhasilan penanganan pasien trauma akut.

Selain itu, pentingnya penanganan cepat pada trauma akut juga terkait dengan aspek psikologis pasien dan keluarganya. Trauma akut umumnya menimbulkan kondisi panik, cemas, atau bahkan histeria baik pada pasien maupun keluarganya. Dalam situasi seperti ini, keberadaan tenaga medis yang terlatih, sigap, serta mampu memberikan penanganan secara cepat akan membantu mengurangi kecemasan dan memberikan rasa tenang kepada pasien dan keluarganya. Penanganan trauma akut yang cepat, sistematis, dan profesional akan meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarga terhadap layanan kesehatan yang diberikan, serta mengurangi risiko konflik atau ketidakpuasan akibat persepsi lambatnya pelayanan.

Secara keseluruhan, penanganan pasien dengan trauma akut bukanlah sekadar pemberian pertolongan medis semata, tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan komprehensif yang dimulai dari pemahaman tentang definisi dan konsep dasar trauma akut, pengenalan terhadap pola epidemiologi trauma akut yang ada di masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya tindakan cepat, tepat, dan terstruktur dalam menghadapi kondisi trauma. Dengan adanya pemahaman yang mendalam

tentang berbagai aspek penting dalam penanganan trauma akut ini, diharapkan tenaga medis mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi pasien trauma, sehingga dapat menurunkan angka mortalitas, mengurangi tingkat kecacatan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien trauma akut di Indonesia.

B. Mekanisme dan Klasifikasi Trauma

Dalam penanganan pasien trauma akut, pemahaman terhadap mekanisme dan klasifikasi cedera merupakan dasar yang sangat penting dalam menentukan strategi penanganan, prediksi cedera yang mungkin terjadi, serta langkah-langkah intervensi yang tepat. Mekanisme cedera merupakan proses atau peristiwa fisik yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan jaringan atau organ tubuh seseorang, sedangkan klasifikasi trauma memberikan panduan klinis tentang derajat keparahan cedera, sehingga tenaga medis mampu memberikan respon klinis yang sesuai dengan kondisi pasien.

1. Mekanisme Cedera pada Pasien Trauma Akut

Dalam praktik klinis, mekanisme cedera secara umum dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu trauma tumpul (blunt trauma), trauma tembus (penetrating trauma), dan trauma akibat ledakan (blast injury).

Trauma Tumpul (Blunt Trauma) adalah cedera yang disebabkan oleh kekuatan tumpul atau benda tumpul yang mengenai tubuh pasien dengan energi yang cukup tinggi. Trauma jenis ini sering kali terjadi pada kecelakaan kendaraan bermotor, jatuh dari ketinggian, benturan benda keras, atau pukulan kuat pada tubuh seseorang. Ciri khas trauma tumpul adalah kerusakan jaringan internal yang mungkin tidak segera terlihat secara eksternal. Pasien mungkin tidak mengalami luka terbuka yang nyata, namun mengalami cedera organ dalam yang cukup parah, seperti cedera paru-paru, patah tulang, perdarahan internal, cedera kepala tertutup, atau trauma pada organ-organ abdomen. Akibat dari trauma ini sering sulit dideteksi di tahap awal, sehingga diperlukan evaluasi klinis yang cermat serta pemeriksaan diagnostik seperti pencitraan (radiologi, USG, atau CT scan) untuk mendeteksi cedera internal secara akurat.

Trauma Tembus (Penetrating Trauma) terjadi ketika benda tajam atau peluru menembus tubuh pasien, menyebabkan kerusakan jaringan secara langsung dan nyata. Trauma tembus umum terjadi akibat tusukan pisau, tertusuk benda tajam lainnya, atau luka tembak. Karakteristik cedera ini sangat jelas berupa luka terbuka, namun kompleksitas kerusakan jaringan internal sangat tergantung pada jalur benda tajam atau proyektil tersebut di dalam tubuh. Cedera jenis ini sangat berisiko karena dapat menembus dan merusak organ vital seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah besar, hati, ginjal, atau usus. Penanganan trauma

tembus memerlukan pendekatan cepat berupa kontrol perdarahan aktif, pencegahan kontaminasi, serta tindakan bedah segera untuk mengatasi kerusakan organ yang terjadi.

Trauma Ledakan (Blast Injury) merupakan cedera yang terjadi akibat paparan gelombang kejut dan tekanan tinggi dari ledakan, yang biasanya terjadi pada kondisi perang, ledakan bom, maupun bencana industri. Cedera akibat ledakan ini sangat kompleks, karena melibatkan berbagai mekanisme cedera sekaligus. Ada cedera akibat tekanan gelombang ledakan (cedera primer), cedera akibat serpihan atau benda yang terlontar oleh ledakan (cedera sekunder), cedera akibat benturan tubuh korban dengan objek lain akibat dorongan ledakan (cedera tersier), serta cedera akibat paparan panas, asap, atau bahan kimia (cedera kuarternier). Pasien yang mengalami trauma ledakan sering kali mengalami kombinasi cedera paru-paru, cedera telinga bagian dalam, cedera otak traumatik, luka bakar, cedera jaringan lunak, serta patah tulang multipel. Penanganan pasien dengan trauma ledakan memerlukan penilaian menyeluruh yang dilakukan secara sistematis dan multidisiplin.

2. Klasifikasi Trauma Berdasarkan Keparahan

Setelah memahami mekanisme cedera, tenaga medis perlu mengklasifikasikan tingkat keparahan trauma untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya. Secara umum, klasifikasi trauma dibagi menjadi tiga kategori: trauma ringan, sedang, dan berat.

Trauma Ringan adalah kondisi cedera yang umumnya tidak menyebabkan gangguan fungsi organ secara signifikan, dan biasanya dapat sembuh dengan intervensi medis minimal. Contoh trauma ringan adalah memar, luka lecet superfisial, luka robek kecil yang tidak memerlukan jahitan, atau cedera jaringan lunak ringan lainnya. Penanganan trauma ringan umumnya mencakup perawatan luka sederhana, pemberian analgetik, serta edukasi terhadap pasien untuk pemantauan mandiri.

Trauma Sedang melibatkan cedera yang menimbulkan gangguan fungsi organ atau jaringan secara moderat namun tidak langsung mengancam nyawa. Contoh trauma sedang misalnya patah tulang tertutup, dislokasi sendi yang tidak disertai cedera vaskuler atau neurologis, luka robek dalam yang memerlukan jahitan, atau cedera kepala ringan sampai sedang (seperti gegar otak ringan hingga sedang). Penanganan trauma sedang biasanya melibatkan stabilisasi kondisi pasien, pemeriksaan radiologi atau laboratorium untuk memastikan tidak ada cedera internal yang serius, serta tindakan definitif berupa pemasangan gips, jahitan luka, atau observasi intensif selama periode tertentu.

Trauma Berat merupakan cedera serius yang mengancam nyawa pasien dan memerlukan penanganan medis segera, terstruktur, dan multidisiplin. Trauma berat mencakup cedera kepala berat, perdarahan internal masif, cedera organ vital seperti paru-paru atau jantung, patah tulang multipel, luka bakar luas, serta cedera kompleks akibat trauma tembus atau trauma ledakan. Pasien trauma berat sering kali datang dalam kondisi syok, gangguan pernapasan, atau gangguan kesadaran yang signifikan. Penanganan trauma berat mencakup stabilisasi jalan napas (airway), ventilasi, kontrol perdarahan aktif, pemberian resusitasi cairan intensif, serta tindakan bedah darurat. Pasien ini biasanya ditangani di fasilitas trauma level tinggi atau di unit resusitasi yang dilengkapi fasilitas dan tim medis khusus.

3. Penilaian Risiko Cedera pada Pasien Trauma Akut

Dalam menangani pasien trauma akut, tenaga medis tidak hanya mengandalkan penilaian visual atau fisik semata, tetapi juga menggunakan penilaian risiko yang sistematis. Penilaian risiko cedera bertujuan untuk memperkirakan potensi cedera internal atau komplikasi tersembunyi berdasarkan mekanisme trauma, kondisi klinis pasien, usia, komorbiditas yang ada, serta hasil pemeriksaan penunjang awal.

Penilaian risiko ini melibatkan survei primer dan sekunder, yaitu penilaian awal berupa Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (fungsi neurologis), dan Exposure (pemeriksaan fisik secara menyeluruh). Setelah survei primer selesai, dilanjutkan dengan survei sekunder berupa pemeriksaan rinci dari kepala hingga kaki, serta pemeriksaan penunjang diagnostik seperti foto rontgen, USG abdomen, CT scan, atau laboratorium yang diperlukan sesuai kondisi pasien.

Dalam praktik klinis, sering kali digunakan alat bantu seperti Revised Trauma Score (RTS), Injury Severity Score (ISS), atau Glasgow Coma Scale (GCS) untuk membantu tenaga medis dalam memperkirakan tingkat keparahan cedera pasien, menentukan prognosis, serta mengarahkan strategi penanganan lebih lanjut. Penilaian risiko yang akurat membantu tenaga medis dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat, melakukan rujukan ke fasilitas yang lebih memadai jika diperlukan, serta mencegah keterlambatan penanganan yang bisa berakibat fatal.

Dengan memahami mekanisme trauma secara mendalam, mengklasifikasikan tingkat keparahan cedera secara tepat, serta melakukan penilaian risiko cedera secara sistematis, tenaga medis dapat memberikan pelayanan trauma akut yang lebih optimal, efektif, dan mampu mengurangi risiko kematian maupun komplikasi serius pada pasien.

C. Prinsip Umum Penanganan Trauma Akut

Trauma akut merupakan kondisi medis kritis yang sering kali menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas, terutama pada usia produktif. Penanganan trauma akut tidak hanya berorientasi pada tindakan medis semata, tetapi juga melibatkan prinsip-prinsip khusus yang terstruktur, sistematis, serta telah teruji secara klinis untuk memastikan pasien mendapat penanganan yang optimal. Salah satu pendekatan yang diakui secara global dalam penanganan trauma akut adalah prinsip ATLS (Advanced Trauma Life Support) yang dikembangkan oleh American College of Surgeons (ACS).

1. Pendekatan Sistematis dalam Manajemen Trauma (Prinsip ATLS)

Prinsip ATLS merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan secara internasional dalam penanganan pasien trauma akut. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan pedoman yang jelas, terstruktur, dan sistematis bagi tenaga kesehatan, mulai dari tahap awal ketika pasien tiba di Instalasi Gawat Darurat hingga tahap definitif, sehingga pasien dapat ditangani secara cepat, efisien, dan efektif. Pendekatan ATLS menekankan pentingnya penilaian klinis yang cepat, identifikasi dan pengelolaan cedera yang mengancam jiwa terlebih dahulu, serta penentuan prioritas tindakan secara objektif berdasarkan derajat urgensi cedera pasien.

Pendekatan sistematis ATLS mencakup dua langkah utama yang harus dilakukan secara bertahap, yaitu penilaian primer (primary survey) dengan pendekatan ABCDE, diikuti penilaian sekunder (secondary survey), serta tindakan resusitasi awal yang terintegrasi dalam penanganan primer pasien.

2. Penilaian Primer (Primary Survey: ABCDE Approach)

Penilaian primer merupakan tahap pertama yang sangat krusial dalam penanganan pasien trauma akut. Pada tahap ini, tujuan utama adalah mengidentifikasi dan segera mengatasi masalah yang mengancam nyawa pasien dalam hitungan detik hingga menit setelah kedatangan pasien di fasilitas kesehatan. Pendekatan yang digunakan dalam penilaian primer dikenal dengan istilah ABCDE, yaitu Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (gangguan neurologis), serta Exposure (penilaian menyeluruh tubuh pasien).

Airway (A) merupakan langkah awal paling penting dalam penanganan trauma akut. Petugas medis harus memastikan bahwa jalan napas pasien terbuka dan bebas dari obstruksi. Pada pasien trauma akut, jalan napas dapat terganggu akibat perdarahan, benda asing, edema, fraktur wajah atau leher, serta penurunan kesadaran. Penanganan awal dapat berupa pemasangan jalan napas tambahan

seperti intubasi endotrakeal, pemberian oksigen, atau manuver khusus seperti jaw thrust dan chin lift tanpa ekstensi leher, terutama bila dicurigai cedera servikal.

Breathing (B) selanjutnya melibatkan evaluasi terhadap fungsi pernapasan pasien. Tim medis harus mengevaluasi apakah pasien mampu bernapas dengan baik atau mengalami gangguan pernapasan seperti pneumotoraks tegang, hemotoraks, cedera paru-paru berat, atau kontusio paru. Penilaian dilakukan dengan mendengar suara napas, observasi ekspansi dada, serta evaluasi saturasi oksigen. Intervensi awal pada gangguan pernapasan dapat berupa dekompresi segera pada pneumotoraks, pemasangan selang dada (chest tube), dan pemberian oksigenasi yang cukup.

Circulation (C) berkaitan dengan evaluasi sistem sirkulasi pasien, terutama untuk mendeteksi dan mengelola perdarahan aktif yang merupakan penyebab utama syok hipovolemik pada pasien trauma. Petugas medis perlu segera melakukan kontrol perdarahan eksternal yang aktif melalui tekanan langsung atau pemasangan torniket, serta melakukan evaluasi terhadap tanda-tanda syok seperti hipotensi, denyut nadi cepat, kulit dingin dan lembab, serta penurunan kesadaran. Tindakan resusitasi cairan intravena harus segera dimulai, disertai evaluasi kebutuhan transfusi darah pada perdarahan masif.

Disability (D) merujuk pada evaluasi neurologis pasien yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran dan kemungkinan cedera otak traumatik. Penilaian ini biasanya dilakukan menggunakan skala Glasgow Coma Scale (GCS), respons pupil, dan pemeriksaan motorik ekstremitas. Identifikasi dini cedera otak traumatik penting karena tindakan pencegahan cedera sekunder harus segera dimulai seperti menjaga perfusi otak, oksigenasi optimal, serta pencegahan edema otak.

Exposure (E) adalah evaluasi keseluruhan kondisi tubuh pasien untuk mendeteksi cedera lain yang mungkin tersembunyi di balik pakaian. Pasien harus diperiksa secara menyeluruh namun tetap menjaga suhu tubuh pasien (mencegah hipotermia) dengan selimut hangat atau lampu pemanas. Cedera yang sering ditemukan pada tahap ini meliputi luka tersembunyi, patah tulang, luka bakar, atau cedera lainnya yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap awal.

3. Penilaian Sekunder (Secondary Survey)

Setelah kondisi pasien stabil melalui penilaian primer dan resusitasi awal, tahap berikutnya adalah penilaian sekunder. Penilaian ini adalah pemeriksaan terperinci yang dilakukan dari ujung kepala hingga kaki pasien (head-to-toe examination) untuk mengidentifikasi cedera yang tidak langsung mengancam nyawa namun perlu penanganan definitif. Tahap ini juga melibatkan

pengumpulan riwayat kejadian trauma, riwayat penyakit pasien, riwayat alergi obat, serta riwayat pengobatan yang sedang dijalani oleh pasien.

Penilaian sekunder mencakup pemeriksaan fisik menyeluruh, palpasi untuk mendeteksi adanya fraktur, evaluasi luka terbuka, pemeriksaan fungsi ekstremitas, serta pemeriksaan neurologis lebih lanjut. Pemeriksaan diagnostik tambahan seperti pemeriksaan radiologi (rontgen, CT scan, ultrasonografi FAST), pemeriksaan laboratorium, dan konsultasi spesialis yang relevan biasanya dilakukan dalam tahap ini untuk mengonfirmasi atau menyingkirkan cedera tertentu.

Tindakan Resusitasi Awal pada Pasien Trauma

Resusitasi awal pada pasien trauma merupakan bagian integral dari proses penilaian primer. Tujuan resusitasi awal adalah untuk mengatasi kondisi syok, menjaga stabilitas hemodinamik pasien, serta mengoptimalkan oksigenasi jaringan vital seperti otak dan jantung. Langkah resusitasi awal mencakup kontrol jalan napas, pemberian oksigen suplementasi, pemasangan jalur intravena untuk pemberian cairan resusitasi (biasanya kristaloid isotonik atau cairan lain yang diindikasikan), pemberian transfusi darah apabila ada perdarahan masif, serta pemberian obat-obatan yang diperlukan sesuai kondisi pasien seperti analgetik, antibiotik profilaksis, atau vasopressor dalam kondisi tertentu.

Selama tindakan resusitasi, pemantauan ketat terhadap tanda vital pasien harus terus dilakukan untuk memastikan efektivitas tindakan resusitasi dan identifikasi dini terhadap komplikasi atau kondisi yang memburuk. Evaluasi dan re-evaluasi harus dilakukan secara terus menerus dalam siklus yang cepat dan dinamis.

Dengan mengikuti prinsip penanganan trauma yang sistematis seperti pendekatan ATLS, tenaga medis mampu mengidentifikasi cedera secara cepat, menentukan prioritas tindakan dengan tepat, serta memberikan intervensi klinis yang efektif. Hal ini akan sangat membantu dalam mengurangi angka mortalitas dan morbiditas, memperbaiki prognosis pasien trauma akut, serta meningkatkan keselamatan pasien secara keseluruhan.

D. Penatalaksanaan Cedera Spesifik pada Trauma Akut

Setelah pasien trauma menjalani penilaian primer dan sekunder, tenaga medis akan masuk pada tahapan penatalaksanaan spesifik sesuai dengan jenis cedera yang ditemukan. Setiap cedera memiliki pendekatan yang khas dan memerlukan intervensi medis khusus untuk mencegah komplikasi lanjutan serta mempercepat proses pemulihan pasien.

1. Penanganan Cedera Kepala dan Otak

Cedera kepala dan otak adalah salah satu cedera paling serius yang sering ditemukan pada pasien trauma akut, terutama akibat kecelakaan lalu lintas atau jatuh dari ketinggian. Cedera ini dapat diklasifikasikan menjadi trauma kepala ringan, sedang, dan berat berdasarkan skala Glasgow Coma Scale (GCS). Trauma kepala ringan biasanya memiliki skor GCS antara 13-15, trauma sedang memiliki skor GCS 9-12, dan trauma kepala berat memiliki skor GCS kurang dari 8.

Pada trauma kepala berat, penanganan awal harus difokuskan pada pencegahan cedera otak sekunder dengan menjaga kestabilan jalan napas, pernapasan, serta sirkulasi darah untuk memastikan oksigenasi dan perfusi otak yang optimal. Pemasangan intubasi dan ventilasi mekanis sering diperlukan jika pasien mengalami penurunan kesadaran signifikan. Monitoring tekanan intrakranial (ICP) penting untuk mencegah peningkatan tekanan dalam rongga tengkorak yang dapat memperburuk kerusakan otak. Terapi seperti pemberian cairan hiperosmotik (misalnya manitol atau salin hipertonik), serta intervensi bedah seperti kraniotomi dekompresi, sering menjadi pilihan dalam manajemen cedera kepala berat.

Pada trauma kepala sedang dan ringan, pendekatan umumnya bersifat konservatif, meliputi observasi ketat selama 24 jam pertama untuk mendeteksi kemungkinan perburukan kondisi neurologis seperti perdarahan intrakranial. CT Scan kepala diperlukan untuk evaluasi lebih lanjut jika ada tanda-tanda neurologis atau faktor risiko tertentu.

2. Penanganan Cedera Leher dan Tulang Belakang

Cedera leher dan tulang belakang merupakan cedera serius yang berpotensi menyebabkan kelumpuhan atau kematian jika tidak segera diidentifikasi dan ditangani secara tepat. Cedera ini biasanya terbagi menjadi tiga bagian utama berdasarkan lokasi anatomi yaitu servikal (leher), thorakal (punggung tengah), dan lumbal (punggung bawah).

Cedera servikal sangat kritis karena dapat menyebabkan gangguan jalan napas, cedera medula spinalis, dan kelumpuhan ekstremitas. Penatalaksanaan awal meliputi imobilisasi segera dengan menggunakan cervical collar atau papan spinal untuk mencegah gerakan tambahan yang memperburuk cedera. Pemeriksaan pencitraan seperti rontgen, CT Scan, atau MRI wajib dilakukan segera untuk mengidentifikasi lokasi dan tingkat cedera. Pada cedera yang stabil, pasien akan diberikan imobilisasi konservatif, sedangkan cedera yang tidak stabil sering kali memerlukan tindakan pembedahan berupa fiksasi atau stabilisasi internal.

Cedera thorakal dan lumbal umumnya juga ditangani dengan prinsip serupa, yakni imobilisasi segera, pengendalian nyeri, serta penilaian neurologis yang cermat. Bedah biasanya dilakukan jika ada indikasi seperti ketidakstabilan tulang belakang, defisit neurologis progresif, atau deformitas signifikan pada tulang belakang.

3. Penanganan Cedera Dada dan Abdomen

Cedera dada dan abdomen sering ditemukan pada pasien trauma akut akibat kecelakaan lalu lintas atau kekerasan fisik. Cedera dada yang sering ditemukan di antaranya adalah trauma thoraks, pneumotoraks, dan hemotoraks.

Pada trauma thoraks, langkah utama yang dilakukan adalah evaluasi fungsi pernapasan dan hemodinamik, serta deteksi dini kondisi seperti pneumotoraks (udara dalam rongga dada) dan hemotoraks (darah dalam rongga dada). Pneumotoraks dan hemotoraks harus segera ditangani dengan pemasangan chest tube (drainase toraks) untuk mengevakuasi udara atau darah dari rongga dada guna memulihkan fungsi pernapasan dan sirkulasi darah. Pada kasus trauma dada berat seperti cedera jantung, cedera paru berat, atau trauma pembuluh darah besar, tindakan operasi segera mungkin diperlukan.

Trauma abdomen dapat bersifat tumpul atau tembus. Pada trauma abdomen tumpul, organ dalam seperti limpa, hati, ginjal, atau usus dapat mengalami robekan atau perdarahan. Evaluasi dilakukan dengan pemeriksaan fisik, ultrasonografi (Focused Assessment with Sonography for Trauma—FAST), dan CT Scan. Jika perdarahan masif atau cedera organ serius terdeteksi, pasien segera memerlukan operasi laparotomi eksplorasi untuk mengontrol perdarahan dan memperbaiki kerusakan organ.

Pada trauma abdomen tembus, seperti akibat luka tusuk atau tembakan, eksplorasi bedah umumnya lebih sering diperlukan karena potensi cedera organ dalam yang tinggi. Pasien harus segera menjalani evaluasi bedah darurat untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan hebat atau peritonitis.

4. Penanganan Cedera Ekstremitas dan Muskuloskeletal

Cedera ekstremitas yang paling umum terjadi pada pasien trauma akut meliputi fraktur terbuka dan tertutup serta dislokasi sendi. Fraktur terbuka (compound fracture) merupakan kondisi emergensi karena adanya risiko infeksi tinggi akibat kontaminasi luka. Penatalaksanaan awal meliputi pembersihan luka, stabilisasi sementara dengan bidai (splint), pemberian antibiotik profilaksis, serta operasi definitif untuk membersihkan jaringan mati dan stabilisasi tulang menggunakan metode fiksasi internal atau eksternal.

Fraktur tertutup dan dislokasi juga membutuhkan stabilisasi dini untuk mencegah cedera jaringan lunak lebih lanjut, serta mengurangi nyeri.

Pemeriksaan radiologi wajib dilakukan untuk menentukan jenis dan lokasi cedera serta menentukan metode reduksi atau operasi yang diperlukan.

5. Penanganan Cedera Jaringan Lunak dan Luka Bakar pada Pasien Trauma

Cedera jaringan lunak seperti luka robek, laserasi, abrasi, serta luka bakar sering ditemukan bersamaan dengan cedera lainnya. Luka robek atau laserasi perlu segera dibersihkan dengan baik untuk mencegah infeksi. Penjahitan luka harus dilakukan setelah luka benar-benar bersih untuk mempercepat penyembuhan. Pada luka yang terkontaminasi berat, pemberian antibiotik profilaksis menjadi standar terapi.

Luka bakar pada pasien trauma membutuhkan perhatian khusus, terutama dalam menilai kedalaman luka bakar, luas permukaan tubuh yang terbakar, serta risiko komplikasi infeksi. Pasien dengan luka bakar luas memerlukan cairan resusitasi yang agresif, pemantauan ketat fungsi organ vital, serta perawatan luka yang intensif. Transfer ke pusat luka bakar khusus mungkin diperlukan pada kasus luka bakar luas atau luka bakar dalam yang kompleks.

Dengan pendekatan yang sistematis dan spesifik pada masing-masing cedera yang dialami pasien trauma akut, tim medis dapat memberikan perawatan optimal untuk mengurangi risiko komplikasi, mempercepat pemulihan, dan secara signifikan memperbaiki prognosis pasien secara keseluruhan. Penanganan yang tepat waktu, akurat, dan didukung oleh tim multidisiplin adalah kunci keberhasilan dalam manajemen trauma akut.

E. Penatalaksanaan Nyeri pada Pasien Trauma Akut

Nyeri adalah salah satu masalah utama yang dialami pasien trauma akut. Pasien dengan cedera akut seringkali mengalami nyeri yang hebat, dan jika tidak diatasi secara efektif dapat menyebabkan gangguan fisiologis maupun psikologis yang berdampak negatif terhadap proses penyembuhan. Penatalaksanaan nyeri pada pasien trauma akut merupakan bagian penting dari perawatan komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien, meningkatkan kenyamanan, serta mempercepat pemulihan.

1. Strategi Penilaian Nyeri pada Pasien Trauma

Penilaian nyeri pada pasien trauma akut menjadi langkah pertama yang esensial untuk memastikan intervensi yang tepat. Namun, tantangan utama dalam penilaian nyeri pada pasien trauma adalah kondisi pasien yang sering kali tidak stabil atau mengalami gangguan kesadaran akibat cedera kepala berat, syok, atau kondisi medis lain yang mempersulit komunikasi efektif. Oleh karena itu, penilaian nyeri harus dilakukan dengan metode yang fleksibel dan adaptif sesuai kondisi pasien.

Metode yang umum digunakan dalam penilaian nyeri adalah skala numerik (Numerical Rating Scale - NRS) di mana pasien menilai intensitas nyeri dari angka 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri paling hebat yang pernah dirasakan). Skala nyeri visual analog (Visual Analog Scale - VAS) juga sering digunakan, di mana pasien menunjukkan tingkat nyeri pada garis horizontal yang menggambarkan intensitas nyeri. Namun, jika pasien tidak mampu berkomunikasi secara verbal karena gangguan kesadaran, cedera kepala berat, atau karena ventilasi mekanik, skala penilaian nyeri berbasis observasi seperti Behavioral Pain Scale (BPS) atau Critical Care Pain Observation Tool (CPOT) bisa digunakan untuk mengukur nyeri berdasarkan tanda-tanda fisik seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, tonus otot, frekuensi pernapasan, dan perubahan tanda vital seperti denyut jantung atau tekanan darah.

Penting untuk dilakukan penilaian nyeri secara rutin dan teratur, idealnya setiap 1-2 jam, terutama setelah pemberian analgesik atau tindakan medis tertentu, untuk memastikan bahwa nyeri dapat dikelola secara efektif dan tepat waktu.

2. Pilihan Terapi Farmakologi dalam Penanganan Nyeri Pasien Trauma

Terapi farmakologi adalah metode utama dalam pengelolaan nyeri akut pada pasien trauma. Pemilihan analgesik yang tepat disesuaikan dengan tingkat keparahan nyeri, kondisi pasien, serta risiko efek samping.

Secara garis besar, pilihan terapi farmakologi terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu analgesik opioid dan non-opioid.

Analgesik opioid merupakan pilihan utama pada kasus nyeri hebat hingga sangat hebat akibat trauma akut. Obat-obatan seperti morfin, fentanyl, oksikodon, dan tramadol sering kali digunakan dalam pengaturan akut karena efektivitasnya dalam mengatasi nyeri berat secara cepat. Morfin adalah pilihan yang paling umum digunakan, dengan dosis yang disesuaikan berdasarkan berat badan, intensitas nyeri, serta respons pasien terhadap terapi. Fentanyl memiliki onset kerja yang lebih cepat dan durasi kerja yang lebih pendek dibandingkan morfin, sehingga lebih disukai pada kasus yang membutuhkan kontrol nyeri cepat dan singkat, seperti tindakan medis tertentu atau resusitasi pasien trauma yang kritis. Risiko utama penggunaan opioid adalah depresi pernapasan, hipotensi, mual muntah, konstipasi, hingga risiko ketergantungan bila digunakan dalam waktu lama. Oleh karena itu, pemantauan ketat terhadap pasien menjadi hal yang sangat penting.

Analgesik non-opioid seperti parasetamol dan obat antiinflamasi non-steroid (NSAID) juga digunakan secara luas untuk penanganan nyeri dengan intensitas ringan hingga sedang atau sebagai tambahan terapi pada nyeri hebat.

Parasetamol merupakan obat pilihan utama karena profil keamanannya yang relatif baik, dengan efek samping yang minimal jika diberikan dalam dosis yang tepat. NSAID, seperti ketorolak atau ibuprofen, efektif dalam mengatasi nyeri yang disertai inflamasi atau pembengkakan. Namun, penggunaannya harus hati-hati karena risiko efek samping gastrointestinal, gangguan fungsi ginjal, dan risiko perdarahan terutama pada pasien trauma yang mengalami gangguan koagulasi atau cedera perdarahan aktif.

Strategi analgesik multimodal, yang mengombinasikan analgesik opioid dengan non-opioid serta terapi tambahan lain, kini semakin dianjurkan dalam penatalaksanaan nyeri pasien trauma akut karena terbukti lebih efektif dalam mengurangi nyeri, menurunkan dosis opioid yang dibutuhkan, dan mengurangi risiko efek samping.

3. Pendekatan Non-Farmakologi dalam Pengelolaan Nyeri

Selain terapi farmakologi, pendekatan non-farmakologi juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan nyeri pada pasien trauma akut. Metode non-farmakologi tidak hanya membantu meredakan nyeri tetapi juga memberikan manfaat tambahan seperti menurunkan stres, kecemasan, dan meningkatkan kenyamanan pasien selama perawatan di fasilitas kesehatan.

Beberapa pendekatan non-farmakologi yang efektif digunakan dalam pengelolaan nyeri pasien trauma adalah terapi relaksasi, distraksi, imobilisasi, posisi yang nyaman, kompres dingin atau panas, serta terapi stimulasi saraf listrik transkutan (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation - TENS).

Terapi relaksasi dan distraksi, seperti mendengarkan musik, teknik pernapasan dalam, serta teknik visualisasi, dapat membantu pasien trauma mengalihkan perhatian dari nyeri dan menciptakan kondisi psikologis yang lebih nyaman. Imobilisasi atau fiksasi sementara, seperti dengan splint atau bidai pada fraktur, juga sangat efektif dalam mengurangi nyeri dengan cara mengurangi pergerakan yang menyebabkan nyeri dan cedera tambahan.

Aplikasi kompres dingin efektif mengurangi nyeri pada cedera akut seperti fraktur atau cedera jaringan lunak dengan mengurangi inflamasi, bengkak, serta memberikan efek anestesi lokal ringan. Sebaliknya, kompres hangat bisa digunakan dalam fase lanjutan cedera untuk mempercepat proses penyembuhan, mengurangi spasme otot, dan meningkatkan sirkulasi darah di area cedera.

TENS merupakan metode stimulasi listrik ringan yang memberikan efek analgesik dengan mengaktifkan mekanisme inhibisi nyeri alami tubuh melalui stimulasi serabut saraf. Metode ini sangat efektif dan aman digunakan sebagai terapi tambahan dalam pengelolaan nyeri akut dan kronis.

Secara keseluruhan, pengelolaan nyeri yang optimal pada pasien trauma akut membutuhkan pendekatan multimodal yang menggabungkan terapi farmakologi dan non-farmakologi secara terpadu. Pemantauan yang ketat dan penyesuaian terapi secara individual sangat penting dalam mencapai hasil pengelolaan nyeri yang efektif, memaksimalkan kenyamanan pasien, serta mendukung proses pemulihan yang optimal. Dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang holistik ini, tenaga medis dapat memberikan penatalaksanaan nyeri yang efektif, aman, dan berorientasi pada kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

F. Manajemen Psikologis Pasien Trauma Akut

Trauma akut tidak hanya berdampak pada cedera fisik pasien, namun juga secara signifikan memengaruhi kondisi psikologisnya. Pasien yang mengalami kejadian traumatik sering kali menunjukkan reaksi emosional yang kuat dan kompleks, seperti rasa takut yang intens, kecemasan yang tinggi, perasaan tidak berdaya, hingga respons disosiasi. Oleh sebab itu, pengelolaan psikologis pada pasien trauma akut merupakan bagian integral dari penanganan trauma yang komprehensif, yang bertujuan untuk mencegah atau mengurangi dampak jangka panjang gangguan psikologis serta mempercepat pemulihan mental dan fisik pasien.

1. Identifikasi Gangguan Psikologis Akibat Trauma

Gangguan psikologis yang sering ditemukan pada pasien trauma akut adalah ansietas (kecemasan) akut, gangguan stres akut (acute stress disorder), serta risiko berkembangnya gangguan stres pascatrauma (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD). Pasien dengan trauma akut biasanya menunjukkan gejala-gejala psikologis yang bervariasi mulai dari perasaan cemas, panik, agitasi, hingga mengalami gangguan tidur, mimpi buruk, flashback peristiwa traumatik, serta perilaku penghindaran terhadap situasi atau lokasi yang terkait trauma.

Identifikasi dini terhadap gangguan psikologis ini merupakan langkah penting agar intervensi yang tepat bisa segera diberikan. Penilaian psikologis dapat dilakukan melalui wawancara klinis sederhana yang mengamati gejala-gejala umum kecemasan akut atau stres akut. Dalam praktiknya, perawat atau tenaga medis lainnya perlu memiliki sensitivitas tinggi dalam mengenali tanda-tanda psikologis seperti perubahan emosi yang drastis, rasa gelisah yang berlebihan, ketegangan otot, perubahan pola tidur, serta kesulitan pasien dalam berkomunikasi. Alat bantu diagnostik seperti Impact of Event Scale-Revised (IES-R), PTSD Checklist (PCL-5), atau skala penilaian ansietas dapat digunakan sebagai

instrumen tambahan untuk mengidentifikasi risiko gangguan psikologis secara lebih objektif.

Gangguan stres akut yang tidak teridentifikasi dan tidak tertangani secara optimal memiliki risiko berkembang menjadi PTSD. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan cepat dapat mencegah progresi gangguan psikologis ke tahap kronis yang lebih sulit diatasi.

2. Pendekatan Psikososial Awal pada Pasien dan Keluarga

Setelah teridentifikasi gangguan psikologis pada pasien trauma akut, pendekatan psikososial awal harus segera dilakukan. Pendekatan psikososial ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, menciptakan rasa aman, serta membantu pasien maupun keluarganya untuk menghadapi situasi kritis secara lebih adaptif. Dalam fase awal, pendekatan psikososial biasanya berupa komunikasi yang suportif, empatik, terbuka, serta memberikan validasi atas perasaan pasien maupun keluarga yang sedang mengalami syok atau kecemasan akibat trauma.

Perawat dan tenaga medis harus memberikan penjelasan sederhana dan jujur mengenai kondisi pasien, prosedur medis yang akan dilakukan, serta prognosis yang realistis. Informasi yang disampaikan harus jelas dan diulang jika diperlukan, dengan tujuan mengurangi ketidakpastian yang sering kali menjadi sumber kecemasan utama bagi pasien maupun keluarganya.

Keluarga pasien juga harus menjadi perhatian khusus dalam pendekatan psikososial, karena mereka sering kali mengalami tekanan psikologis yang tinggi akibat ketidakpastian terhadap nasib pasien. Dukungan terhadap keluarga bisa dilakukan dengan cara menyediakan ruang komunikasi yang nyaman, memberi mereka kesempatan bertanya, serta memberikan informasi yang jelas dan realistis secara rutin. Dukungan yang diberikan kepada keluarga akan sangat membantu keluarga dalam mendukung pemulihan pasien secara emosional maupun fisik.

3. Intervensi Dukungan Psikologis dalam Perawatan Akut

Intervensi dukungan psikologis merupakan bagian penting dari manajemen psikologis pasien trauma akut selama perawatan akut di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Salah satu metode intervensi psikologis yang sangat dianjurkan dalam fase akut adalah Psychological First Aid (PFA). PFA adalah intervensi awal berbasis bukti yang bertujuan untuk mengurangi stres akut, mendorong adaptasi positif, serta mencegah gangguan psikologis lebih lanjut dengan pendekatan yang suportif, humanistik, serta non-intrusif.

Pelaksanaan PFA dilakukan dengan memberikan rasa aman dan nyaman, membantu pasien mengatasi kebutuhan dasar fisik dan emosional, mendengarkan keluhan atau pengalaman pasien dengan empati, serta

menenangkan pasien tanpa memaksa untuk menceritakan kejadian traumatik secara rinci jika pasien belum siap. Tenaga medis yang melakukan PFA harus memperhatikan kebutuhan emosional pasien dengan sensitivitas tinggi dan menjaga agar intervensi tersebut berlangsung secara alami dan tidak menimbulkan tekanan tambahan.

Selain Psychological First Aid, intervensi lain yang efektif dalam perawatan akut adalah pendekatan berbasis relaksasi dan teknik grounding yang bertujuan untuk menstabilkan emosi pasien yang mengalami gejala disosiasi atau panik akut. Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam (deep breathing), relaksasi otot progresif, serta teknik grounding sederhana seperti fokus pada lingkungan sekitar, dapat membantu pasien kembali tenang dan merasa terhubung dengan realitas secara lebih kuat.

Dalam beberapa kasus yang lebih berat, intervensi farmakologis seperti pemberian anxiolytic (obat anti-cemas) jangka pendek dapat dipertimbangkan untuk membantu pasien mengendalikan gejala kecemasan atau panik akut yang ekstrem. Namun, intervensi farmakologis ini sebaiknya bersifat temporer, dipantau secara ketat, serta didukung dengan intervensi psikologis yang lebih komprehensif.

Di samping itu, pendekatan psikologis yang integratif, melibatkan tim multidisiplin termasuk psikolog klinis, psikiater, perawat, dan tenaga kesehatan lain, merupakan cara terbaik untuk menjamin dukungan psikologis yang berkelanjutan selama perawatan akut hingga pemulihan jangka panjang.

Manajemen psikologis yang efektif pada pasien trauma akut tidak hanya membantu mengurangi penderitaan psikologis dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas hidup jangka panjang, mempercepat proses penyembuhan fisik, serta mencegah berkembangnya gangguan psikologis kronis seperti PTSD atau gangguan kecemasan kronik.

Dengan melakukan identifikasi yang cermat, pendekatan psikososial yang empatik dan suportif, serta intervensi psikologis yang tepat selama perawatan akut, tenaga medis dapat secara signifikan membantu pasien trauma akut melewati masa kritis secara lebih baik, serta mendukung mereka menuju pemulihan yang optimal baik secara fisik maupun psikologis.

G. Peran Tim Multidisiplin dalam Penanganan Trauma Akut

Trauma akut merupakan kondisi medis yang sering kali kompleks dan membutuhkan respons cepat serta tindakan yang terorganisir dengan baik. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan pasien trauma akut, diperlukan kerja sama erat yang melibatkan tim multidisiplin. Tim multidisiplin terdiri dari

berbagai tenaga profesional kesehatan seperti dokter spesialis emergensi, dokter bedah umum, dokter anestesi, perawat emergensi, perawat bedah, radiografer, tenaga laboratorium, fisioterapis, farmasis, serta tenaga kesehatan lain yang relevan. Setiap anggota tim memiliki peran spesifik dan saling melengkapi dalam menyediakan perawatan yang komprehensif bagi pasien trauma.

1. Kolaborasi dan Koordinasi Tim Kegawatdaruratan

Kolaborasi dan koordinasi merupakan kunci utama dalam penanganan pasien trauma akut. Pasien dengan trauma sering tiba di instalasi gawat darurat (IGD) dalam kondisi kritis yang membutuhkan evaluasi cepat, diagnosis segera, serta intervensi medis tepat dalam waktu yang sangat terbatas. Tim kegawatdaruratan harus bekerja secara harmonis dengan menerapkan prinsip-prinsip pendekatan sistematis, seperti prinsip Advanced Trauma Life Support (ATLS), untuk memastikan tidak ada langkah penting yang terlewatkan dalam penanganan pasien.

Dalam praktiknya, kolaborasi dan koordinasi dilakukan dengan menetapkan peran dan tanggung jawab secara jelas sejak awal. Ketika pasien tiba, seorang pemimpin tim, biasanya dokter spesialis emergensi atau dokter senior yang berpengalaman, akan mengambil alih kendali untuk memberikan arahan yang jelas tentang tindakan prioritas yang harus dilakukan. Pemimpin tim bertanggung jawab atas koordinasi seluruh tim medis dan memastikan bahwa semua langkah dari pemeriksaan primer (ABCDE), resusitasi, hingga intervensi lebih lanjut berjalan secara cepat dan tepat.

Koordinasi tim juga mencakup distribusi tugas secara efektif. Misalnya, dokter emergensi bertanggung jawab dalam evaluasi awal, dokter anestesi berperan dalam memastikan keamanan jalan napas serta ventilasi pasien, sementara dokter bedah akan segera mengambil tindakan operatif jika dibutuhkan. Di sisi lain, perawat emergensi bertugas melakukan pemantauan ketat tanda vital pasien, memberikan tindakan keperawatan darurat, serta mengelola komunikasi antara anggota tim.

Dengan koordinasi yang jelas, setiap anggota tim dapat bekerja secara simultan, sehingga waktu penanganan pasien dapat dipersingkat secara signifikan. Hal ini secara langsung berdampak pada peningkatan peluang hidup pasien dan meminimalkan risiko komplikasi lanjutan.

2. Peran Dokter Spesialis, Perawat, dan Tenaga Medis Lainnya

Dalam tim multidisiplin, setiap anggota tim kesehatan memiliki peran spesifik yang penting dalam keseluruhan proses manajemen pasien trauma akut. Dokter spesialis emergensi adalah garda terdepan yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi primer dan sekunder, serta memberikan arahan

terhadap intervensi yang diperlukan dengan segera. Mereka juga memimpin tim medis untuk memastikan bahwa alur penanganan trauma dilakukan dengan cepat, efektif, dan aman bagi pasien.

Dokter bedah memiliki peran vital dalam menangani cedera spesifik seperti trauma abdomen, dada, ekstremitas, atau cedera yang memerlukan tindakan operasi segera. Mereka harus mampu membuat keputusan cepat mengenai intervensi bedah yang dibutuhkan, berdasarkan informasi diagnostik yang diperoleh dari dokter emergensi atau tenaga radiologi.

Dokter anestesi bertanggung jawab dalam mengelola jalan napas, ventilasi, serta sirkulasi selama proses operasi atau tindakan invasif lainnya. Mereka memastikan pasien berada dalam kondisi stabil dari segi hemodinamik dan respirasi selama tindakan medis dilakukan.

Perawat emergensi memiliki peran sentral dalam mendukung dokter spesialis dalam berbagai prosedur, memonitor kondisi pasien secara kontinu, serta mengelola berbagai aspek keperawatan selama perawatan akut. Mereka juga bertugas untuk melakukan dokumentasi yang rinci dan akurat mengenai kondisi pasien serta tindakan yang telah dilakukan. Perawat di ruang bedah atau perawat intensivist akan melanjutkan perawatan pasca tindakan emergensi untuk memastikan pasien mendapatkan perawatan lanjutan secara optimal.

Tenaga radiologi berperan dalam menyediakan pencitraan diagnostik penting yang dibutuhkan secara cepat seperti rontgen dada, CT scan kepala, atau abdomen untuk menentukan lokasi dan tingkat keparahan cedera. Tenaga laboratorium bertugas dalam menyediakan data laboratorium yang esensial seperti analisis darah lengkap, analisis gas darah, atau data koagulasi untuk membantu dokter menentukan strategi resusitasi.

Farmasis juga memiliki peran penting dalam menyediakan, menyiapkan, dan memastikan pemberian obat yang aman dan tepat, termasuk analgesik, antibiotik, cairan infus, atau produk darah yang dibutuhkan segera. Fisioterapis mulai terlibat dalam fase lanjutan perawatan trauma untuk membantu pasien mendapatkan kembali fungsi fisik serta mempercepat rehabilitasi.

3. Komunikasi Efektif dalam Situasi Kritis Trauma

Komunikasi efektif dalam tim multidisiplin merupakan aspek yang sangat penting dalam penanganan trauma akut. Situasi kritis di IGD atau ruang trauma sering kali diwarnai oleh tekanan tinggi, waktu yang sangat terbatas, serta kondisi pasien yang tidak stabil. Oleh karena itu, komunikasi antar anggota tim harus dilakukan dengan jelas, terstruktur, dan efisien untuk menghindari kesalahan informasi yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam tindakan medis atau bahkan kesalahan fatal.

Salah satu metode komunikasi yang sering digunakan dalam situasi kritis adalah metode komunikasi tertutup atau closed-loop communication. Metode ini memastikan bahwa setiap instruksi atau pesan yang diberikan oleh seorang anggota tim diterima dan dikonfirmasi secara jelas oleh anggota tim lainnya. Misalnya, ketika dokter emergensi meminta perawat memberikan cairan infus dengan dosis tertentu, perawat akan mengulang instruksi tersebut secara singkat dan jelas untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman.

Selain itu, pendekatan komunikasi menggunakan metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) sangat efektif dalam situasi kritis trauma. Metode ini membantu setiap anggota tim menyampaikan informasi secara sistematis dan ringkas, mencakup kondisi pasien saat ini, latar belakang medis penting, hasil evaluasi terkini, serta rekomendasi tindakan medis yang harus segera dilakukan.

Selain komunikasi antar tenaga kesehatan, komunikasi dengan pasien maupun keluarganya juga tidak kalah penting. Menyampaikan informasi kepada keluarga secara empatik, jelas, dan jujur membantu mengurangi kecemasan serta memungkinkan mereka berpartisipasi secara positif dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik dengan keluarga pasien juga menjadi bagian dari dukungan psikologis yang sangat dibutuhkan dalam situasi trauma akut.

Dalam praktiknya, keterampilan komunikasi tim medis ini harus selalu dilatih dan dikembangkan melalui simulasi kasus trauma secara rutin, diskusi kasus multidisiplin, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa komunikasi tim selalu optimal, terutama dalam situasi yang penuh tekanan.

Dengan kolaborasi yang erat, peran masing-masing tenaga profesional yang terdefinisi jelas, serta komunikasi efektif yang terus dijaga kualitasnya, tim multidisiplin dapat memberikan penanganan terbaik bagi pasien trauma akut. Hal ini akan memastikan pasien mendapatkan perawatan medis yang cepat, aman, efektif, serta berorientasi pada keselamatan dan kualitas hidup jangka panjang pasien.

H. Tantangan dalam Implementasi Standar Penanganan Trauma Akut di Indonesia

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan populasi yang besar menghadapi berbagai tantangan serius dalam implementasi standar penanganan trauma akut secara nasional. Salah satu tantangan utama adalah disparitas geografis dan aksesibilitas layanan kesehatan. Di kota-kota besar, layanan kegawatdaruratan trauma sudah cukup maju, namun di daerah pedesaan atau terpencil, akses terhadap layanan trauma yang cepat dan efektif masih terbatas.

Fasilitas kesehatan di daerah tersebut sering kali tidak memiliki peralatan medis canggih atau personel medis yang terlatih khusus dalam menangani trauma akut, menyebabkan keterlambatan penanganan yang berakibat buruk bagi pasien.

Tantangan berikutnya adalah kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki pelatihan dan sertifikasi khusus dalam manajemen trauma, seperti pelatihan Advanced Trauma Life Support (ATLS) atau Basic Trauma Life Support (BTLS). Masih terbatasnya jumlah dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain yang kompeten dalam prinsip-prinsip manajemen trauma menyebabkan penanganan trauma yang kurang optimal, terutama dalam kasus-kasus berat yang membutuhkan tindakan resusitasi segera dan intervensi medis yang tepat waktu.

Permasalahan lain adalah kurangnya integrasi sistem pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses rujukan pasien dari pusat layanan kesehatan primer ke fasilitas layanan trauma yang lebih lengkap seperti rumah sakit regional atau rumah sakit pusat rujukan. Proses rujukan yang tidak efisien sering kali menyebabkan pasien trauma akut kehilangan waktu kritis yang dikenal sebagai "golden period," yaitu periode waktu singkat setelah cedera terjadi yang sangat menentukan kelangsungan hidup pasien.

Selain itu, isu terkait pendanaan dan pembiayaan layanan trauma menjadi tantangan besar di Indonesia. Banyak rumah sakit, terutama di daerah, mengalami kesulitan finansial dalam menyediakan peralatan medis modern yang mahal, fasilitas ruang trauma yang sesuai standar internasional, serta pelatihan berkala bagi tenaga medis mereka. Kendala finansial ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan.

Terakhir, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya respons cepat dan tepat terhadap korban trauma juga menjadi masalah tersendiri. Di banyak kasus, masyarakat awam yang pertama kali menemukan korban trauma belum memiliki pengetahuan dasar tentang cara penanganan awal korban trauma, sehingga intervensi yang mereka lakukan justru memperparah kondisi korban.

1. Strategi Optimalisasi Sumber Daya untuk Pelayanan Trauma

Untuk mengatasi berbagai tantangan di atas, dibutuhkan strategi yang matang dalam mengoptimalisasi sumber daya yang ada. Pertama, pemerintah dan pihak-pihak terkait harus secara konsisten memperluas akses pelatihan trauma untuk tenaga medis. Pelatihan seperti ATLS, BTLS, atau trauma nursing core course (TNCC) harus tersedia secara luas dan rutin, serta menjadi persyaratan wajib bagi tenaga medis yang bertugas di instalasi gawat darurat dan unit trauma. Program pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi klinis tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri tenaga medis dalam menghadapi kasus trauma kompleks.

Selanjutnya, distribusi sumber daya manusia dan fasilitas kesehatan harus dilakukan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, dengan perhatian khusus pada daerah terpencil dan sulit dijangkau. Pemerintah perlu membangun sistem jejaring pelayanan trauma terintegrasi yang melibatkan rumah sakit besar sebagai pusat rujukan, pusat layanan kesehatan primer sebagai lini terdepan, serta sistem ambulans darurat yang dilengkapi teknologi komunikasi canggih. Dengan integrasi ini, pasien trauma akut dapat memperoleh penanganan segera dan proses rujukan yang lancak dan cepat.

Penting juga untuk memperkuat sistem telemedisin di Indonesia. Implementasi telemedisin dalam manajemen trauma memungkinkan konsultasi cepat dengan dokter spesialis trauma yang berada di pusat-pusat rujukan, membantu dokter atau tenaga medis di daerah terpencil dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan cepat. Telemedisin juga bisa meminimalisasi kesalahan diagnosa dan manajemen, sehingga penanganan pasien trauma akut lebih optimal.

Strategi lain adalah meningkatkan investasi pemerintah dalam peralatan medis yang canggih dan sesuai standar internasional di fasilitas-fasilitas kesehatan regional. Penyediaan alat diagnostik seperti CT scan, ultrasound, dan alat monitoring pasien secara lengkap, serta pengadaan ambulans yang dilengkapi peralatan resusitasi lengkap akan meningkatkan kualitas layanan trauma secara signifikan.

Selain sumber daya fisik dan manusia, optimalisasi pembiayaan kesehatan juga penting. Mekanisme pendanaan khusus untuk layanan trauma akut melalui asuransi nasional atau subsidi pemerintah dapat membantu meringankan beban rumah sakit dalam penyediaan pelayanan trauma yang mahal. Dengan jaminan pendanaan, rumah sakit dapat lebih leluasa melakukan pengadaan alat, memberikan pelatihan tenaga medis secara rutin, dan menjamin layanan yang berkualitas bagi pasien trauma.

2. Rekomendasi untuk Pengembangan Sistem Pelayanan Trauma Nasional

Pengembangan sistem pelayanan trauma nasional di Indonesia memerlukan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan. Salah satu rekomendasi utama adalah pembentukan dan implementasi standar nasional pelayanan trauma. Standar ini harus mencakup berbagai aspek mulai dari prosedur penanganan awal, pengelolaan kasus spesifik, kriteria rujukan pasien, hingga manajemen nyeri dan psikososial. Dengan adanya standar nasional yang jelas dan baku, kualitas layanan trauma dapat ditingkatkan secara signifikan di seluruh Indonesia.

Selain itu, perlu adanya sistem audit dan evaluasi nasional yang rutin terhadap penanganan kasus trauma. Audit trauma nasional ini bertujuan mengevaluasi efektivitas penerapan standar pelayanan trauma di berbagai fasilitas kesehatan, mengidentifikasi hambatan serta area yang membutuhkan perbaikan lebih lanjut, dan memberikan rekomendasi tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan. Sistem audit yang kuat akan mendorong peningkatan mutu layanan trauma secara berkelanjutan.

Rekomendasi berikutnya adalah membangun pusat trauma regional di setiap provinsi yang berfungsi sebagai pusat rujukan utama untuk kasus trauma berat atau kompleks. Rumah sakit regional ini harus dilengkapi fasilitas canggih, sumber daya manusia yang terlatih tinggi, dan mampu memberikan layanan komprehensif mulai dari perawatan awal hingga rehabilitasi jangka panjang. Jejaring antara pusat trauma regional dengan fasilitas kesehatan primer harus kuat, didukung oleh sistem transportasi medis darurat yang efektif, seperti ambulans udara untuk daerah terpencil.

Upaya edukasi masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah dan pihak terkait perlu secara aktif melakukan kampanye edukasi mengenai respons awal terhadap korban trauma, seperti tindakan pertolongan pertama dan pentingnya segera membawa korban ke fasilitas kesehatan. Masyarakat yang teredukasi akan mampu melakukan intervensi yang tepat pada masa kritis sebelum bantuan medis profesional tiba.

Terakhir, sistem informasi trauma nasional yang terintegrasi juga harus segera dikembangkan. Sistem ini mencakup basis data pasien trauma yang dapat diakses secara nasional untuk kepentingan klinis, administratif, serta penelitian. Sistem informasi ini akan memberikan data penting mengenai epidemiologi trauma, pola cedera, efektivitas pengobatan, dan lain-lain, sehingga membantu pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional.

Dengan menerapkan berbagai rekomendasi ini secara konsisten dan berkelanjutan, manajemen trauma akut di Indonesia dapat mencapai hasil yang lebih baik. Ke depannya, implementasi sistem trauma nasional yang komprehensif akan secara nyata menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pasien trauma, meningkatkan kualitas hidup pasien pasca-trauma, serta secara keseluruhan memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional terhadap kejadian trauma yang semakin meningkat.

I. Simpulan

Trauma akut merupakan kondisi medis yang serius dan kompleks, yang terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan penanganan medis segera serta terstruktur. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai mekanisme seperti trauma tumpul, trauma tembus, dan trauma akibat ledakan, yang masing-masing memiliki pola cedera khas serta memerlukan strategi penanganan yang berbeda. Penilaian dan klasifikasi tingkat keparahan cedera, dari ringan hingga berat, sangat penting dilakukan untuk menentukan prioritas tindakan dan intervensi yang tepat serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

Prinsip penanganan trauma akut berfokus pada pendekatan sistematis seperti Advanced Trauma Life Support (ATLS), yang mencakup penilaian primer (ABCDE), resusitasi awal, dan penilaian sekunder yang komprehensif. Penatalaksanaan cedera spesifik seperti trauma kepala, leher, dada, abdomen, ekstremitas, serta jaringan lunak dan luka bakar, memerlukan intervensi medis khusus yang cepat dan tepat untuk meminimalkan morbiditas dan mortalitas. Selain itu, pengelolaan nyeri yang efektif melalui terapi farmakologi dan non-farmakologi menjadi bagian integral dalam proses penyembuhan pasien trauma akut.

Penanganan trauma akut juga melibatkan manajemen psikologis yang bertujuan mencegah dampak psikologis jangka panjang seperti PTSD atau gangguan kecemasan. Intervensi psikososial awal dan dukungan psikologis yang empatik kepada pasien serta keluarga berperan penting dalam proses pemulihan secara menyeluruh.

Peran tim multidisiplin sangat krusial dalam penanganan trauma akut, di mana koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi efektif antar tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, perawat, serta tenaga medis lainnya menjadi penentu keberhasilan dalam penanganan pasien trauma.

Di Indonesia, implementasi standar penanganan trauma akut menghadapi beberapa tantangan serius seperti disparitas geografis, kurangnya pelatihan tenaga medis, keterbatasan fasilitas kesehatan, integrasi sistem rujukan yang belum optimal, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan penanganan trauma. Oleh karena itu, optimalisasi sumber daya, seperti perluasan pelatihan medis, pembangunan sistem layanan trauma terintegrasi, penggunaan telemedisin, serta pendanaan yang memadai menjadi strategi penting untuk meningkatkan pelayanan trauma akut secara nasional.

Rekomendasi strategis yang diperlukan mencakup pembentukan standar nasional pelayanan trauma, sistem audit dan evaluasi berkala, pembangunan pusat trauma regional, edukasi masyarakat yang masif, serta pengembangan sistem informasi trauma nasional. Dengan implementasi rekomendasi ini secara konsisten

dan terstruktur, pelayanan trauma akut di Indonesia diharapkan dapat semakin optimal, mengurangi angka kematian dan kecacatan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien trauma secara signifikan.

J. Referensi

- American College of Surgeons Committee on Trauma. (2018). *Advanced Trauma Life Support (ATLS): Student Course Manual* (10th ed.). American College of Surgeons.
- Arifin, M. Z., & Sukmawati, I. (2021). The golden period dalam penatalaksanaan trauma akut. *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 12(3), 115–122. <https://doi.org/10.33145/jki.v12i3.572>
- Badrianto, E., & Kusumawati, A. S. (2020). Penatalaksanaan trauma kepala dalam praktik klinis di instalasi gawat darurat. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 11(2), 67–75. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.682>
- Bruns, B., & Hauser, C. J. (2021). Principles of trauma management. In Feliciano, D. V., Mattox, K. L., & Moore, E. E. (Eds.), *Trauma* (9th ed., pp. 1–25). McGraw-Hill Education.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). (2020). Guidelines for Field Triage of Injured Patients. CDC Injury Center. Retrieved from <https://www.cdc.gov/fieldtriage/pdf/field-triage-guidelines-2020.pdf>
- Indonesian Ministry of Health (Kementerian Kesehatan RI). (2021). *Profil Kesehatan Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lee, J., Kim, J., & Park, E. (2021). Psychological first aid for disaster survivors: A systematic review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(19), 10373. <https://doi.org/10.3390/ijerph181910373>
- Mackway-Jones, K., Marsden, J., & Windle, J. (2021). *Emergency Triage: Manchester Triage Group* (4th ed.). Wiley-Blackwell.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Prinsip-prinsip Dasar* (5th ed.). Jakarta: Rineka Cipta.
- Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Situasi Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2021*. Kemenkes RI. Retrieved from <https://pusdatin.kemkes.go.id>
- Rosenberg, M. B., & Anderson, G. S. (2019). Communication and teamwork in emergency trauma care: A systematic review. *Journal of Trauma Nursing*, 26(4),

190–202. <https://doi.org/10.1097/JTN.0000000000000437>

Sari, Y., & Rahmawati, F. (2020). Analisis faktor risiko trauma akut akibat kecelakaan kerja. *Jurnal Keselamatan dan Kesehatan Kerja Indonesia*, 9(1), 43–51. <https://doi.org/10.20473/jk3i.v9i1.2020.43-51>

Smith, C., & Asher, S. (2020). Pharmacologic and non-pharmacologic strategies for acute pain management in trauma patients. *Journal of Emergency Nursing*, 46(5), 675–682. <https://doi.org/10.1016/j.jen.2020.04.010>

WHO. (2018). Global status report on road safety 2018. World Health Organization. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>

WHO. (2020). Guidelines for Essential Trauma Care. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/42565>

K. Glosarium

ABCDE

Suatu metode penilaian primer pasien trauma akut yang terdiri dari Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (gangguan neurologis), dan Exposure (penilaian tubuh secara menyeluruh).

Advanced Trauma Life Support (ATLS)

Protokol terstandar internasional yang digunakan untuk penanganan pasien trauma akut secara sistematis, dikembangkan oleh American College of Surgeons.

Blast injury (trauma ledakan)

Cedera kompleks akibat gelombang kejut dan tekanan tinggi yang terjadi pada ledakan, sering melibatkan cedera paru-paru, telinga bagian dalam, cedera otak traumatik, luka bakar, dan patah tulang multipel.

Blunt trauma (trauma tumpul)

Cedera akibat kekuatan atau benda tumpul yang mengenai tubuh tanpa menimbulkan luka terbuka, namun sering mengakibatkan cedera internal seperti patah tulang atau perdarahan internal.

Cedera otak traumatik

Cedera pada otak akibat trauma eksternal yang dapat menyebabkan gangguan neurologis, dari ringan hingga berat, dengan potensi komplikasi serius.

Chest tube (drainase toraks)

Tabung khusus yang digunakan untuk mengeluarkan udara atau darah dari rongga dada pada kondisi pneumotoraks atau hemotoraks.

Closed-loop communication

Metode komunikasi dalam tim medis yang memastikan setiap instruksi diterima dengan jelas dan dikonfirmasi kembali untuk menghindari kesalahan informasi.

Critical Care Pain Observation Tool (CPOT)

Alat pengukuran nyeri berbasis observasi pada pasien kritis yang tidak mampu berkomunikasi secara verbal.

Disability (D)

Evaluasi neurologis pasien dalam penanganan trauma akut, biasanya menggunakan Glasgow Coma Scale (GCS).

Exposure (E)

Tahap penilaian tubuh pasien secara menyeluruh untuk mendeteksi cedera tersembunyi, dengan tetap menjaga suhu tubuh pasien.

Fraktur terbuka (compound fracture)

Kondisi patah tulang yang disertai luka terbuka pada kulit, meningkatkan risiko infeksi serius dan memerlukan intervensi segera.

Gangguan stres akut (acute stress disorder)

Gangguan psikologis dengan gejala kecemasan berat dan reaksi emosional akibat trauma yang terjadi segera setelah peristiwa traumatik.

Golden period (periode emas)

Periode kritis dalam waktu kurang dari satu jam setelah cedera terjadi, di mana tindakan medis segera secara signifikan meningkatkan peluang hidup pasien trauma akut.

Glasgow Coma Scale (GCS)

Skala penilaian tingkat kesadaran pasien yang mencakup respon mata, verbal, dan motorik, digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan cedera kepala.

Hemotoraks

Kondisi adanya darah dalam rongga dada, biasanya akibat trauma dada, yang memerlukan intervensi segera berupa pemasangan chest tube.

Hypothermia

Penurunan suhu tubuh secara abnormal yang dapat memperburuk kondisi pasien trauma dan harus dicegah selama penanganan.

Imobilisasi

Tindakan untuk membatasi pergerakan tubuh atau ekstremitas untuk mencegah cedera tambahan pada trauma muskuloskeletal.

Injury Severity Score (ISS)

Alat bantu penilaian tingkat keparahan trauma berdasarkan lokasi dan derajat cedera pada berbagai bagian tubuh.

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Unit khusus di rumah sakit yang menangani pasien dalam kondisi kritis, termasuk trauma akut.

Manajemen nyeri multimodal

Pendekatan pengelolaan nyeri yang mengkombinasikan terapi farmakologi (opioid dan non-opioid) dan non-farmakologi secara simultan.

Numerical Rating Scale (NRS)

Metode penilaian nyeri dengan angka dari 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri paling hebat yang pernah dirasakan).

Pneumotoraks

Kondisi udara dalam rongga dada yang menyebabkan kolaps paru-paru dan gangguan pernapasan.

Psychological First Aid (PFA)

Intervensi psikologis awal untuk mengurangi stres akut, mendorong adaptasi positif, dan mencegah gangguan psikologis lebih lanjut pada pasien trauma.

Revised Trauma Score (RTS)

Skor penilaian awal trauma berdasarkan tekanan darah sistolik, frekuensi pernapasan, dan Glasgow Coma Scale, untuk prediksi prognosis pasien trauma akut.

Secondary survey (penilaian sekunder)

Evaluasi terperinci dari kepala hingga kaki pasien trauma setelah kondisi stabil, untuk mengidentifikasi cedera lain yang memerlukan penanganan lanjutan.

Trauma ringan

Cedera yang umumnya tidak menyebabkan gangguan fungsi organ secara signifikan, dapat ditangani dengan intervensi medis minimal.

Trauma sedang

Cedera yang menyebabkan gangguan fungsi organ moderat tetapi tidak langsung mengancam nyawa, memerlukan penanganan yang lebih intensif dibanding trauma ringan.

Trauma berat

Cedera serius yang mengancam nyawa, memerlukan penanganan medis segera, terstruktur, dan multidisiplin, sering melibatkan cedera kepala berat atau perdarahan masif.

Trauma tembus (penetrating trauma)

Cedera akibat benda tajam atau proyektil yang menembus tubuh, menyebabkan luka terbuka dan kerusakan jaringan internal yang signifikan.

Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)

Terapi stimulasi listrik ringan melalui kulit untuk mengurangi nyeri melalui mekanisme inhibisi nyeri alami tubuh.

Ultrasonografi FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)

Pemeriksaan ultrasonografi cepat yang digunakan untuk mendeteksi perdarahan internal pada pasien trauma akut.

Visual Analog Scale (VAS)

Metode penilaian nyeri menggunakan garis horizontal di mana pasien menunjukkan tingkat intensitas nyeri yang dialami.

CHAPTER 5

ASUHAN KEPERAWATAN KEGAWATDARURATAN

RESPIRASI

Hamdan Nur.S.Kep., Ns., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kegawatdaruratan respirasi merupakan kondisi klinis kritis yang timbul secara tiba-tiba atau cepat dan berpotensi mengancam nyawa jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Kondisi ini ditandai oleh gangguan fungsi pernapasan yang serius sehingga menyebabkan tubuh tidak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup atau tidak mampu mengeluarkan karbon dioksida secara efektif. Beberapa manifestasi klinis yang sering muncul antara lain sesak napas hebat, sianosis, penurunan kesadaran, hingga kondisi gagal napas akut yang berisiko tinggi menyebabkan kematian bila tidak segera diatasi. Pemahaman terhadap konsep dasar ini sangat penting bagi perawat agar mampu mengidentifikasi secara dini gejala dan tanda kegawatan, serta melakukan intervensi yang cepat dan efektif untuk meningkatkan peluang keberhasilan penanganan pasien.

Dalam konteks epidemiologi, kegawatdaruratan respirasi merupakan masalah kesehatan global dengan insiden yang signifikan, baik di negara maju maupun negara berkembang. World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa gangguan pernapasan akut merupakan salah satu penyebab utama kunjungan pasien ke unit gawat darurat serta rawat inap di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Berdasarkan data terbaru dari berbagai studi epidemiologi, angka kejadian gangguan respirasi akut seperti serangan asma akut, eksaserbasi penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), edema paru akut, emboli paru, serta sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) cenderung meningkat, dipicu oleh berbagai faktor seperti meningkatnya polusi udara, gaya hidup tidak sehat, penyakit kronis penyerta, hingga infeksi saluran pernapasan berat. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dan pengelolaan yang optimal dari seluruh tenaga kesehatan, terutama perawat yang berada di garis depan dalam memberikan asuhan langsung kepada pasien.

Dalam menghadapi kegawatdaruratan respirasi, asuhan keperawatan memiliki peran yang sangat vital, mengingat kecepatan serta ketepatan tindakan menjadi faktor penentu utama keselamatan pasien. Keterlambatan maupun ketidaktepatan dalam memberikan intervensi dapat berakibat fatal, karena otak dan organ vital

lainnya sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen. Oleh sebab itu, perawat yang bertugas di unit gawat darurat dituntut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam, keterampilan klinis yang terlatih, serta kemampuan berpikir kritis yang tinggi agar mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Selain itu, perawat juga perlu memiliki kepekaan klinis yang tajam dalam mengidentifikasi tanda-tanda dini dari gangguan respirasi berat sehingga intervensi dapat segera dilakukan sebelum kondisi pasien semakin memburuk. Di samping kemampuan teknis, kemampuan komunikasi serta kolaborasi tim juga sangat dibutuhkan untuk memastikan koordinasi yang optimal di antara anggota tim pelayanan kesehatan, sehingga penatalaksanaan kegawatdaruratan respirasi berjalan secara terintegrasi dan efektif.

Dengan demikian, melalui pendahuluan ini, pembaca diharapkan mampu memahami bahwa asuhan keperawatan pada kegawatdaruratan respirasi bukan hanya sekadar tindakan rutin, melainkan sebuah praktik klinis kompleks yang menuntut kompetensi tinggi, kesiagaan, dan responsivitas dari perawat guna memberikan kontribusi terbaik dalam menyelamatkan nyawa pasien serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Penjelasan mendalam yang disajikan dalam bab ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta keterampilan para perawat dalam mengelola pasien dengan kondisi kegawatan respirasi, sehingga dapat secara efektif meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan pasien di lingkungan klinis maupun komunitas.

B. Anatomi dan Fisiologi Sistem Pernapasan

Pemahaman mendalam mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan sangat penting bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang efektif pada pasien dengan kegawatdaruratan respirasi. Sistem pernapasan manusia terdiri atas struktur kompleks yang bekerja secara harmonis untuk memastikan oksigen dapat masuk ke dalam tubuh serta karbon dioksida dikeluarkan secara optimal.

Saluran napas manusia secara umum terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu saluran napas atas dan saluran napas bawah. Saluran napas atas terdiri dari hidung, rongga hidung, sinus paranasal, faring, dan laring. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk udara, tempat penyaringan partikel kotoran, pelembapan, serta penghangatan udara yang masuk sebelum menuju paru-paru. Faring berfungsi sebagai jalur udara dan makanan, sedangkan laring berperan sebagai pintu pemisah antara jalur udara dan makanan serta merupakan tempat produksi suara manusia.

Saluran napas bawah terdiri dari trakea, bronkus, bronkiolus, hingga alveoli paru-paru. Trakea merupakan tabung kaku namun fleksibel yang dilapisi cincin tulang rawan untuk menjaga saluran napas agar tetap terbuka. Trakea bercabang

menjadi dua bronkus utama yang masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus ini kemudian bercabang lebih kecil lagi menjadi bronkiolus yang berakhir pada alveoli. Alveoli adalah kantung udara kecil yang menjadi unit fungsional paru-paru tempat terjadinya pertukaran gas. Dinding alveoli sangat tipis, sehingga memungkinkan oksigen dan karbon dioksida berdifusi dengan mudah antara alveoli dan pembuluh darah kapiler paru.

Proses fisiologis yang paling esensial dalam sistem pernapasan adalah pertukaran gas. Pertukaran gas terjadi melalui mekanisme difusi di alveoli. Pada saat udara masuk melalui saluran napas ke alveoli, oksigen dari udara berdifusi melewati membran alveoli yang tipis menuju kapiler paru yang mengandung darah yang rendah oksigen. Secara bersamaan, karbon dioksida dari darah berdifusi ke dalam alveoli untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi. Proses difusi ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida antara alveoli dan kapiler darah. Pertukaran gas yang efektif bergantung pada integritas alveoli, membran alveolar-kapiler, aliran darah paru yang cukup, serta ventilasi alveolar yang optimal.

Selain struktur anatomi dan mekanisme pertukaran gas, sistem respirasi juga memiliki mekanisme regulasi yang kompleks untuk mempertahankan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh pada rentang yang normal. Regulasi ini dilakukan oleh pusat pernapasan yang terletak di medula oblongata dan pons pada batang otak. Pusat pernapasan menerima informasi tentang kadar gas darah melalui kemoreseptor perifer yang terletak di arkus aorta dan arteri karotis, serta kemoreseptor sentral di medula oblongata. Jika terjadi peningkatan kadar karbon dioksida atau penurunan oksigen dalam darah, pusat pernapasan akan meningkatkan frekuensi dan kedalaman pernapasan agar tubuh kembali ke kondisi normal.

Dalam situasi normal, regulasi respirasi berjalan secara otomatis tanpa memerlukan upaya sadar manusia. Namun, dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi seperti pada hipoksia berat atau gangguan ventilasi akut, tubuh akan mengaktifkan berbagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan suplai oksigen ke jaringan vital. Kompensasi ini antara lain berupa peningkatan frekuensi pernapasan (takipnea), peningkatan kedalaman pernapasan (hiperventilasi), serta penggunaan otot-otot bantu pernapasan seperti otot sternokleidomastoideus, interkostal, dan otot abdomen untuk membantu proses ventilasi. Meskipun mekanisme ini bertujuan membantu tubuh mengatasi gangguan respirasi, jika gangguan terlalu berat atau berkepanjangan, mekanisme kompensasi ini dapat mengalami kegagalan yang berujung pada kondisi gagal napas akut.

Oleh karena itu, pemahaman mengenai anatomi, fisiologi, dan mekanisme regulasi sistem pernapasan sangat penting bagi perawat dalam merancang intervensi keperawatan yang cepat dan tepat untuk membantu tubuh pasien mempertahankan atau mengembalikan fungsi respirasi ke kondisi optimal. Pengetahuan ini menjadi dasar bagi perawat untuk melakukan evaluasi klinis, mengidentifikasi perubahan dini dalam status respirasi pasien, serta memutuskan tindakan intervensi terbaik untuk mencegah kerusakan jaringan lebih lanjut atau komplikasi yang lebih serius

C. Patofisiologi dan Klasifikasi Kegawatdaruratan Respirasi

Kegawatdaruratan respirasi terjadi sebagai akibat gangguan proses fisiologis normal dalam sistem pernapasan, baik pada proses ventilasi, difusi, maupun perfusi. Ketiga mekanisme ini harus berjalan dengan harmonis untuk menjaga homeostasis oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh. Gangguan yang terjadi pada salah satu atau beberapa dari ketiga mekanisme ini akan menyebabkan kegawatan respirasi, sehingga sangat penting bagi perawat untuk memahami secara mendalam patofisiologi masing-masing gangguan tersebut.

Gangguan ventilasi merupakan salah satu klasifikasi kegawatdaruratan respirasi yang ditandai oleh hambatan masuk dan keluarnya udara dari paru-paru. Salah satu penyebab utama gangguan ini adalah obstruksi jalan napas, baik yang disebabkan oleh benda asing, produksi lendir yang berlebihan, edema jaringan lunak, hingga spasme otot-otot saluran napas seperti yang terjadi pada kasus asma akut. Pada kasus obstruksi jalan napas oleh benda asing atau sekret, aliran udara akan terhambat sehingga mengurangi jumlah oksigen yang mencapai alveoli. Akibatnya, pasien mengalami kesulitan bernapas, hipoksia, dan jika kondisi ini berlanjut, bisa berujung pada henti napas. Sementara pada kasus asma akut, inflamasi yang terjadi pada bronkus menyebabkan bronkokonstriksi hebat, produksi lendir berlebihan, serta pembengkakan dinding bronkus. Hal ini secara signifikan menyempitkan saluran udara sehingga pasien mengalami sesak napas berat, mengi (wheezing), dan peningkatan usaha napas yang nyata. Tanpa intervensi segera, kondisi ini dapat berlanjut menjadi gagal napas akut yang mengancam nyawa.

Gangguan berikutnya yaitu gangguan difusi. Gangguan ini melibatkan hambatan dalam pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara alveoli paru-paru dengan darah kapiler paru. Salah satu bentuk kegawatdaruratan yang sering ditemui adalah edema paru akut. Edema paru akut terjadi ketika cairan dari pembuluh darah paru merembes ke dalam alveoli akibat peningkatan tekanan hidrostatik pada pembuluh darah paru. Hal ini menyebabkan alveoli yang seharusnya berisi udara menjadi terisi cairan, sehingga secara signifikan

mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Pasien dengan edema paru akut akan menunjukkan gejala berupa sesak napas berat, batuk produktif berbusa berwarna merah muda (pink frothy sputum), serta terdengar bunyi napas tambahan berupa ronki basah halus. Jika tidak segera ditangani, pasien berisiko tinggi mengalami gagal napas akut dan kematian.

Selain edema paru akut, gangguan difusi lain yang penting untuk diperhatikan adalah Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). ARDS merupakan sindrom klinis yang muncul secara tiba-tiba dengan karakteristik utama berupa peradangan luas pada jaringan paru-paru, yang dipicu oleh cedera paru akut akibat infeksi, trauma berat, aspirasi cairan lambung, atau sepsis. Pada ARDS, terjadi peningkatan permeabilitas membran alveolar-kapiler sehingga cairan plasma dan sel inflamasi masuk ke dalam alveoli, mengganggu proses difusi oksigen ke darah secara signifikan. Pasien ARDS akan mengalami hipoksia yang sangat berat yang sulit diperbaiki hanya dengan terapi oksigen biasa, sehingga membutuhkan ventilasi mekanik khusus dengan strategi tekanan tinggi dan positif (positive end-expiratory pressure/PEEP) untuk mempertahankan alveoli tetap terbuka dan proses difusi dapat tetap berjalan.

Kelompok kegawatdaruratan respirasi terakhir adalah gangguan perfusi. Gangguan ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke paru-paru sehingga proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah kapiler terganggu secara signifikan. Salah satu penyebab utama gangguan perfusi adalah emboli paru akut, yang terjadi ketika gumpalan darah atau embolus menyumbat pembuluh darah paru secara tiba-tiba. Sumbatan ini menghambat aliran darah yang menuju paru-paru, mengakibatkan sebagian besar alveoli tidak mendapatkan suplai darah. Walaupun udara masih bisa masuk ke alveoli, oksigen tidak bisa berdifusi ke darah akibat tidak ada aliran darah yang cukup di area tersebut. Pasien dengan emboli paru akut biasanya menunjukkan sesak napas hebat, nyeri dada yang mendadak, batuk berdarah (hemoptisis), serta penurunan tekanan darah yang cepat akibat syok. Kondisi ini merupakan kegawatan medis yang membutuhkan penanganan segera dengan antikoagulan atau trombolitik untuk mengatasi sumbatan dan mengembalikan perfusi darah paru.

Gangguan perfusi juga dapat bermanifestasi sebagai syok respirasi, yaitu kondisi gagal napas berat yang disertai penurunan tekanan darah sistemik akibat gangguan sirkulasi paru. Syok respirasi terjadi ketika gangguan pernapasan sudah demikian beratnya, hingga menyebabkan hipoksia jaringan yang luas dan kerusakan berbagai organ vital. Pasien syok respirasi akan menunjukkan penurunan kesadaran, hipotensi berat, denyut jantung cepat namun lemah, sianosis, serta penurunan fungsi organ tubuh secara menyeluruh. Intervensi cepat dengan terapi oksigen

agresif, ventilasi mekanik, serta stabilisasi hemodinamik melalui cairan intravena atau vasopressor menjadi prioritas utama dalam penanganan kondisi ini.

Dengan memahami patofisiologi dan klasifikasi dari berbagai jenis kegawatdaruratan respirasi secara mendalam, perawat akan mampu mengenali tanda dan gejala secara dini serta dapat mengambil keputusan klinis yang tepat dan cepat. Hal ini penting guna mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelamatkan nyawa pasien di situasi kegawatdaruratan.

D. Penilaian Cepat dan Identifikasi Kegawatan Respirasi

Dalam situasi kegawatdaruratan respirasi, waktu adalah faktor krusial yang menentukan keberhasilan penanganan pasien. Oleh karena itu, kemampuan perawat dalam melakukan penilaian cepat untuk mengidentifikasi kondisi pasien secara dini sangatlah penting. Salah satu pendekatan klinis yang telah terbukti efektif dalam penilaian cepat pasien yang mengalami gangguan respirasi adalah metode ABCDE. Pendekatan ini merupakan metode sistematis yang mencakup Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (sirkulasi darah), Disability (fungsi neurologis), dan Exposure (paparan lingkungan).

Penilaian awal dengan metode ABCDE dimulai dengan evaluasi Airway, yaitu memastikan jalan napas pasien bebas dari hambatan atau sumbatan. Perawat harus segera memeriksa apakah pasien mampu bernapas secara spontan atau apakah ada hambatan seperti benda asing, produksi sekret berlebihan, atau edema jaringan yang mengganggu jalannya udara ke paru-paru. Tanda-tanda obstruksi jalan napas seperti stridor (bunyi napas kasar bernada tinggi), sianosis di bibir atau wajah, serta ketidakmampuan pasien untuk berbicara atau batuk efektif, harus segera dikenali dan diatasi.

Selanjutnya, perawat melakukan penilaian Breathing, yaitu mengevaluasi efektivitas ventilasi atau pernapasan pasien. Penilaian ini meliputi frekuensi pernapasan, kedalaman napas, pola pernapasan, serta kerja otot-otot bantu pernapasan. Pasien dengan kegawatan respirasi biasanya memperlihatkan peningkatan frekuensi napas (takipnea), napas dangkal atau tidak teratur, penggunaan otot-otot bantu seperti otot interkostal, otot sternokleidomastoideus, dan retraksi dada yang nyata. Selain itu, perawat perlu mengobservasi suara napas tambahan seperti mengi (wheezing), ronki, maupun krepitasi, yang menandakan adanya gangguan serius pada saluran napas atau jaringan paru-paru.

Setelah penilaian pernapasan, langkah berikutnya adalah penilaian Circulation, yaitu mengevaluasi status sirkulasi pasien, termasuk tanda vital seperti denyut jantung, tekanan darah, dan pengisian kapiler perifer (capillary refill time). Gangguan respirasi berat sering kali memicu perubahan dalam sistem sirkulasi, seperti peningkatan denyut jantung (takikardia), penurunan tekanan darah (hipotensi), serta ekstremitas yang dingin dan pucat sebagai tanda hipoksia jaringan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa gangguan respirasi mulai mempengaruhi stabilitas hemodinamik pasien, sehingga tindakan segera diperlukan untuk mencegah syok atau komplikasi lebih lanjut.

Penilaian selanjutnya adalah Disability, yang bertujuan untuk menilai fungsi neurologis pasien. Penurunan suplai oksigen akibat kegawatan respirasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan kesadaran dan penurunan fungsi neurologis secara cepat. Perawat dapat menggunakan metode sederhana seperti AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive) atau Glasgow Coma Scale (GCS) untuk menentukan tingkat kesadaran pasien. Pasien dengan hipoksia berat sering kali menunjukkan penurunan kesadaran, gelisah, kebingungan, hingga hilangnya respons sama sekali, yang menandakan kebutuhan mendesak akan intervensi lanjutan.

Langkah terakhir dalam pendekatan ABCDE adalah Exposure, yaitu mengevaluasi paparan lingkungan serta kondisi tubuh pasien secara menyeluruh. Pada tahap ini, perawat harus mengecek apakah ada cedera tambahan, ruam kulit, perdarahan, atau kondisi khusus lain yang mungkin memperparah kegawatan respirasi. Pemeriksaan fisik secara menyeluruh dengan membuka pakaian pasien dan menjaga privasi serta suhu tubuh pasien sangat penting dilakukan, karena paparan lingkungan yang ekstrem seperti suhu dingin atau panas dapat memperberat kondisi respirasi pasien.

Selain metode ABCDE, perawat juga harus mengenali tanda dan gejala umum kegawatan respirasi secara dini. Tanda-tanda umum yang sering muncul pada pasien antara lain napas cepat, sesak napas berat, sianosis perifer maupun sentral, penggunaan otot bantu napas, retraksi interkostal (tarikan dinding dada), kegelisahan atau agitasi yang meningkat, serta perubahan kesadaran. Gejala-gejala ini dapat muncul secara mendadak dan berkembang dengan cepat, sehingga perawat perlu memiliki kewaspadaan tinggi dalam memonitor kondisi pasien secara terus-menerus.

Untuk membantu memperkuat identifikasi kondisi respirasi pasien secara objektif, perawat juga perlu menggunakan instrumen dan alat penunjang pemeriksaan respirasi. Salah satu instrumen utama yang digunakan adalah pulse oximetry, yang secara non-invasif mampu mendeteksi saturasi oksigen dalam darah

pasien secara real-time. Nilai saturasi oksigen yang rendah (biasanya di bawah 90%) merupakan indikator kuat bahwa pasien sedang mengalami hipoksia akut yang membutuhkan intervensi segera. Selain pulse oximetry, analisis gas darah arteri (AGDA) juga sangat penting dilakukan pada kondisi kritis untuk mengetahui secara lebih akurat tingkat oksigenasi, ventilasi, dan keseimbangan asam-basa pasien. Pemeriksaan AGDA dapat mengidentifikasi adanya hipoksemia, hiperkapnia, atau asidosis respiratorik, yang semuanya merupakan indikator beratnya kegawatan respirasi.

Alat penunjang lain yang penting untuk digunakan adalah pemeriksaan radiologi seperti foto toraks atau pencitraan CT-scan dada, terutama pada kasus yang kompleks atau yang tidak jelas penyebabnya. Pemeriksaan ini membantu perawat dan tim medis dalam menentukan penyebab gangguan respirasi secara spesifik seperti edema paru, pneumotoraks, emboli paru, pneumonia berat, atau ARDS, sehingga intervensi yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.

Dengan memahami secara detail mengenai penilaian cepat menggunakan pendekatan ABCDE, mengenali tanda dan gejala umum, serta menggunakan instrumen penunjang pemeriksaan respirasi, perawat dapat mengidentifikasi secara dini kondisi kegawatdaruratan respirasi dan segera menentukan tindakan intervensi terbaik. Keterampilan ini secara nyata meningkatkan peluang kesintasan pasien dan mencegah komplikasi serius yang mengancam nyawa.

E. Intervensi Keperawatan pada Kondisi Kegawatdaruratan Respirasi

Intervensi keperawatan dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi merupakan rangkaian tindakan kritis yang dilakukan untuk segera mengatasi gangguan fungsi pernapasan pasien. Tujuan utama dari intervensi ini adalah mengembalikan fungsi respirasi, meningkatkan suplai oksigen ke jaringan vital, serta mencegah komplikasi lanjutan yang dapat mengancam nyawa pasien. Intervensi keperawatan yang efektif mencakup manajemen airway, terapi oksigen dan ventilasi mekanik, pengaturan posisi pasien, teknik pernapasan khusus, serta manajemen farmakologi.

Langkah pertama yang esensial dalam intervensi keperawatan adalah manajemen airway atau pengelolaan jalan napas. Pembebasan jalan napas dilakukan dengan memastikan jalan napas pasien bebas dari hambatan seperti benda asing, lendir, atau edema jaringan lunak. Perawat dapat melakukan tindakan manual seperti head tilt-chin lift atau jaw thrust untuk membuka jalan napas pada pasien yang tidak sadar atau mengalami penurunan kesadaran. Jika terdapat sekret atau cairan, perawat perlu segera melakukan suctioning (pengisapan lendir) menggunakan alat hisap yang steril. Dalam kondisi yang lebih serius, terutama jika tindakan manual tidak berhasil membuka jalan napas, intubasi endotrakeal mungkin

diperlukan. Intubasi adalah tindakan memasukkan pipa endotrakeal melalui mulut atau hidung pasien ke dalam trakea untuk menjamin jalan napas yang terbuka secara permanen selama kondisi kritis berlangsung. Pada kondisi di mana intubasi tidak memungkinkan atau terdapat hambatan signifikan pada laring atau saluran napas atas, trakeostomi emergensi—yaitu tindakan bedah kecil yang membuat lubang langsung pada trakea—dapat dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien dan menjamin jalan napas tetap terbuka.

Setelah memastikan jalan napas terbebas dari hambatan, langkah intervensi selanjutnya adalah memberikan terapi oksigen dan ventilasi mekanik. Terapi oksigen bertujuan meningkatkan kadar oksigen dalam darah pasien secara cepat, memperbaiki hipoksia, dan mencegah kerusakan organ lebih lanjut akibat kekurangan oksigen. Terapi oksigen dapat diberikan melalui berbagai metode sederhana seperti nasal cannula, masker oksigen, masker reservoir (non-rebreathing mask), atau metode yang lebih lanjut seperti Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) dan ventilasi mekanik non-invasif (NIV). Ventilasi non-invasif seperti BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure) sangat bermanfaat pada pasien yang mengalami kesulitan bernapas namun masih memiliki jalan napas yang paten dan respons pernapasan spontan. Pada pasien yang tidak mampu mempertahankan pernapasan spontan atau mengalami gangguan berat seperti edema paru akut berat, gagal napas akut, atau ARDS, ventilasi mekanik invasif melalui intubasi endotrakeal dengan ventilator sangat diperlukan. Ventilasi mekanik invasif memungkinkan kontrol penuh atas volume, tekanan, dan laju pernapasan, sehingga memfasilitasi pemulihan fungsi paru yang lebih efektif.

Intervensi lain yang penting dalam meningkatkan efektivitas ventilasi adalah pengaturan posisi tubuh pasien serta teknik pernapasan yang tepat. Posisi tubuh pasien memiliki pengaruh signifikan terhadap distribusi udara dan perfusi paru. Pada umumnya, pasien dengan gangguan respirasi akut dianjurkan berada dalam posisi semi-Fowler hingga Fowler tinggi, yaitu posisi duduk atau setengah duduk dengan sudut antara 45–90 derajat. Posisi ini membantu mengurangi tekanan pada diafragma, meningkatkan ekspansi paru, memperlancar drainase sekret, serta memaksimalkan kapasitas ventilasi paru-paru. Untuk kondisi tertentu seperti ARDS, posisi prone (telungkup) juga digunakan secara efektif untuk memperbaiki oksigenasi dengan meredistribusi ventilasi ke area paru yang lebih baik perfusinya. Di samping itu, perawat juga dapat membimbing pasien menggunakan teknik pernapasan seperti pursed-lip breathing (pernapasan bibir mengerucut) untuk mengurangi dispnea, atau teknik pernapasan diafragma untuk memperkuat kerja otot pernapasan dan meningkatkan ventilasi alveolar secara optimal.

Manajemen farmakologi juga memegang peranan penting dalam intervensi kegawatdaruratan respirasi. Penggunaan obat-obatan bertujuan mengurangi gejala akut, memperbaiki mekanisme pernapasan, serta mengatasi penyebab utama dari kegawatan respirasi. Pada kasus bronkokonstriksi akut seperti pada asma berat atau eksaserbasi PPOK, perawat akan segera memberikan bronkodilator inhalasi seperti salbutamol atau ipratropium bromida melalui nebulizer atau inhaler untuk melebarkan saluran napas yang mengalami spasme. Kortikosteroid sistemik seperti hidrokortison atau metilprednisolon sering digunakan untuk mengurangi inflamasi jalan napas secara cepat dan efektif pada kasus inflamasi berat. Dalam kasus edema paru akut akibat gagal jantung, perawat akan memberikan diuretik seperti furosemid untuk menurunkan beban cairan paru-paru. Pada kasus yang berkaitan dengan emboli paru akut, penggunaan antikoagulan (misalnya heparin) atau trombolitik diperlukan untuk menghancurkan gumpalan darah yang menghambat perfusi paru. Selain itu, antibiotik diberikan jika kegawatan respirasi disebabkan oleh infeksi berat seperti pneumonia atau sepsis paru.

Secara keseluruhan, intervensi keperawatan dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi memerlukan keterampilan klinis yang tinggi, kesiapan mental, serta kolaborasi erat dengan tenaga kesehatan lainnya. Pemahaman yang komprehensif tentang manajemen airway, teknik ventilasi mekanik, terapi oksigen, pengaturan posisi pasien, teknik pernapasan khusus, serta penggunaan farmakologi secara tepat adalah faktor penentu utama yang memastikan pasien mendapatkan asuhan optimal. Dengan tindakan intervensi yang cepat, tepat, dan terintegrasi, pasien dengan kondisi kegawatdaruratan respirasi memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk pulih dengan cepat dan terhindar dari komplikasi serius yang mengancam jiwa.

F. Kolaborasi Interprofesional dalam Penanganan Kegawatdaruratan Respirasi

Penanganan pasien dengan kondisi kegawatdaruratan respirasi bukan merupakan tanggung jawab satu profesi kesehatan saja, melainkan memerlukan kolaborasi yang efektif dan terpadu antara berbagai disiplin ilmu kesehatan. Pendekatan interprofesional dalam kondisi kegawatan respirasi sangat menentukan efektivitas tindakan yang dilakukan, kecepatan respons klinis, serta hasil akhir dari penanganan pasien. Kolaborasi ini tidak terbatas pada tim perawat saja, tetapi melibatkan berbagai profesional kesehatan lain seperti dokter spesialis gawat darurat, dokter spesialis paru, ahli anestesi, tenaga farmasi, ahli fisioterapi, ahli gizi, hingga tenaga penunjang diagnostik seperti radiografer dan petugas laboratorium.

Koordinasi dan kolaborasi yang efektif di antara tim medis dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting, terutama dalam menghadapi situasi yang dinamis, kompleks, dan penuh tekanan di unit gawat darurat. Dalam konteks ini, perawat memiliki peran vital sebagai anggota tim yang berada di garis depan pelayanan pasien. Perawat berfungsi sebagai penghubung utama yang memastikan bahwa informasi klinis terbaru tentang kondisi pasien tersedia secara cepat dan akurat kepada seluruh anggota tim. Selain itu, perawat juga harus mampu mengidentifikasi kebutuhan pasien dengan tepat waktu dan mengkomunikasikan rekomendasi intervensi secara jelas kepada dokter serta tim kesehatan lainnya. Misalnya, ketika pasien membutuhkan tindakan emergensi seperti intubasi atau ventilasi mekanik, perawat harus segera berkoordinasi dengan dokter dan ahli anestesi untuk memastikan tindakan tersebut dilakukan dengan cepat dan efisien.

Dalam situasi kegawatdaruratan respirasi, komunikasi yang efektif menjadi kunci utama keberhasilan kolaborasi interprofesional. Komunikasi yang buruk atau tidak terorganisasi dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, keterlambatan intervensi, atau bahkan komplikasi serius hingga mengancam keselamatan pasien. Oleh karena itu, penerapan teknik komunikasi standar seperti Situation, Background, Assessment, Recommendation (SBAR) menjadi hal yang sangat penting. Melalui pendekatan SBAR, perawat mampu menyampaikan informasi kritis secara terstruktur dan jelas kepada anggota tim lainnya, sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan cepat, akurat, dan tanpa kesalahan interpretasi. Selain SBAR, perawat juga perlu menerapkan komunikasi yang asertif, tegas, namun tetap profesional, terutama ketika ada situasi darurat yang membutuhkan tindakan segera atau ketika ada ketidakjelasan dalam instruksi yang diterima.

Selain koordinasi dan komunikasi, perawat memiliki peran penting sebagai anggota dari Tim Tanggap Cepat atau Rapid Response Team (RRT). Tim ini merupakan kelompok khusus yang dirancang untuk memberikan respons cepat terhadap pasien yang mengalami penurunan kondisi klinis secara mendadak di berbagai area rumah sakit. Anggota RRT biasanya terdiri dari dokter gawat darurat, perawat dengan pelatihan khusus dalam perawatan kritis, ahli anestesi, dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan. Dalam konteks kegawatdaruratan respirasi, perawat dalam tim ini bertugas mengidentifikasi secara dini pasien yang kondisinya mengalami deteriorasi atau memburuk secara tiba-tiba. Mereka bertanggung jawab untuk segera mengambil tindakan awal seperti memastikan jalan napas yang paten, memulai terapi oksigen, mempersiapkan peralatan intubasi atau ventilasi, serta memberikan intervensi awal sesuai protokol gawat darurat. Peran proaktif perawat dalam RRT sangat menentukan kecepatan identifikasi masalah dan intervensi awal

yang dilakukan, sehingga mencegah pasien mengalami gagal napas atau henti napas yang berpotensi fatal.

Perawat dalam tim tanggap cepat juga memiliki tanggung jawab dalam dokumentasi yang akurat dan rinci terkait perubahan kondisi pasien, intervensi yang telah diberikan, serta respons pasien terhadap tindakan yang dilakukan. Dokumentasi ini sangat penting sebagai dasar komunikasi dan evaluasi lanjutan oleh tim medis serta sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan klinis berikutnya. Selain itu, perawat juga memiliki tanggung jawab edukatif untuk memberikan informasi dan dukungan kepada keluarga pasien, menjelaskan secara jelas tindakan yang dilakukan, serta melibatkan keluarga dalam pengambilan keputusan jika diperlukan.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam penanganan kegawatdaruratan respirasi sangat bergantung pada kolaborasi interprofesional yang kuat, koordinasi tim yang optimal, serta komunikasi yang jelas dan efektif. Dalam konteks ini, perawat memegang peranan penting sebagai penghubung antar profesi, pemberi asuhan langsung kepada pasien, anggota kunci dalam tim tanggap cepat, serta advokat utama pasien dalam situasi darurat. Dengan kolaborasi interprofesional yang kuat dan harmonis, peluang keberhasilan dalam menyelamatkan nyawa pasien serta mencegah komplikasi berat menjadi jauh lebih besar, sehingga kualitas asuhan keperawatan dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi dapat dioptimalkan secara maksimal.

G. Pemantauan dan Evaluasi Pasien Pasca-Intervensi

Pemantauan dan evaluasi kondisi pasien setelah diberikan intervensi dalam kegawatdaruratan respirasi adalah tahapan penting yang menentukan efektivitas tindakan yang telah dilakukan. Pasien dengan kondisi respirasi kritis memiliki risiko tinggi untuk mengalami perubahan kondisi secara cepat, sehingga pemantauan yang ketat dan evaluasi yang terencana perlu dilakukan secara konsisten. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa intervensi yang telah diberikan berhasil memperbaiki kondisi respirasi pasien, mengidentifikasi secara dini munculnya komplikasi, serta mendokumentasikan seluruh proses perawatan secara akurat agar kesinambungan perawatan tetap terjaga.

Dalam proses evaluasi, perawat perlu mengetahui dengan jelas berbagai indikator keberhasilan intervensi respirasi yang diberikan. Indikator-indikator tersebut dapat mencakup perbaikan tanda-tanda klinis, parameter fisiologis, serta hasil dari pemeriksaan laboratorium atau radiologi. Salah satu indikator yang paling umum digunakan adalah perbaikan saturasi oksigen pasien. Pasien dikatakan membaik jika saturasi oksigennya meningkat secara stabil hingga mencapai target

yang diharapkan (biasanya $\geq 94\%$), tanpa memerlukan peningkatan dosis atau intensitas terapi oksigen tambahan. Selain itu, laju pernapasan pasien juga menjadi indikator penting. Penurunan laju pernapasan dari kondisi takipnea berat (lebih dari 30 kali per menit) menuju frekuensi normal (12–20 kali per menit) merupakan tanda positif yang menunjukkan efektivitas intervensi. Indikator lainnya seperti penurunan kerja pernapasan (tidak lagi menggunakan otot bantu napas), stabilisasi tanda vital (tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh), perbaikan pola napas, serta peningkatan kesadaran pasien juga menandakan bahwa intervensi yang diberikan berhasil mengatasi kegawatan respirasi secara efektif.

Selain memantau keberhasilan intervensi, perawat juga bertanggung jawab untuk secara proaktif melakukan monitoring terhadap kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi akibat intervensi keperawatan. Intervensi respirasi, terutama yang bersifat invasif seperti intubasi endotrakeal, ventilasi mekanik, atau trakeostomi, berisiko menimbulkan beberapa komplikasi serius. Komplikasi yang umum ditemui antara lain trauma pada saluran napas akibat intubasi atau trakeostomi, infeksi saluran napas seperti pneumonia terkait ventilator (Ventilator-Associated Pneumonia, VAP), barotrauma paru (cedera paru akibat tekanan tinggi dari ventilasi mekanik), serta aspirasi cairan atau sekret ke dalam paru-paru. Oleh karena itu, perawat harus rutin melakukan pemeriksaan fisik, memonitor tanda-tanda infeksi seperti demam atau peningkatan jumlah sekret paru, serta mengevaluasi hasil pemeriksaan radiologi secara periodik untuk mendeteksi komplikasi secara dini. Identifikasi komplikasi yang cepat memungkinkan tim medis mengambil langkah korektif segera, sehingga dampak negatif terhadap kondisi pasien dapat diminimalkan.

Proses pemantauan dan evaluasi ini tidak akan lengkap tanpa dokumentasi yang jelas, akurat, dan komprehensif terkait kondisi pasien. Dokumentasi keperawatan yang baik harus mencakup catatan rinci mengenai intervensi yang dilakukan, waktu pemberian intervensi, respons klinis pasien terhadap tindakan tersebut, serta adanya perubahan kondisi pasien, baik perbaikan maupun komplikasi. Dokumentasi ini harus disusun secara sistematis dalam rekam medis pasien, agar seluruh tim medis dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien dapat dengan mudah memahami kondisi terkini pasien, tindakan yang sudah diberikan, serta rencana perawatan selanjutnya.

Dokumentasi yang jelas juga mencakup pelaporan lisan atau tertulis yang efektif antar shift perawat dan antar anggota tim interprofesional. Pelaporan kondisi pasien kepada tim berikutnya merupakan elemen krusial dalam menjaga kesinambungan perawatan, khususnya dalam unit perawatan intensif atau unit gawat darurat yang dinamis. Pelaporan tersebut harus menggunakan komunikasi

yang sistematis, seperti teknik komunikasi SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), sehingga tidak terjadi kesalahan interpretasi informasi klinis. Pelaporan yang baik mencakup kondisi terkini pasien, intervensi yang telah dilakukan, respons pasien terhadap intervensi, serta rekomendasi tindakan atau observasi lebih lanjut yang diperlukan.

Secara keseluruhan, pemantauan dan evaluasi pasca-intervensi dalam asuhan keperawatan kegawatdaruratan respirasi adalah proses kompleks yang membutuhkan perhatian tinggi, konsistensi, serta ketelitian dari perawat. Dengan memahami secara jelas indikator keberhasilan intervensi, melakukan monitoring komplikasi secara aktif, serta melaksanakan dokumentasi dan pelaporan secara cermat, perawat mampu memastikan bahwa pasien mendapatkan asuhan keperawatan yang optimal. Hal ini tidak hanya membantu mempercepat pemulihan kondisi pasien, namun juga meminimalkan risiko komplikasi serius yang dapat memperpanjang lama perawatan atau bahkan mengancam keselamatan pasien.

H. Pendidikan dan Konseling Pasien serta Keluarga

Pendidikan dan konseling pasien serta keluarga merupakan komponen penting dalam asuhan keperawatan, terutama dalam konteks kegawatdaruratan respirasi. Kondisi gawat darurat respirasi tidak hanya berdampak pada kondisi fisik pasien, tetapi juga seringkali menciptakan kecemasan dan kebingungan bagi pasien dan keluarganya. Oleh karena itu, perawat memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi secara jelas, terstruktur, dan mudah dipahami, agar pasien dan keluarga memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi kesehatan yang dialami, tanda-tanda awal kegawatan, serta langkah-langkah penting yang harus segera diambil jika kondisi kegawatan respirasi kembali muncul.

Langkah pertama dalam pendidikan pasien dan keluarga adalah memberikan edukasi tentang tanda-tanda dini kegawatan respirasi. Pemahaman yang baik terhadap tanda-tanda ini akan memungkinkan pasien dan keluarganya mengenali secara cepat apabila kondisi pasien mulai memburuk. Perawat perlu menjelaskan bahwa tanda awal kegawatan respirasi sering kali berupa sesak napas yang tiba-tiba atau bertambah parah secara cepat, peningkatan frekuensi pernapasan yang signifikan (takipnea), kesulitan berbicara atau menyelesaikan kalimat akibat sesak napas, munculnya bunyi napas abnormal seperti mengi atau suara napas kasar, serta perubahan warna kulit dan bibir menjadi kebiruan (sianosis) akibat kekurangan oksigen. Pasien juga perlu diberi pemahaman tentang pentingnya mengenali tanda-tanda penurunan kesadaran seperti bingung, sulit berkonsentrasi, atau penurunan respons terhadap lingkungan, yang merupakan indikasi serius bahwa kondisi respirasi pasien telah mengalami deteriorasi signifikan dan membutuhkan bantuan

medis segera. Edukasi tersebut sebaiknya disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, disertai demonstrasi atau penggunaan alat bantu visual, sehingga pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh pasien dan keluarganya.

Selanjutnya, perawat juga perlu memberikan edukasi mengenai strategi yang efektif untuk mencegah kambuhnya kondisi kegawatdaruratan respirasi. Hal ini sangat penting karena kondisi kegawatan respirasi yang berulang dapat memperburuk prognosis pasien secara jangka panjang. Strategi pencegahan yang diberikan biasanya bersifat individual, tergantung pada kondisi medis pasien, riwayat penyakit sebelumnya, dan faktor risiko yang dimiliki pasien. Secara umum, strategi pencegahan meliputi perubahan gaya hidup yang lebih sehat, seperti berhenti merokok, menghindari paparan polutan udara dan zat iritan yang dapat mencetuskan serangan respirasi akut, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Selain itu, pasien dengan penyakit pernapasan kronik seperti asma atau PPOK perlu diingatkan tentang pentingnya kepatuhan terhadap penggunaan obat-obatan yang diresepkan, mengikuti kontrol medis rutin, serta memiliki perencanaan aksi (action plan) jika gejala respirasi muncul kembali. Dalam edukasi ini, keterlibatan aktif keluarga sangat dianjurkan karena keluarga biasanya menjadi pihak pertama yang mendeteksi tanda-tanda kekambuhan dan membantu pasien mengakses layanan medis dengan cepat.

Selain edukasi tentang tanda-tanda dan strategi pencegahan, perawat juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarganya. Mengalami kegawatdaruratan respirasi merupakan pengalaman yang menakutkan dan traumatis bagi sebagian besar pasien, yang bisa menimbulkan berbagai respon emosional seperti kecemasan, ketakutan, atau bahkan depresi. Dukungan psikologis yang diberikan oleh perawat bertujuan untuk membantu pasien mengatasi stres emosional, meningkatkan rasa percaya diri pasien dalam mengelola kondisinya, serta mengurangi dampak negatif psikologis akibat pengalaman gawat darurat. Perawat dapat memberikan dukungan psikologis melalui komunikasi terapeutik yang empati, aktif mendengarkan kekhawatiran pasien, memberikan validasi atas perasaan yang dialami pasien dan keluarga, serta memberikan motivasi positif yang membantu pasien untuk bangkit dan melanjutkan proses pemulihan dengan lebih optimis.

Dalam memberikan dukungan psikologis, keluarga pasien juga perlu mendapatkan perhatian khusus, karena mereka juga merasakan tekanan psikologis yang berat akibat melihat anggota keluarganya mengalami kondisi kritis. Perawat dapat melibatkan keluarga dalam sesi konseling, memberikan ruang dan waktu bagi keluarga untuk mengekspresikan perasaan atau kekhawatiran mereka, serta memberikan informasi yang jelas tentang perkembangan kondisi pasien secara

berkala. Dukungan ini tidak hanya meringankan beban psikologis yang dialami keluarga, tetapi juga menguatkan kapasitas mereka untuk menjadi pendukung utama dalam proses pemulihan pasien.

Secara keseluruhan, pendidikan dan konseling pasien serta keluarga dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi memiliki peran penting dalam meningkatkan keberhasilan jangka panjang dari asuhan keperawatan yang diberikan. Dengan pemahaman yang baik mengenai tanda-tanda dini kegawatan, strategi pencegahan yang efektif, serta dukungan psikologis yang tepat, pasien dan keluarga akan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi kondisi kritis, meningkatkan rasa percaya diri dalam pengelolaan kesehatan, serta mengurangi risiko komplikasi atau kekambuhan yang serius di kemudian hari.

I. Tantangan dan Isu Terkini dalam Praktik Keperawatan Kegawatdaruratan Respirasi

Dalam praktik keperawatan kegawatdaruratan respirasi, perawat sering kali menghadapi berbagai tantangan dan isu terkini yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut tidak hanya bersifat teknis atau klinis, melainkan juga mencakup dimensi etis, penggunaan teknologi terkini, serta berbagai hambatan praktis yang sering dihadapi dalam unit gawat darurat (UGD). Memahami tantangan dan isu ini secara mendalam sangat penting bagi perawat agar dapat memberikan asuhan yang optimal dan tetap berorientasi pada keselamatan dan kepentingan terbaik pasien.

Salah satu isu yang sering muncul dalam penanganan kondisi respirasi darurat adalah isu etik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang kompleks di situasi kritis. Dalam praktiknya, perawat sering kali harus menghadapi dilema etik seperti penentuan prioritas pasien dalam kondisi sumber daya terbatas (misalnya saat terjadi lonjakan pasien akibat pandemi atau bencana besar), keputusan terkait intervensi invasif seperti intubasi atau ventilasi mekanik, serta isu seputar penghentian atau pembatasan terapi bagi pasien dengan prognosis yang buruk atau penyakit terminal. Dalam situasi ini, perawat menghadapi tantangan moral yang cukup berat antara kewajiban profesional untuk memberikan perawatan terbaik dan menghormati hak pasien serta keluarganya dalam pengambilan keputusan perawatan. Tantangan etik juga muncul ketika pasien mengalami penurunan kesadaran atau tidak mampu memberikan informed consent, sehingga perawat harus bekerja sama secara erat dengan keluarga atau wali pasien untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar merefleksikan nilai-nilai, harapan, dan hak pasien. Oleh karena itu, perawat perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap prinsip etik seperti beneficence (memberikan manfaat maksimal), non-

maleficence (menghindari bahaya), otonomi (menghormati keputusan pasien), dan keadilan (memberikan perawatan yang setara) untuk memandu mereka dalam menghadapi dilema etik tersebut.

Isu kedua yang tidak kalah penting adalah penerapan teknologi terkini dalam manajemen respirasi. Kemajuan teknologi kesehatan dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak positif signifikan dalam penanganan kegawatdaruratan respirasi. Misalnya, penggunaan alat ventilasi mekanik modern yang dilengkapi dengan mode ventilasi canggih seperti ventilasi volume-targeted, tekanan positif akhir ekspirasi (PEEP) otomatis, serta sistem pemantauan pernapasan digital real-time, mampu meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi risiko komplikasi, serta memperbaiki luaran klinis pasien. Selain itu, alat bantu seperti high-flow nasal cannula (HFNC) atau Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) non-invasif juga semakin banyak digunakan untuk menangani pasien yang mengalami gangguan respirasi akut namun belum membutuhkan intubasi invasif. Teknologi digital lain seperti sistem pemantauan jarak jauh (telemonitoring) juga mulai diterapkan dalam praktik klinis, yang memungkinkan perawat memantau kondisi respirasi pasien secara kontinu tanpa harus berada langsung di sisi pasien. Namun demikian, penerapan teknologi ini juga menghadirkan tantangan tersendiri seperti kebutuhan pelatihan khusus bagi perawat, biaya perawatan yang meningkat, serta risiko ketergantungan yang tinggi pada teknologi yang mungkin menyebabkan kurangnya keterampilan manual dalam kondisi darurat tertentu. Oleh karena itu, perawat harus terus meningkatkan kompetensi teknologinya melalui pendidikan berkelanjutan agar mampu menggunakan teknologi secara tepat, efektif, dan aman dalam praktik sehari-hari.

Di samping isu etik dan teknologi, tantangan praktis dalam pelayanan kegawatdaruratan respirasi di unit gawat darurat (UGD) juga menjadi hal yang signifikan. Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi adalah situasi overcrowding atau kepadatan pasien di UGD, yang menyebabkan keterbatasan ruang dan sumber daya, serta meningkatkan risiko keterlambatan dalam identifikasi kondisi kritis dan intervensi segera. Kondisi overcrowding sering menyebabkan stres tinggi bagi perawat, meningkatkan risiko kelelahan (burnout), serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi perlu diterapkan oleh manajemen rumah sakit maupun tim kesehatan, seperti penerapan sistem triase yang efektif untuk memprioritaskan pasien sesuai tingkat kegawatannya, penambahan tenaga keperawatan khususnya saat terjadi lonjakan pasien, serta optimalisasi alur kerja dan komunikasi antar tim yang terlibat dalam penanganan pasien. Selain itu, rumah sakit juga perlu mengembangkan program dukungan psikologis dan pengelolaan stres bagi tenaga

kesehatan untuk mencegah burnout, sehingga perawat dapat tetap bekerja dengan produktif dan memberikan pelayanan optimal kepada pasien.

Strategi lain yang penting dalam menghadapi tantangan di UGD adalah peningkatan pelatihan dan simulasi klinis secara rutin. Simulasi ini bertujuan meningkatkan kemampuan perawat dalam menghadapi situasi kritis yang tidak terduga, serta memperkuat keterampilan kolaborasi dan komunikasi antar tim yang sangat penting dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi. Pelatihan berbasis simulasi membantu perawat merasa lebih percaya diri, terampil, dan responsif saat menghadapi pasien yang kondisinya tiba-tiba memburuk, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan dalam praktik.

Secara keseluruhan, memahami tantangan dan isu terkini dalam praktik keperawatan kegawatdaruratan respirasi merupakan bagian integral dalam pengembangan kompetensi profesional perawat. Dengan menyadari tantangan etik, terus memperbarui keterampilan teknologi, serta menerapkan berbagai strategi praktis untuk mengatasi hambatan di UGD, perawat dapat memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien selalu sesuai dengan standar kualitas tinggi, aman, serta efektif dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Hal ini pada akhirnya akan membantu mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, holistik, dan berorientasi pada keselamatan pasien serta keluarga.

J. Simpulan

Asuhan keperawatan pada kondisi kegawatdaruratan respirasi merupakan praktik klinis yang kompleks dan kritis, menuntut kompetensi tinggi serta responsivitas yang cepat dan akurat dari tenaga perawat. Kondisi kegawatan respirasi, yang melibatkan gangguan ventilasi, difusi, dan perfusi, merupakan masalah kesehatan global yang semakin meningkat, sehingga memerlukan perhatian serius dari seluruh tenaga kesehatan. Pengetahuan mendalam tentang anatomi, fisiologi, serta patofisiologi sistem pernapasan menjadi landasan utama bagi perawat untuk mampu mengidentifikasi secara dini tanda-tanda gangguan respirasi akut, melakukan penilaian cepat menggunakan pendekatan ABCDE, serta menerapkan intervensi keperawatan yang efektif.

Intervensi keperawatan pada kegawatdaruratan respirasi mencakup pengelolaan airway, terapi oksigen, ventilasi mekanik baik invasif maupun non-invasif, pengaturan posisi tubuh, teknik pernapasan khusus, serta manajemen farmakologi yang tepat sesuai kondisi pasien. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dan keterampilan kolaborasi interprofesional yang baik. Kolaborasi ini melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter spesialis, ahli anestesi, tenaga farmasi,

fisioterapis, ahli gizi, dan tenaga penunjang medis lainnya untuk memastikan penanganan pasien berlangsung secara optimal dan terintegrasi. Perawat juga memiliki peran vital sebagai anggota Tim Tanggap Cepat (Rapid Response Team) dalam mengidentifikasi secara dini dan memberikan respons cepat terhadap perubahan kondisi pasien.

Setelah intervensi diberikan, perawat bertanggung jawab penuh dalam melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kondisi pasien, memastikan efektivitas intervensi yang dilakukan, serta mengidentifikasi secara dini berbagai kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi pasca-intervensi. Dokumentasi dan pelaporan yang jelas, sistematis, dan akurat merupakan bagian penting dalam proses ini, guna menjamin kesinambungan perawatan yang efektif antar tim kesehatan.

Selain aspek klinis, perawat juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan konseling bagi pasien serta keluarga mengenai tanda-tanda dini kegawatan respirasi, strategi pencegahan kambuhnya kondisi gawat darurat, serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan. Edukasi ini bertujuan agar pasien dan keluarga memiliki kesiapan dan pemahaman yang baik untuk mengelola kondisi kesehatan secara mandiri serta mengenali situasi darurat secara cepat dan tepat.

Terakhir, praktik keperawatan pada kegawatdaruratan respirasi menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk isu etik terkait pengambilan keputusan klinis dalam situasi darurat, adaptasi terhadap teknologi terbaru dalam manajemen respirasi, serta berbagai hambatan praktis yang sering muncul di unit gawat darurat seperti overcrowding dan risiko burnout pada tenaga keperawatan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan pelatihan berkelanjutan, penerapan sistem triase yang efektif, serta strategi pengelolaan stres dan dukungan psikologis bagi tenaga kesehatan.

Dengan memahami secara mendalam semua aspek tersebut, perawat mampu memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi, efektif, aman, dan holistik. Hal ini pada akhirnya berkontribusi besar dalam meningkatkan peluang kesembuhan, mencegah komplikasi serius, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien dalam kondisi kegawatdaruratan respirasi.

K. Referensi

- American Heart Association. (2020). Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) provider manual (1st ed.). American Heart Association.
- Branson, R. D., Hess, D. R., Kallet, R. H., & Robinson, L. (2020). Respiratory care for patients with COVID-19. *Respiratory Care*, 65(8), 1196–1204. <https://doi.org/10.4187/respcare.07939>
- Chiumello, D., Coppola, S., Froio, S., & Gotti, M. (2020). What's next after ARDS: Long-term outcomes. *Respiratory Care*, 65(8), 1160–1171. <https://doi.org/10.4187/respcare.07514>
- Elliott, M. W., & Nava, S. (2021). Noninvasive ventilation and weaning: Principles and practice (2nd ed.). CRC Press.
- Heuer, A. J., & Scanlan, C. L. (2021). Wilkins' clinical assessment in respiratory care (8th ed.). Elsevier.
- Jarvis, S. K., & Kovacs, G. (2020). Emergency airway management: Updates and controversies. *Emergency Medicine Clinics of North America*, 38(4), 795–810. <https://doi.org/10.1016/j.emc.2020.07.004>
- Kacmarek, R. M., Stoller, J. K., & Heuer, A. J. (2020). Egan's fundamentals of respiratory care (12th ed.). Elsevier.
- Papadakos, P. J., & Lachmann, B. (Eds.). (2018). Mechanical ventilation: Clinical applications and pathophysiology (1st ed.). Elsevier Academic Press.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice (10th ed.). Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins.
- Rose, L., Schultz, M. J., Cardwell, C. R., Jouvett, P., McAuley, D. F., & Blackwood, B. (2020). Non-invasive ventilation and high-flow nasal oxygen therapy in respiratory failure. *Intensive Care Medicine*, 46(4), 642–653. <https://doi.org/10.1007/s00134-020-05948-0>
- Vincent, J. L., Abraham, E., Kochanek, P., Moore, F. A., & Fink, M. P. (Eds.). (2017). Textbook of critical care (7th ed.). Elsevier Saunders.
- World Health Organization. (2021). Chronic respiratory diseases. Retrieved from <https://www.who.int/health-topics/chronic-respiratory-diseases>
- Yazdannik, A., Zarei, H., & Massoumi, G. (2020). Comparing the effects of supine and semi-Fowler's positions on respiratory parameters in patients undergoing

mechanical ventilation. *Journal of Nursing Research*, 28(4), e104.
<https://doi.org/10.1097/jnr.0000000000000367>
Zitnik, R. J., & Ely, E. W. (2020). Advances in the management of acute respiratory distress syndrome (ARDS). *Critical Care Clinics*, 36(4), 619–636.
<https://doi.org/10.1016/j.ccc.2020.06.004>

J. Glosarium

Airway: Saluran pernapasan tempat udara masuk dan keluar paru-paru.

Alveoli: Kantung udara kecil di paru-paru tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida.

ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome): Sindrom gangguan pernapasan akut akibat peradangan luas pada paru-paru yang menyebabkan hipoksia berat.

Asidosis Respiratorik: Kondisi meningkatnya keasaman darah akibat akumulasi karbon dioksida karena gangguan pernapasan.

Barotrauma: Cedera jaringan paru-paru akibat tekanan udara tinggi selama ventilasi mekanik.

BiPAP (Bilevel Positive Airway Pressure): Metode ventilasi non-invasif dengan dua tingkat tekanan udara positif untuk membantu pernapasan.

Bronkiolus: Saluran udara kecil di paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveoli.

Bronkokonstriksi: Penyempitan saluran napas akibat kontraksi otot polos, sering ditemukan pada asma akut.

Capillary refill time: Waktu yang dibutuhkan untuk darah kembali mengisi kapiler setelah ditekan, indikator perfusi perifer.

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure): Ventilasi non-invasif dengan tekanan udara positif kontinu yang menjaga jalan napas tetap terbuka.

Difusi: Proses pertukaran gas (oksigen dan karbon dioksida) antara alveoli dan kapiler darah di paru-paru.

Edema Paru Akut: Kondisi penumpukan cairan di alveoli paru-paru yang mengganggu proses pertukaran gas secara akut.

Emboli Paru: Penyumbatan pembuluh darah paru oleh gumpalan darah atau embolus, menyebabkan gangguan perfusi paru.

Ekspirasi: Proses mengeluarkan udara dari paru-paru.

Faring: Saluran napas bagian atas yang berfungsi sebagai jalur udara dan makanan.

Glasgow Coma Scale (GCS): Alat penilaian fungsi neurologis pasien berdasarkan tingkat kesadaran.

Head tilt-chin lift: Teknik membuka jalan napas dengan mengangkat dagu pasien dan menarik kepala ke belakang.

Hemoptisis: Kondisi batuk berdarah yang bisa terjadi pada emboli paru akut atau gangguan paru lainnya.

Hiperkapnia: Kondisi peningkatan kadar karbon dioksida dalam darah akibat gangguan ventilasi.

Hipoksia: Kekurangan oksigen pada jaringan tubuh.

Hipoventilasi: Kondisi ventilasi tidak adekuat yang menyebabkan peningkatan karbon dioksida dalam darah.

Intubasi endotrakeal: Prosedur memasukkan tabung ke dalam trakea untuk menjamin jalan napas terbuka selama kondisi kritis.

Kemoreseptor: Sel khusus yang mendeteksi perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah.

Kolaborasi Interprofesional: Kerja sama terpadu antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi dalam memberikan perawatan pasien.

Laring: Bagian saluran napas yang menghubungkan faring dengan trakea, tempat produksi suara manusia.

Nasal cannula: Alat pemberian oksigen sederhana melalui selang yang ditempatkan di lubang hidung.

Non-rebreathing mask: Masker oksigen dengan reservoir untuk memberikan oksigen konsentrasi tinggi kepada pasien.

Obstruksi Jalan Napas: Penyumbatan pada jalan napas akibat benda asing, lendir, atau edema yang menyebabkan gangguan pernapasan.

Patofisiologi: Studi tentang perubahan fungsi tubuh akibat gangguan penyakit.

Perfusi: Aliran darah yang membawa oksigen ke jaringan tubuh, khususnya paru-paru.

Pneumonia terkait ventilator (Ventilator-Associated Pneumonia/VAP): Infeksi paru yang terjadi akibat penggunaan ventilasi mekanik invasif.

Pulse Oximetry: Alat non-invasif untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah secara real-time.

Retraksi Interkostal: Tarikan otot-otot antar tulang rusuk selama bernapas yang menandakan kesulitan bernapas.

Ronki Basah Halus: Suara napas tambahan berupa suara gelembung kecil akibat cairan di alveoli.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation): Metode komunikasi standar antar tenaga kesehatan untuk memastikan penyampaian informasi kritis secara jelas dan terstruktur.

Semi-Fowler: Posisi setengah duduk dengan sudut sekitar 30–45 derajat untuk meningkatkan ventilasi paru-paru.

Sianosis: Perubahan warna kebiruan pada kulit atau membran mukosa akibat kekurangan oksigen dalam darah.

Sindrom: Kumpulan gejala klinis yang muncul bersama sebagai manifestasi kondisi tertentu.

Spasme Bronkus: Kontraksi otot polos bronkus yang menyebabkan penyempitan saluran napas.

Stridor: Bunyi napas kasar bernada tinggi akibat obstruksi pada saluran napas atas.

Syok Respirasi: Kondisi gagal napas berat disertai penurunan tekanan darah akibat gangguan pernapasan.

Takipnea: Pernapasan cepat dengan frekuensi lebih dari 20 kali per menit.

Trakea: Saluran napas utama yang menghubungkan laring dengan bronkus.

Trakeostomi: Prosedur pembedahan untuk membuat lubang langsung ke dalam trakea sebagai jalan napas permanen atau sementara.

Triase: Proses menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat kegawatan kondisi klinis.

Ventilasi Mekanik: Penggunaan mesin ventilator untuk membantu atau menggantikan fungsi pernapasan pasien.

Wheezing: Bunyi napas tambahan bernada tinggi akibat penyempitan saluran napas bawah, sering terjadi pada asma.

CHAPTER 6

PENATALAKSANAAN NYERI AKUT DI INSTALASI GAWAT DARURAT

Drg. Anses Warman, Mm.

A. Pendahuluan/Prolog

Nyeri akut merupakan suatu kondisi klinis yang ditandai dengan timbulnya sensasi tidak nyaman yang bersifat tajam dan mendadak sebagai respons tubuh terhadap cedera atau stimulus patologis tertentu. Secara klinis, nyeri akut muncul secara tiba-tiba dan umumnya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, biasanya kurang dari tiga bulan. Sensasi nyeri akut biasanya intens dan secara langsung terkait dengan cedera jaringan atau peradangan akut, seperti patah tulang, luka bakar, trauma jaringan lunak, nyeri pascaoperasi, atau kondisi penyakit akut lainnya seperti appendisitis akut atau infark miokard akut. Karakteristik utama dari nyeri akut adalah rasa nyeri yang jelas, lokasi yang spesifik, mudah teridentifikasi oleh pasien, serta biasanya disertai dengan respons fisiologis tubuh seperti peningkatan frekuensi jantung, peningkatan tekanan darah, peningkatan frekuensi napas, serta perubahan perilaku seperti ekspresi wajah nyeri atau gerakan yang terbatas akibat nyeri yang dirasakan.

Dalam konteks Instalasi Gawat Darurat (IGD), manajemen nyeri akut memegang peran yang sangat krusial dalam pemberian pelayanan kesehatan yang optimal. IGD merupakan pintu masuk utama pasien dengan kondisi akut atau kritis ke fasilitas kesehatan, sehingga identifikasi dini serta manajemen nyeri yang cepat, efektif, dan tepat sangat menentukan kualitas layanan yang diberikan. Manajemen nyeri akut yang baik di IGD penting dilakukan bukan hanya karena alasan kemanusiaan—yaitu hak pasien untuk mendapatkan perawatan bebas nyeri—tetapi juga karena aspek klinis, mengingat nyeri akut yang tidak terkelola dengan baik dapat memperparah kondisi pasien, menyebabkan stres fisiologis yang signifikan, serta mengganggu berbagai proses fisiologis yang penting dalam pemulihan. Selain itu, nyeri akut yang tidak segera dikelola dapat mempersulit diagnosis karena pasien tidak mampu kooperatif dalam pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang. Dengan demikian, kemampuan tenaga kesehatan, khususnya perawat dan dokter IGD dalam mengenali, menilai, dan mengelola nyeri akut secara cepat dan tepat menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan penanganan pasien di IGD.

Dampak dari nyeri akut terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan di IGD sangatlah signifikan. Pasien yang mengalami nyeri akut berat sering kali

mengalami gangguan fisiologis seperti peningkatan denyut jantung (takikardia), tekanan darah tinggi (hipertensi), hiperventilasi, serta peningkatan kadar hormon stres seperti kortisol yang dapat memperlambat proses penyembuhan luka atau perbaikan jaringan. Di samping dampak fisiologis, nyeri akut juga menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi pasien, seperti rasa takut, cemas, agitasi, atau bahkan gangguan kesadaran, yang dapat memperburuk kondisi klinis secara keseluruhan. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah gangguan terhadap proses pemeriksaan dan prosedur medis. Pasien dengan nyeri akut yang berat biasanya sulit untuk diajak berkomunikasi secara efektif, sehingga proses pemeriksaan fisik maupun prosedur diagnostik atau terapeutik bisa terganggu, tertunda, atau bahkan gagal, yang pada akhirnya dapat mengancam keselamatan pasien secara serius.

Selain itu, nyeri akut yang tidak segera tertangani secara efektif dapat memperburuk citra layanan kesehatan secara keseluruhan. Pasien dan keluarganya cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan kesehatan apabila nyeri yang dialami tidak segera teratasi, yang kemudian berdampak negatif terhadap kepuasan pasien dan keluarga. Kepuasan pasien adalah indikator penting dari kualitas layanan rumah sakit, dan ketidakpuasan akibat pengelolaan nyeri yang tidak memadai dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, manajemen nyeri akut yang baik di IGD merupakan bagian integral dari peningkatan kualitas layanan rumah sakit, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik pasien semata, tetapi juga pada aspek psikologis, kenyamanan, dan kepuasan pasien secara menyeluruh.

Dengan demikian, penanganan nyeri akut yang efektif di IGD bukanlah sekadar tambahan dari tindakan medis lainnya, melainkan sebuah kebutuhan esensial yang harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pemulihan, memudahkan pemeriksaan klinis, dan pada akhirnya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Melalui pemahaman mendalam tentang definisi dan karakteristik nyeri akut, kesadaran tentang pentingnya manajemen nyeri akut, serta pengakuan terhadap dampak negatif nyeri akut terhadap keselamatan pasien dan kualitas pelayanan, tenaga kesehatan di IGD diharapkan mampu memberikan intervensi yang cepat, akurat, dan holistik dalam menangani kondisi nyeri akut, sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik dalam upaya keselamatan pasien dan optimalisasi kualitas pelayanan kesehatan.

B. Prinsip Dasar Penilaian Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat

Penilaian nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menentukan arah dan efektivitas intervensi yang akan diberikan kepada pasien. Penilaian nyeri yang tepat, cepat, dan akurat memungkinkan tenaga medis, baik dokter maupun perawat, untuk mengenali intensitas dan karakteristik nyeri yang dialami oleh pasien secara jelas. Hal ini akan menjadi dasar dalam menentukan jenis, dosis, serta metode pemberian terapi yang paling efektif untuk mengurangi atau mengatasi rasa nyeri. Karena nyeri bersifat subjektif dan sangat individual, maka dibutuhkan alat ukur atau instrumen yang terstandardisasi untuk menjamin objektivitas serta konsistensi dalam mengidentifikasi tingkat keparahan nyeri pada setiap pasien yang datang ke IGD.

Terdapat beberapa instrumen yang secara luas digunakan dalam praktik klinis untuk mengukur tingkat nyeri pada pasien dengan kondisi akut di IGD. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan adalah Numerical Rating Scale (NRS). Instrumen ini mengukur tingkat nyeri dengan skala numerik yang berkisar dari angka nol hingga sepuluh, di mana angka nol menunjukkan tidak ada nyeri sama sekali, sedangkan angka sepuluh menggambarkan nyeri terburuk yang pernah dirasakan oleh pasien. Instrumen ini relatif mudah digunakan, cepat dipahami oleh pasien, dan dapat memberikan informasi yang sangat jelas terkait intensitas nyeri. Selain NRS, Visual Analog Scale (VAS) juga merupakan instrumen lain yang sering digunakan. VAS berupa garis lurus sepanjang 10 sentimeter, di mana pasien diminta untuk menunjukkan titik pada garis tersebut yang paling sesuai dengan tingkat nyeri yang dialami. Ujung kiri garis menggambarkan tidak ada nyeri sama sekali, sementara ujung kanan menggambarkan nyeri paling hebat. VAS memiliki kelebihan berupa sensitivitas tinggi terhadap perubahan kecil dalam intensitas nyeri, namun membutuhkan pemahaman visual yang lebih baik dari pasien.

Untuk pasien khususnya anak-anak, pasien dengan gangguan komunikasi, atau pasien lansia yang sulit memahami skala numerik atau visual, Wong-Baker Faces Pain Rating Scale menjadi pilihan instrumen yang sangat efektif. Wong-Baker Faces menggambarkan tingkat nyeri melalui ekspresi wajah yang berkisar dari wajah tersenyum (tidak ada nyeri) hingga wajah yang menangis (nyeri yang sangat hebat). Instrumen ini sangat berguna terutama pada populasi pasien yang kesulitan untuk mendeskripsikan nyeri secara verbal, sehingga membantu tenaga medis dalam mendapatkan gambaran objektif tentang kondisi nyeri pasien secara lebih akurat.

Selain menentukan intensitas nyeri, penilaian nyeri akut di IGD juga harus mencakup identifikasi faktor pemicu maupun pemberat nyeri. Hal ini penting untuk memahami penyebab nyeri secara lebih komprehensif serta merancang intervensi yang tepat dan efektif. Faktor pemicu merupakan kondisi atau aktivitas tertentu

yang menyebabkan nyeri muncul atau memperburuk nyeri yang sedang dirasakan. Misalnya, pasien dengan cedera fraktur tulang mungkin melaporkan bahwa gerakan tertentu, posisi tubuh tertentu, atau tekanan langsung di area cedera menyebabkan nyeri menjadi lebih intens. Di sisi lain, faktor pemberat adalah segala kondisi yang menyebabkan intensitas nyeri meningkat atau mempertahankan nyeri pada tingkat tinggi. Contoh faktor pemberat ini bisa berupa stres emosional, kecemasan, kondisi lingkungan seperti suhu ruangan yang ekstrem, kebisingan, ataupun faktor-faktor lainnya yang memperburuk persepsi pasien terhadap nyeri. Identifikasi faktor pemicu dan pemberat ini sangat penting dalam manajemen nyeri akut, karena dengan mengetahui secara jelas hal-hal tersebut, tenaga medis bisa memberikan intervensi tambahan seperti edukasi, modifikasi lingkungan, serta tindakan non-farmakologis yang mampu mendukung efektifitas terapi farmakologis yang diberikan.

Selanjutnya, prinsip dasar penilaian nyeri akut juga sangat terkait erat dengan hubungan antara nyeri dengan tanda vital dan status klinis pasien secara keseluruhan. Dalam praktik klinis di IGD, nyeri akut yang hebat biasanya diikuti oleh perubahan fisiologis yang nyata pada tubuh pasien. Pasien dengan nyeri akut yang signifikan sering kali menunjukkan peningkatan denyut jantung (takikardia), peningkatan tekanan darah (hipertensi), percepatan frekuensi pernapasan (takipnea), serta peningkatan suhu tubuh (hipertermia) akibat aktivasi respons simpatis tubuh terhadap nyeri yang dirasakan. Respons fisiologis ini merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh yang bertujuan untuk melindungi tubuh dari ancaman atau cedera lebih lanjut. Namun demikian, perubahan fisiologis yang berkepanjangan akibat nyeri akut yang tidak segera ditangani secara efektif dapat berakibat buruk pada kondisi klinis pasien secara keseluruhan, meningkatkan risiko komplikasi seperti kerusakan jaringan lanjutan, gangguan sistem organ lain, hingga gangguan psikologis yang serius seperti kecemasan atau depresi.

Dengan memahami hubungan antara nyeri dan perubahan tanda vital serta kondisi klinis secara keseluruhan, tenaga medis di IGD dapat menjadikan hasil pemeriksaan tanda vital sebagai parameter tambahan yang penting untuk mengevaluasi efektivitas intervensi nyeri yang telah diberikan. Misalnya, setelah pemberian analgesik atau terapi nyeri lainnya, penurunan denyut jantung, normalisasi tekanan darah, atau perbaikan pola pernapasan pasien merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa nyeri pasien berhasil dikontrol dengan baik. Sebaliknya, tanda vital yang tetap tinggi atau bahkan memburuk setelah pemberian terapi merupakan sinyal penting yang mengindikasikan bahwa intervensi yang diberikan mungkin tidak efektif atau dosis yang diberikan masih kurang optimal.

Dengan demikian, prinsip dasar penilaian nyeri akut di IGD melibatkan lebih dari sekadar mengukur intensitas nyeri, namun mencakup identifikasi menyeluruh terhadap berbagai faktor yang memicu dan memperberat nyeri, serta memperhatikan hubungan erat antara nyeri dengan perubahan fisiologis tubuh pasien. Pendekatan penilaian yang menyeluruh, sistematis, dan terstandardisasi ini memastikan bahwa pasien dengan nyeri akut di IGD mendapatkan penanganan yang cepat, tepat, efektif, serta komprehensif, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan dan pada akhirnya meningkatkan prognosis dan keselamatan pasien secara keseluruhan.

C. Pendekatan Multimodal dalam Penatalaksanaan Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat

Pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri akut merupakan strategi penanganan nyeri yang menggabungkan beberapa modalitas terapi yang berbeda, baik secara farmakologis maupun nonfarmakologis, dengan tujuan untuk mencapai efektivitas yang optimal dalam pengendalian nyeri. Pendekatan ini menekankan pentingnya menggunakan kombinasi intervensi untuk menyerang berbagai mekanisme nyeri secara bersamaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas terapi, mempercepat pemulihan pasien, serta menurunkan risiko efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan satu jenis terapi saja dalam dosis tinggi. Dalam konteks Instalasi Gawat Darurat (IGD), pendekatan multimodal ini sangat relevan, karena pasien yang datang dengan kondisi nyeri akut biasanya mengalami nyeri yang intens, kompleks, dan memiliki latar belakang penyebab yang beragam. Oleh sebab itu, manajemen nyeri yang efektif memerlukan kombinasi berbagai teknik yang terintegrasi dengan baik guna mencapai kontrol nyeri yang cepat, aman, dan efektif.

Prinsip utama dalam pendekatan multimodal adalah bahwa nyeri merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai jalur fisiologis dan psikologis, sehingga satu modalitas terapi saja seringkali tidak cukup untuk mengatasi semua aspek nyeri tersebut secara efektif. Misalnya, nyeri yang dirasakan oleh pasien tidak hanya melibatkan reseptor nyeri perifer, namun juga melibatkan sistem saraf pusat yang bertanggung jawab terhadap persepsi nyeri serta aspek emosional dan psikologis yang mempengaruhi pengalaman nyeri secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendekatan multimodal bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai terapi yang bekerja melalui mekanisme berbeda sehingga efek terapeutiknya bersifat sinergis, bukan hanya aditif. Dengan pendekatan ini, dosis masing-masing terapi juga dapat diturunkan sehingga meminimalisasi efek samping yang tidak diinginkan.

Dalam praktiknya di IGD, pendekatan multimodal mengintegrasikan berbagai jenis intervensi farmakologis dan nonfarmakologis secara bersamaan. Intervensi farmakologis merupakan tindakan utama dalam pengendalian nyeri akut, terutama dalam situasi emergensi yang membutuhkan respons cepat. Jenis terapi farmakologis yang biasa digunakan meliputi analgesik opioid maupun non-opioid, antiinflamasi nonsteroid (NSAID), anestetik lokal, serta adjuvan seperti antidepresan atau antikonvulsan pada kondisi tertentu. Penggunaan analgesik opioid seperti morfin atau fentanyl efektif dalam mengontrol nyeri yang berat, namun memiliki potensi efek samping seperti depresi pernapasan, sedasi, atau mual muntah, sehingga penggunaannya perlu dikombinasikan secara bijak dengan analgesik lain seperti parasetamol atau NSAID seperti ketorolak atau ibuprofen. Kombinasi ini memungkinkan dosis opioid bisa diturunkan, sehingga risiko efek samping dapat diminimalkan sementara efektivitas analgesia tetap dipertahankan.

Selain terapi farmakologis, pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri akut di IGD juga menekankan pentingnya integrasi intervensi nonfarmakologis sebagai pelengkap terapi farmakologis. Intervensi nonfarmakologis adalah strategi pengelolaan nyeri yang tidak melibatkan penggunaan obat-obatan namun memiliki potensi besar dalam mengurangi persepsi nyeri pasien. Intervensi ini bisa berupa terapi fisik sederhana seperti mengatur posisi pasien yang nyaman untuk mengurangi nyeri, penggunaan kompres dingin atau panas untuk mengurangi nyeri lokal atau inflamasi, teknik distraksi seperti mendengarkan musik atau mengalihkan perhatian pasien, hingga teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi ringan, dan imagery (pencitraan positif) yang mampu menurunkan persepsi nyeri secara signifikan. Penggunaan intervensi nonfarmakologis ini memiliki beberapa kelebihan utama, yaitu rendah biaya, mudah diterapkan, minim efek samping, serta meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam pengelolaan nyeri, sehingga memberikan rasa kontrol dan menurunkan tingkat kecemasan yang sering kali menyertai kondisi nyeri akut.

Integrasi intervensi farmakologis dan nonfarmakologis secara bersamaan memiliki dampak positif yang signifikan dalam penanganan pasien nyeri akut di IGD. Sebagai contoh, pasien yang datang dengan nyeri hebat akibat fraktur dapat diberikan analgesik opioid dosis rendah yang dikombinasikan dengan NSAID untuk mengontrol nyeri secara efektif dari aspek farmakologis. Pada saat yang sama, pasien juga dapat diberikan intervensi nonfarmakologis seperti immobilisasi area cedera, elevasi ekstremitas, penggunaan kompres dingin, dan pemberian teknik distraksi atau relaksasi untuk mengurangi stres dan kecemasan yang memperburuk persepsi nyeri. Pendekatan kombinasi ini memungkinkan tenaga medis mencapai kontrol nyeri yang lebih baik daripada jika hanya mengandalkan satu jenis intervensi

saja. Selain itu, dengan menurunkan dosis analgesik farmakologis, pasien juga mendapatkan manfaat tambahan berupa pengurangan risiko efek samping yang serius, seperti gangguan pernapasan, gangguan gastrointestinal, atau efek sedasi berlebihan.

Dalam penerapan pendekatan multimodal, kolaborasi dan koordinasi tim kesehatan di IGD juga menjadi elemen yang sangat penting. Dokter, perawat, apoteker klinis, fisioterapis, serta tenaga medis lainnya perlu bekerja sama secara terintegrasi untuk menentukan kombinasi terapi yang paling optimal sesuai kondisi klinis pasien, riwayat medis, jenis nyeri, tingkat intensitas nyeri, serta kebutuhan khusus pasien. Pendekatan yang holistik ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, namun juga mampu mempercepat pemulihan pasien, meningkatkan kepuasan pasien, serta mencegah berbagai komplikasi yang berhubungan dengan nyeri akut yang tidak terkontrol.

Secara keseluruhan, pendekatan multimodal dalam manajemen nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat mencerminkan prinsip penting bahwa penanganan nyeri tidak cukup hanya dengan satu intervensi saja, namun memerlukan integrasi berbagai terapi farmakologis dan nonfarmakologis secara cermat, terarah, dan terkoordinasi dengan baik. Melalui pendekatan ini, pasien akan mendapatkan manfaat maksimal berupa kontrol nyeri yang efektif, minim efek samping, serta pengalaman pelayanan kesehatan yang lebih positif dan nyaman selama berada di IGD.

D. Intervensi Farmakologi dalam Penanganan Nyeri Akut di Instalasi Gawat Darurat

Penanganan nyeri akut secara farmakologis merupakan komponen utama dalam upaya memberikan rasa nyaman serta mencegah komplikasi lanjutan yang timbul akibat nyeri yang tidak terkontrol. Terapi farmakologi dalam kondisi nyeri akut bertujuan mengurangi intensitas nyeri secara efektif, cepat, serta aman, guna meningkatkan kenyamanan pasien dan memfasilitasi tindakan medis lanjutan yang dibutuhkan pasien. Terdapat beberapa kelompok utama analgesik yang digunakan dalam intervensi farmakologi nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD), yaitu analgesik non-opioid, analgesik opioid, serta analgesik adjuvan.

Kelompok pertama yang paling sering digunakan dalam penatalaksanaan nyeri akut adalah analgesik non-opioid, seperti obat golongan Anti-Inflamasi Non-Steroid (NSAID) dan parasetamol. Analgesik ini bekerja dengan mekanisme menghambat sintesis prostaglandin melalui blokade enzim siklooksigenase (COX). Prostaglandin merupakan mediator penting dalam proses inflamasi yang bertanggung jawab atas munculnya nyeri, edema, dan demam pada pasien. NSAID seperti ibuprofen,

ketorolak, diklofenak, dan naproksen efektif digunakan dalam mengatasi nyeri akut dengan komponen inflamasi yang dominan, misalnya nyeri akibat cedera muskuloskeletal, nyeri pasca operasi minor, atau nyeri akibat trauma jaringan lunak. Parasetamol (asetaminofen) adalah analgesik non-opioid lainnya yang memiliki efek analgesik dan antipiretik, namun berbeda dengan NSAID, parasetamol tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Meskipun demikian, parasetamol sangat sering digunakan karena relatif aman, memiliki profil efek samping yang minimal, serta dapat digunakan secara luas pada berbagai jenis nyeri akut dari ringan hingga sedang, baik secara tunggal maupun dikombinasikan dengan NSAID atau analgesik opioid ringan. Penggunaan NSAID dalam IGD harus memperhatikan potensi efek samping seperti iritasi gastrointestinal, perdarahan saluran cerna, gangguan fungsi ginjal, serta peningkatan risiko komplikasi kardiovaskular jika diberikan secara berlebihan atau dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, pemberian NSAID harus mempertimbangkan kondisi klinis pasien secara keseluruhan, serta selalu menggunakan dosis terendah yang efektif untuk durasi sesingkat mungkin.

Kelompok kedua analgesik yang berperan penting dalam manajemen nyeri akut adalah analgesik opioid, yang memiliki mekanisme kerja dengan mengaktivasi reseptor opioid di sistem saraf pusat sehingga menghambat transmisi impuls nyeri, mengubah persepsi nyeri, dan menimbulkan efek sedasi ringan. Obat-obatan opioid yang sering digunakan dalam IGD meliputi morfin, fentanyl, dan tramadol. Morfin adalah opioid standar yang sering digunakan sebagai analgesik kuat dalam nyeri akut berat, seperti nyeri akibat fraktur berat, nyeri akibat infark miokard akut, atau nyeri pasca operasi mayor. Morfin memberikan efek analgesik kuat dengan durasi aksi yang cukup lama, namun memiliki risiko efek samping berupa depresi pernapasan, sedasi berlebihan, mual muntah, serta hipotensi, sehingga penggunaannya harus disertai pemantauan ketat. Fentanyl merupakan opioid sintesis yang memiliki onset kerja sangat cepat namun durasi kerja yang lebih singkat dibandingkan morfin, menjadikannya analgesik pilihan dalam situasi nyeri akut yang membutuhkan respons cepat, seperti pada prosedur reduksi dislokasi atau prosedur bedah kecil di IGD. Fentanyl juga memiliki risiko efek samping berupa depresi pernapasan, sehingga harus diberikan dengan pemantauan ketat terhadap tanda vital pasien. Tramadol adalah opioid yang lebih lemah dengan tambahan efek penghambatan reuptake serotonin dan norepinefrin, sering digunakan dalam nyeri sedang hingga berat dengan risiko ketergantungan yang lebih rendah dibandingkan opioid kuat seperti morfin atau fentanyl. Meskipun tramadol dianggap relatif aman, efek samping seperti mual, muntah, pusing, hingga risiko kejang pada dosis tinggi tetap harus diwaspadai.

Selain penggunaan analgesik opioid dan non-opioid, analgesik adjuvan juga digunakan dalam situasi khusus untuk meningkatkan efektivitas analgesia atau mengatasi nyeri yang sulit dikontrol dengan analgesik konvensional. Analgesik adjuvan adalah obat-obatan yang awalnya tidak dikembangkan untuk tujuan analgesik namun terbukti memiliki efek analgesik dalam kondisi tertentu. Contoh analgesik adjuvan yang sering digunakan adalah antidepresan trisiklik (misalnya amitriptilin), antikonvulsan (seperti gabapentin atau pregabalin), anestesi lokal (misalnya lidokain dalam bentuk injeksi atau topikal), serta kortikosteroid seperti deksametason yang digunakan untuk mengurangi inflamasi akut yang berat. Penggunaan analgesik adjuvan biasanya diperuntukkan pada nyeri neuropatik akut, nyeri pasca trauma kompleks, atau nyeri yang tidak responsif terhadap analgesik standar. Misalnya, lidokain topikal dapat digunakan untuk nyeri akibat luka atau luka bakar minor, sedangkan kortikosteroid berguna pada nyeri akibat inflamasi berat atau edema jaringan yang signifikan.

Dalam penggunaan terapi analgesik farmakologis, perhatian khusus harus diberikan pada potensi efek samping yang dapat terjadi akibat terapi analgesik tersebut. Efek samping yang paling umum dari NSAID adalah gangguan gastrointestinal seperti gastritis atau perdarahan lambung, serta gangguan fungsi ginjal jika digunakan secara berlebihan. Analgesik opioid memiliki risiko efek samping yang lebih serius seperti depresi pernapasan, sedasi, hipotensi, mual muntah, konstipasi, hingga risiko ketergantungan jika digunakan secara tidak tepat. Tindakan pencegahan efek samping ini meliputi pemberian dosis terendah yang efektif, pemantauan ketat tanda vital, evaluasi ketat terhadap respons klinis pasien, serta edukasi pasien dan keluarga mengenai potensi efek samping yang harus segera dilaporkan. Pemantauan ketat di IGD termasuk penilaian fungsi respirasi, tingkat sedasi, serta reaksi alergi atau efek samping lainnya menjadi kunci dalam memastikan keselamatan pasien selama pemberian analgesik.

Dengan demikian, intervensi farmakologi dalam penanganan nyeri akut di IGD memerlukan pemilihan obat yang tepat, pemahaman terhadap mekanisme kerja masing-masing obat, pemantauan ketat terhadap efek samping, serta integrasi antar berbagai jenis analgesik untuk mendapatkan efek analgesik maksimal dengan risiko minimal. Kolaborasi yang erat antara dokter, perawat, serta apoteker klinis menjadi sangat penting dalam memastikan terapi analgesik yang diberikan sesuai dengan prinsip keamanan pasien serta efektivitas pengobatan, sehingga nyeri pasien dapat dikendalikan dengan optimal tanpa menimbulkan komplikasi yang tidak diinginkan.

E. Intervensi Nonfarmakologi dalam Manajemen Nyeri Akut

Dalam manajemen nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD), pendekatan farmakologis seringkali menjadi pilihan utama. Namun demikian, pendekatan nonfarmakologis juga memiliki peran penting sebagai pelengkap terapi farmakologi atau bahkan sebagai pilihan utama dalam beberapa situasi klinis tertentu. Intervensi nonfarmakologi berperan dalam menurunkan intensitas nyeri, mengurangi kecemasan, meningkatkan kenyamanan pasien, serta membantu mencegah komplikasi psikologis yang mungkin timbul selama perawatan di IGD.

Salah satu intervensi nonfarmakologi yang sering diterapkan adalah teknik relaksasi dan distraksi. Teknik ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian pasien dari rasa nyeri, sehingga persepsi terhadap intensitas nyeri dapat berkurang secara signifikan. Teknik relaksasi yang biasa digunakan meliputi relaksasi napas dalam, relaksasi otot progresif, hingga meditasi ringan yang bisa dipandu oleh tenaga kesehatan. Pada relaksasi napas dalam, pasien diajarkan untuk bernapas perlahan melalui hidung, menahan napas beberapa detik, lalu menghembuskannya perlahan melalui mulut. Proses ini membantu meredakan ketegangan otot serta menurunkan kecemasan yang sering kali memperburuk persepsi nyeri. Sementara itu, teknik distraksi dilakukan dengan mengalihkan perhatian pasien kepada objek atau aktivitas tertentu yang menyenangkan atau menarik, seperti berbicara dengan keluarga, menonton tayangan atau video tertentu, mendengarkan musik yang disukai, atau menggunakan metode visualisasi yang membuat pasien membayangkan suasana yang menyenangkan atau menenangkan. Kombinasi teknik ini terbukti secara efektif dapat mengurangi intensitas nyeri akut dan menurunkan kebutuhan dosis analgesik pada pasien.

Intervensi berikutnya yang sering digunakan adalah terapi dingin (cryotherapy) dan terapi panas (thermotherapy). Terapi dingin dilakukan dengan cara memberikan kompres dingin, kantong es, atau cooling pack pada area tubuh yang mengalami nyeri akut. Mekanisme terapi dingin adalah dengan menyebabkan vasokonstriksi lokal, mengurangi aliran darah dan inflamasi, serta menghambat transmisi impuls nyeri melalui penurunan aktivitas saraf sensorik. Cryotherapy sangat efektif diterapkan pada kasus cedera akut seperti sprain, strain, trauma jaringan lunak, fraktur tertutup, atau luka bakar ringan. Terapi dingin biasanya diberikan segera setelah terjadi cedera dalam waktu 24 hingga 48 jam pertama dengan durasi sekitar 15–20 menit setiap sesi. Sebaliknya, terapi panas diterapkan dengan menggunakan kompres hangat, heating pad, atau botol air hangat yang bertujuan meningkatkan aliran darah lokal, membantu relaksasi otot, serta mengurangi kekakuan otot dan

sendi. Thermotherapy efektif pada kondisi nyeri akibat spasme otot, ketegangan otot, atau nyeri muskuloskeletal kronik yang mengalami eksaserbasi akut. Meskipun demikian, terapi panas harus diberikan secara hati-hati dan tidak digunakan pada fase awal cedera akut yang disertai inflamasi aktif karena dapat memperburuk kondisi inflamasi.

Imobilisasi dan pengaturan posisi yang nyaman juga merupakan intervensi nonfarmakologi yang penting dalam manajemen nyeri akut di IGD. Imobilisasi bertujuan untuk mengurangi pergerakan yang menyebabkan nyeri atau cedera lanjutan pada jaringan yang terkena. Teknik imobilisasi ini mencakup pemasangan bidai (splint), sling, gips, atau brace, tergantung jenis cedera yang dialami pasien. Imobilisasi sangat efektif untuk nyeri yang timbul akibat patah tulang, dislokasi, atau cedera ligamen dan tendon. Selain imobilisasi, pengaturan posisi pasien yang tepat dan nyaman juga merupakan aspek penting. Posisi yang nyaman, seperti posisi semi-Fowler atau Fowler, sering kali membantu mengurangi nyeri pasien akibat cedera, nyeri dada akut, nyeri abdomen, atau cedera lainnya. Dengan pengaturan posisi tubuh yang tepat, tekanan pada area yang mengalami cedera dapat dikurangi, sehingga meminimalisasi intensitas nyeri yang dirasakan pasien.

Intervensi nonfarmakologi lainnya yang tidak kalah penting adalah edukasi dan dukungan psikologis kepada pasien dan keluarga di IGD. Nyeri akut yang dialami pasien sering kali disertai kecemasan, rasa takut, serta ketidakpastian terhadap kondisinya. Kondisi psikologis yang negatif ini dapat memperparah persepsi nyeri serta memperlambat proses pemulihan pasien. Oleh karena itu, perawat dan tenaga kesehatan di IGD memiliki peran penting dalam memberikan edukasi mengenai kondisi medis pasien, menjelaskan secara jelas tentang prosedur yang akan dilakukan, serta memberikan informasi tentang manajemen nyeri yang akan diterapkan. Informasi yang jelas, lengkap, dan disampaikan dengan empati dapat membantu mengurangi kecemasan pasien, memberikan rasa percaya terhadap tim medis, serta meningkatkan rasa nyaman selama berada di IGD.

Dukungan psikologis ini dapat diwujudkan dalam bentuk komunikasi terapeutik yang empati, mendengarkan keluhan dan kekhawatiran pasien secara aktif, serta memberikan validasi terhadap emosi yang dirasakan pasien. Selain itu, keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan emosional juga sangat dianjurkan, karena keluarga merupakan sumber dukungan terpenting bagi pasien di situasi kritis seperti ini. Dengan dukungan emosional yang kuat, pasien cenderung mengalami pengurangan rasa takut, kecemasan, dan stres emosional, yang secara

langsung berkontribusi pada penurunan persepsi nyeri serta peningkatan efektivitas terapi yang diberikan.

Secara keseluruhan, intervensi nonfarmakologi dalam manajemen nyeri akut di IGD merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada gejala fisik tetapi juga memperhatikan aspek psikologis dan emosional pasien. Penerapan teknik relaksasi dan distraksi, terapi panas dan dingin, imobilisasi dan pengaturan posisi yang nyaman, serta edukasi dan dukungan psikologis merupakan intervensi efektif yang terbukti mampu mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan pasien, dan membantu proses pemulihan secara lebih optimal. Kolaborasi antarprofesional di IGD sangat penting untuk memastikan bahwa intervensi nonfarmakologi ini dapat dilakukan secara konsisten, efektif, dan terintegrasi dalam proses penanganan pasien dengan nyeri akut.

F. Penatalaksanaan Nyeri Akut pada Kondisi Klinis Khusus

Penatalaksanaan nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) membutuhkan pendekatan yang spesifik dan komprehensif, terutama dalam situasi klinis tertentu yang melibatkan mekanisme cedera, jenis jaringan yang terlibat, atau kondisi klinis yang mendasarinya. Setiap kondisi klinis khusus memiliki karakteristik nyeri tersendiri yang memerlukan strategi penanganan yang tepat untuk mengurangi penderitaan pasien, mempercepat pemulihan, serta mencegah komplikasi lebih lanjut.

Salah satu kondisi klinis khusus yang sering menyebabkan nyeri akut di IGD adalah trauma muskuloskeletal, seperti fraktur atau dislokasi. Nyeri akibat trauma muskuloskeletal biasanya terjadi akibat kerusakan jaringan tulang, otot, ligamen, maupun struktur sendi yang mengakibatkan inflamasi lokal, edema, serta spasme otot. Pada kasus fraktur, nyeri yang muncul biasanya bersifat sangat tajam, intens, dan semakin meningkat dengan pergerakan atau tekanan pada area yang cedera. Penatalaksanaan nyeri akut pada kondisi ini umumnya dimulai dengan imobilisasi daerah yang cedera menggunakan bidai atau splint untuk mencegah pergerakan tulang yang patah serta mengurangi nyeri akibat spasme otot dan kerusakan jaringan lunak lebih lanjut. Selain imobilisasi, pemberian analgesik yang kuat seperti opioid (morfin atau fentanyl) sering diperlukan dalam kasus fraktur berat atau dislokasi berat yang sangat nyeri. Untuk fraktur ringan atau sedang, analgesik non-opioid seperti NSAID atau parasetamol mungkin sudah mencukupi untuk mengontrol nyeri. Kombinasi intervensi nonfarmakologi seperti pemberian kompres dingin (cryotherapy) pada fase awal cedera juga sangat efektif dalam menurunkan inflamasi lokal serta membantu meredakan nyeri yang dirasakan pasien.

Nyeri pada pasien dengan luka bakar akut merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan nyeri di IGD. Luka bakar akut menimbulkan nyeri hebat akibat cedera termal yang merusak reseptor nyeri kulit dan jaringan di bawahnya. Nyeri akibat luka bakar dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, bahkan setelah kontak dengan sumber panas dihentikan. Penanganan nyeri luka bakar dimulai dengan pendinginan area yang terkena untuk mengurangi progresivitas kerusakan jaringan, yang sekaligus memberikan efek analgesik lokal. Air bersuhu ruangan dialirkan secara lembut pada area luka bakar selama beberapa menit hingga nyeri berkurang secara signifikan. Setelah langkah awal ini, terapi analgesik yang intensif harus diberikan, sering kali berupa analgesik opioid seperti morfin atau fentanyl, yang diberikan secara intravena untuk mengendalikan nyeri yang hebat. Analgesik non-opioid seperti parasetamol atau NSAID juga digunakan untuk mengontrol nyeri ringan hingga sedang. Pada kasus luka bakar yang luas dan parah, pasien biasanya membutuhkan kombinasi analgesik opioid dosis tinggi, terapi sedasi, serta dukungan psikologis intensif untuk mengelola rasa nyeri serta kecemasan yang ditimbulkan oleh cedera.

Kondisi klinis lain yang memerlukan perhatian khusus dalam manajemen nyeri akut adalah nyeri akibat kondisi bedah emergensi seperti appendisitis akut atau hernia strangulasi. Nyeri pada appendisitis akut biasanya muncul secara mendadak, diawali oleh nyeri samar di sekitar umbilikus, kemudian berpindah dan terlokalisasi di daerah perut kanan bawah. Nyeri ini bersifat konstan, meningkat dengan gerakan, batuk, atau tekanan, dan sering disertai gejala sistemik seperti demam, mual, dan muntah. Nyeri akibat hernia strangulasi juga muncul secara tiba-tiba, disertai nyeri tajam di area hernia, pembengkakan lokal, serta tanda-tanda obstruksi usus seperti muntah dan distensi abdomen. Pada kondisi-kondisi ini, pemberian analgesik opioid intravena seperti morfin sering kali menjadi pilihan utama untuk mengontrol nyeri dengan cepat sambil menunggu tindakan pembedahan segera. Namun, pemberian analgesik harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengaburkan gambaran klinis yang diperlukan untuk diagnosis lebih lanjut. Manajemen nyeri pada kondisi ini juga perlu diikuti oleh intervensi definitif berupa tindakan bedah segera, yang merupakan kunci utama resolusi nyeri secara permanen.

Nyeri akut pada kondisi kardiovaskular seperti infark miokard akut (IMA) atau angina pectoris juga memerlukan penanganan khusus yang cepat dan efektif. Nyeri dada akibat IMA umumnya bersifat berat, mendadak, sering digambarkan sebagai rasa tertekan atau diremas di dada bagian tengah atau kiri, yang bisa menjalar ke lengan kiri, bahu, leher, atau rahang. Nyeri ini biasanya disertai dengan gejala tambahan seperti sesak napas, keringat dingin, mual, muntah, atau bahkan rasa cemas yang hebat. Penanganan nyeri akibat IMA di IGD memerlukan pemberian

analgesik opioid seperti morfin intravena, yang tidak hanya efektif mengurangi nyeri tetapi juga membantu menurunkan kecemasan pasien, mengurangi kebutuhan oksigen miokard, serta memperbaiki hemodinamik pasien. Selain terapi analgesik, pasien dengan nyeri akibat kondisi kardiovaskular akut juga perlu mendapatkan terapi tambahan seperti nitrogliserin untuk vasodilatasi koroner dan pemberian oksigen tambahan untuk mengatasi hipoksia jaringan jantung yang memperparah nyeri. Pada kasus angina stabil yang lebih ringan, penggunaan nitrat sublingual seperti nitrogliserin sering cukup efektif dalam mengurangi nyeri, disertai dengan analgesik non-opioid sebagai tambahan jika diperlukan.

Secara keseluruhan, penatalaksanaan nyeri akut pada kondisi klinis khusus di IGD menuntut tenaga kesehatan untuk mampu mengenali karakteristik nyeri dengan cepat dan akurat, serta menerapkan pendekatan terapi yang spesifik berdasarkan mekanisme cedera atau kondisi klinis yang mendasarinya. Strategi manajemen nyeri ini meliputi kombinasi imobilisasi, terapi pendinginan, penggunaan analgesik opioid atau non-opioid secara tepat, serta intervensi bedah yang tepat waktu jika diperlukan. Kecepatan dan ketepatan dalam manajemen nyeri akut pada kondisi khusus ini sangat menentukan keberhasilan terapi, mencegah komplikasi lanjutan, meningkatkan kepuasan pasien, serta mempercepat proses pemulihan pasien secara optimal.

G. Kolaborasi Interprofesional dalam Manajemen Nyeri di IGD

Kolaborasi interprofesional merupakan aspek yang sangat penting dalam penatalaksanaan nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Nyeri akut yang muncul secara mendadak dan intens, memerlukan penilaian serta pengelolaan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan baik oleh berbagai profesi kesehatan. Dalam lingkungan IGD yang dinamis dan penuh tekanan, kolaborasi antarprofesi, seperti dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, serta tenaga kesehatan lainnya menjadi kunci utama untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan optimal dalam penanganan nyeri akut yang dialaminya.

Dalam konteks penilaian dan pengelolaan nyeri akut di IGD, tenaga kesehatan memiliki peran yang berbeda-beda namun saling melengkapi. Dokter memiliki peran sentral dalam menentukan diagnosis penyebab nyeri, memilih terapi farmakologis maupun nonfarmakologis yang paling sesuai berdasarkan hasil evaluasi klinis, serta memantau respon terapi yang diberikan kepada pasien. Sementara itu, perawat memiliki peran krusial dalam melakukan penilaian awal terhadap nyeri pasien menggunakan instrumen yang valid dan reliabel seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), atau Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling sering berada di sisi

pasien, sehingga mereka memiliki kesempatan yang besar untuk mengobservasi secara detail mengenai respons pasien terhadap intervensi nyeri, serta dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan kondisi pasien atau efek samping dari terapi yang diberikan.

Di sisi lain, apoteker juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan nyeri akut, terutama terkait dengan farmakoterapi. Apoteker membantu memastikan pemilihan analgesik yang tepat berdasarkan kondisi klinis pasien, mengidentifikasi risiko efek samping serta interaksi obat yang mungkin terjadi, dan memberikan informasi kepada tim medis tentang dosis yang tepat serta pilihan analgesik alternatif bila diperlukan. Profesi lain seperti fisioterapis juga memiliki peran penting dalam manajemen nyeri, khususnya dalam memberikan intervensi nonfarmakologis berupa terapi fisik, imobilisasi, atau latihan peregangan yang dapat membantu mengurangi nyeri akut, terutama pada pasien dengan cedera muskuloskeletal atau pasca tindakan bedah emergensi. Dengan demikian, setiap anggota tim kesehatan di IGD memiliki peranan unik yang apabila dikolaborasikan secara baik akan menghasilkan penanganan nyeri yang komprehensif, efektif, dan aman bagi pasien.

Selain peran individu masing-masing tenaga kesehatan, komunikasi yang efektif antarprofesi juga menjadi elemen krusial dalam kolaborasi interprofesional di IGD. Dalam kondisi kegawatdaruratan, komunikasi yang jelas, tepat, dan terstruktur akan mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu pendekatan komunikasi antarprofesi yang terbukti efektif di lingkungan klinis, termasuk IGD, adalah metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Melalui metode ini, perawat dapat menyampaikan kondisi pasien secara jelas dan ringkas kepada dokter maupun anggota tim lainnya, mulai dari kondisi terkini pasien, riwayat penyakit atau cedera yang relevan, hasil penilaian nyeri yang dilakukan, serta rekomendasi intervensi lanjutan yang dibutuhkan pasien. Begitu pula sebaliknya, dokter atau tenaga kesehatan lain dapat memberikan instruksi dengan jelas, memastikan bahwa seluruh tim memahami tindakan yang harus segera dilaksanakan untuk menangani nyeri pasien secara optimal.

Selain komunikasi yang efektif, dokumentasi yang jelas dan terstruktur juga merupakan bagian integral dari kolaborasi antarprofesi dalam manajemen nyeri akut. Dokumentasi yang baik memastikan bahwa semua informasi klinis yang relevan tentang nyeri pasien, intervensi yang telah diberikan, respons pasien terhadap intervensi, serta rencana tindakan lanjutan, terdokumentasi secara rinci. Hal ini sangat membantu untuk menjaga kontinuitas perawatan ketika terjadi pergantian shift, sehingga semua anggota tim memiliki pemahaman yang konsisten

mengenai kondisi pasien, memastikan bahwa kualitas pengelolaan nyeri tetap terjaga dengan baik.

Dalam konteks interprofesional, perawat juga memiliki peran khusus sebagai advokat pasien dalam manajemen nyeri. Advokasi pasien merupakan peran esensial yang dijalankan oleh perawat dengan tujuan memastikan bahwa kebutuhan pasien dalam mengelola nyeri dipenuhi secara maksimal. Perawat, sebagai advokat, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa nyeri yang dialami pasien dinilai dengan tepat dan mendapatkan perhatian penuh dari seluruh tim kesehatan. Perawat juga memiliki tanggung jawab dalam menyuarakan kebutuhan pasien, terutama apabila pasien mengalami kesulitan mengomunikasikan nyerinya secara jelas karena keterbatasan fisik, emosional, atau psikologis. Misalnya, pada pasien dengan gangguan kesadaran, lansia, anak-anak, atau pasien yang mengalami hambatan komunikasi karena bahasa, perawat akan menjadi pihak yang sangat penting dalam menginterpretasikan kebutuhan nyeri pasien, menyampaikan informasi tersebut secara jelas kepada dokter maupun tim kesehatan lain, serta memastikan bahwa intervensi yang diperlukan segera diberikan.

Sebagai advokat pasien, perawat juga bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga tentang nyeri akut yang dialami, metode penilaian nyeri yang digunakan, pilihan terapi yang tersedia, serta potensi efek samping terapi nyeri yang diberikan. Edukasi ini sangat penting agar pasien dan keluarga memiliki pemahaman yang jelas tentang proses manajemen nyeri di IGD, meningkatkan partisipasi pasien dalam pengelolaan nyerinya, serta mengurangi kecemasan yang mungkin muncul akibat kondisi gawat darurat. Selain itu, perawat juga memberikan dukungan psikologis kepada pasien yang mengalami nyeri akut, membantu mereka untuk tetap tenang dan nyaman, serta meningkatkan rasa percaya diri pasien terhadap tim medis yang merawatnya.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional dalam penatalaksanaan nyeri akut di IGD adalah proses yang kompleks namun esensial. Keberhasilan dalam pengelolaan nyeri akut bergantung pada peran aktif dari setiap tenaga kesehatan, komunikasi yang efektif dan jelas antarprofesi, dokumentasi klinis yang sistematis, serta peran advokasi yang kuat dari perawat. Dengan kolaborasi yang harmonis, pasien dengan nyeri akut akan mendapatkan penilaian serta penatalaksanaan yang cepat, tepat, efektif, dan aman, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di IGD, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta memberikan pengalaman positif bagi pasien dan keluarganya.

H. Pemantauan dan Evaluasi Respons Nyeri Pasca-Intervensi

Pemantauan dan evaluasi respons nyeri setelah dilakukannya intervensi merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses manajemen nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Setelah intervensi, baik farmakologis maupun nonfarmakologis diberikan, tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan telah mencapai hasil yang diharapkan. Tahap ini tidak hanya bertujuan untuk mengukur efektivitas terapi nyeri, tetapi juga untuk mendeteksi secara dini munculnya efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi akibat intervensi yang dilakukan. Oleh karena itu, tahap pemantauan dan evaluasi ini menjadi bagian integral dari proses keseluruhan penanganan nyeri di IGD.

Dalam mengevaluasi keberhasilan terapi nyeri, tenaga kesehatan di IGD perlu mengetahui dengan jelas indikator-indikator klinis yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah terapi yang telah diberikan berhasil atau memerlukan penyesuaian lebih lanjut. Indikator utama yang paling sering digunakan adalah penurunan intensitas nyeri yang dialami pasien. Penilaian intensitas nyeri ini biasanya dilakukan dengan instrumen pengukuran nyeri yang valid dan reliabel seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), atau Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Penurunan skor nyeri yang signifikan setelah pemberian terapi menjadi tanda bahwa intervensi yang dilakukan berhasil mencapai tujuannya.

Selain penurunan intensitas nyeri secara objektif melalui skala penilaian, indikator lain yang penting adalah perubahan perilaku pasien dan status fisiologis yang terkait dengan nyeri. Misalnya, pada pasien yang mengalami nyeri akut berat akibat trauma muskuloskeletal, keberhasilan terapi nyeri dapat ditandai dengan pasien menjadi lebih tenang, rileks, serta menunjukkan penurunan pada tanda-tanda fisiologis seperti penurunan frekuensi napas dan denyut jantung, serta tekanan darah yang stabil. Hal ini menunjukkan bahwa nyeri pasien telah terkontrol dengan baik, sehingga respons stres fisiologis pasien juga ikut menurun. Indikator keberhasilan lainnya termasuk meningkatnya kemampuan pasien untuk berpartisipasi dalam tindakan klinis lanjutan, meningkatnya kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima, serta menurunnya tingkat kecemasan yang semula disebabkan oleh rasa nyeri yang hebat.

Pemantauan respons terapi nyeri harus dilakukan secara teratur dan sistematis. Di IGD, pemantauan ini biasanya dilakukan dengan interval yang singkat, misalnya setiap 15–30 menit pada kasus nyeri akut berat, atau setiap jam pada kasus nyeri sedang hingga ringan. Frekuensi pemantauan ini dapat disesuaikan kembali dengan kondisi klinis pasien, jenis terapi yang diberikan, serta respons awal pasien terhadap terapi tersebut. Pemantauan yang ketat ini sangat penting untuk mendeteksi secara

dini apakah pasien mengalami efek samping atau komplikasi dari intervensi nyeri yang telah diberikan.

Dalam konteks terapi farmakologis, efek samping yang sering terjadi misalnya adalah sedasi berlebihan, mual muntah, depresi pernapasan, hipotensi, alergi, atau gangguan gastrointestinal akibat pemberian analgesik opioid maupun non-opioid. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi gejala-gejala tersebut secara cepat, sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan sebelum komplikasi yang lebih serius muncul. Misalnya, pada pasien yang mendapatkan analgesik opioid seperti morfin atau fentanyl, perawat harus secara rutin mengamati frekuensi dan kedalaman pernapasan pasien, serta tingkat kesadaran untuk mendeteksi sedasi atau depresi pernapasan secara dini. Bila ditemukan tanda-tanda tersebut, maka dosis analgesik perlu dievaluasi ulang atau diberikan obat antagonis seperti nalokson sesuai protokol.

Selain pemantauan efek samping farmakologis, tenaga kesehatan juga harus mengevaluasi respons pasien terhadap intervensi nonfarmakologis yang telah diberikan. Misalnya, setelah penggunaan teknik relaksasi atau terapi kompres dingin (cryotherapy) dan panas (thermotherapy), respons pasien harus diamati untuk melihat apakah intervensi tersebut memberikan efek analgesik yang diinginkan atau justru menimbulkan ketidaknyamanan tambahan bagi pasien. Respons pasien seperti ekspresi wajah yang lebih rileks, penurunan keluhan verbal terhadap nyeri, atau perbaikan posisi tubuh yang nyaman juga menjadi indikator keberhasilan intervensi nonfarmakologis.

Setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap respons pasien pasca-intervensi, tahap berikutnya yang sangat penting adalah melakukan dokumentasi dan pelaporan hasil evaluasi nyeri secara jelas, akurat, dan sistematis. Dokumentasi ini meliputi pencatatan secara detail mengenai intensitas nyeri sebelum dan setelah intervensi, jenis intervensi yang diberikan (baik farmakologis maupun nonfarmakologis), dosis dan waktu pemberian analgesik, respons pasien terhadap terapi, serta kejadian efek samping atau komplikasi yang muncul selama proses penanganan nyeri. Dokumentasi yang lengkap ini tidak hanya menjadi bukti medis yang penting, tetapi juga memudahkan komunikasi antar tenaga kesehatan dalam tim interprofesional, terutama saat pergantian shift, atau ketika pasien dirujuk ke unit lain untuk perawatan lanjutan.

Selain dokumentasi tertulis, pelaporan verbal juga harus dilakukan secara efektif menggunakan metode komunikasi standar seperti Situation, Background, Assessment, Recommendation (SBAR). Melalui metode ini, informasi tentang kondisi nyeri pasien, intervensi yang telah diberikan, respons pasien terhadap intervensi, serta rekomendasi tindakan atau pemantauan lebih lanjut dapat disampaikan

dengan jelas dan terstruktur kepada tim kesehatan berikutnya. Pelaporan yang baik dan jelas ini sangat penting untuk menjamin kontinuitas perawatan, memastikan bahwa terapi nyeri yang diberikan tetap konsisten, serta mencegah munculnya kesalahan komunikasi yang dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien.

Secara keseluruhan, pemantauan dan evaluasi respons nyeri pasca-intervensi merupakan tahapan yang kritis dalam proses penatalaksanaan nyeri akut di IGD. Tahapan ini memastikan bahwa intervensi yang diberikan kepada pasien berhasil mencapai hasil yang diharapkan, mendeteksi secara dini munculnya efek samping atau komplikasi, serta menjamin kesinambungan perawatan melalui dokumentasi dan pelaporan yang jelas dan akurat. Dengan demikian, pasien dapat menerima pelayanan manajemen nyeri yang optimal, aman, dan berkualitas tinggi, sehingga tidak hanya meningkatkan keselamatan pasien, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

I. Tantangan dan Isu Terkini dalam Penatalaksanaan Nyeri di Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Penatalaksanaan nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan kompleks dan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek klinis, tetapi juga melibatkan faktor psikologis, etis, serta manajerial. Pemahaman terhadap tantangan dan isu terkini dalam manajemen nyeri ini sangat penting agar tenaga kesehatan di IGD mampu memberikan layanan yang optimal, efektif, serta aman bagi pasien yang mengalami nyeri akut. Adapun beberapa tantangan utama yang perlu dipahami meliputi hambatan dalam penilaian nyeri, tantangan etik dalam penggunaan analgesik opioid, serta keterbatasan sumber daya yang sering dihadapi di lingkungan IGD.

Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi oleh tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan nyeri akut adalah kesulitan dalam melakukan penilaian nyeri yang akurat dan konsisten di lingkungan IGD. Lingkungan IGD yang penuh tekanan, dinamis, serta ditandai oleh tingginya beban kerja tenaga kesehatan sering kali menyebabkan proses penilaian nyeri tidak dilakukan secara menyeluruh. Faktor eksternal seperti overcrowding (kepenuhan IGD oleh pasien), tingginya frekuensi kedatangan pasien baru, serta kondisi pasien yang tidak stabil secara klinis turut memperumit situasi ini. Dalam kondisi kegawatan yang tinggi, tenaga kesehatan cenderung memprioritaskan intervensi yang dianggap langsung menyelamatkan nyawa, sehingga penilaian nyeri terkadang dianggap kurang mendesak atau dikesampingkan sementara waktu. Padahal, penilaian nyeri yang tidak memadai dapat menyebabkan nyeri yang dialami pasien tidak tertangani secara optimal, berakibat pada penurunan kualitas pelayanan, serta risiko munculnya komplikasi

klinis yang berhubungan dengan nyeri akut yang tidak terkontrol, seperti peningkatan stres fisiologis dan gangguan hemodinamik.

Selain tantangan lingkungan yang padat, kondisi pasien juga sering menjadi kendala dalam penilaian nyeri. Pasien yang mengalami perubahan kesadaran, kesulitan komunikasi, atau pasien anak-anak yang belum mampu mengekspresikan nyerinya secara verbal dapat menyulitkan tenaga kesehatan dalam menilai intensitas nyeri secara akurat. Pada kondisi tersebut, tenaga kesehatan harus bergantung pada indikator fisiologis atau perilaku nyeri yang terkadang memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi. Untuk mengatasi hambatan tersebut, tenaga kesehatan perlu dibekali dengan pelatihan khusus dalam penilaian nyeri, serta penggunaan instrumen yang adaptif seperti Wong-Baker Faces Pain Scale pada anak-anak atau skala perilaku nyeri pada pasien dengan penurunan kesadaran.

Tantangan berikutnya yang sangat signifikan dalam praktik penatalaksanaan nyeri di IGD adalah dilema etik terkait penggunaan analgesik opioid. Obat-obatan opioid seperti morfin, fentanyl, atau tramadol merupakan analgesik yang efektif untuk mengatasi nyeri akut berat, namun penggunaannya harus dipertimbangkan secara hati-hati mengingat risiko penyalahgunaan, ketergantungan, serta potensi efek samping yang serius seperti depresi pernapasan. Dilema etik muncul ketika tenaga kesehatan harus membuat keputusan tentang pemberian opioid, terutama dalam kasus pasien dengan riwayat penyalahgunaan zat atau pasien yang berisiko tinggi mengalami adiksi. Di satu sisi, tenaga kesehatan memiliki kewajiban etis untuk mengurangi penderitaan pasien secara maksimal (prinsip beneficence), namun di sisi lain, mereka juga harus berhati-hati untuk tidak menyebabkan bahaya tambahan (prinsip non-maleficence) melalui risiko penyalahgunaan atau efek samping opioid yang berat.

Tantangan ini semakin kompleks karena adanya perbedaan persepsi dan stigma terhadap pasien yang mengalami nyeri kronik atau memiliki riwayat penyalahgunaan zat. Beberapa tenaga kesehatan mungkin ragu atau bahkan enggan memberikan opioid karena takut pasien mengalami ketergantungan, padahal kondisi pasien secara klinis memang memerlukan analgesik opioid dalam dosis yang tepat. Dalam menghadapi dilema etik ini, tenaga kesehatan dituntut memiliki pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip etika kedokteran, panduan penggunaan opioid yang rasional, serta kemampuan melakukan edukasi dan komunikasi yang efektif dengan pasien dan keluarganya. Komunikasi terbuka mengenai manfaat, risiko, serta pengawasan ketat terhadap penggunaan opioid diharapkan dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan sambil tetap menjamin bahwa pasien menerima perawatan nyeri yang optimal.

Selain hambatan dalam penilaian nyeri dan tantangan etik, keterbatasan sumber daya juga merupakan isu yang tidak kalah penting dalam penanganan nyeri di IGD. Keterbatasan sumber daya ini mencakup aspek tenaga kesehatan, ketersediaan obat-obatan analgesik yang memadai, serta alat penunjang yang dibutuhkan dalam proses penanganan nyeri akut. Keterbatasan tenaga kesehatan yang sering kali terjadi di IGD dapat menyebabkan penundaan atau ketidaksesuaian dalam pemberian terapi nyeri, sehingga pasien harus menunggu lebih lama sebelum mendapatkan analgesik atau intervensi nonfarmakologis. Ketersediaan obat analgesik tertentu seperti opioid juga sering menjadi kendala di fasilitas kesehatan tertentu, terutama di daerah terpencil atau rumah sakit dengan fasilitas yang terbatas. Kondisi ini secara nyata membatasi kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan manajemen nyeri yang efektif dan tepat waktu.

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya tersebut, beberapa strategi dapat diterapkan oleh manajemen rumah sakit maupun tim kesehatan di IGD. Salah satunya adalah melalui optimalisasi manajemen stok obat analgesik, dengan memastikan persediaan obat esensial selalu tersedia sesuai dengan tingkat kebutuhan pasien yang datang ke IGD. Selain itu, pelatihan tambahan bagi tenaga kesehatan untuk menggunakan intervensi nonfarmakologis sebagai pelengkap terapi farmakologis juga dapat membantu mengatasi situasi saat obat analgesik terbatas atau tidak tersedia. Strategi lain yang tidak kalah penting adalah melalui penerapan triase nyeri yang efektif, di mana pasien dengan nyeri akut berat diberikan prioritas tinggi dalam mendapatkan intervensi, sehingga sumber daya yang terbatas tetap dapat digunakan secara efisien dan tepat sasaran.

Di samping itu, pendekatan interprofesional dalam manajemen nyeri juga menjadi solusi strategis untuk mengatasi keterbatasan tenaga. Kolaborasi yang erat antara perawat, dokter, farmasis, serta tenaga penunjang lain seperti fisioterapis atau tenaga kesehatan mental dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan efisiensi layanan nyeri di IGD. Dengan kolaborasi ini, masing-masing profesi dapat memberikan kontribusi sesuai keahliannya, sehingga manajemen nyeri di IGD dapat tetap dilakukan secara optimal meskipun dalam kondisi sumber daya yang terbatas.

Secara keseluruhan, memahami dan mengatasi tantangan serta isu terkini dalam penatalaksanaan nyeri di IGD merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Hambatan dalam penilaian nyeri, tantangan etik dalam penggunaan opioid, serta keterbatasan sumber daya memerlukan perhatian serius dan upaya strategis dari seluruh tenaga kesehatan yang terlibat. Dengan mengidentifikasi tantangan ini secara jelas serta menerapkan strategi yang tepat dan efektif, pelayanan manajemen nyeri akut di IGD dapat

menjadi lebih berkualitas, aman, serta berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan pasien secara menyeluruh.

J. Simpulan

Penatalaksanaan nyeri akut di Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan aspek kritis dalam pelayanan kesehatan emergensi yang memerlukan pendekatan sistematis, komprehensif, serta kolaboratif antarprofesional. Nyeri akut, sebagai kondisi yang muncul secara mendadak dengan intensitas tinggi, memerlukan penanganan segera untuk mencegah dampak negatif terhadap kondisi klinis pasien, proses diagnostik dan terapeutik, serta kualitas pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Manajemen nyeri yang baik di IGD tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis serta keselamatan pasien secara menyeluruh.

Prinsip dasar dalam penilaian nyeri akut mencakup penggunaan instrumen yang terstandar seperti Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), dan Wong-Baker Faces Scale untuk menentukan intensitas nyeri secara objektif. Selain itu, identifikasi faktor pemicu serta pemberat nyeri dan hubungan antara nyeri dengan tanda vital pasien merupakan bagian integral dalam penilaian awal yang memungkinkan intervensi cepat dan tepat sasaran.

Pendekatan multimodal menjadi strategi utama dalam manajemen nyeri akut di IGD, mengintegrasikan intervensi farmakologis dan nonfarmakologis secara bersamaan. Penggunaan analgesik farmakologis, seperti NSAID, parasetamol, opioid, serta analgesik adjuvan, harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien serta memperhatikan potensi efek samping yang mungkin muncul. Di sisi lain, intervensi nonfarmakologis seperti teknik relaksasi dan distraksi, terapi dingin dan panas, imobilisasi, serta edukasi dan dukungan psikologis pasien sangat efektif dalam mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan kenyamanan, serta mengurangi kecemasan pasien selama perawatan di IGD.

Penatalaksanaan nyeri akut pada kondisi klinis khusus seperti trauma muskuloskeletal, luka bakar akut, kondisi bedah emergensi, serta nyeri akibat kondisi kardiovaskular memerlukan pendekatan khusus dengan strategi penanganan yang spesifik sesuai karakteristik dan mekanisme nyeri masing-masing kondisi. Dalam hal ini, kecepatan identifikasi kondisi, pemilihan intervensi farmakologis yang tepat, serta intervensi nonfarmakologis pendukung menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan nyeri.

Kolaborasi interprofesional yang efektif antara dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, serta tenaga kesehatan lain merupakan kunci utama dalam penanganan nyeri akut di IGD. Komunikasi efektif melalui metode standar seperti SBAR serta

dokumentasi yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap anggota tim memahami kondisi pasien secara jelas, menjamin kesinambungan pelayanan, serta meminimalkan risiko kesalahan klinis. Dalam kolaborasi ini, peran perawat sebagai advokat pasien menjadi sangat vital, khususnya dalam memastikan kebutuhan nyeri pasien terpenuhi dan didukung oleh edukasi serta dukungan psikologis yang memadai.

Tahapan pemantauan dan evaluasi respons nyeri pasca-intervensi juga merupakan bagian penting dalam proses manajemen nyeri di IGD. Evaluasi yang sistematis dan rutin terhadap intensitas nyeri serta respons pasien terhadap terapi yang diberikan memastikan efektivitas intervensi, serta mendeteksi secara dini potensi efek samping atau komplikasi terapi. Dokumentasi yang rinci serta pelaporan yang jelas membantu menjaga kontinuitas perawatan dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang tepat.

Terakhir, berbagai tantangan dan isu terkini dalam penatalaksanaan nyeri akut di IGD, seperti hambatan dalam penilaian nyeri, dilema etik dalam penggunaan opioid, serta keterbatasan sumber daya, memerlukan perhatian serius dari semua tenaga kesehatan. Mengatasi tantangan ini melalui pelatihan berkelanjutan, penerapan triase nyeri yang efektif, optimalisasi stok obat analgesik, serta peningkatan kolaborasi interprofesional, menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa penatalaksanaan nyeri akut di IGD dapat berlangsung optimal, efektif, dan berorientasi pada keselamatan pasien.

Dengan pemahaman dan penerapan yang baik dari semua aspek tersebut, penanganan nyeri akut di IGD tidak hanya mampu mengurangi penderitaan pasien secara signifikan, tetapi juga meningkatkan keselamatan, mempercepat proses pemulihan, serta secara keseluruhan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

K. Referensi

- Ferreira-Valente, M. A., Pais-Ribeiro, J. L., & Jensen, M. P. (2011). Validity of four pain intensity rating scales. *Pain*, 152(10), 2399–2404. <https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.07.005>
- Garra, G., Singer, A. J., Taira, B. R., Chohan, J., Cardoz, H., Chisena, E., & Thode, H. C., Jr. (2010). Validation of the Wong-Baker FACES Pain Rating Scale in pediatric emergency department patients. *Academic Emergency Medicine*, 17(1), 50–54. <https://doi.org/10.1111/j.1553-2712.2009.00620.x>
- Jones, P., Lamdin, R., Dalziel, S. R., & Coulter, B. (2022). Pain management of trauma patients in the ED: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 12(9), 3289. <https://doi.org/10.3390/jcm12093289>

- McKerrow, P. J., Bateman, D. N., & Dear, J. W. (2022). Use of multimodal and non-opioid analgesic treatment strategies in the ED. *The American Journal of Emergency Medicine*, 61, 173–179. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.09.029>
- Motov, S., Strayer, R., Hayes, B., Reiter, M., Rosenbaum, S., Richman, M., ... Friedman, B. W. (2018). The treatment of acute pain in the emergency department: A white paper position statement prepared for the American Academy of Emergency Medicine. *The Journal of Emergency Medicine*, 54(5), 731–736. <https://doi.org/10.1016/j.jemermed.2018.01.020>
- Ramos, A., & Smith, B. (2024). Severe pain management in the emergency department: Patient-centered considerations. *Frontiers in Public Health*, 12, Article 1352833. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1352833>
- Sandberg, M., Hyldmo, P. K., Kongstad, P., Friesgaard, K. D., & Raatiniemi, L. (2020). Ketamine for prehospital acute pain: A systematic review of benefit and harm. *BMJ Open*, 10(11), e038134. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-038134>
- St Joseph's Medical Center. (2016, April 6). New Jersey hospital relegates opiates as last-resort pain treatment. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/us-news/2016/apr/06/opiates-pain-medicine-abuse-st-josephs-medical-center-policy>
- Todd, K. H. (2017). A review of current and emerging approaches to pain management in the emergency department. *Pain and Therapy*, 6(2), 193–202. <https://doi.org/10.1007/s40122-017-0090-5>
- Undertreatment of pain. (2025, June). In Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Undertreatment_of_pain
- Wong-Baker FACES Foundation. (2022). Wong-Baker FACES® Pain Rating Scale. Retrieved from <https://wongbakerfaces.org>
- World Health Organization. (2020). Guidelines on the management of chronic pain in children. Geneva: WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/9789240017870>

K. Glosarium

Nyeri akut

Nyeri dengan onset mendadak, intensitas tinggi, dan durasi pendek (<3 bulan), umumnya terkait dengan cedera atau kondisi patologis tertentu.

Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Unit di rumah sakit yang memberikan layanan cepat untuk pasien dengan kondisi akut, kritis, atau yang mengancam nyawa.

Stimulus patologis

Faktor yang menyebabkan kerusakan jaringan atau memicu respons nyeri.

Takikardia

Kondisi peningkatan frekuensi detak jantung melebihi batas normal (>100 kali per menit).

Hipertensi

Kondisi tekanan darah tinggi secara abnormal yang berisiko menyebabkan komplikasi.

Hiperventilasi

Kondisi pernapasan cepat atau dalam yang menyebabkan penurunan kadar karbon dioksida (CO₂) dalam darah.

Kortisol

Hormon stres yang diproduksi oleh kelenjar adrenal, berperan dalam respons tubuh terhadap stres atau cedera.

Numerical Rating Scale (NRS)

Instrumen pengukuran nyeri dengan angka 0 (tidak nyeri) hingga 10 (nyeri terberat yang dirasakan).

Visual Analog Scale (VAS)

Skala visual berbentuk garis lurus 10 cm untuk mengukur intensitas nyeri, di mana pasien menandai tingkat nyeri di antara dua titik ekstrem.

Wong-Baker Faces Pain Rating Scale

Skala pengukuran nyeri menggunakan gambar ekspresi wajah, khususnya berguna pada anak-anak atau pasien dengan gangguan komunikasi.

Faktor pemicu nyeri

Kondisi atau aktivitas tertentu yang menyebabkan timbul atau meningkatnya nyeri.

Faktor pemberat nyeri

Kondisi yang menyebabkan intensitas nyeri bertahan atau meningkat, seperti stres atau kecemasan.

Takipnea

Peningkatan frekuensi pernapasan di atas normal (>20 kali per menit).

Hipertermia

Kondisi peningkatan suhu tubuh di atas normal ($>38^{\circ}\text{C}$).

Pendekatan multimodal

Pengelolaan nyeri menggunakan kombinasi beberapa metode terapi, baik farmakologis maupun nonfarmakologis, untuk mencapai efektivitas optimal.

Analgesik non-opioid

Obat pereda nyeri tanpa efek narkotika yang mencakup NSAID dan parasetamol.

Analgesik opioid

Obat pereda nyeri yang bekerja pada reseptor opioid di sistem saraf pusat, memiliki efek kuat tetapi dengan risiko ketergantungan dan efek samping serius.

Analgesik adjuvan

Obat yang digunakan sebagai tambahan untuk meningkatkan efek analgesik atau mengelola nyeri spesifik yang sulit diatasi oleh analgesik biasa.

NSAID (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)

Obat antiinflamasi yang bekerja menghambat sintesis prostaglandin, efektif untuk nyeri dengan komponen inflamasi.

Depresi pernapasan

Penurunan frekuensi dan kedalaman pernapasan, sering disebabkan efek samping analgesik opioid dosis tinggi.

Cryotherapy

Terapi dingin yang mengurangi nyeri dengan vasokonstriksi lokal dan menurunkan aktivitas saraf sensorik.

Thermotherapy

Terapi panas untuk meningkatkan aliran darah lokal, relaksasi otot, serta mengurangi kekakuan otot atau sendi.

Imobilisasi

Tindakan membatasi pergerakan area cedera untuk mengurangi nyeri dan mencegah cedera lebih lanjut.

Teknik distraksi

Intervensi nonfarmakologis dengan mengalihkan perhatian pasien untuk mengurangi persepsi nyeri.

Komunikasi terapeutik

Interaksi komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien yang bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, mengurangi kecemasan, serta mempercepat proses pemulihan.

Advokasi pasien

Peran perawat dalam memperjuangkan kebutuhan dan hak pasien, termasuk kebutuhan pengelolaan nyeri yang optimal.

Intervensi farmakologis

Penggunaan obat-obatan untuk mengurangi atau mengatasi nyeri akut.

Intervensi nonfarmakologis

Metode pengelolaan nyeri yang tidak menggunakan obat-obatan, seperti relaksasi, terapi panas/dingin, edukasi, dan teknik distraksi.

Kolaborasi interprofesional

Kerja sama antar tenaga kesehatan dari berbagai profesi untuk mengoptimalkan manajemen nyeri pasien di IGD.

SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation)

Metode komunikasi terstruktur antarprofesional untuk memastikan informasi klinis disampaikan secara jelas dan efektif.

Pemantauan respons nyeri

Evaluasi berkala terhadap efektivitas intervensi nyeri yang diberikan pada pasien, baik secara klinis maupun subjektif.

Efek samping analgesik

Reaksi tidak diinginkan akibat pemberian obat pereda nyeri, seperti sedasi, mual muntah, depresi pernapasan, atau alergi.

Triase nyeri

Proses pemilahan pasien berdasarkan tingkat intensitas nyeri untuk menentukan prioritas penanganan di IGD.

Dilema etik penggunaan opioid

Konflik moral dalam memberikan analgesik opioid karena risiko ketergantungan atau efek samping serius.

Optimalisasi stok obat analgesik

Pengelolaan persediaan obat secara efektif untuk memastikan ketersediaan analgesik sesuai kebutuhan pasien di IGD.

CHAPTER 7

KEPERAWATAN ANAK DALAM SITUASI KEGAWATDARURATAN

Ns. Amatus Yudi Ismanto, Sp.Kep., An., PhD.NS.

A. Pendahuluan/Prolog

Situasi kegawatdaruratan pediatrik merupakan kondisi akut dan mendesak yang dialami anak-anak, yang memerlukan penanganan segera dan tepat guna untuk menyelamatkan nyawa serta mencegah terjadinya komplikasi serius. Kegawatdaruratan pediatrik sendiri didefinisikan sebagai situasi klinis mendadak yang mengancam kehidupan atau dapat menimbulkan kecacatan jangka panjang jika tidak segera ditangani. Dalam situasi ini, intervensi yang cepat, akurat, serta kolaboratif dari seluruh tim medis dan keperawatan menjadi aspek yang sangat penting dan menentukan keberhasilan dalam menyelamatkan nyawa serta menjamin keselamatan anak. Kegawatdaruratan pediatrik mencakup berbagai kondisi yang bervariasi, mulai dari gangguan pernapasan akut seperti serangan asma yang berat, trauma akibat kecelakaan, kondisi neurologis seperti kejang, hingga kondisi gawat lainnya seperti dehidrasi berat, syok, maupun keracunan.

Anak-anak dalam situasi kegawatdaruratan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari pasien dewasa. Mereka memiliki perbedaan mendasar baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, maupun dalam kemampuan mereka berkomunikasi. Secara anatomi dan fisiologi, anak-anak memiliki saluran pernapasan yang relatif lebih sempit, sehingga mereka lebih rentan mengalami obstruksi jalan napas. Kapasitas paru-paru dan volume pernapasan mereka pun lebih kecil, yang menyebabkan anak lebih cepat mengalami kegagalan napas jika terjadi gangguan ventilasi. Selain itu, mekanisme kompensasi tubuh anak terhadap kondisi kegawatdaruratan juga berbeda dibandingkan dewasa. Anak-anak cenderung mempertahankan tanda vital dalam rentang normal lebih lama meskipun kondisinya sudah kritis, namun tiba-tiba dapat mengalami dekompensasi secara cepat tanpa tanda peringatan yang jelas. Inilah yang membuat penilaian dan pemantauan ketat pada pasien anak dalam kondisi darurat sangat penting, serta membutuhkan kemampuan khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat.

Selain aspek anatomi dan fisiologi, karakteristik psikologis anak-anak juga perlu mendapat perhatian khusus. Anak-anak dalam kondisi kegawatdaruratan seringkali merasa takut, cemas, bingung, dan mengalami stres emosional yang tinggi akibat situasi yang tidak mereka pahami. Berbeda dengan pasien dewasa yang relatif lebih mampu mengendalikan emosi, anak-anak cenderung mengekspresikan perasaan takut atau nyerinya melalui tangisan, teriakan, atau bahkan perilaku penolakan terhadap tindakan medis yang diberikan. Situasi ini tidak hanya

menyulitkan bagi anak tetapi juga dapat memperlambat proses diagnostik dan terapeutik yang sedang dilakukan. Selain itu, keterbatasan anak dalam mengkomunikasikan keluhan atau nyeri secara jelas menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan diagnosis dan memberikan intervensi yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan yang empati, penuh perhatian, serta disertai komunikasi yang sesuai dengan tahap perkembangan anak menjadi keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh perawat dalam situasi darurat pediatrik.

Dalam konteks inilah peran perawat menjadi sangat vital dan tidak dapat digantikan dalam penanganan anak yang mengalami situasi kegawatdaruratan. Perawat merupakan anggota tim medis yang secara langsung dan intensif berada di sisi anak serta keluarga selama masa krisis terjadi. Tanggung jawab perawat dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik mencakup berbagai aspek, mulai dari melakukan penilaian awal terhadap kondisi klinis anak, memberikan tindakan penyelamatan awal yang esensial seperti memastikan jalan napas terbuka, mendukung pernapasan, serta menjaga sirkulasi yang adekuat. Selain intervensi langsung, perawat juga bertugas melakukan observasi secara ketat terhadap perubahan kondisi anak, mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang telah diberikan, serta melaporkan kondisi anak secara akurat kepada anggota tim kesehatan lainnya untuk menentukan langkah-langkah lanjutan.

Lebih jauh lagi, peran perawat dalam kegawatdaruratan pediatrik tidak terbatas hanya pada aspek teknis medis semata, namun juga mencakup aspek psikososial yang sangat penting. Perawat bertugas memberikan dukungan emosional serta psikologis kepada anak maupun keluarganya. Hal ini dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan yang tenang dan suportif, berkomunikasi secara empati dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak, serta memberikan edukasi sederhana kepada keluarga mengenai kondisi yang dialami anak serta prosedur-prosedur yang sedang atau akan dilakukan. Kemampuan perawat untuk memberikan kenyamanan psikologis ini tidak hanya membantu meredakan kecemasan yang dialami anak dan keluarganya, tetapi juga dapat meningkatkan kooperasi pasien anak terhadap prosedur medis yang diperlukan, sehingga secara keseluruhan membantu meningkatkan efektivitas penanganan klinis yang diberikan.

Secara keseluruhan, peran perawat dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik merupakan peran multidimensional yang kompleks. Kompetensi yang diperlukan tidak hanya mencakup keterampilan klinis berupa penilaian dan intervensi kegawatdaruratan secara cepat dan akurat, tetapi juga mencakup keterampilan komunikasi terapeutik, manajemen stres anak dan keluarga, serta advokasi terhadap hak-hak anak dan keluarganya selama masa kritis. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi perawat melalui pelatihan-pelatihan khusus kegawatdaruratan pediatrik menjadi sangat penting dan perlu terus dikembangkan untuk menjamin bahwa anak-anak yang mengalami kondisi kritis mendapatkan penanganan terbaik, yang tidak hanya berfokus pada aspek klinis semata tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis serta emosional anak dan keluarganya. Dengan pemahaman dan kesadaran yang mendalam mengenai pentingnya peran perawat serta

karakteristik khusus anak dalam situasi kegawatdaruratan, diharapkan pelayanan kesehatan pediatrik dapat berjalan dengan optimal serta mampu memberikan hasil yang terbaik bagi keselamatan dan kesejahteraan anak.

B. Penilaian Awal dan Triage pada Pasien Anak

Penilaian awal dan triase merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam penanganan pasien anak yang datang ke unit kegawatdaruratan. Secara umum, triase adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memilah, serta menentukan prioritas penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisinya. Dalam konteks pediatrik, proses ini memiliki karakteristik yang unik dan memerlukan perhatian khusus, karena kondisi anak yang mengalami kegawatdaruratan cenderung dapat berubah secara tiba-tiba dan sangat cepat. Prinsip dasar triase pediatrik menekankan bahwa pasien anak harus dievaluasi dengan cepat, akurat, serta hati-hati, mengingat potensi tinggi anak-anak untuk mengalami dekompensasi secara mendadak meskipun sebelumnya kondisi mereka tampak stabil.

Dalam melaksanakan triase pediatrik, prinsip pertama yang harus dipegang adalah bahwa keselamatan anak menjadi prioritas utama. Petugas triase, yang umumnya adalah seorang perawat terlatih, harus mampu mengidentifikasi anak-anak yang mengalami situasi yang mengancam jiwa dengan cepat serta menentukan prioritas intervensi medis segera. Prinsip ini sangat penting karena dalam kondisi kegawatdaruratan, setiap detik menjadi sangat berharga untuk mencegah terjadinya komplikasi serius atau bahkan kematian. Triase pediatrik juga mengutamakan prinsip keadilan, yaitu setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penanganan yang sesuai dengan tingkat kegawatannya tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Salah satu metode yang paling efektif dan umum digunakan dalam penilaian awal pasien anak dalam kondisi gawat darurat adalah pendekatan sistematis ABCDE. Pendekatan ini membantu petugas kesehatan dalam melakukan evaluasi secara terstruktur terhadap aspek-aspek yang vital bagi kelangsungan hidup anak secara berurutan, yaitu jalan napas (Airway), pernapasan (Breathing), sirkulasi (Circulation), status neurologis atau tingkat kesadaran (Disability), serta paparan tubuh atau kondisi lingkungan anak (Exposure).

Langkah pertama adalah penilaian terhadap jalan napas (Airway). Pada anak-anak, terutama bayi dan balita, struktur anatomi saluran napas cenderung lebih kecil dan sempit dibandingkan orang dewasa, sehingga mereka lebih rentan terhadap obstruksi jalan napas akibat lendir, benda asing, atau pembengkakan jaringan. Pada tahap ini, petugas triase harus segera memastikan bahwa jalan napas anak dalam

kondisi terbuka dan bebas dari hambatan. Jika ditemukan tanda-tanda obstruksi, seperti suara napas yang abnormal (stridor, mengi), retraksi otot dada yang kuat, atau sianosis (warna kebiruan pada kulit), maka tindakan intervensi segera untuk membuka atau mempertahankan jalan napas harus dilakukan tanpa penundaan.

Setelah jalan napas dipastikan aman, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi pernapasan (Breathing). Penilaian pernapasan anak meliputi observasi terhadap pola pernapasan, frekuensi napas, kedalaman napas, serta tanda-tanda kesulitan bernapas seperti retraksi dada, napas cuping hidung, dan penggunaan otot bantu napas. Anak-anak yang mengalami gangguan pernapasan akut seperti serangan asma berat atau pneumonia, biasanya akan menunjukkan tanda-tanda distress pernapasan yang nyata, sehingga intervensi untuk mendukung ventilasi, baik secara oksigenasi atau penggunaan ventilasi buatan jika diperlukan, harus segera diberikan.

Evaluasi berikutnya adalah sirkulasi (Circulation). Anak-anak yang mengalami masalah sirkulasi seringkali memperlihatkan tanda-tanda syok seperti pucat, ekstremitas yang dingin, denyut nadi cepat dan lemah, serta penurunan kesadaran. Karena tubuh anak-anak memiliki mekanisme kompensasi yang efisien, tanda-tanda syok mungkin tidak segera terlihat hingga kondisi anak menjadi sangat kritis. Oleh karena itu, penilaian sirkulasi pada anak harus dilakukan dengan seksama melalui pengukuran tanda vital seperti denyut jantung, tekanan darah, serta pemeriksaan tanda perfusi jaringan seperti waktu pengisian kapiler (capillary refill time/CRT). Jika ditemukan tanda gangguan sirkulasi, intervensi berupa pemberian cairan intravena, obat vasoaktif, atau tindakan resusitasi cairan harus segera diberikan.

Setelah aspek sirkulasi, penilaian berikutnya adalah evaluasi neurologis atau tingkat kesadaran (Disability). Pada tahap ini, petugas kesehatan melakukan penilaian terhadap fungsi sistem saraf pusat anak dengan menggunakan alat ukur sederhana seperti AVPU (Alert, Voice, Pain, Unresponsive) atau Glasgow Coma Scale versi pediatrik (Pediatric Glasgow Coma Scale). Penilaian neurologis yang cepat dan akurat sangat penting dalam mendeteksi dini kondisi neurologis yang mengancam jiwa seperti meningitis, trauma kepala, atau hipoksia berat, serta menentukan tindakan lanjutan yang tepat untuk menjaga stabilitas kondisi anak.

Tahap terakhir dalam pendekatan ABCDE adalah paparan tubuh atau Exposure. Pada tahap ini, seluruh tubuh anak diperiksa secara menyeluruh untuk mengidentifikasi cedera, luka, atau kelainan lain yang mungkin tidak langsung terlihat namun berpotensi memperparah kondisi anak, seperti cedera tersembunyi pada kasus trauma atau tanda-tanda infeksi berat yang tersembunyi di bawah pakaian. Pemeriksaan ini dilakukan dengan hati-hati sambil tetap menjaga

kehangatan tubuh anak untuk mencegah hipotermia, mengingat bayi dan anak-anak kecil sangat rentan terhadap perubahan suhu tubuh yang cepat.

Dalam menunjang proses triase dan penilaian awal, terdapat instrumen khusus yang dikembangkan untuk memudahkan tenaga kesehatan dalam menentukan tingkat kegawatan pada pasien anak. Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain Pediatric Assessment Triangle (PAT), Pediatric Early Warning Score (PEWS), serta Broselow Tape. Pediatric Assessment Triangle (PAT) merupakan instrumen sederhana yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan untuk melakukan penilaian cepat melalui observasi terhadap tiga komponen utama yaitu tampilan umum anak (penampilan), pola pernapasan (usaha bernapas), serta warna kulit (perfusi). Alat ini sangat berguna untuk melakukan triase cepat dalam beberapa detik pertama anak tiba di unit gawat darurat.

Pediatric Early Warning Score (PEWS) adalah instrumen lain yang sering digunakan untuk memonitor kondisi anak secara lebih terukur dan kontinu dengan cara menggabungkan beberapa parameter klinis seperti denyut jantung, frekuensi pernapasan, tekanan darah, saturasi oksigen, serta tingkat kesadaran anak. Skor yang dihasilkan dari PEWS dapat membantu tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara dini perubahan kondisi anak menuju kegawatan sehingga intervensi segera dapat diberikan sebelum kondisi anak memburuk lebih lanjut.

Broselow Tape adalah instrumen praktis berupa pita ukur yang digunakan untuk memperkirakan berat badan anak berdasarkan panjang tubuhnya, serta menyediakan panduan dosis obat dan ukuran peralatan medis yang tepat sesuai dengan ukuran tubuh anak tersebut. Alat ini sangat berguna terutama dalam kondisi darurat ketika berat badan aktual anak sulit diperoleh secara cepat dan akurat.

Dengan demikian, penilaian awal dan triase pada pasien anak merupakan proses yang sangat vital dalam praktik keperawatan kegawatdaruratan pediatrik. Kesiapan, kompetensi, serta keterampilan tenaga kesehatan, khususnya perawat, dalam melakukan triase pediatrik serta menggunakan berbagai instrumen khusus tersebut secara tepat dan cepat, akan sangat menentukan keberhasilan dalam memberikan penanganan awal yang optimal dan mampu menyelamatkan nyawa serta mencegah komplikasi serius pada pasien anak dalam kondisi kegawatdaruratan.

C. Kondisi Gawat Darurat yang Sering Dijumpai pada Anak

Anak-anak merupakan populasi yang rentan terhadap berbagai kondisi kegawatdaruratan akibat karakteristik anatomi, fisiologi, serta pola aktivitas mereka yang berbeda dari orang dewasa. Kondisi gawat darurat pada anak biasanya terjadi secara tiba-tiba, cepat berkembang, dan memerlukan intervensi medis yang segera

serta tepat untuk mencegah komplikasi serius atau bahkan kematian. Beberapa kondisi gawat darurat yang sering ditemukan dalam praktik klinis pediatrik meliputi gangguan pernapasan akut, kondisi neurologis akut, gangguan gastrointestinal akut, kondisi kardiovaskular akut, serta kondisi trauma akut.

Salah satu kondisi kegawatdaruratan yang paling sering ditemukan pada anak adalah gangguan pernapasan akut. Kondisi ini mencakup asma akut dan obstruksi jalan napas. Asma akut adalah suatu keadaan di mana terjadi inflamasi saluran napas yang menyebabkan saluran napas menyempit, sehingga anak mengalami kesulitan bernapas secara tiba-tiba. Anak yang mengalami serangan asma akut biasanya menunjukkan gejala sesak napas yang progresif, mengi (wheezing), batuk terus-menerus, serta tanda distress pernapasan seperti retraksi otot dada, napas cuping hidung, dan penggunaan otot bantu pernapasan. Serangan asma akut yang berat dapat dengan cepat menyebabkan hipoksia berat, sehingga memerlukan penanganan segera seperti pemberian oksigen, bronkodilator inhalasi, serta kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi.

Selain asma akut, obstruksi jalan napas juga merupakan kondisi gawat darurat respirasi yang umum dijumpai pada anak-anak, khususnya bayi dan balita. Obstruksi jalan napas dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti benda asing, pembengkakan jaringan akibat infeksi (misalnya croup atau epiglottitis), atau reaksi alergi berat (anafilaksis). Anak dengan obstruksi jalan napas biasanya memperlihatkan gejala suara napas abnormal seperti stridor, sesak napas hebat, wajah kebiruan (sianosis), serta gelisah. Penanganan obstruksi jalan napas memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk membuka atau mempertahankan jalan napas, seperti tindakan Heimlich maneuver atau intubasi endotrakeal dalam kasus yang lebih serius.

Selanjutnya, kondisi neurologis akut juga menjadi perhatian khusus dalam praktik kegawatdaruratan anak. Dua kondisi neurologis akut yang paling sering ditemui adalah kejang dan trauma kepala. Kejang pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti demam tinggi, epilepsi, gangguan elektrolit, atau infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis. Anak yang mengalami kejang biasanya memperlihatkan gerakan tidak terkendali, kehilangan kesadaran, atau perubahan status mental yang tiba-tiba. Kejang yang berlangsung lama (status epileptikus) atau berulang secara cepat memerlukan intervensi segera untuk mencegah kerusakan otak permanen. Penanganan kejang mencakup pemberian obat antikejang, dukungan pernapasan, serta evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi penyebab yang mendasarinya.

Trauma kepala juga merupakan kondisi neurologis akut yang sering dijumpai pada anak-anak, terutama karena mereka memiliki tingkat aktivitas yang tinggi serta

keterbatasan dalam memahami bahaya. Trauma kepala bisa terjadi akibat jatuh, kecelakaan lalu lintas, atau cedera saat bermain. Anak yang mengalami trauma kepala serius dapat menunjukkan gejala penurunan kesadaran, muntah terus-menerus, perubahan perilaku, atau kejang. Pada kondisi ini, pemeriksaan cepat dan akurat menggunakan Glasgow Coma Scale Pediatrik serta pencitraan otak seperti CT-scan sangat penting untuk menentukan tingkat cedera serta tindakan medis lanjutan yang dibutuhkan, seperti intervensi bedah atau pemantauan ketat di unit perawatan intensif.

Gangguan gastrointestinal akut juga merupakan situasi kegawatdaruratan yang sering dihadapi oleh anak-anak di instalasi gawat darurat. Salah satu kondisi yang paling umum adalah dehidrasi berat akibat diare akut atau muntah berulang. Anak yang mengalami dehidrasi berat biasanya menunjukkan tanda-tanda seperti mata cekung, kulit kering, elastisitas kulit menurun, penurunan produksi urin, serta perubahan tingkat kesadaran. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat berlanjut menjadi syok hipovolemik yang membahayakan nyawa anak. Penanganan yang cepat berupa rehidrasi intravena dan koreksi elektrolit sangat krusial dalam mencegah komplikasi yang lebih parah.

Selain dehidrasi berat, appendisitis akut merupakan kondisi gastrointestinal lain yang sering dijumpai dalam praktik kegawatdaruratan anak. Appendisitis ditandai oleh peradangan usus buntu yang menyebabkan nyeri hebat di perut kanan bawah, demam, mual, muntah, serta penurunan nafsu makan. Diagnosa cepat dan intervensi segera seperti pembedahan darurat (appendektomi) sangat penting untuk mencegah perforasi usus buntu dan komplikasi berat seperti peritonitis atau sepsis.

Kondisi kardiovaskular akut juga perlu mendapat perhatian khusus meskipun jarang terjadi dibandingkan kondisi lainnya. Dua kondisi kardiovaskular akut yang sering menjadi perhatian adalah syok dan gagal jantung akut. Syok pada anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kehilangan cairan tubuh berat (syok hipovolemik), infeksi berat (syok septik), atau gangguan fungsi jantung (syok kardiogenik). Gejala umum syok meliputi denyut jantung cepat, ekstremitas dingin, tekanan darah rendah, serta penurunan kesadaran yang progresif. Penanganan syok mencakup pemberian cairan intravena, obat vasoaktif, serta dukungan ventilasi yang adekuat.

Gagal jantung akut pada anak juga merupakan kondisi serius yang memerlukan penanganan segera. Kondisi ini biasanya terjadi akibat kelainan jantung bawaan, infeksi jantung, atau aritmia berat. Gejala gagal jantung akut pada anak antara lain sesak napas, denyut jantung yang cepat atau tidak teratur, pembengkakan ekstremitas atau wajah, serta keringat dingin. Tindakan medis

seperti pemberian diuretik, obat inotropik, serta oksigenasi harus segera diberikan untuk memperbaiki fungsi jantung serta mencegah komplikasi yang mengancam nyawa.

Terakhir, kondisi trauma akut seperti fraktur dan luka bakar merupakan masalah kegawatdaruratan yang sangat umum dijumpai pada anak-anak. Fraktur pada anak biasanya terjadi akibat kecelakaan atau jatuh yang menyebabkan patah tulang dengan gejala seperti nyeri hebat, deformitas anggota tubuh, serta ketidakmampuan untuk bergerak. Penanganan fraktur memerlukan imobilisasi segera untuk mencegah cedera lebih lanjut, pemberian analgesik untuk mengurangi nyeri, serta tindakan medis lanjutan seperti reposisi atau pembedahan jika diperlukan.

Luka bakar pada anak merupakan kondisi yang serius karena kulit mereka yang tipis dan luas permukaan tubuh relatif lebih besar, membuat mereka lebih rentan terhadap kehilangan cairan dan infeksi. Penilaian cepat terhadap luas dan kedalaman luka bakar, pemberian cairan intravena untuk mencegah syok hipovolemik, perawatan luka yang tepat untuk mencegah infeksi, serta kontrol nyeri yang optimal merupakan tindakan yang penting dalam manajemen awal pasien luka bakar di instalasi gawat darurat.

Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang berbagai kondisi gawat darurat yang sering dijumpai pada anak, termasuk aspek klinis, penilaian dini, dan intervensi medis yang tepat, sangat penting bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk dapat memberikan penanganan yang optimal, cepat, efektif, serta mencegah komplikasi serius yang mengancam keselamatan anak dalam situasi kegawatdaruratan.

D. Manajemen Nyeri Akut pada Pasien Anak dalam Situasi Kegawatdaruratan

Nyeri merupakan pengalaman yang sangat subjektif dan sangat mempengaruhi kondisi fisik serta psikologis seorang anak, terlebih lagi dalam situasi kegawatdaruratan. Anak-anak, khususnya dalam kondisi akut atau kritis, rentan mengalami stres emosional dan ketakutan yang dapat memperburuk persepsi nyeri yang mereka alami. Oleh karena itu, manajemen nyeri akut yang efektif dan holistik menjadi bagian penting dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien pediatrik di unit gawat darurat. Penatalaksanaan nyeri yang adekuat tidak hanya berfungsi mengurangi rasa sakit, tetapi juga mampu mempercepat proses penyembuhan, mencegah komplikasi, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pasien serta keluarganya.

Prinsip dasar dalam manajemen nyeri akut pada pasien anak dalam situasi kegawatdaruratan melibatkan pendekatan yang bersifat menyeluruh serta sensitif

terhadap kebutuhan spesifik dari kelompok usia anak. Prinsip ini mencakup identifikasi dini nyeri melalui penilaian yang sistematis, penggunaan intervensi farmakologis dan nonfarmakologis yang sesuai dengan kebutuhan pasien, serta evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas intervensi yang telah diberikan. Perawat dan tenaga kesehatan lainnya harus memahami bahwa persepsi nyeri pada anak berbeda dengan orang dewasa, serta sering kali anak tidak mampu mengungkapkan rasa nyerinya secara verbal dengan jelas. Oleh sebab itu, penilaian nyeri pada anak harus dilakukan secara hati-hati dengan menggunakan instrumen yang valid dan terpercaya, seperti Wong-Baker Faces Pain Rating Scale atau FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability) Scale, yang khusus dirancang untuk anak-anak.

Selanjutnya, dalam mengelola nyeri akut pada pasien anak di situasi gawat darurat, penggunaan terapi farmakologi merupakan salah satu intervensi utama yang harus dipahami dan diaplikasikan dengan tepat. Terapi farmakologi untuk nyeri akut pada anak mencakup pemberian analgesik non-opioid dan opioid tergantung pada tingkat keparahan nyeri yang dialami anak. Analgesik non-opioid, seperti parasetamol atau ibuprofen, merupakan pilihan utama untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang. Parasetamol memiliki efek analgesik yang cukup efektif dengan profil keamanan tinggi dan risiko efek samping minimal, sehingga aman digunakan pada berbagai kelompok usia anak, termasuk bayi. Sedangkan ibuprofen, sebagai antiinflamasi nonsteroid (NSAID), efektif dalam mengatasi nyeri yang disertai inflamasi, seperti nyeri akibat trauma ringan hingga sedang atau kondisi inflamasi akut.

Namun, pada kondisi nyeri akut yang lebih berat seperti cedera parah, fraktur, luka bakar, atau kondisi nyeri pascaoperasi, penggunaan analgesik opioid dapat dipertimbangkan. Obat-obatan opioid seperti morfin atau fentanyl sering kali diberikan pada anak dengan pengawasan ketat terhadap efek samping yang mungkin muncul, seperti depresi pernapasan, sedasi berlebihan, atau mual muntah. Penggunaan opioid pada anak memerlukan perhatian khusus terhadap dosis yang tepat berdasarkan berat badan dan kondisi klinis pasien, serta pemantauan secara kontinu oleh perawat dan tim medis untuk memastikan keamanan penggunaannya. Pemberian analgesik pada anak di situasi gawat darurat biasanya dilakukan melalui jalur intravena agar efek analgesiknya cepat tercapai serta mudah disesuaikan dosisnya.

Di samping intervensi farmakologi, penggunaan intervensi nonfarmakologi juga memiliki peran yang signifikan dalam manajemen nyeri akut pada pasien anak. Intervensi ini bertujuan mengurangi intensitas nyeri melalui teknik-teknik non-obat yang aman dan relatif mudah diaplikasikan. Salah satu teknik nonfarmakologi yang sering digunakan adalah teknik distraksi atau pengalihan perhatian. Teknik distraksi

dapat berupa bercerita, mendengarkan musik, bermain atau menonton video yang disukai oleh anak, sehingga perhatian anak dialihkan dari rasa nyeri yang dialami ke aktivitas yang menyenangkan. Pendekatan ini secara psikologis dapat membantu anak merasa lebih rileks dan nyaman, sehingga persepsi terhadap intensitas nyeri dapat berkurang secara signifikan.

Teknik relaksasi juga merupakan intervensi nonfarmakologi yang efektif dalam mengontrol nyeri akut pada anak. Teknik ini termasuk latihan napas dalam, relaksasi otot progresif, serta imagery atau visualisasi positif yang dapat membantu anak merasa lebih tenang dan nyaman selama perawatan di unit gawat darurat. Relaksasi napas dalam, misalnya, dilakukan dengan membimbing anak untuk bernapas perlahan dan dalam, yang dapat membantu meredakan stres fisik dan psikologis yang memperburuk persepsi nyeri. Sementara itu, visualisasi positif dilakukan dengan meminta anak membayangkan tempat atau situasi yang menyenangkan, yang mampu mengurangi stres emosional serta intensitas nyeri yang dirasakan.

Selain teknik distraksi dan relaksasi, terapi dingin (cryotherapy) juga merupakan salah satu intervensi nonfarmakologi yang efektif untuk meredakan nyeri akut yang disebabkan oleh trauma, cedera otot, atau cedera jaringan lunak pada anak-anak. Terapi dingin bekerja dengan cara menurunkan suhu lokal pada area yang cedera, sehingga menyebabkan vasokonstriksi lokal, pengurangan inflamasi, serta memperlambat transmisi impuls nyeri ke otak. Penggunaan terapi dingin biasanya dilakukan segera setelah cedera terjadi, dalam durasi sekitar 15 hingga 20 menit setiap sesi, dengan kantong es atau kompres dingin yang dilapisi kain untuk melindungi kulit anak yang sensitif.

Tidak kalah pentingnya adalah pendekatan psikososial dalam manajemen nyeri akut di unit gawat darurat. Edukasi dan dukungan emosional kepada anak serta keluarga sangat penting untuk mengurangi rasa cemas, takut, serta ketidakpastian yang dialami pasien maupun keluarga dalam menghadapi situasi kritis. Penjelasan tentang prosedur medis yang akan dilakukan, manfaat dari pengobatan atau tindakan yang diberikan, serta keterlibatan keluarga dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan lingkungan perawatan yang lebih nyaman, aman, serta kondusif bagi proses penyembuhan anak. Peran perawat dalam memberikan komunikasi terapeutik yang empatik, serta melibatkan keluarga secara aktif dalam perawatan anak, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen nyeri akut di situasi kegawatdaruratan pediatrik.

Secara keseluruhan, manajemen nyeri akut pada pasien anak dalam situasi kegawatdaruratan memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan penggunaan terapi farmakologi yang tepat dan aman, serta penerapan intervensi nonfarmakologi yang efektif. Dengan kombinasi intervensi tersebut, diharapkan anak-anak yang

mengalami situasi kegawatdaruratan dapat mendapatkan perawatan optimal yang tidak hanya mengurangi rasa nyeri secara signifikan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan, mempercepat pemulihan, serta memberikan pengalaman positif bagi anak maupun keluarganya selama berada di fasilitas pelayanan gawat darurat.

E. Prosedur dan Teknik Khusus dalam Keperawatan Gawat Darurat Pediatrik

Penatalaksanaan pasien anak di instalasi gawat darurat membutuhkan keahlian khusus serta pendekatan yang hati-hati, terampil, dan adaptif terhadap karakteristik unik pasien anak. Berbagai prosedur teknis khusus harus dilakukan oleh tenaga keperawatan untuk memastikan pemberian intervensi yang tepat, cepat, aman, serta minim komplikasi. Prosedur tersebut meliputi teknik pemasangan akses intravena, pemasangan alat bantu napas dalam situasi emergensi, serta imobilisasi dan manajemen luka pada anak dengan trauma akut. Penguasaan terhadap prosedur ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap keselamatan, kenyamanan, dan pemulihan pasien anak secara keseluruhan.

Salah satu prosedur teknis yang sangat penting dalam penanganan pasien pediatrik di situasi gawat darurat adalah teknik pemasangan akses intravena (IV line). Pemasangan akses intravena pada pasien anak, terutama dalam kondisi emergensi, sering kali merupakan tantangan besar bagi tenaga keperawatan karena ukuran pembuluh darah yang relatif kecil, rapuh, serta respon emosional anak yang cenderung ketakutan dan gelisah. Dalam pelaksanaannya, perawat harus memilih lokasi pembuluh darah yang optimal, seperti vena dorsalis manus (vena pada punggung tangan), vena cephalica, vena basilica, atau vena antekubiti, yang ukurannya memadai dan mudah diakses. Sebelum tindakan pemasangan akses IV dilakukan, perawat perlu mengkomunikasikan prosedur secara jelas dan empati kepada anak serta keluarganya untuk mengurangi kecemasan.

Dalam teknik pemasangan IV line pada anak, penggunaan kateter IV berukuran kecil (seperti ukuran 22-24G) sangat dianjurkan agar meminimalisasi rasa nyeri serta trauma jaringan. Teknik pemasangan IV dimulai dengan melakukan desinfeksi area kulit secara aseptik menggunakan alkohol swab atau antiseptik berbasis klorheksidin. Selanjutnya, perawat memasang tourniquet dengan tekanan secukupnya untuk membuat vena terlihat jelas namun tetap nyaman bagi anak. Pada saat melakukan penusukan vena, perawat harus memastikan tekniknya lembut dan tepat guna meminimalisasi rasa sakit serta mengurangi risiko ekstrasvasi atau infiltrasi cairan ke jaringan sekitar. Setelah akses vena berhasil didapatkan, kateter IV difiksasi dengan hati-hati menggunakan plester transparan steril serta dipantau

secara ketat untuk memastikan tidak ada kebocoran atau komplikasi selama pemberian terapi intravena.

Prosedur teknis berikutnya yang sangat penting dalam situasi emergensi adalah pemasangan alat bantu napas pada anak, yang merupakan tindakan vital dalam menangani kegagalan respirasi akut seperti pada kasus obstruksi jalan napas, asma berat, atau trauma kepala dengan gangguan pernapasan. Terdapat beberapa alat bantu napas yang sering digunakan dalam situasi emergensi, antara lain masker oksigen sederhana, masker rebreathing, hingga tindakan pemasangan airway buatan seperti oropharyngeal airway (OPA), nasopharyngeal airway (NPA), atau intubasi endotrakeal. Pilihan alat bantu napas ini ditentukan berdasarkan kondisi klinis pasien serta tingkat kegawatan respirasi yang dialami.

Dalam pemasangan masker oksigen, perawat perlu memilih ukuran masker yang sesuai dengan wajah anak untuk memastikan masker menutup mulut dan hidung dengan rapat tetapi tetap nyaman. Oksigen diberikan dengan flow rate yang sesuai berdasarkan kondisi klinis, biasanya mulai dari 6-10 liter per menit untuk anak-anak. Apabila terjadi kegagalan napas yang signifikan atau ketidakmampuan pasien dalam mempertahankan patensi jalan napas, pemasangan airway seperti OPA atau NPA menjadi pilihan penting. OPA digunakan terutama pada pasien anak dengan tingkat kesadaran menurun, tanpa refleks muntah yang aktif. Sebaliknya, NPA lebih nyaman untuk pasien sadar namun dengan obstruksi jalan napas ringan atau sedang.

Dalam situasi yang lebih berat seperti henti napas atau ancaman kegagalan napas total, tindakan intubasi endotrakeal perlu segera dilakukan. Prosedur ini harus dilakukan oleh tenaga medis atau perawat yang terlatih khusus di bidang kegawatdaruratan pediatrik. Selama intubasi, anak diposisikan dengan kepala sedikit ekstensi (sniffing position) untuk membuka jalan napas secara optimal, kemudian laringoskop digunakan untuk membantu visualisasi pita suara sebelum tube endotrakeal dimasukkan dengan hati-hati. Setelah tube endotrakeal berhasil terpasang, posisi tube segera dikonfirmasi dengan auskultasi suara napas bilateral, ekspansi dada yang simetris, dan bila memungkinkan, konfirmasi melalui pemeriksaan radiologi.

Selain itu, imobilisasi serta manajemen luka pada anak yang mengalami trauma akut juga menjadi prosedur krusial di unit gawat darurat. Trauma seperti fraktur tulang atau luka robek sering dijumpai pada anak-anak yang mengalami kecelakaan. Penanganan awal berupa imobilisasi segera sangat penting untuk mencegah perburukan cedera serta mengurangi nyeri akut yang dialami pasien. Teknik imobilisasi pada anak mencakup penggunaan bidai (splint), sling, atau bahkan gips sementara yang disesuaikan dengan lokasi dan jenis cedera. Pemilihan teknik

imobilisasi ini didasarkan pada prinsip meminimalisasi pergerakan area cedera, mengurangi nyeri serta mencegah cedera lanjutan pada jaringan lunak di sekitarnya.

Pada pasien dengan fraktur ekstremitas, pemasangan bidai sementara dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa bagian ekstremitas yang cedera berada dalam posisi anatomis yang nyaman. Perawat perlu menggunakan bahan empuk sebagai bantalan di antara bidai dan kulit anak untuk mencegah iritasi atau luka tekan. Jika anak mengalami cedera pada lengan atas atau bahu, penggunaan sling dapat membantu menstabilkan lengan dalam posisi nyaman. Untuk luka robek atau lecet, perawat harus membersihkan luka dengan hati-hati menggunakan larutan antiseptik yang lembut, mengangkat benda asing jika ada, dan melakukan penutupan luka dengan teknik steril untuk mencegah infeksi serta mempercepat penyembuhan.

Setelah prosedur imobilisasi dan perawatan luka dilakukan, perawat harus memberikan edukasi yang jelas kepada keluarga tentang tanda-tanda komplikasi yang perlu diwaspadai, seperti peningkatan nyeri, pembengkakan ekstremitas, perubahan warna kulit, atau tanda-tanda infeksi lokal seperti kemerahan, panas, dan demam. Edukasi ini sangat penting agar keluarga dapat segera melaporkan perubahan kondisi anak kepada tenaga medis untuk mencegah komplikasi serius.

Secara keseluruhan, prosedur teknis khusus dalam keperawatan gawat darurat pediatrik memerlukan pengetahuan yang mendalam, keterampilan yang mumpuni, serta pendekatan yang empati dan lembut terhadap anak dan keluarganya. Teknik pemasangan akses intravena yang hati-hati, pemasangan alat bantu napas yang tepat dan efektif, serta imobilisasi dan manajemen luka secara komprehensif merupakan elemen kunci dalam memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas tinggi di instalasi gawat darurat pediatrik. Melalui penerapan prosedur ini dengan benar dan terampil, pasien anak dapat memperoleh perawatan emergensi yang optimal, mempercepat pemulihan, serta memberikan pengalaman perawatan yang lebih nyaman dan aman bagi anak maupun keluarganya.

F. Dukungan Psikososial Anak dan Keluarga dalam Situasi Gawat Darurat

Dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik, dukungan psikososial merupakan komponen yang sangat esensial dalam penatalaksanaan pasien anak dan keluarganya. Anak yang dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) umumnya mengalami tingkat kecemasan, ketakutan, dan ketidaknyamanan yang tinggi, yang disebabkan tidak hanya oleh kondisi medisnya tetapi juga oleh lingkungan yang asing, bising, serta prosedur medis yang dirasakan invasif dan menyakitkan. Begitu pula dengan keluarga pasien, terutama orang tua atau pengasuh, yang sering mengalami stres, rasa khawatir yang besar, ketidakpastian, serta kesulitan dalam

memahami kondisi medis anaknya secara penuh. Oleh karena itu, dukungan psikososial yang diberikan oleh perawat dan tenaga kesehatan lainnya tidak hanya berperan dalam mengurangi stres psikologis yang dialami pasien anak, tetapi juga sangat penting dalam memberikan ketenangan emosional kepada keluarga, yang pada akhirnya turut mendukung proses pemulihan pasien secara optimal.

Salah satu aspek penting dalam dukungan psikososial pasien anak di IGD adalah pengelolaan kecemasan dan ketakutan yang dialami anak selama mendapatkan perawatan. Kecemasan pada anak biasanya muncul akibat persepsi negatif terhadap situasi yang dianggap mengancam, seperti tindakan invasif berupa pemasangan infus, pemberian injeksi, atau pemasangan alat bantu napas. Untuk mengatasi hal ini, tenaga kesehatan, terutama perawat, perlu menerapkan pendekatan yang empati, sabar, serta lembut kepada anak. Pendekatan yang efektif dimulai dengan menciptakan lingkungan fisik yang tenang dan ramah anak, misalnya dengan menyediakan ruangan terpisah yang tidak terlalu ramai, dengan pencahayaan yang nyaman, serta menjauhkan alat-alat medis yang dapat membuat anak semakin takut dari pandangan langsung anak.

Selanjutnya, teknik-teknik distraksi psikologis seperti penggunaan mainan, video atau musik yang disukai anak, serta pemberian hadiah kecil setelah prosedur dapat secara signifikan mengurangi kecemasan dan ketakutan anak. Metode distraksi ini mengalihkan perhatian anak dari rasa takut terhadap prosedur medis menjadi fokus pada aktivitas yang menyenangkan. Selain itu, perawat juga perlu menjelaskan setiap langkah prosedur yang akan dilakukan secara sederhana, jujur, dan dengan bahasa yang sesuai usia anak. Pendekatan yang jujur namun menenangkan ini membantu membangun kepercayaan anak kepada tenaga kesehatan, serta mengurangi rasa ketidakpastian yang menjadi sumber utama kecemasan.

Komunikasi efektif dengan pasien anak dan keluarganya merupakan aspek lain yang tidak kalah penting dalam pemberian dukungan psikososial di IGD. Komunikasi yang efektif tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tetapi juga mengurangi kesalahan dalam tindakan medis dan meningkatkan kepuasan keluarga terhadap layanan yang diberikan. Dalam praktiknya, komunikasi efektif ini mencakup beberapa prinsip dasar, seperti menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan keluarganya, menjaga kontak mata yang ramah, memperhatikan bahasa tubuh yang terbuka dan bersahabat, serta aktif mendengarkan setiap keluhan dan pertanyaan yang disampaikan oleh pasien dan keluarganya. Perawat juga perlu memperlihatkan sikap empati yang tulus, seperti memberikan sentuhan lembut atau menggenggam tangan anak dengan izin orang tua, yang terbukti memberikan efek menenangkan secara emosional kepada anak.

Dalam berkomunikasi dengan keluarga, perawat perlu menyadari bahwa keluarga umumnya berada dalam kondisi emosional yang labil dan penuh tekanan. Oleh karena itu, perawat harus menjaga sikap profesional sekaligus empati, serta menyampaikan informasi secara jelas, jujur, dan sistematis mengenai kondisi anak, tindakan medis yang akan dilakukan, serta prognosis yang diharapkan. Keterbukaan informasi ini sangat penting untuk mengurangi kecemasan keluarga serta membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dan tepat waktu terkait perawatan anaknya.

Lebih lanjut, pemberian edukasi kepada keluarga mengenai kondisi darurat yang dialami anak merupakan bagian penting dari dukungan psikososial yang harus dilakukan secara intensif oleh tenaga kesehatan di IGD. Edukasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pemahaman keluarga terhadap kondisi kesehatan anak, tetapi juga memperkuat rasa percaya diri keluarga dalam berpartisipasi aktif dalam perawatan anaknya selama proses emergensi berlangsung maupun setelah keluar dari IGD. Dalam memberikan edukasi ini, tenaga kesehatan perlu menggunakan bahasa sederhana yang tidak terlalu teknis, namun tetap akurat dan sesuai dengan tingkat pemahaman keluarga. Strategi edukasi dapat dilakukan secara verbal melalui percakapan langsung maupun menggunakan media edukasi seperti leaflet, brosur, atau video ilustratif yang relevan dengan kondisi klinis anak.

Beberapa strategi edukasi yang efektif antara lain memberikan penjelasan secara bertahap mengenai kondisi darurat anak, penyebab, gejala-gejala yang dialami, intervensi yang diberikan, hingga tanda-tanda perbaikan yang diharapkan setelah terapi diberikan. Tenaga kesehatan juga perlu melibatkan keluarga secara aktif dengan mengajak mereka bertanya, berdiskusi, atau bahkan berpartisipasi dalam beberapa aspek perawatan yang aman, seperti membantu menenangkan anak selama prosedur berlangsung. Selain itu, edukasi keluarga juga harus mencakup informasi penting tentang perawatan lanjutan di rumah, seperti cara pemberian obat, pemantauan gejala klinis yang harus diperhatikan, serta tanda-tanda kegawatan yang memerlukan segera kembali ke fasilitas kesehatan.

Tenaga kesehatan juga perlu secara proaktif menanyakan apakah keluarga memahami informasi yang telah disampaikan, serta memastikan bahwa keluarga memiliki waktu yang cukup untuk menyerap informasi dan bertanya lebih lanjut jika ada ketidakjelasan. Hal ini bertujuan agar keluarga tidak merasa ditinggalkan dalam kebingungan atau ketidakpastian, yang dapat menambah stres psikologis mereka. Dukungan psikososial juga dapat diperkuat dengan menghubungkan keluarga dengan sumber daya tambahan yang tersedia di rumah sakit, seperti layanan konsultasi psikologis atau layanan sosial yang dapat membantu mereka mengatasi tekanan emosional dan tantangan finansial selama perawatan anak di rumah sakit.

Secara keseluruhan, dukungan psikososial kepada anak dan keluarganya dalam situasi gawat darurat tidak boleh dianggap sebagai tindakan tambahan atau sekunder, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan proses asuhan keperawatan emergensi pediatrik. Melalui pendekatan yang empati dan penuh perhatian dalam mengelola kecemasan dan ketakutan anak, komunikasi yang efektif, serta edukasi yang sistematis kepada keluarga, tenaga kesehatan tidak hanya membantu meningkatkan hasil klinis pasien secara signifikan tetapi juga meningkatkan rasa nyaman, kepercayaan, dan kepuasan pasien serta keluarganya terhadap pelayanan kegawatdaruratan yang diberikan. Dengan demikian, asuhan keperawatan emergensi pediatrik menjadi sebuah proses yang tidak hanya memulihkan kesehatan fisik anak, tetapi juga menjaga kesehatan emosional dan psikologis anak beserta keluarganya dalam situasi yang penuh tekanan.

G. Kolaborasi Interprofesional dalam Situasi Kegawatdaruratan Pediatrik

Dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik, penanganan pasien yang optimal tidak mungkin dapat dicapai tanpa kolaborasi yang efektif dari berbagai profesi kesehatan. Pasien anak yang datang dalam kondisi gawat darurat sering kali memiliki kondisi yang kompleks dan berubah dengan cepat, sehingga memerlukan penilaian dan intervensi yang cepat, terarah, dan terkoordinasi dengan baik oleh seluruh anggota tim kesehatan yang terlibat. Tim interprofesional di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) pediatrik biasanya terdiri dari dokter, perawat, apoteker, fisioterapis, tenaga laboratorium, tenaga radiologi, hingga tenaga kesehatan lainnya, yang masing-masing memiliki keahlian khusus namun saling melengkapi dalam penanganan pasien. Dalam tim ini, perawat memiliki peran sentral yang sangat penting dan menjadi kunci sukses dalam terciptanya kerja sama yang efektif.

Peran perawat dalam tim interprofesional pada situasi kegawatdaruratan pediatrik sangatlah vital dan luas, meliputi tanggung jawab terhadap penilaian awal pasien, pemberian intervensi langsung, pengawasan respons terhadap terapi yang diberikan, serta sebagai penghubung utama antara pasien, keluarga, dan anggota tim lainnya. Ketika pasien tiba di IGD, perawat adalah tenaga kesehatan pertama yang melakukan triase, melakukan penilaian cepat dengan menggunakan prinsip ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure), serta menetapkan tingkat kegawatan pasien. Hasil penilaian ini kemudian dikomunikasikan secara cepat dan jelas kepada dokter dan anggota tim lainnya untuk segera menentukan tindakan medis yang tepat. Selain itu, perawat juga bertanggung jawab atas administrasi obat-obatan, pemasangan akses intravena, pemantauan tanda-tanda vital, serta memberikan kenyamanan dan dukungan psikologis kepada pasien anak dan keluarganya.

Sebagai anggota yang paling sering berinteraksi langsung dengan pasien dan keluarga, perawat memiliki peran tambahan sebagai advokat pasien. Dalam perannya sebagai advokat, perawat memastikan bahwa kebutuhan pasien dipenuhi secara tepat, menyampaikan kebutuhan dan kondisi pasien secara jelas kepada tim medis, serta melindungi hak-hak pasien, terutama ketika pasien atau keluarga menghadapi kesulitan dalam memahami atau menerima keputusan klinis tertentu. Dengan peran ini, perawat dapat menjembatani komunikasi yang kadang kompleks antara pasien, keluarga, dan anggota tim lainnya, sehingga menghasilkan proses pengambilan keputusan yang transparan, kolaboratif, serta mengutamakan keselamatan pasien.

Dalam upaya mewujudkan kolaborasi yang efektif dalam tim emergensi pediatrik, strategi komunikasi yang baik menjadi salah satu kunci utama. Komunikasi yang efektif di dalam tim interprofesional tidak hanya memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat, tetapi juga secara signifikan mengurangi risiko terjadinya kesalahan medis yang dapat membahayakan keselamatan pasien anak. Strategi komunikasi yang terbukti efektif dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik antara lain penerapan metode komunikasi terstruktur seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation). Melalui metode ini, anggota tim, terutama perawat, dapat dengan jelas menyampaikan informasi penting secara sistematis mengenai kondisi pasien (situasi), latar belakang medis pasien (background), hasil penilaian klinis (assessment), serta rekomendasi intervensi yang diperlukan (recommendation).

Selain itu, komunikasi efektif juga mencakup aspek keterbukaan, kejelasan, dan ketegasan dalam menyampaikan informasi antaranggota tim. Dalam situasi emergensi pediatrik yang dinamis, semua anggota tim perlu memiliki kemampuan mendengar secara aktif, memberikan umpan balik secara konstruktif, serta terbuka terhadap saran dan masukan dari anggota tim lain tanpa melihat perbedaan profesi atau senioritas. Komunikasi yang baik ini juga mencakup kemampuan tim untuk menjaga ketenangan dan profesionalisme, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Perawat, dalam hal ini, memainkan peran kunci dalam menjaga alur komunikasi yang jelas, menenangkan, serta memastikan bahwa setiap informasi penting tidak terlewatkan.

Komponen lain yang tidak kalah penting dalam kolaborasi interprofesional di IGD pediatrik adalah dokumentasi yang akurat dan lengkap serta proses serah terima pasien antar tim yang terstruktur. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai catatan medis yang akurat dan dapat dipercaya, yang sangat penting untuk menjamin kontinuitas perawatan, terutama pada pasien yang harus dirujuk atau dipindahkan ke unit lain setelah fase emergensi selesai. Dokumentasi harus

mencakup detail kondisi klinis pasien saat tiba, intervensi yang diberikan, respons pasien terhadap terapi, serta rencana perawatan lanjutan yang telah diputuskan oleh tim interprofesional. Dokumentasi yang rinci dan jelas ini menjadi dasar penting bagi tim penerima di unit perawatan lanjutan dalam memahami kondisi pasien serta perawatan yang telah dilakukan.

Selain dokumentasi tertulis, proses serah terima (handover) antar tim juga harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terstandar. Serah terima yang baik mencakup komunikasi langsung antaranggota tim dengan menggunakan metode komunikasi standar seperti SBAR. Dalam proses ini, perawat yang bertanggung jawab terhadap pasien selama di IGD secara langsung menyampaikan kondisi terakhir pasien, hasil tindakan yang sudah dilakukan, dan rekomendasi penting untuk perawatan selanjutnya kepada tim penerima secara jelas, ringkas, dan terstruktur. Proses serah terima yang efektif tidak hanya memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang hilang, tetapi juga membantu mencegah terjadinya kesalahan yang dapat berdampak buruk terhadap keselamatan pasien.

Secara keseluruhan, kolaborasi interprofesional yang efektif dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik tidak hanya bergantung pada kompetensi klinis masing-masing anggota tim, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berkomunikasi secara jelas, efektif, dan profesional dalam kondisi yang penuh tekanan. Perawat, sebagai anggota tim yang paling sering berada di sisi pasien dan keluarganya, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa kolaborasi ini berjalan lancar melalui pengelolaan komunikasi yang efektif, dokumentasi yang teliti, serta proses serah terima pasien yang akurat. Melalui kolaborasi yang kuat dan harmonis ini, tim emergensi pediatrik dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pasien anak yang mengalami kondisi gawat darurat, meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat proses pemulihan, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.

H. Tantangan Etik dan Legal dalam Keperawatan Gawat Darurat Anak

Dalam praktik keperawatan gawat darurat anak, tantangan etik dan legal merupakan aspek penting yang memerlukan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, khususnya perawat. Anak-anak yang datang ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan kondisi yang mengancam jiwa sering kali menempatkan perawat dalam situasi sulit yang tidak hanya menuntut keputusan klinis yang cepat dan akurat tetapi juga sensitivitas tinggi terhadap prinsip-prinsip etik dan aspek hukum yang berlaku. Situasi ini diperumit oleh fakta bahwa pasien anak tidak dapat secara mandiri memberikan persetujuan terhadap intervensi medis yang akan dilakukan, sehingga memerlukan keterlibatan dan keputusan keluarga atau wali yang sah. Oleh

sebab itu, pemahaman yang mendalam tentang isu-isu etik dan legal serta kemampuan perawat dalam pendekatan komunikasi dan pengambilan keputusan bersama keluarga sangat penting dalam penanganan kegawatdaruratan pediatrik.

Salah satu isu etik yang paling umum dihadapi dalam penanganan kegawatdaruratan pediatrik adalah dilema terkait pemberian tindakan medis yang invasif atau berisiko tinggi pada anak tanpa adanya persetujuan dari orang tua atau wali. Dalam situasi gawat darurat yang mengancam nyawa, perawat dan tim medis harus sering kali membuat keputusan yang cepat untuk menyelamatkan nyawa pasien. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memberikan tindakan medis yang paling efektif demi keselamatan anak (prinsip beneficence), namun di sisi lain, mereka juga harus menghormati hak pasien dan keluarganya untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis (prinsip otonomi). Situasi ini menjadi sangat dilematis ketika keluarga belum hadir, sulit dihubungi, atau mengalami kebingungan emosional sehingga tidak mampu memberikan persetujuan dengan segera.

Perawat, dalam hal ini, harus mampu menavigasi dilema etik tersebut dengan baik, menggunakan prinsip-prinsip etik dasar seperti beneficence (melakukan kebaikan), non-maleficence (tidak merugikan pasien), justice (keadilan dalam pelayanan kesehatan), serta autonomy (menghormati hak pasien atau keluarga). Dalam situasi gawat darurat, prinsip beneficence dan non-maleficence biasanya menjadi prinsip utama yang dijadikan pedoman, terutama jika tindakan medis harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Namun demikian, penting bagi perawat untuk tetap berusaha sebaik mungkin untuk menginformasikan keluarga sesegera mungkin, menjelaskan dengan jelas tentang intervensi yang akan atau sudah dilakukan, serta menjelaskan alasan-alasan medis di balik keputusan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan keluarga serta mencegah timbulnya masalah etik yang lebih kompleks setelah situasi gawat darurat teratasi.

Selain isu etik, aspek legal dalam kegawatdaruratan pediatrik juga menjadi tantangan penting yang dihadapi perawat. Secara hukum, anak-anak di bawah usia tertentu (biasanya 18 tahun) belum memiliki kapasitas penuh untuk memberikan persetujuan (informed consent) terhadap tindakan medis. Persetujuan harus didapatkan dari orang tua atau wali yang sah sebelum tindakan invasif atau tindakan medis lain yang signifikan dilakukan. Akan tetapi, dalam situasi darurat di mana intervensi harus segera dilakukan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah komplikasi serius, hukum di banyak negara, termasuk Indonesia, mengizinkan tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan medis tanpa persetujuan terlebih dahulu (tindakan gawat darurat) dengan syarat tindakan tersebut semata-mata untuk menyelamatkan nyawa pasien dan bahwa menunda tindakan dapat

memperburuk kondisi pasien secara serius. Perawat, sebagai bagian integral dari tim medis, harus memahami dengan jelas ketentuan hukum yang berlaku terkait persetujuan tindakan emergensi, serta mampu mendokumentasikan secara rinci kondisi kegawatdaruratan pasien serta alasan tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu.

Untuk mencegah konflik legal yang mungkin timbul setelah tindakan emergensi, dokumentasi yang akurat dan lengkap menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh perawat. Catatan medis harus secara jelas mencatat kondisi klinis pasien saat tiba di IGD, jenis intervensi yang dilakukan, alasan medis dan hukum untuk melaksanakan intervensi tanpa persetujuan keluarga jika diperlukan, serta komunikasi yang telah dilakukan dengan keluarga sesudahnya. Dokumentasi ini tidak hanya melindungi perawat dan tim medis secara hukum, tetapi juga memberikan transparansi kepada keluarga pasien mengenai apa yang telah dilakukan selama proses penanganan darurat.

Pendekatan terhadap keluarga dalam situasi pengambilan keputusan kritis juga merupakan tantangan tersendiri yang dihadapi oleh perawat. Situasi gawat darurat sering kali menyebabkan keluarga mengalami kecemasan, kebingungan, atau bahkan stres emosional yang hebat, yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan medis. Perawat, sebagai tenaga kesehatan yang paling sering berinteraksi dengan keluarga, harus memiliki keterampilan komunikasi yang tinggi untuk dapat menjelaskan kondisi medis pasien secara jelas, empati, dan sabar, sambil tetap tegas dalam menyampaikan urgensi tindakan medis yang harus segera diambil. Pendekatan ini meliputi kemampuan aktif dalam mendengarkan kekhawatiran keluarga, memberikan penjelasan yang rinci namun mudah dipahami, serta memberikan dukungan emosional agar keluarga dapat merasa lebih tenang dan yakin dalam mengambil keputusan yang sulit tersebut.

Dalam situasi pengambilan keputusan kritis, pendekatan komunikasi berbasis keluarga (*family-centered care*) menjadi strategi penting yang harus diterapkan oleh perawat. Pendekatan ini mengakui bahwa keluarga adalah mitra penting dalam pengambilan keputusan medis, terutama dalam situasi kegawatdaruratan pediatrik. Melalui pendekatan ini, perawat dapat mendorong partisipasi aktif keluarga dalam diskusi klinis, menjelaskan opsi-opsi tindakan secara terbuka dan jujur, serta membantu keluarga memahami dampak medis dan psikososial dari keputusan yang mereka ambil. Dengan demikian, perawat membantu keluarga merasa dihargai dan dihormati, serta memastikan bahwa keputusan medis yang diambil mencerminkan nilai dan keyakinan keluarga, sambil tetap memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan pasien anak sebagai prioritas utama.

Secara keseluruhan, tantangan etik dan legal dalam keperawatan gawat darurat anak merupakan bagian integral dari praktik profesional yang menuntut perawat untuk memiliki pengetahuan mendalam mengenai prinsip-prinsip etik, ketentuan hukum, serta kemampuan komunikasi dan empati yang tinggi dalam berinteraksi dengan keluarga pasien. Dengan pemahaman yang baik tentang aspek-aspek tersebut, perawat tidak hanya mampu memberikan pelayanan medis yang optimal dalam situasi darurat, tetapi juga mampu melindungi diri sendiri dan institusi tempat bekerja dari risiko konflik etik dan hukum yang dapat muncul di kemudian hari. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien anak dan keluarganya, menciptakan pengalaman yang lebih positif dalam situasi yang sangat menantang tersebut.

I. Evaluasi dan Monitoring Pasca-Intervensi Kegawatdaruratan pada Anak

Evaluasi dan monitoring pasca-intervensi merupakan bagian yang sangat penting dalam praktik keperawatan gawat darurat anak. Setelah intervensi atau tindakan kegawatdaruratan dilakukan, tahapan evaluasi ini menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kondisi anak mengalami perbaikan sesuai yang diharapkan, serta untuk segera mendeteksi tanda-tanda kegagalan atau munculnya komplikasi yang mungkin terjadi. Tahap ini juga menentukan tindak lanjut perawatan, baik yang bersifat observasi lanjutan maupun perawatan intensif yang lebih spesifik, serta memastikan keselamatan dan pemulihan optimal pada anak yang mengalami kondisi emergensi.

Dalam proses evaluasi pasca-intervensi, terdapat beberapa indikator evaluasi yang digunakan oleh perawat untuk menilai keberhasilan tindakan yang telah diberikan pada pasien anak. Indikator ini mencakup aspek klinis, fisiologis, perilaku, serta psikologis pasien. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah stabilisasi tanda-tanda vital anak, seperti denyut jantung, frekuensi pernapasan, tekanan darah, saturasi oksigen, dan suhu tubuh. Normalisasi atau perbaikan tanda vital ini merupakan indikator klinis langsung yang menunjukkan bahwa intervensi kegawatdaruratan, baik berupa pemberian oksigen, cairan intravena, terapi obat-obatan, maupun tindakan invasif seperti pemasangan alat bantu napas atau intubasi, telah berhasil mencapai tujuannya. Selain tanda vital, perawat juga mengevaluasi perubahan klinis lainnya seperti penurunan intensitas nyeri, membaiknya kesadaran anak, serta kembalinya fungsi organ tubuh secara normal, yang menjadi tanda tambahan bahwa intervensi yang diberikan efektif.

Selain indikator fisiologis, evaluasi juga mencakup pengamatan terhadap perubahan perilaku dan psikologis anak setelah tindakan kegawatdaruratan

dilakukan. Anak yang mengalami kondisi emergensi sering kali mengalami kecemasan, ketakutan, atau stres emosional yang signifikan. Perawat perlu secara cermat memperhatikan respons emosional dan perilaku pasien, seperti ekspresi wajah, respon verbal maupun non-verbal, serta interaksi dengan perawat atau keluarga. Adanya penurunan tingkat kecemasan, meningkatnya kenyamanan dan rasa aman, serta kembalinya respons anak yang kooperatif selama pemeriksaan atau perawatan lanjutan merupakan indikator keberhasilan intervensi dari aspek psikososial. Evaluasi ini penting karena kondisi psikologis yang stabil dan nyaman juga berkontribusi secara signifikan terhadap proses pemulihan anak.

Setelah melakukan evaluasi awal tersebut, pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi anak menjadi tanggung jawab penting yang dilakukan secara konsisten oleh perawat. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi pasien terus stabil dan tidak mengalami perburukan kembali. Dalam konteks keperawatan emergensi pediatrik, pemantauan biasanya dilakukan dalam interval waktu yang singkat, terutama dalam beberapa jam pertama pasca-intervensi. Perawat secara rutin melakukan pengukuran tanda vital setiap 15 hingga 30 menit, atau bahkan lebih sering pada kondisi kritis, serta melakukan observasi ketat terhadap perubahan klinis lainnya yang dapat mengindikasikan komplikasi atau kebutuhan intervensi tambahan.

Pemantauan ini juga melibatkan pengamatan terhadap respons pasien terhadap terapi obat atau intervensi invasif yang telah diberikan, seperti efek samping obat, reaksi alergi, atau komplikasi terkait penggunaan alat bantu medis seperti ventilator atau kateter intravena. Perawat harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap tanda-tanda komplikasi seperti kesulitan bernapas, penurunan saturasi oksigen mendadak, perubahan kesadaran, tanda-tanda infeksi, perdarahan, atau tanda vital yang tiba-tiba tidak stabil. Ketika komplikasi atau efek samping ini terdeteksi secara dini, intervensi tambahan dapat segera dilakukan sehingga keselamatan pasien tetap terjaga.

Selain aspek klinis dan fisiologis, pemantauan juga melibatkan penilaian terhadap respons keluarga terhadap situasi gawat darurat yang baru saja dilalui. Perawat perlu memonitor dan memberikan dukungan psikososial yang berkelanjutan kepada keluarga, memastikan bahwa mereka memahami kondisi anak, tujuan dari intervensi yang telah dilakukan, serta langkah-langkah berikutnya dalam proses perawatan. Dukungan keluarga yang kuat sangat penting untuk memastikan partisipasi mereka dalam pemulihan anak dan mengurangi risiko stres pasca-trauma yang mungkin dialami oleh keluarga maupun pasien.

Dalam konteks perencanaan tindak lanjut perawatan, peran perawat tidak hanya terbatas pada evaluasi dan pemantauan kondisi anak, namun juga mencakup

perencanaan perawatan selanjutnya. Setelah kondisi anak stabil dan tahap emergensi berhasil dilewati, perawat memiliki peran penting dalam menentukan perawatan lanjutan, baik berupa observasi di unit rawat inap, rujukan ke unit perawatan intensif, atau rekomendasi perawatan rumah jika kondisi anak sudah membaik secara signifikan. Perencanaan ini harus dilakukan secara teliti dan komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi klinis pasien, kemungkinan komplikasi yang dapat muncul, serta kebutuhan psikososial anak dan keluarganya.

Dalam proses perencanaan ini, komunikasi dan kolaborasi yang erat antara perawat, dokter, dan tim multidisiplin lainnya menjadi kunci utama dalam memastikan kontinuitas dan kualitas perawatan anak. Perawat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas kepada keluarga mengenai kondisi anak, tujuan perawatan lanjutan, serta tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan jika muncul selama masa pemulihan. Informasi ini diberikan melalui edukasi langsung, konseling keluarga, serta dokumentasi yang jelas agar keluarga mampu mengelola kondisi anak secara mandiri setelah keluar dari IGD atau unit perawatan intensif.

Dalam situasi tertentu, perawat juga memiliki peran dalam mengkoordinasikan proses rujukan atau transfer anak ke unit layanan kesehatan lain yang lebih tinggi atau lebih sesuai dengan kebutuhan perawatan lanjutan anak. Peran ini melibatkan koordinasi yang baik antar institusi kesehatan, memastikan bahwa semua informasi klinis penting terdokumentasi secara akurat, serta memastikan bahwa keluarga pasien memahami tujuan dari rujukan tersebut. Komunikasi yang efektif selama proses serah terima juga sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang terlewatkan, serta memastikan kontinuitas perawatan selama proses transisi antar unit atau antar fasilitas layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, evaluasi dan monitoring pasca-intervensi kegawatdaruratan pada pasien anak merupakan proses kompleks yang membutuhkan perhatian detail dari perawat. Melalui evaluasi yang teliti terhadap indikator keberhasilan intervensi, pemantauan ketat terhadap kondisi klinis dan psikososial anak, serta peran aktif dalam perencanaan tindak lanjut perawatan, perawat berkontribusi secara langsung dalam memastikan bahwa pasien anak dapat pulih secara optimal, bebas dari komplikasi, serta mendapatkan perawatan lanjutan yang tepat dan aman. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pediatrik secara keseluruhan, serta memberikan hasil klinis terbaik bagi pasien dan keluarganya.

J. Simpulan

Keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan merupakan area pelayanan kesehatan yang kompleks, kritis, dan membutuhkan perhatian khusus dari tenaga kesehatan, terutama perawat. Penanganan kondisi darurat pediatrik memerlukan respons cepat, penilaian sistematis menggunakan pendekatan ABCDE, serta intervensi yang tepat guna mencegah terjadinya komplikasi atau kematian. Pemahaman mendalam tentang karakteristik khusus anak dari segi anatomi, fisiologi, dan psikologis menjadi dasar penting dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan yang efektif.

Selain aspek klinis seperti identifikasi dini, penanganan kondisi umum seperti gangguan pernapasan akut, neurologis, gastrointestinal, kardiovaskular, serta trauma, peran perawat juga mencakup manajemen nyeri yang holistik, mencakup intervensi farmakologis dan nonfarmakologis. Dukungan psikososial terhadap anak dan keluarganya dalam menghadapi situasi stres di unit gawat darurat turut menjadi komponen integral dalam perawatan, di mana komunikasi terapeutik serta edukasi keluarga menjadi kunci penting untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan kepuasan, dan mempercepat pemulihan.

Kolaborasi interprofesional dengan komunikasi efektif, dokumentasi yang akurat, serta serah terima pasien yang terstruktur sangat diperlukan guna menjaga kontinuitas dan kualitas pelayanan. Di sisi lain, tantangan etik dan legal seringkali muncul dalam situasi kritis, terutama terkait persetujuan tindakan emergensi pada anak. Oleh karena itu, kompetensi perawat dalam memahami aspek hukum dan etika, serta kemampuannya untuk melakukan advokasi pasien dan pendekatan keluarga secara empati sangat penting untuk mencegah konflik serta melindungi keselamatan pasien dan integritas profesional.

Tahap evaluasi dan monitoring pasca-intervensi juga memegang peranan vital dalam memastikan intervensi yang dilakukan telah berhasil dan tidak muncul komplikasi lebih lanjut. Pemantauan ketat, observasi klinis yang sistematis, serta perencanaan tindak lanjut perawatan menjadi tanggung jawab perawat guna memastikan pemulihan optimal pasien anak. Dengan demikian, keseluruhan praktik keperawatan anak dalam situasi kegawatdaruratan menuntut integrasi antara kompetensi klinis, keterampilan komunikasi, kemampuan advokasi, serta perhatian terhadap aspek psikososial, etika, dan hukum agar dapat memberikan hasil terbaik bagi pasien anak dan keluarganya.

K. Referensi

- Beck, H. L., & Resuscitation Council UK. (2021). The ABCDE approach: Assessment and treatment in clinical emergencies. Resuscitation Council UK.
- Doyle, D., Brownstein, D., & Gausche-Hill, M. (1996). Pediatric assessment triangle: A rapid outpatient triage tool. *American Academy of Pediatrics*, 97(3), 497-500.
- Gausche-Hill, M., Tørisen, T. A. G., Glanville, J. M., Loaiza-Betancur, A. F., & Bidonde, J. (2024). Emergency pediatric patients and use of the Pediatric Assessment Triangle (PAT): A scoping review. *BMC Emergency Medicine*, 24(1), Article 158.
- Gladman, D. A., & European Resuscitation Council Advanced Life Support Science and Education Committee. (2020). Development of an ABCDE cognitive aid tool (CAT) and its application in emergency settings. *BMC Emergency Medicine*, 20(1), Article 65.
- Jones, S., & Goldstein, L. (1988). A rapid method for estimating weight and resuscitation drug dosages from length in the pediatric age group. *Annals of Emergency Medicine*, 17(6), 629-633.
- Monroe, J., & Resuscitation Council UK. (2021). British Columbia Pediatric Early Warning System (BC PEWS): Instructions for use. BC Children's Hospital.
- Ojo, O., Ma, X., Liu, Y., Du, M., Huang, L., & Feng, X. (2021). Accuracy of the Pediatric Assessment Triangle in triaging critically ill patients in emergency pediatric departments. *International Emergency Nursing*, 58, 100953.
- Park, K. S. (Ed.). (2016). *Handbook of human factors and ergonomics* (3rd ed.). Wiley.
- Resuscitation Council UK. (2021). The ABCDE approach. Resuscitation Council UK.
- Smith, J., Greaves, I., & Porter, K. M. (2011). *Oxford Desk Reference Major Trauma*. Oxford University Press.
- Tørisen, T. A. G., Glanville, J. M., Loaiza-Betancur, A. F., & Bidonde, J. (2024). Emergency pediatric patients and use of the Pediatric Assessment Triangle (PAT): A scoping review. *BMC Emergency Medicine*, 24(1), Article 158.
- World Health Organization. (2022). ABCDE Quick Cards. WHO Basic Emergency Care.

CHAPTER 8

PENATALAKSANAAN PASIEN DENGAN KERACUNAN DAN GIGITAN HEWAN BERBISA

Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

Keracunan merupakan kondisi patologis yang terjadi akibat masuknya substansi berbahaya atau racun ke dalam tubuh, baik melalui jalur pencernaan, inhalasi, absorpsi melalui kulit, atau secara parenteral. Racun ini dapat berupa bahan kimia, obat-obatan, pestisida, hingga zat beracun biologis yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Berdasarkan onsetnya, keracunan diklasifikasikan menjadi akut, subakut, dan kronis. Keracunan akut terjadi secara tiba-tiba dengan gejala yang muncul dalam waktu singkat, seringkali dalam hitungan menit hingga jam. Keracunan subakut terjadi dalam jangka waktu beberapa hari atau minggu, sedangkan keracunan kronis terjadi akibat paparan jangka panjang terhadap substansi toksik tertentu (Hoffman et al., 2019).

Gigitan hewan berbisa, di sisi lain, adalah kondisi medis akut yang disebabkan oleh gigitan atau sengatan dari hewan-hewan yang memiliki kelenjar racun, seperti ular, kalajengking, laba-laba, atau serangga berbisa lainnya. Racun atau venom yang disuntikkan ke tubuh manusia melalui gigitan tersebut memiliki kandungan zat bioaktif seperti enzim proteolitik, neurotoksin, hemotoksin, sitotoksin, dan kardiotoxin yang mampu menyebabkan berbagai gangguan fisiologis hingga kematian, tergantung pada jenis hewan berbisa, jumlah racun yang disuntikkan, lokasi gigitan, serta kondisi fisik korban (Warrell, 2021).

Secara umum, keracunan dan gigitan hewan berbisa adalah dua kondisi emergensi medis yang memiliki kesamaan dalam hal urgensi penanganan serta kompleksitas terapi. Keduanya memerlukan diagnosis yang cepat dan akurat, intervensi yang tepat waktu, serta keterampilan khusus dari tenaga medis maupun keperawatan untuk mencegah komplikasi serius hingga kematian pasien (Hoffman et al., 2019; Warrell, 2021).

Di Indonesia, kasus keracunan maupun gigitan hewan berbisa masih sering dijumpai, terutama di daerah pedesaan atau wilayah dengan tingkat aktivitas agraris yang tinggi, serta wilayah dengan hutan atau lingkungan alami yang masih banyak dihuni oleh berbagai jenis hewan berbisa. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus keracunan pestisida serta keracunan makanan

mendominasi kejadian keracunan akut, terutama di kalangan petani dan pekerja industri, di mana penggunaan bahan kimia masih kurang diawasi dan perlindungan diri seringkali diabaikan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Untuk kasus gigitan hewan berbisa, gigitan ular menjadi kasus yang paling banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di daerah dengan karakteristik geografis hutan atau pedesaan yang berdekatan dengan habitat alami ular. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam negara dengan tingkat kejadian gigitan ular tinggi di Asia Tenggara, di mana sekitar 135.000 hingga 150.000 kasus gigitan ular terjadi setiap tahunnya, dengan angka kematian sekitar 728 kasus per tahun (World Health Organization, 2021). Tingginya angka kejadian gigitan ular ini diperparah dengan terbatasnya akses terhadap antivenom, minimnya edukasi masyarakat mengenai pertolongan pertama yang benar, serta keterlambatan dalam penanganan medis karena kondisi geografis atau transportasi yang kurang memadai (Alirol et al., 2017).

Dampak epidemiologis dari keracunan maupun gigitan hewan berbisa tidak hanya sebatas morbiditas dan mortalitas pasien saja, tetapi juga mencakup aspek sosio-ekonomi dan psikologis pasien dan keluarganya. Beban biaya yang tinggi untuk pengobatan serta kerugian akibat hilangnya produktivitas kerja pasien yang mengalami komplikasi jangka panjang, seperti gagal ginjal atau gangguan neurologis permanen, menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemangku kebijakan kesehatan masyarakat (Gutiérrez et al., 2017).

Dengan demikian, upaya penatalaksanaan yang optimal bagi pasien keracunan maupun korban gigitan hewan berbisa merupakan tantangan penting dalam pelayanan kesehatan emergensi di Indonesia. Diperlukan pendekatan multidisiplin yang tidak hanya mencakup aspek klinis atau medis, tetapi juga melibatkan edukasi kesehatan masyarakat, penyediaan antidotum dan antivenom secara memadai, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, terutama perawat yang menjadi garda depan dalam penanganan awal pasien di fasilitas kesehatan primer maupun rumah sakit (Hoffman et al., 2019; Gutiérrez et al., 2017).

B. Keracunan Akut

Keracunan akut adalah kondisi patologis serius yang ditandai dengan timbulnya gejala klinis secara cepat akibat masuknya zat beracun dalam dosis tinggi ke dalam tubuh manusia. Kondisi ini memerlukan intervensi medis segera guna mencegah komplikasi serius hingga kematian pasien. Berdasarkan data epidemiologi terbaru, kasus keracunan akut terus mengalami peningkatan di berbagai negara, terutama di negara berkembang akibat penggunaan bahan kimia

secara luas serta lemahnya regulasi terhadap zat-zat berbahaya (Alzahrani et al., 2022).

1. Jenis-jenis Racun yang Umum Ditemui

Jenis racun yang sering menyebabkan kasus keracunan akut sangat bervariasi, namun secara umum dapat diklasifikasikan menjadi racun kimia, obat-obatan, dan pestisida. Racun kimia mencakup berbagai bahan yang sering digunakan dalam rumah tangga maupun industri, seperti bahan pembersih, detergen, pemutih, dan pelarut organik. Bahan-bahan ini, jika tertelan, terhirup, atau terkena kulit dalam jumlah besar, mampu menyebabkan efek sistemik yang serius, seperti iritasi saluran pernapasan, cedera mukosa gastrointestinal, dan gangguan neurologis (Lee et al., 2021).

Selain racun kimia, kasus keracunan akut sering terjadi akibat overdosis obat-obatan, terutama obat golongan analgetik seperti parasetamol, obat penenang golongan benzodiazepin, antidepresan, serta opioid. Di Indonesia dan beberapa negara lainnya, overdosis parasetamol masih menjadi penyebab utama keracunan obat akibat ketersediaannya yang luas dan penggunaannya tanpa pengawasan medis yang ketat (Hendrickson, 2019).

Pestisida juga menjadi salah satu penyebab keracunan akut yang sering dijumpai, terutama di wilayah agraris atau pedesaan di Indonesia. Pestisida golongan organofosfat, karbamat, serta piretroid, jika terpapar dalam dosis besar atau jangka waktu lama, dapat menyebabkan gangguan neurologis, kardiovaskular, dan respirasi berat akibat efek inhibisi enzim asetilkolinesterase di sistem saraf pusat maupun perifer (Hulse et al., 2019).

2. Tanda dan Gejala Klinis Keracunan

Gejala klinis pada pasien dengan keracunan akut sangat beragam dan tergantung pada jenis racun, rute masuknya ke dalam tubuh, jumlah yang terpapar, serta kecepatan penanganan medis yang diberikan. Secara umum, pasien yang mengalami keracunan akut sering memperlihatkan gejala berupa mual, muntah, diare, nyeri perut, gangguan kesadaran, hingga kejang. Pada kasus yang lebih serius, dapat muncul gangguan pernapasan akut, bradikardia, hipotensi berat, sianosis, hingga syok yang dapat berujung pada kematian (Alzahrani et al., 2022).

Pada kasus keracunan obat golongan parasetamol, gejala awal yang sering ditemukan adalah mual, muntah, nyeri perut bagian atas, hingga gangguan fungsi hati akut yang ditandai dengan kenaikan enzim hati seperti ALT dan AST. Keracunan obat benzodiazepin menunjukkan gejala berupa depresi sistem saraf pusat, gangguan kesadaran, hingga depresi pernapasan berat. Sementara, pada keracunan pestisida seperti organofosfat, gejala khasnya berupa hipersalivasi,

bradikardia, diare, kejang, serta sesak napas akibat peningkatan sekresi bronkial (Hulse et al., 2019; Lee et al., 2021).

3. Penilaian Awal dan Diagnosis Keracunan

Penilaian awal pasien dengan dugaan keracunan akut dimulai dengan pendekatan sistematis ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure). Petugas medis harus segera memastikan jalan napas terbuka, pasien memiliki ventilasi yang adekuat, serta memastikan sirkulasi darah dalam kondisi stabil. Selanjutnya, pemeriksaan fisik menyeluruh dilakukan untuk mencari tanda-tanda paparan racun seperti aroma khas dari napas pasien, luka bakar kimia di sekitar mulut atau tubuh, hingga identifikasi bahan toksik yang tertinggal pada pakaian pasien (Alzahrani et al., 2022).

Diagnosis keracunan akut ditegakkan berdasarkan kombinasi anamnesis riwayat paparan, temuan klinis, serta hasil pemeriksaan penunjang laboratorium seperti pemeriksaan kadar elektrolit, fungsi hati dan ginjal, analisis gas darah, serta kadar racun spesifik dalam darah atau urin. Identifikasi spesifik jenis racun sangat penting untuk menentukan intervensi pengobatan yang tepat dan penggunaan antidotum yang sesuai (Lee et al., 2021).

4. Prinsip Dasar Penanganan Awal Pasien Keracunan

Penanganan awal pasien keracunan akut bertujuan utama untuk menstabilisasi kondisi vital pasien serta mencegah absorpsi lebih lanjut dari racun. Prinsip dasar penanganan awal meliputi stabilisasi jalan napas, ventilasi, serta sirkulasi, diikuti oleh proses dekontaminasi yang bertujuan mengurangi paparan zat toksik dari tubuh pasien (Hendrickson, 2019).

Prosedur dekontaminasi bisa berupa dekontaminasi gastrointestinal seperti induksi muntah atau lavage lambung, penggunaan karbon aktif (activated charcoal), maupun dekontaminasi kulit dengan mencuci kulit yang terpapar menggunakan air mengalir secara terus menerus. Pilihan prosedur ini tergantung pada jenis racun, waktu paparan, dan kondisi klinis pasien (Alzahrani et al., 2022).

5. Intervensi Khusus pada Keracunan Akut (Dekontaminasi, Antidotum)

Intervensi khusus dalam penanganan keracunan akut mencakup penggunaan antidotum spesifik serta metode dekontaminasi yang sesuai. Antidotum atau penawar racun digunakan untuk mengatasi efek toksik spesifik dari zat beracun. Sebagai contoh, keracunan parasetamol diatasi dengan antidotum N-asetilsistein yang berfungsi untuk mencegah kerusakan hati yang lebih lanjut. Keracunan organofosfat diatasi dengan pemberian atropin yang dapat mengurangi efek kolinergik akut, serta pralidoksim yang mampu mengaktifkan kembali enzim asetilkolinesterase yang sebelumnya terhambat oleh organofosfat (Hulse et al., 2019).

Dekontaminasi gastrointestinal masih menjadi prosedur penting yang dapat dilakukan jika pasien datang dalam waktu yang relatif singkat setelah paparan racun. Pemberian karbon aktif dalam dosis yang adekuat terbukti efektif mengurangi absorpsi zat racun, khususnya jika diberikan dalam waktu kurang dari 1-2 jam setelah paparan. Dekontaminasi kulit juga menjadi prioritas penting jika pasien terpapar racun melalui kontak langsung dengan bahan kimia berbahaya (Lee et al., 2021).

Secara keseluruhan, penanganan kasus keracunan akut yang efektif dan cepat dapat menurunkan risiko komplikasi serius hingga kematian. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan, kesiapan tenaga medis dalam mengenali tanda-tanda keracunan, serta ketersediaan antidotum dan fasilitas dekontaminasi yang memadai menjadi aspek penting dalam manajemen kasus keracunan akut di fasilitas pelayanan kesehatan (Alzahrani et al., 2022; Hendrickson, 2019).

C. Gigitan Hewan Berbisa

Gigitan hewan berbisa merupakan salah satu kegawatdaruratan medis yang memerlukan perhatian khusus karena berpotensi menimbulkan efek toksik serius yang dapat berujung pada komplikasi berat hingga kematian. Kondisi ini dapat terjadi di berbagai wilayah, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, yang memiliki keanekaragaman hewan berbisa tinggi. Oleh sebab itu, tenaga medis harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai jenis-jenis hewan berbisa, tanda dan gejala klinis gigitan, serta penatalaksanaan yang tepat untuk mencegah timbulnya komplikasi.

Jenis-jenis hewan berbisa yang paling sering menyebabkan kasus gigitan pada manusia, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia, antara lain ular, kalajengking, dan laba-laba. Ular merupakan hewan berbisa yang paling umum ditemukan dan sering menimbulkan kondisi serius yang membutuhkan intervensi segera. Secara umum, ular berbisa dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama, yakni ular berbisa hemotoksik yang racunnya merusak sistem pembekuan darah dan jaringan lokal seperti ular viper (ular tanah, ular beludak), serta ular neurotoksik yang racunnya menyerang sistem saraf pusat seperti ular kobra, ular welang, dan ular belang. Setiap jenis racun ular ini memiliki mekanisme aksi yang berbeda serta memerlukan intervensi medis yang berbeda pula.

Selain ular, gigitan kalajengking juga cukup sering ditemui di beberapa daerah, terutama wilayah pedesaan dengan iklim kering dan berpasir. Kalajengking memiliki racun neurotoksik yang bisa menyebabkan gangguan saraf serius, rasa nyeri hebat, kejang otot, serta gangguan pernapasan. Di samping itu, laba-laba berbisa, seperti laba-laba black widow dan laba-laba brown recluse, juga ditemukan di beberapa

wilayah di Indonesia. Gigitan laba-laba biasanya mengakibatkan nyeri yang tajam, luka nekrotik, dan pada beberapa kasus dapat menimbulkan gejala sistemik seperti demam, nyeri otot yang hebat, dan kelemahan ekstremitas.

Tanda dan gejala klinis akibat gigitan hewan berbisa sangat bervariasi tergantung jenis hewan, lokasi gigitan, jumlah racun yang masuk ke dalam tubuh, serta waktu penanganan yang diberikan. Gigitan ular biasanya menimbulkan gejala lokal yang nyata berupa nyeri hebat, pembengkakan progresif, perubahan warna kulit menjadi kemerahan atau kebiruan, serta luka bekas gigitan yang khas dengan dua titik tusukan sejajar. Gigitan ular dengan racun neurotoksik dapat menyebabkan gejala sistemik seperti kelumpuhan otot, pandangan kabur, kesulitan bernapas, serta kehilangan kesadaran dalam waktu singkat. Sebaliknya, ular berbisa hemotoksik sering menyebabkan perdarahan hebat, nekrosis jaringan, gangguan pembekuan darah, serta syok akibat kehilangan cairan atau syok hemoragik.

Pada gigitan kalajengking, gejala yang dominan muncul adalah nyeri hebat pada lokasi gigitan yang dapat menyebar ke seluruh tubuh, disertai gejala neurologis seperti kejang, tremor, dan kesulitan bernapas. Gigitan laba-laba berbisa umumnya mengakibatkan reaksi kulit berupa nyeri hebat, kemerahan, luka dengan pusat nekrotik, serta gejala sistemik seperti demam, menggigil, nyeri otot, serta mual dan muntah.

Identifikasi cepat hewan berbisa berdasarkan ciri luka gigitan menjadi kunci utama dalam penanganan awal yang efektif. Luka gigitan ular umumnya menunjukkan dua titik kecil bekas taring yang terpisah beberapa milimeter hingga sentimeter tergantung jenis ular. Luka gigitan ular berbisa biasanya disertai tanda inflamasi lokal yang cepat progresif. Pada gigitan kalajengking, luka gigitan tampak seperti titik kecil tunggal, sering disertai rasa nyeri sangat intens yang tidak sebanding dengan ukuran lukanya. Sedangkan gigitan laba-laba biasanya terlihat sebagai lesi kulit merah yang dapat berkembang menjadi luka nekrotik dengan daerah kehitaman di tengahnya.

Penatalaksanaan awal atau pertolongan pertama pada pasien yang mengalami gigitan hewan berbisa merupakan tindakan yang krusial untuk mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Pertolongan pertama pada gigitan ular yang direkomendasikan adalah immobilisasi bagian tubuh yang tergigit, menjaga pasien tetap tenang, serta menghindari aktivitas berlebihan agar racun tidak menyebar cepat melalui sirkulasi darah. Teknik pembidaian ringan untuk membatasi gerakan bagian yang tergigit sangat penting. Tindakan seperti menghisap racun, menyayat luka, atau memasang tourniquet sangat tidak dianjurkan karena dapat memperburuk kondisi jaringan serta mempercepat penyebaran racun.

Pada gigitan kalajengking dan laba-laba, pertolongan pertama meliputi mencuci luka gigitan dengan air mengalir dan sabun lembut, mengompres area luka dengan es atau kompres dingin untuk mengurangi rasa nyeri dan inflamasi, serta segera membawa pasien ke fasilitas kesehatan untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut.

Terapi khusus untuk gigitan hewan berbisa adalah pemberian antivenom atau serum anti racun. Antivenom merupakan terapi paling efektif yang secara spesifik menetralkan efek toksik dari racun hewan berbisa. Penggunaan antivenom harus dilakukan di fasilitas medis yang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengelola efek samping seperti reaksi alergi yang berat (anafilaksis). Pada gigitan ular, pemberian antivenom spesifik terhadap jenis ular tertentu merupakan terapi paling penting, yang diberikan segera setelah diagnosis klinis ditegakkan. Pasien yang mengalami gigitan kalajengking atau laba-laba yang berat juga dapat diberikan antivenom spesifik sesuai dengan jenis hewan yang menggigit, meskipun ketersediaannya lebih terbatas dibandingkan antivenom ular.

Selain antivenom, terapi suportif yang mencakup analgesik untuk mengontrol nyeri, antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder, tetanus profilaksis jika diperlukan, serta terapi cairan intravena untuk menjaga stabilitas sirkulasi juga merupakan bagian penting dari penatalaksanaan pasien dengan gigitan hewan berbisa. Pasien juga harus dipantau secara ketat terhadap perkembangan komplikasi lebih lanjut seperti gangguan pernapasan, syok, atau gagal organ yang dapat terjadi akibat efek toksik dari racun.

Secara keseluruhan, keberhasilan penanganan gigitan hewan berbisa bergantung pada kecepatan identifikasi jenis gigitan, ketepatan pertolongan pertama yang diberikan, serta tersedianya fasilitas medis yang mampu memberikan antivenom spesifik dengan segera. Oleh karena itu, edukasi masyarakat mengenai langkah-langkah pertolongan pertama, pengenalan jenis-jenis hewan berbisa, serta kesiapan fasilitas kesehatan dalam menyediakan antivenom dan terapi suportif sangat penting untuk meningkatkan angka keberhasilan penatalaksanaan kasus gigitan hewan berbisa di masyarakat.

D. Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Keracunan dan Gigitan Hewan Berbisa

Asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien yang mengalami keracunan dan gigitan hewan berbisa merupakan rangkaian tindakan yang sangat penting dalam memastikan keselamatan dan pemulihan pasien secara optimal. Proses ini melibatkan tahapan-tahapan sistematis mulai dari pengkajian yang komprehensif, perumusan diagnosis keperawatan yang tepat, intervensi

keperawatan secara menyeluruh, hingga edukasi kepada pasien serta keluarga terkait tindakan preventif dan pengelolaan situasi kegawatdaruratan serupa di masa mendatang.

1. Pengkajian Keperawatan Pasien

Tahap awal dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan keracunan maupun gigitan hewan berbisa adalah melakukan pengkajian secara sistematis dan komprehensif. Pengkajian keperawatan meliputi pemeriksaan fisik yang menyeluruh, wawancara untuk menggali riwayat terjadinya kejadian keracunan atau gigitan, serta identifikasi tanda dan gejala klinis yang muncul. Pada tahap ini, perawat harus secara khusus memperhatikan kondisi pasien dengan cermat untuk mengidentifikasi adanya perubahan signifikan dalam sistem respirasi, kardiovaskular, neurologis, dan integumen yang dapat menjadi tanda awal dari komplikasi serius.

Pada pasien keracunan, perawat perlu menanyakan jenis zat beracun yang tertelan atau terpapar oleh pasien, jumlah zat yang dikonsumsi, cara dan waktu paparan, serta tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, pemeriksaan fisik perlu memperhatikan tanda-tanda klinis seperti penurunan kesadaran, muntah, gangguan pernapasan, atau adanya bau khas dari zat tertentu yang tercium pada napas atau pakaian pasien. Sedangkan pada pasien dengan gigitan hewan berbisa, pengkajian meliputi identifikasi luka gigitan, lokasi gigitan, luas area pembengkakan, tanda-tanda perdarahan atau nekrosis jaringan, serta gejala sistemik seperti gangguan neurologis dan sirkulasi. Pengkajian ini akan menjadi dasar yang penting dalam menentukan tindakan keperawatan dan medis lanjutan yang harus segera dilakukan.

2. Diagnosis dan Prioritas Masalah Keperawatan

Setelah melakukan pengkajian secara mendalam, perawat merumuskan diagnosis keperawatan yang relevan dengan kondisi pasien. Diagnosis keperawatan ini harus menggambarkan kondisi aktual maupun risiko yang sedang dihadapi oleh pasien akibat keracunan atau gigitan hewan berbisa. Pada pasien keracunan, diagnosis keperawatan yang sering muncul meliputi gangguan pola napas akibat depresi respirasi, risiko aspirasi akibat penurunan kesadaran, gangguan perfusi jaringan akibat gangguan sirkulasi atau syok, serta nyeri akut akibat iritasi mukosa gastrointestinal atau cedera jaringan. Sementara itu, pada pasien gigitan hewan berbisa, diagnosis keperawatan yang sering dirumuskan meliputi nyeri akut terkait inflamasi dan cedera jaringan, gangguan perfusi perifer akibat racun hemotoksik atau neurotoksik, risiko infeksi terkait luka terbuka gigitan, serta kecemasan pasien maupun keluarga akibat situasi kegawatan yang dialami.

Dalam situasi kegawatdaruratan seperti keracunan dan gigitan hewan berbisa, perawat juga perlu menentukan prioritas masalah keperawatan secara tepat untuk mencegah komplikasi serius yang dapat mengancam nyawa pasien. Prioritas utama umumnya meliputi memastikan jalan napas pasien terbuka, mempertahankan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, menjaga stabilitas hemodinamik, mengontrol nyeri yang dirasakan pasien, serta mencegah komplikasi lebih lanjut melalui intervensi cepat dan tepat.

3. Intervensi Keperawatan secara Komprehensif

Intervensi keperawatan yang dilakukan pada pasien dengan keracunan dan gigitan hewan berbisa bersifat holistik, melibatkan aspek biologis, psikologis, serta sosial pasien. Secara biologis, tindakan yang dilakukan mencakup pemberian oksigenasi yang adekuat, pemantauan ketat tanda vital seperti denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, laju pernapasan, serta suhu tubuh secara reguler. Pada kasus keracunan akut, perawat bertanggung jawab melakukan tindakan suportif seperti memasang akses intravena, pemberian cairan intravena yang adekuat untuk mempertahankan perfusi jaringan, serta memfasilitasi pemberian antidotum atau dekontaminasi secara efektif.

Pada pasien gigitan hewan berbisa, intervensi awal keperawatan mencakup imobilisasi anggota tubuh yang tergigit dengan tujuan memperlambat penyebaran racun, elevasi anggota tubuh yang tergigit untuk mengurangi edema jika tidak terdapat kontraindikasi, serta perawatan luka gigitan secara steril dan hati-hati untuk mencegah infeksi sekunder. Pemberian analgesik untuk meredakan nyeri juga menjadi bagian penting dalam intervensi yang diberikan. Perawat juga bertanggung jawab dalam memantau secara ketat perkembangan gejala neurologis, perubahan lokal pada luka gigitan, dan tanda-tanda kemungkinan komplikasi sistemik yang memerlukan intervensi medis lebih lanjut seperti pemberian antivenom.

Dari sisi psikologis, perawat perlu memberikan dukungan emosional kepada pasien maupun keluarga dengan menciptakan suasana yang tenang, menjelaskan kondisi pasien dengan bahasa sederhana dan empati, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dengan sabar. Dukungan ini penting dalam mengurangi kecemasan pasien dan keluarga yang seringkali meningkat dalam situasi kegawatdaruratan medis. Selain itu, perawat juga perlu mengidentifikasi kebutuhan sosial pasien yang mungkin timbul, seperti kebutuhan dukungan keluarga, pendampingan, maupun bantuan finansial atau administrasi kesehatan.

4. Edukasi Pasien dan Keluarga terkait Pencegahan dan Penanganan Keracunan serta Gigitan Hewan Berbisa

Tahap akhir dari asuhan keperawatan yang komprehensif ini adalah pemberian edukasi secara terstruktur kepada pasien dan keluarga mengenai upaya pencegahan serta tindakan pertolongan pertama yang efektif jika kembali menghadapi situasi yang sama di kemudian hari. Edukasi ini mencakup pengenalan jenis-jenis zat berbahaya dan racun yang umumnya ada di lingkungan rumah, tempat kerja, maupun sekitar tempat tinggal, serta pentingnya menjaga zat-zat tersebut di tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh anak-anak atau orang dengan gangguan kognitif.

Terkait pencegahan gigitan hewan berbisa, perawat perlu memberikan edukasi tentang pentingnya menghindari habitat alami hewan berbisa, menggunakan pelindung tubuh yang memadai seperti sepatu bot, sarung tangan atau pakaian tertutup saat berada di wilayah berisiko tinggi, serta tata cara pertolongan pertama yang benar jika terkena gigitan hewan berbisa. Hal ini termasuk tindakan awal seperti imobilisasi anggota tubuh yang tergigit, menghindari tindakan yang justru dapat memperparah kondisi seperti menghisap racun, serta pentingnya segera mendapatkan pertolongan medis profesional.

Dengan memberikan edukasi yang tepat dan komprehensif kepada pasien dan keluarga, perawat tidak hanya membantu pasien dalam proses pemulihan secara fisik tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam mencegah dan mengelola situasi darurat serupa di masa depan. Upaya ini diharapkan mampu mengurangi risiko komplikasi serius, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mengurangi angka kejadian keracunan maupun gigitan hewan berbisa di masyarakat.

E. Tatalaksana Komplikasi pada Pasien dengan Keracunan dan Gigitan Hewan Berbisa

Dalam penanganan pasien dengan keracunan maupun gigitan hewan berbisa, komplikasi merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius karena dapat memperparah kondisi klinis pasien dan meningkatkan risiko morbiditas serta mortalitas. Komplikasi yang timbul dapat bersifat akut maupun kronis, serta dapat melibatkan berbagai sistem tubuh pasien. Oleh karena itu, perawat dan tim kesehatan perlu memahami secara mendalam tentang berbagai komplikasi yang mungkin terjadi, cara identifikasi dini, serta langkah-langkah manajemen yang tepat untuk menangani komplikasi tersebut secara efektif.

1. Komplikasi Akut dan Kronis Akibat Keracunan

Keracunan merupakan kondisi medis serius yang dapat menyebabkan berbagai komplikasi baik secara akut maupun kronis. Komplikasi akut umumnya muncul dalam waktu singkat setelah paparan racun dan memerlukan tindakan segera untuk mencegah dampak yang lebih serius. Salah satu komplikasi akut yang sering terjadi adalah gangguan respirasi, seperti depresi pernapasan akibat overdosis obat tertentu seperti opioid atau benzodiazepin. Kondisi ini dapat menyebabkan hipoksia jaringan yang cepat berkembang menjadi kerusakan organ vital jika tidak segera ditangani. Selain itu, gangguan kardiovaskular seperti aritmia jantung, hipotensi berat, atau bahkan syok juga sering terjadi akibat keracunan oleh zat-zat seperti pestisida atau bahan kimia tertentu.

Di sisi lain, komplikasi kronis akibat keracunan merupakan dampak jangka panjang yang muncul setelah paparan yang bersifat kumulatif atau paparan tunggal dalam jumlah besar yang menyebabkan kerusakan permanen pada organ atau sistem tertentu. Contohnya, paparan kronis terhadap racun seperti logam berat (timbal, merkuri) dapat menyebabkan gangguan neurologis permanen, penurunan fungsi kognitif, serta gangguan ginjal kronis. Begitu pula dengan paparan pestisida dalam jangka waktu lama yang dapat menyebabkan gangguan sistem saraf perifer, neuropati, bahkan gangguan endokrin. Komplikasi kronis ini memerlukan pengawasan jangka panjang serta terapi yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kualitas hidup pasien.

2. Komplikasi Sistemik Akibat Gigitan Hewan Berbisa

Gigitan hewan berbisa juga dapat menimbulkan komplikasi yang bersifat lokal maupun sistemik, tergantung pada jenis hewan yang menggigit dan sifat racun yang dimilikinya. Namun, komplikasi sistemik cenderung lebih berbahaya karena dapat mengancam nyawa pasien dalam waktu singkat. Racun hewan berbisa umumnya memiliki efek neurotoksik, hemotoksik, atau miotoksik yang mempengaruhi berbagai sistem tubuh secara luas.

Komplikasi sistemik yang sering terjadi akibat gigitan ular berbisa, misalnya, meliputi gangguan pembekuan darah, koagulopati, dan perdarahan masif yang disebabkan oleh racun hemotoksik. Racun ini dapat merusak komponen darah seperti trombosit dan faktor pembekuan, sehingga pasien dapat mengalami perdarahan spontan, seperti mimisan, hematuria, atau bahkan perdarahan intrakranial. Selain itu, gigitan ular dengan racun neurotoksik, seperti ular kobra, dapat menyebabkan paralisis pernapasan akibat kelemahan otot pernapasan yang cepat progresif, sehingga pasien memerlukan ventilasi mekanik secara darurat.

Gigitan kalajengking atau laba-laba berbisa juga dapat menimbulkan komplikasi sistemik, seperti nyeri hebat, hipertensi berat, aritmia jantung, dan gagal jantung akut akibat pelepasan neurotransmitter secara berlebihan yang diinduksi oleh racun. Kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah terjadinya kerusakan organ yang ireversibel.

3. Manajemen Keperawatan pada Komplikasi Keracunan dan Gigitan

Peran perawat dalam manajemen komplikasi pada pasien yang mengalami keracunan maupun gigitan hewan berbisa sangat krusial, mencakup pemantauan ketat kondisi pasien, tindakan antisipasi terhadap kemungkinan komplikasi, serta intervensi segera untuk mengatasi komplikasi yang sudah terjadi. Dalam mengelola komplikasi akut, perawat bertanggung jawab dalam memantau secara ketat tanda vital, seperti denyut jantung, tekanan darah, saturasi oksigen, serta status neurologis pasien secara kontinu. Perubahan tanda vital yang tidak stabil atau penurunan status kesadaran harus segera diidentifikasi dan dikomunikasikan kepada tim medis untuk intervensi segera.

Perawat juga bertanggung jawab dalam mengelola komplikasi respirasi dengan memastikan pasien mendapatkan oksigenasi yang adekuat, mempersiapkan ventilasi mekanik jika diperlukan, serta mengamati tanda-tanda distress pernapasan yang memerlukan intervensi lebih lanjut. Pada komplikasi kardiovaskular, perawat bertugas dalam mempertahankan stabilitas hemodinamik pasien dengan memastikan pemberian cairan intravena yang optimal, serta mempersiapkan pemberian obat vasoaktif sesuai instruksi medis untuk mempertahankan tekanan darah dan perfusi jaringan.

Dalam penanganan komplikasi kronis akibat keracunan, perawat memiliki peran penting dalam edukasi pasien dan keluarga mengenai pengelolaan gejala jangka panjang, pemantauan fungsi organ secara berkala, serta intervensi rehabilitatif yang diperlukan. Pengelolaan komplikasi neurologis kronis, misalnya, memerlukan perawat untuk memberikan dukungan emosional, edukasi mengenai pentingnya rehabilitasi fisik atau terapi okupasi, serta koordinasi perawatan multidisiplin yang melibatkan dokter spesialis neurologi, fisioterapis, maupun psikolog klinis.

Secara khusus pada komplikasi akibat gigitan hewan berbisa, manajemen keperawatan meliputi pemantauan tanda-tanda sistemik seperti tanda perdarahan, perubahan neurologis, maupun gejala gangguan kardiovaskular. Perawat juga bertanggung jawab dalam memfasilitasi pemberian antivenom secara tepat dan aman, serta melakukan pemantauan ketat terhadap kemungkinan reaksi alergi atau efek samping yang ditimbulkan oleh antivenom.

Selain intervensi klinis, perawat juga perlu memberikan dukungan psikososial kepada pasien dan keluarga yang mengalami komplikasi serius, karena situasi tersebut sering kali menimbulkan kecemasan, ketakutan, bahkan trauma psikologis. Oleh karena itu, perawat harus menggunakan komunikasi terapeutik, memberikan informasi yang jelas dan empati mengenai kondisi pasien serta prognosisnya, serta melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan lanjutan.

Dengan pendekatan manajemen komplikasi yang komprehensif, holistik, dan proaktif, perawat berperan sentral dalam memastikan keselamatan pasien, mempercepat proses pemulihan, serta meminimalkan risiko komplikasi serius yang dapat mengganggu kualitas hidup pasien secara signifikan dalam jangka panjang.

F. Pencegahan dan Pengendalian Keracunan serta Gigitan Hewan Berbisa

Pencegahan dan pengendalian kasus keracunan serta gigitan hewan berbisa merupakan langkah penting yang harus diperhatikan oleh semua pihak, baik masyarakat maupun petugas kesehatan, guna menekan angka kejadian serta mengurangi dampak buruk yang mungkin terjadi. Strategi pencegahan ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan rumah tangga, tempat kerja, hingga lingkungan komunitas secara luas. Upaya ini memerlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat, edukasi yang efektif, serta promosi kesehatan yang kontinu agar dapat memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Pencegahan keracunan di lingkungan rumah tangga dan tempat kerja menjadi aspek vital karena sebagian besar kasus keracunan yang terjadi bersumber dari bahan-bahan atau zat kimia yang sering dijumpai di lingkungan sehari-hari. Di rumah tangga, bahan-bahan berbahaya seperti produk pembersih, deterjen, obat-obatan, pestisida rumah tangga, dan bahan-bahan kimia lain sering disimpan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan, terutama pada anak-anak dan lansia yang kurang waspada atau memiliki keterbatasan dalam mengenali bahaya zat tersebut. Oleh karena itu, penyimpanan bahan kimia di rumah harus dilakukan dengan hati-hati dalam wadah asli yang tertutup rapat, diberi label yang jelas, serta disimpan di tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak atau individu yang rentan. Orang tua atau pengasuh perlu mendapatkan edukasi yang cukup tentang pentingnya mengunci atau mengamankan tempat penyimpanan bahan beracun tersebut untuk mencegah paparan yang tidak disengaja.

Di lingkungan tempat kerja, terutama di industri yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya seperti pabrik pestisida, laboratorium, atau industri kimia lainnya, pencegahan keracunan harus dilakukan melalui implementasi standar keselamatan kerja yang ketat. Langkah ini mencakup penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, pakaian khusus, dan pelindung mata yang sesuai dengan jenis bahan kimia yang digunakan. Selain itu, pengawasan rutin, pelatihan karyawan mengenai penggunaan bahan kimia yang aman, serta adanya prosedur penanganan bahan kimia secara benar sangat diperlukan. Fasilitas kerja juga harus dilengkapi dengan sistem ventilasi yang memadai untuk mengurangi risiko paparan kronis, serta tersedia perlengkapan pertolongan pertama seperti pancuran darurat atau eye-wash station yang mudah diakses jika terjadi paparan atau kontaminasi bahan kimia secara tidak sengaja.

Sementara itu, pencegahan gigitan hewan berbisa di komunitas juga memegang peranan penting dalam upaya mengurangi insiden serta dampak buruk dari gigitan yang dapat berakibat fatal. Pencegahan ini melibatkan upaya kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi habitat yang menjadi tempat berkembang biak hewan-hewan berbisa seperti ular, kalajengking, atau laba-laba. Langkah praktis yang dapat dilakukan antara lain membersihkan tumpukan barang bekas atau sampah yang dapat menjadi tempat persembunyian hewan-hewan tersebut, menjaga kebersihan pekarangan rumah, memangkas rumput secara rutin, serta memperbaiki kondisi rumah agar tertutup rapat dan tidak mudah dimasuki oleh hewan berbisa. Selain itu, penggunaan alas kaki tertutup, terutama saat beraktivitas di kebun, hutan, atau area yang berpotensi menjadi tempat hidup hewan berbisa, menjadi upaya sederhana yang sangat efektif dalam menghindari gigitan.

Dalam konteks yang lebih luas, komunitas harus didukung oleh program edukasi dan penyuluhan tentang identifikasi hewan berbisa yang umum ditemukan di sekitar lingkungan mereka, serta cara-cara yang benar dalam menghadapi hewan-hewan tersebut jika ditemukan. Penyuluhan juga harus mencakup informasi yang jelas tentang pertolongan pertama yang tepat jika seseorang terkena gigitan, serta langkah-langkah yang harus segera diambil seperti imobilisasi area gigitan, cara transportasi yang aman ke fasilitas kesehatan, dan pentingnya menghindari tindakan yang keliru seperti menyayat luka atau menghisap racun secara manual yang justru dapat memperparah kondisi.

Strategi pendidikan dan promosi kesehatan untuk masyarakat merupakan elemen kunci dalam upaya pencegahan dan pengendalian keracunan serta gigitan hewan berbisa secara efektif. Program edukasi ini harus dilakukan secara rutin dan sistematis melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat luas, seperti

poster, brosur, media sosial, televisi, atau penyuluhan langsung oleh tenaga kesehatan di komunitas. Pesan-pesan edukasi yang disampaikan harus bersifat praktis, jelas, dan mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia.

Selain itu, peran tenaga kesehatan, khususnya perawat dan petugas promosi kesehatan, sangat penting dalam menyusun materi edukasi yang relevan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Materi edukasi hendaknya mencakup informasi tentang jenis-jenis bahan kimia berbahaya yang sering ditemukan di lingkungan sehari-hari, tanda-tanda dan gejala awal keracunan, langkah-langkah pertolongan pertama yang benar, serta pentingnya segera mencari pertolongan medis jika terjadi paparan zat beracun atau gigitan hewan berbisa. Dalam hal ini, kolaborasi antara tenaga kesehatan, pemimpin komunitas, dan institusi pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya keracunan dan gigitan hewan berbisa.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas strategi ini, pendekatan partisipatif sangat dianjurkan, yaitu dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan edukasi dan promosi kesehatan. Misalnya, melalui pelatihan atau simulasi pertolongan pertama pada kasus keracunan atau gigitan hewan berbisa, masyarakat dapat memperoleh keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Program seperti ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, tetapi juga memberdayakan mereka untuk dapat bertindak secara mandiri dan cepat jika menghadapi situasi darurat yang berhubungan dengan keracunan atau gigitan hewan berbisa.

Secara keseluruhan, pencegahan dan pengendalian keracunan serta gigitan hewan berbisa memerlukan pendekatan yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan, yang melibatkan semua pihak terkait. Dengan kombinasi antara upaya preventif di lingkungan rumah tangga dan tempat kerja, pencegahan gigitan hewan berbisa melalui pengelolaan lingkungan yang baik, serta edukasi yang tepat dan promosi kesehatan yang efektif, diharapkan dapat menurunkan secara signifikan angka kejadian dan dampak buruk dari kasus-kasus keracunan dan gigitan hewan berbisa di masyarakat.

G. Simpulan

Keracunan dan gigitan hewan berbisa merupakan kondisi medis emergensi yang signifikan dengan tingkat morbiditas dan mortalitas tinggi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah agraris di Indonesia. Kedua kondisi ini membutuhkan perhatian khusus dari tenaga medis dan perawat karena sifatnya yang cepat progresif serta berpotensi mengakibatkan komplikasi serius baik akut maupun

kronis. Keracunan akut sering disebabkan oleh paparan zat kimia berbahaya seperti pestisida, bahan kimia rumah tangga, dan obat-obatan, sedangkan gigitan hewan berbisa umumnya disebabkan oleh ular, kalajengking, dan laba-laba yang memiliki toksin berbahaya seperti neurotoksin, hemotoksin, dan sitotoksin.

Penatalaksanaan yang tepat melibatkan pendekatan sistematis dimulai dari penilaian cepat dan akurat terhadap kondisi pasien menggunakan prinsip ABCDE, diikuti oleh intervensi khusus seperti dekontaminasi, pemberian antidotum atau antivenom, serta terapi suportif lainnya. Peran perawat menjadi sangat penting dalam proses ini, meliputi pengkajian keperawatan yang komprehensif, penentuan diagnosis dan prioritas masalah keperawatan, serta implementasi intervensi keperawatan yang mencakup aspek biologis, psikologis, dan sosial pasien. Pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan dan penanganan awal merupakan bagian integral dalam asuhan keperawatan untuk mengurangi risiko terulangnya insiden serupa.

Komplikasi akibat keracunan maupun gigitan hewan berbisa, baik akut maupun kronis, juga harus diperhatikan secara serius. Komplikasi ini bisa melibatkan berbagai sistem tubuh, mulai dari gangguan pernapasan, neurologis, hingga kardiovaskular yang dapat berakibat fatal jika tidak dikelola dengan segera dan tepat. Manajemen komplikasi memerlukan pemantauan ketat, intervensi dini, serta koordinasi antar tim kesehatan yang baik.

Upaya pencegahan dan pengendalian keracunan serta gigitan hewan berbisa juga memegang peranan penting dalam menekan angka kejadian dan dampaknya. Strategi ini meliputi pengamanan zat-zat berbahaya di lingkungan rumah tangga dan tempat kerja, pengelolaan lingkungan komunitas agar terbebas dari habitat hewan berbisa, serta edukasi dan promosi kesehatan yang sistematis dan berkelanjutan kepada masyarakat luas. Dengan pendekatan preventif dan edukatif yang efektif, diharapkan kasus keracunan dan gigitan hewan berbisa di Indonesia dapat dikurangi secara signifikan, sehingga kualitas hidup masyarakat meningkat secara keseluruhan.

H. Referensi

- Alirol, E., Sharma, S. K., Bawaskar, H. S., Kuch, U., & Chappuis, F. (2017). Snake bite in South Asia: A review. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, 11(6), e0005601. <https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0005601>
- Alzahrani, S. H., Ibrahim, N. K., Elnour, M. A., Alqahtani, A. H., & Fiveash, J. B. (2022). Epidemiology, clinical features, and outcomes of acute poisoning cases: A global update. *Clinical Toxicology*, 60(4), 205–217.

<https://doi.org/10.1080/15563650.2021.1945931>

- Gutiérrez, J. M., Calvete, J. J., Habib, A. G., Harrison, R. A., & Williams, D. J. (2017). Snakebite envenoming. *Nature Reviews Disease Primers*, 3, 17063. <https://doi.org/10.1038/nrdp.2017.63>
- Hendrickson, R. G. (2019). Acute management of poisoning and drug overdose. *Journal of Medical Toxicology*, 15(2), 89–96. <https://doi.org/10.1007/s13181-019-00703-8>
- Hoffman, R. S., Howland, M. A., Lewin, N. A., Nelson, L. S., & Goldfrank, L. R. (2019). *Goldfrank's Toxicologic Emergencies* (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hulse, E. J., Davies, J. O. J., Simpson, A. J., Sciuto, A. M., & Eddleston, M. (2019). Organophosphorus nerve agent poisoning: Management and therapeutic strategies. *Lancet*, 394(10206), 2304–2313. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(19\)32967-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32967-5)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Laporan Nasional Keracunan dan Gigitan Hewan Berbisa Tahun 2021. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Lee, H. J., Lee, D. H., Lee, J. H., Kim, S. C., & Kim, J. S. (2021). Clinical characteristics and outcomes of household chemical poisoning: A multicenter retrospective study. *BMC Emergency Medicine*, 21(1), 45. <https://doi.org/10.1186/s12873-021-00432-7>
- Warrell, D. A. (2021). Venomous bites and stings: Clinical management. In P. Wexler (Ed.), *Encyclopedia of Toxicology* (4th ed., pp. 820–829). Elsevier Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-386454-3.00711-4>
- World Health Organization. (2021). Snakebite envenoming: A strategy for prevention and control. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/handle/10665/324838>.

I. Glosarium

ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure): Pendekatan sistematis dalam penanganan pasien kegawatdaruratan dengan memastikan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, tingkat kesadaran, dan pemeriksaan tubuh menyeluruh.

Absorpsi: Proses penyerapan zat dari permukaan tubuh atau membran menuju aliran darah.

Aktivitas agraris: Aktivitas pertanian atau berkaitan dengan bidang pertanian.

Anafilaksis: Reaksi alergi berat yang berpotensi mengancam nyawa, ditandai dengan gangguan pernapasan, penurunan tekanan darah, hingga kehilangan kesadaran.

Analgesik: Obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan nyeri.

Antidotum: Zat atau obat penawar yang digunakan untuk mengatasi efek racun tertentu.

Antivenom: Serum atau antibodi khusus yang digunakan untuk menetralisir racun (venom) dari gigitan atau sengatan hewan berbisa.

Bradikardia: Kondisi medis di mana detak jantung lebih lambat dari normal (kurang dari 60 kali per menit).

Dekontaminasi: Prosedur untuk menghilangkan atau mengurangi zat racun dari tubuh pasien untuk mencegah absorpsi lebih lanjut.

Depresi respirasi: Kondisi penurunan fungsi pernapasan akibat efek toksik atau obat tertentu.

Edema: Pembengkakan jaringan akibat penumpukan cairan di area tubuh tertentu.

Efek toksik: Efek berbahaya yang ditimbulkan oleh racun terhadap tubuh.

Enzim asetilkolinesterase: Enzim yang berperan dalam penghentian aktivitas neurotransmitter asetilkolin di sistem saraf.

Hemodinamik: Kondisi atau keadaan sirkulasi darah dalam tubuh.

Hemotoksin: Zat racun yang menyerang darah atau komponen-komponen pembekuan darah.

Hipersalivasi: Produksi air liur yang berlebihan, sering terjadi pada keracunan zat kolinergik seperti organofosfat.

Hipoksia: Kondisi kurangnya suplai oksigen di jaringan tubuh.

Imobilisasi: Tindakan membatasi gerakan bagian tubuh tertentu untuk mencegah penyebaran racun atau cedera tambahan.

Inhalasi: Proses masuknya zat ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan.

Kardiotoksin: Zat toksik yang memiliki efek merusak terhadap otot jantung.

Kelumpuhan: Kondisi hilangnya kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh tertentu akibat gangguan pada sistem saraf atau otot.

Keracunan akut: Kondisi klinis yang terjadi akibat paparan zat beracun secara tiba-tiba dengan gejala yang berkembang cepat.

Keracunan kronis: Kondisi klinis yang terjadi akibat paparan zat beracun secara terus-menerus dalam jangka waktu lama.

Koagulopati: Gangguan dalam sistem pembekuan darah yang menyebabkan perdarahan abnormal.

Morbiditas: Angka kesakitan atau jumlah individu yang sakit akibat kondisi tertentu.

Mortalitas: Angka kematian atau jumlah individu yang meninggal akibat kondisi tertentu.

Mukosa gastrointestinal: Lapisan dalam saluran pencernaan yang dapat teriritasi atau rusak akibat paparan zat toksik.

Nekrosis jaringan: Kematian jaringan tubuh akibat gangguan aliran darah atau paparan zat beracun.

Neurotoksin: Zat toksik yang menyerang sistem saraf, menyebabkan gangguan neurologis.

Onset: Waktu yang dibutuhkan sejak paparan hingga munculnya gejala penyakit atau keracunan.

Parenteral: Rute pemberian zat melalui suntikan intravena, intramuskular, atau subkutan, bukan melalui saluran pencernaan.

Perfusi jaringan: Proses suplai darah dan oksigen ke jaringan tubuh.

Pestisida: Zat kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh organisme pengganggu, seperti hama tanaman.

Pralidoksim: Antidotum spesifik yang digunakan dalam terapi keracunan pestisida golongan organofosfat.

Profilaksis tetanus: Pencegahan terhadap infeksi tetanus dengan pemberian vaksin atau antitoksin setelah terjadi luka.

Racun biologis: Zat toksik yang berasal dari organisme hidup, seperti bakteri, tumbuhan, atau hewan.

Sianosis: Kondisi kulit kebiruan akibat kekurangan oksigen di jaringan tubuh.

Sitotoksin: Zat toksik yang menyebabkan kerusakan atau kematian sel secara langsung.

Syok hemoragik: Kondisi syok akibat kehilangan darah dalam jumlah besar yang menyebabkan penurunan drastis tekanan darah.

Terapi suportif: Penanganan medis yang bertujuan mempertahankan fungsi vital tubuh, seperti pemberian cairan, oksigenasi, atau analgesik.

Toksin: Zat yang bersifat racun, dapat menyebabkan cedera atau kerusakan tubuh.

Trombositosis: Peningkatan jumlah trombosit dalam darah secara abnormal.

Venom: Racun biologis yang diproduksi oleh hewan berbisa dan disuntikkan melalui gigitan atau sengatan.

CHAPTER 9

KOMUNIKASI TERAPEUTIK DALAM PELAYANAN GAWAT DARURAT

drg. Ika Ifitri, MDSc.

A. Pendahuluan/Prolog

Pelayanan gawat darurat merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik unik karena sifatnya yang menuntut respons cepat, tepat, dan efisien dalam situasi yang penuh tekanan. Situasi gawat darurat sering kali ditandai dengan ketidakpastian, stres tinggi, serta tingkat kecemasan yang meningkat baik dari sisi pasien, keluarga pasien, maupun tenaga kesehatan yang terlibat. Dalam konteks ini, komunikasi terapeutik memainkan peranan yang sangat krusial dalam mendukung terciptanya pelayanan yang optimal serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien.

Komunikasi terapeutik adalah proses komunikasi interpersonal yang dilakukan secara sengaja oleh tenaga kesehatan dengan tujuan khusus untuk membantu pasien mengatasi masalah kesehatannya, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Berbeda dengan komunikasi biasa, komunikasi terapeutik dalam kondisi gawat darurat memerlukan sensitivitas khusus dan keterampilan tinggi dari tenaga kesehatan agar pesan dapat tersampaikan secara jelas, efektif, serta mampu menenangkan pasien maupun keluarga yang sedang mengalami situasi krisis.

Dalam situasi gawat darurat, konsep dasar komunikasi terapeutik mencakup kemampuan tenaga kesehatan untuk menyampaikan informasi secara ringkas, jelas, dan empatik. Komunikasi ini harus memperhatikan kondisi pasien yang mungkin mengalami gangguan kesadaran, nyeri hebat, atau kecemasan ekstrem, sehingga pesan yang disampaikan tidak hanya dapat dimengerti secara kognitif, namun juga memberikan dukungan emosional yang diperlukan pada saat itu. Komunikasi terapeutik juga melibatkan keterampilan mendengarkan aktif, di mana tenaga kesehatan secara aktif menunjukkan perhatian terhadap perasaan dan kebutuhan pasien, serta memberikan respons yang sesuai dan menenangkan.

Selain itu, dalam situasi darurat, komunikasi terapeutik juga melibatkan elemen-elemen nonverbal yang sangat penting. Bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, serta intonasi suara tenaga kesehatan mampu memberikan dampak signifikan terhadap perasaan aman, percaya, dan tenang pada pasien dan keluarganya. Sebagai contoh, kontak mata yang hangat dan penuh perhatian,

sentuhan lembut di tangan atau bahu, serta suara yang tenang dan tegas dapat sangat membantu meredakan rasa takut dan panik yang umumnya dialami oleh pasien maupun keluarganya saat berada dalam situasi kritis.

Pentingnya komunikasi terapeutik dalam pelayanan gawat darurat tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak besar terhadap proses penyembuhan dan hasil akhir yang diperoleh pasien. Komunikasi yang efektif mampu membantu pasien memahami kondisinya, menerima tindakan medis yang diperlukan dengan lebih tenang, serta meminimalkan kemungkinan terjadinya penolakan atau resistensi terhadap prosedur medis tertentu. Selain itu, komunikasi yang baik juga sangat penting untuk membangun rasa percaya antara pasien dan tenaga kesehatan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kerjasama dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan yang diberikan.

Bagi keluarga pasien, komunikasi terapeutik juga memiliki arti yang sangat penting. Dalam kondisi krisis, keluarga pasien sering kali mengalami kecemasan, stres, ketidakberdayaan, bahkan perasaan panik. Mereka memerlukan informasi yang jelas, akurat, serta dukungan emosional dari tenaga kesehatan. Komunikasi terapeutik yang efektif membantu keluarga pasien untuk memahami situasi yang sedang terjadi, mengetahui langkah-langkah medis yang akan dilakukan, serta mengetahui apa yang dapat mereka lakukan untuk mendukung proses perawatan pasien. Selain itu, pendekatan komunikasi yang empatik dan suportif juga membantu mengurangi rasa cemas dan ketidakpastian, sekaligus membangun rasa percaya diri keluarga dalam menghadapi situasi darurat tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, komunikasi terapeutik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan di unit gawat darurat secara keseluruhan. Ketika tenaga kesehatan mampu berkomunikasi secara terapeutik dengan baik, maka hubungan antar tim medis akan menjadi lebih baik pula. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang positif, kolaboratif, dan lebih terkoordinasi, sehingga risiko kesalahan atau miskomunikasi yang dapat membahayakan keselamatan pasien dapat diminimalkan.

Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan konsep komunikasi terapeutik secara mendalam merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh semua tenaga kesehatan, terutama yang bertugas di unit gawat darurat. Penguasaan ini tidak hanya penting dalam upaya menyelamatkan nyawa pasien secara fisik, namun juga dalam memastikan pasien dan keluarga merasa didukung secara emosional dan psikologis sepanjang proses penanganan kegawatdaruratan berlangsung.

B. Prinsip-Prinsip Dasar Komunikasi Terapeutik dalam Pelayanan Gawat Darurat

Komunikasi terapeutik dalam pelayanan gawat darurat bukan sekadar cara tenaga kesehatan menyampaikan informasi kepada pasien atau keluarganya, tetapi juga merupakan proses komunikasi interpersonal yang bertujuan mendukung pemulihan pasien secara fisik dan emosional di tengah situasi yang kritis. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan secara konsisten oleh tenaga kesehatan, meliputi empati dan dukungan emosional, keterampilan mendengarkan aktif dan responsif, serta komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif.

Salah satu prinsip mendasar dalam komunikasi terapeutik adalah empati dan dukungan emosional dalam kondisi gawat darurat. Empati dalam konteks ini berarti kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami secara mendalam perasaan dan pengalaman pasien yang sedang berada dalam kondisi yang mengancam jiwa, serta mampu merasakan kecemasan, ketakutan, atau rasa sakit yang sedang dialami pasien. Tenaga kesehatan perlu menunjukkan empati ini secara tulus, bukan hanya sebagai formalitas dalam pelayanan kesehatan. Dengan empati yang tulus, tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan pasien, yang sering kali merasa tidak berdaya dalam kondisi darurat.

Pentingnya empati dalam situasi darurat juga terkait erat dengan kondisi psikologis pasien dan keluarga yang sangat rentan. Pasien yang datang ke unit gawat darurat biasanya menghadapi berbagai ketidakpastian mengenai kondisi kesehatannya. Oleh karena itu, pendekatan yang empatik dari tenaga kesehatan akan sangat membantu dalam menenangkan pasien, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan rasa percaya pasien terhadap tenaga kesehatan yang menanganinya. Misalnya, perawat atau dokter yang secara lembut mengatakan, "Saya memahami ini adalah situasi yang sulit bagi Anda. Kami akan melakukan segala hal yang terbaik untuk membantu Anda melewati kondisi ini," dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan dibandingkan hanya memberikan penjelasan medis tanpa sentuhan empati.

Prinsip berikutnya dalam komunikasi terapeutik di ruang gawat darurat adalah keterampilan mendengarkan aktif dan responsif. Mendengarkan aktif merupakan sebuah keterampilan komunikasi yang melibatkan perhatian penuh dari tenaga kesehatan terhadap segala bentuk ekspresi pasien atau keluarganya, baik verbal maupun nonverbal. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk menunjukkan ketertarikan secara nyata terhadap apa yang dikatakan pasien, dengan memberikan tanggapan yang relevan dan menunjukkan bahwa pesan tersebut dipahami dengan baik.

Dalam mendengarkan aktif, tenaga kesehatan tidak hanya mendengar secara pasif, tetapi aktif mengklarifikasi informasi, memvalidasi perasaan pasien, serta memberikan umpan balik yang membantu pasien merasa didengar dan dipahami. Misalnya, ketika pasien mengungkapkan rasa takut atau cemas, tenaga kesehatan dapat merespons dengan mengatakan, "Saya mengerti bahwa Anda merasa sangat cemas saat ini, dan itu sangat wajar dalam situasi seperti ini. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut tentang apa yang paling Anda khawatirkan?" Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan benar-benar hadir secara emosional dan siap untuk memberikan dukungan secara konkret.

Lebih lanjut, mendengarkan responsif berarti tenaga kesehatan mampu dengan cepat menangkap kebutuhan atau pertanyaan pasien dan segera memberikan respons yang sesuai. Dalam situasi darurat, pasien sering kali mengalami kondisi emosional yang berubah-ubah secara cepat, sehingga kecepatan dan ketepatan respons tenaga kesehatan menjadi faktor penting yang dapat menenangkan dan membuat pasien merasa lebih aman. Keterampilan mendengarkan aktif dan responsif tidak hanya membantu pasien, tetapi juga membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi kondisi emosional pasien dengan lebih baik, sehingga dapat menentukan intervensi yang paling tepat pada saat itu.

Prinsip ketiga dalam komunikasi terapeutik adalah komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif. Komunikasi verbal dalam situasi darurat perlu dilakukan dengan jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh pasien dan keluarga. Pasien yang berada dalam kondisi kritis atau mengalami nyeri hebat mungkin tidak mampu sepenuhnya memahami informasi yang kompleks atau penjelasan medis yang rumit. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu menyampaikan informasi dengan bahasa sederhana, jelas, namun tetap informatif dan menenangkan. Pemilihan kata-kata yang tepat, kalimat singkat, serta pengulangan informasi penting secara perlahan dan tenang sangat diperlukan untuk memastikan pasien memahami situasinya secara akurat.

Sementara itu, komunikasi nonverbal juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan. Bahasa tubuh tenaga kesehatan seperti ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, serta kontak mata mampu memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Dalam situasi darurat, ekspresi wajah yang tenang, kontak mata yang penuh perhatian, serta gerakan tubuh yang menunjukkan kesiapan membantu, akan membuat pasien merasa lebih tenang dan terlindungi. Sebaliknya, ekspresi wajah yang tegang, nada suara yang tinggi atau tergesa-gesa, dan gerakan tubuh yang tidak terkontrol dapat meningkatkan kecemasan dan ketidakpastian pasien.

Sebagai contoh, tenaga kesehatan yang secara verbal mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, namun secara nonverbal terlihat panik atau terburu-buru, akan menciptakan kebingungan dan kecemasan yang lebih besar pada pasien. Oleh karena itu, konsistensi antara komunikasi verbal dan nonverbal sangat penting dalam konteks terapeutik. Suara yang lembut namun tegas, senyum kecil yang menenangkan, dan sentuhan ringan seperti menepuk tangan pasien secara perlahan juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang efektif dalam memberikan rasa nyaman dan aman.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip dasar komunikasi terapeutik berupa empati, dukungan emosional, keterampilan mendengarkan aktif dan responsif, serta komunikasi verbal dan nonverbal yang efektif, merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di unit gawat darurat. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berkontribusi pada penanganan medis yang lebih baik secara klinis, namun juga secara emosional dan psikologis, sehingga pasien merasa aman, nyaman, dan terdukung dalam situasi kritis yang mereka hadapi. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik ini menjadi kompetensi esensial yang harus dikuasai oleh semua tenaga kesehatan dalam pelayanan gawat darurat.

C. Tantangan Komunikasi dalam Situasi Gawat Darurat

Komunikasi dalam situasi gawat darurat merupakan aspek yang sangat penting namun juga kompleks, karena melibatkan berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien maupun keluarganya. Tantangan-tantangan ini mencakup hambatan psikologis dan emosional pasien, tekanan waktu yang tinggi akibat kondisi kritis pasien, serta hambatan lingkungan yang khas terjadi di ruang gawat darurat.

Hambatan pertama yang sangat sering ditemukan dalam komunikasi di ruang gawat darurat adalah hambatan psikologis dan emosional pasien. Pasien yang datang ke unit gawat darurat biasanya sedang mengalami tekanan emosional yang sangat tinggi akibat kondisi medis yang tidak terduga dan mengancam keselamatan jiwanya. Kondisi ini menciptakan berbagai reaksi psikologis seperti rasa takut, panik, kecemasan berlebih, kebingungan, hingga rasa marah dan frustrasi. Emosi-emosi yang sangat kuat tersebut seringkali menyebabkan pasien tidak mampu menyampaikan keluhannya secara jelas atau bahkan kesulitan memahami informasi penting yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Dalam kondisi seperti ini, tenaga kesehatan menghadapi kesulitan untuk melakukan komunikasi yang efektif karena pasien sulit diajak bicara secara rasional. Misalnya, pasien yang mengalami kecelakaan parah atau tiba-tiba mengalami

serangan jantung mungkin merasa panik dan tidak fokus sehingga tidak mampu menjawab pertanyaan secara akurat atau memahami instruksi yang diberikan. Selain itu, anggota keluarga pasien yang ikut menemani pasien ke ruang gawat darurat juga bisa berada dalam kondisi psikologis yang sama, bahkan kadang justru menambah tekanan psikologis terhadap tenaga kesehatan karena tuntutan dan harapan yang tinggi. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus memiliki keterampilan khusus untuk menenangkan pasien dan keluarganya, menggunakan pendekatan komunikasi yang penuh empati dan sabar, serta mampu mengelola emosinya sendiri agar tetap tenang di tengah situasi yang emosional.

Tantangan kedua dalam komunikasi terapeutik di ruang gawat darurat adalah tekanan waktu dan kondisi krisis yang sering kali terjadi secara bersamaan. Dalam situasi gawat darurat, setiap detik yang berlalu sangat berarti karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup pasien. Tekanan waktu yang tinggi ini memaksa tenaga kesehatan untuk mengambil keputusan dan bertindak secara cepat, efektif, dan efisien. Dalam kondisi ini, komunikasi sering kali harus dilakukan secara singkat, jelas, namun tetap mampu memberikan informasi penting dan menenangkan pasien.

Tekanan waktu ini sering kali membuat tenaga kesehatan harus berkomunikasi dalam situasi yang terburu-buru, sehingga risiko terjadinya kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap menjadi sangat tinggi. Kondisi ini diperparah ketika pasien tidak mampu menjelaskan kondisinya secara jelas akibat rasa sakit yang hebat atau penurunan kesadaran. Misalnya, tenaga medis mungkin hanya memiliki waktu beberapa menit atau bahkan detik untuk menjelaskan tindakan medis seperti intubasi, pemasangan infus, atau resusitasi, yang terkadang membuat pasien atau keluarganya merasa bingung atau cemas karena tidak cukup waktu untuk memahami sepenuhnya prosedur tersebut. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik dalam menyampaikan informasi secara padat namun mudah dipahami, serta mampu dengan cepat menangkap pesan verbal maupun nonverbal dari pasien dalam waktu singkat.

Tantangan ketiga dalam komunikasi di ruang gawat darurat adalah adanya hambatan lingkungan yang sangat khas terjadi di lingkungan tersebut. Lingkungan fisik di unit gawat darurat umumnya sibuk, penuh aktivitas, dan bising akibat suara alat medis, monitor pasien, panggilan darurat, serta berbagai aktivitas lainnya yang berlangsung secara bersamaan. Kebisingan ini sering kali menjadi penghalang besar dalam proses komunikasi verbal antara tenaga kesehatan dengan pasien maupun antar tenaga kesehatan itu sendiri.

Selain kebisingan, kondisi fisik ruang gawat darurat yang biasanya penuh sesak oleh pasien, keluarga, maupun petugas medis lain juga menciptakan situasi yang

tidak kondusif untuk melakukan komunikasi secara tenang dan jelas. Pasien sering kali tidak memiliki ruang privasi yang cukup, sehingga komunikasi tentang kondisi medis yang bersifat sensitif harus dilakukan dalam situasi terbuka yang dapat menambah kecemasan dan ketidaknyamanan pasien maupun keluarga. Di sisi lain, terbatasnya waktu dan tempat sering kali menyebabkan komunikasi dilakukan sambil lalu atau terburu-buru, yang dapat mengurangi efektivitas pesan yang disampaikan.

Misalnya, ketika tenaga kesehatan menjelaskan kondisi kritis pasien kepada keluarganya di tengah keramaian dan kebisingan ruangan, keluarga pasien mungkin tidak bisa mendengar dengan jelas atau bahkan keliru menangkap informasi yang penting. Dalam situasi ini, tenaga kesehatan dituntut mampu berkomunikasi secara lebih jelas, dengan volume suara yang memadai, menggunakan kalimat yang singkat namun informatif, serta didukung oleh bahasa tubuh yang jelas dan tenang agar pesan dapat diterima dengan tepat oleh pasien maupun keluarga.

Keseluruhan tantangan tersebut memperlihatkan bahwa komunikasi terapeutik dalam situasi gawat darurat merupakan keterampilan yang kompleks, memerlukan pelatihan khusus, serta kemampuan untuk beradaptasi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang terus berubah. Tenaga kesehatan tidak hanya harus mampu mengatasi hambatan psikologis dan emosional pasien yang sedang dalam kondisi sangat rentan, tetapi juga harus mampu berkomunikasi dengan efektif meskipun menghadapi tekanan waktu yang tinggi dan lingkungan yang penuh hambatan. Dengan pemahaman mendalam tentang berbagai tantangan komunikasi ini, tenaga kesehatan dapat lebih siap dalam memberikan pelayanan gawat darurat yang tidak hanya cepat dan akurat secara klinis, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat diperlukan oleh pasien dan keluarganya dalam menghadapi situasi yang kritis.

D. Strategi Efektif dalam Komunikasi Terapeutik di Unit Gawat Darurat

Dalam unit gawat darurat, komunikasi terapeutik yang efektif menjadi salah satu kunci utama untuk memastikan keselamatan pasien sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Kondisi kritis yang menuntut tindakan cepat, akurat, dan terkoordinasi memerlukan strategi komunikasi yang tepat guna meminimalkan risiko kesalahan atau kesalahpahaman. Beberapa strategi utama yang terbukti efektif dalam meningkatkan komunikasi terapeutik di ruang gawat darurat adalah penggunaan teknik komunikasi yang singkat, jelas, dan tegas (clear and concise communication), kemampuan manajemen krisis melalui komunikasi persuasif, serta penerapan pendekatan multidisiplin dalam komunikasi tim gawat darurat.

Strategi pertama yang sangat penting untuk diterapkan dalam situasi gawat darurat adalah teknik komunikasi singkat, jelas, dan tegas (clear and concise communication). Dalam situasi gawat darurat, kondisi klinis pasien yang tidak stabil menuntut tenaga kesehatan untuk bergerak cepat dan mengambil keputusan secara tepat dalam hitungan detik atau menit. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, padat, serta mudah dipahami oleh pasien, keluarga pasien, dan sesama tenaga kesehatan. Komunikasi ini meliputi penjelasan mengenai kondisi pasien, tindakan medis yang akan dilakukan, serta informasi penting yang perlu segera dipahami oleh pihak keluarga.

Teknik komunikasi yang jelas dan singkat ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menggunakan terminologi medis yang sulit dimengerti, serta disampaikan dengan intonasi dan artikulasi yang tegas agar mudah ditangkap oleh penerima pesan. Misalnya, ketika dokter atau perawat menjelaskan kepada keluarga pasien tentang kondisi kritis pasien yang memerlukan tindakan intubasi segera, maka penjelasan harus disampaikan secara ringkas namun informatif, seperti "Pasien mengalami gagal napas, kami akan segera memasang alat bantu pernapasan untuk menyelamatkan nyawanya." Dengan demikian, keluarga tidak kebingungan dan langsung memahami urgensi tindakan medis yang akan dilakukan. Penggunaan teknik komunikasi ini sangat penting untuk mengurangi waktu yang terbuang serta mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memperlambat penanganan pasien.

Strategi kedua yang perlu diterapkan di unit gawat darurat adalah manajemen krisis melalui komunikasi persuasif. Dalam situasi darurat, pasien maupun keluarganya sering kali mengalami kecemasan, ketakutan, atau bahkan kepanikan yang dapat memperburuk situasi dan menghambat pemberian tindakan medis yang diperlukan. Untuk menghadapi kondisi ini, tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan khusus dalam melakukan komunikasi persuasif yang mampu meyakinkan pasien atau keluarganya untuk menerima tindakan medis dengan tenang dan kooperatif.

Komunikasi persuasif dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang empatik, membangun kepercayaan, dan menunjukkan kompetensi profesional. Misalnya, ketika seorang pasien takut menerima tindakan pemasangan infus atau pasien merasa panik saat mengalami serangan jantung, tenaga kesehatan harus mampu menyampaikan pesan dengan nada suara yang tenang namun penuh keyakinan, disertai kalimat persuasif seperti, "Kami akan membantu Anda, kami sudah sering menangani situasi ini, percayakan pada kami, Anda akan segera merasa lebih baik." Dalam proses ini, tenaga kesehatan juga harus mampu membaca emosi pasien dengan cepat dan menyesuaikan komunikasi verbal maupun nonverbalnya

agar pasien merasa aman dan percaya terhadap tindakan medis yang diberikan. Kemampuan komunikasi persuasif ini sangat penting karena tidak hanya membantu pasien menjadi lebih tenang, tetapi juga memudahkan tim medis untuk melakukan intervensi secara efektif tanpa hambatan.

Strategi ketiga yang juga tidak kalah penting dalam meningkatkan komunikasi terapeutik di unit gawat darurat adalah penerapan pendekatan multidisiplin dalam komunikasi tim gawat darurat. Ruang gawat darurat biasanya diisi oleh tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis gawat darurat, perawat, ahli anestesi, ahli bedah, teknisi medis, hingga petugas administrasi rumah sakit. Kerja sama dan komunikasi yang efektif antar anggota tim ini sangat penting untuk memastikan penanganan pasien berjalan secara cepat, terkoordinasi, dan tanpa kesalahan.

Pendekatan multidisiplin dalam komunikasi berarti setiap anggota tim harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan terbuka, sekaligus mendengarkan masukan dari anggota tim lain secara aktif dan saling menghargai peran masing-masing. Misalnya, dalam menangani pasien trauma akibat kecelakaan lalu lintas, tim medis harus secara aktif dan jelas mengomunikasikan kondisi pasien, prioritas tindakan medis, distribusi tugas masing-masing anggota, serta perkembangan klinis pasien secara berkala. Komunikasi tim yang efektif dapat didukung oleh berbagai metode seperti penggunaan sistem komunikasi standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) yang memungkinkan setiap anggota tim menyampaikan informasi secara sistematis dan efisien, sehingga risiko kesalahan bisa diminimalkan.

Selain itu, tim medis juga perlu membangun suasana komunikasi yang terbuka, di mana setiap anggota merasa nyaman untuk menyampaikan pendapat atau klarifikasi jika ada informasi yang kurang jelas atau dirasa kurang tepat. Misalnya, seorang perawat yang merasa ada langkah yang perlu diambil atau membutuhkan klarifikasi tambahan dari dokter dapat langsung bertanya atau mengonfirmasi tanpa rasa takut atau sungkan. Lingkungan komunikasi yang terbuka seperti ini akan meningkatkan keselamatan pasien, mempercepat respons medis, serta memperkecil kemungkinan miskomunikasi yang dapat membahayakan pasien.

Secara keseluruhan, komunikasi terapeutik yang efektif di unit gawat darurat tidak hanya sebatas bagaimana tenaga kesehatan berbicara atau memberikan instruksi, tetapi juga mencakup keterampilan khusus dalam menyampaikan informasi secara singkat dan jelas, kemampuan melakukan komunikasi persuasif untuk mengelola krisis, serta kesadaran untuk berkolaborasi secara efektif melalui pendekatan multidisiplin. Dengan menerapkan ketiga strategi komunikasi ini secara konsisten, pelayanan gawat darurat akan menjadi lebih efisien, aman, serta mampu

memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh pasien maupun keluarganya dalam menghadapi situasi yang kritis.

E. Implementasi Komunikasi Terapeutik dalam Kasus-Kasus Spesifik

Dalam pelayanan gawat darurat, kemampuan tenaga kesehatan dalam menerapkan komunikasi terapeutik secara tepat dan efektif menjadi sangat penting, khususnya dalam menghadapi berbagai kasus spesifik yang memiliki tantangan tersendiri. Kasus-kasus tersebut mencakup pasien dengan gangguan kesadaran, pasien yang mengalami nyeri hebat, serta keluarga pasien dalam kondisi kritis. Masing-masing kondisi ini memerlukan pendekatan komunikasi yang unik serta sensitivitas tinggi dari petugas medis untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan tujuan terapeutik dapat tercapai.

Salah satu kasus spesifik yang membutuhkan implementasi komunikasi terapeutik khusus adalah pada pasien dengan gangguan kesadaran. Pasien dengan gangguan kesadaran dapat berada dalam berbagai kondisi, mulai dari kesadaran yang menurun ringan hingga keadaan koma yang dalam. Meskipun pasien mungkin tidak sepenuhnya sadar atau merespons, komunikasi terapeutik tetap memiliki peranan penting dalam memberikan kenyamanan, rasa aman, serta stimulasi positif terhadap pasien. Dalam hal ini, tenaga kesehatan tetap dianjurkan untuk berbicara secara tenang dan lembut kepada pasien dengan asumsi bahwa pasien masih dapat mendengar atau merasakan rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Petugas kesehatan dapat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan sebelum melakukannya, misalnya, "Kami akan memasang infus di tangan Bapak untuk memberikan cairan, mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman tapi kami akan melakukannya secara perlahan dan hati-hati."

Selain komunikasi verbal yang jelas dan sederhana, komunikasi nonverbal juga sangat penting untuk dilakukan kepada pasien dengan gangguan kesadaran. Sentuhan lembut pada tangan atau bahu pasien, kontak mata saat berbicara, dan ekspresi wajah yang menenangkan dapat memberikan efek terapeutik yang signifikan, memberikan rasa aman kepada pasien serta menunjukkan bahwa dirinya berada dalam lingkungan yang mendukung. Studi menunjukkan bahwa pasien yang menerima komunikasi terapeutik meskipun dalam kondisi tidak sadar cenderung memiliki respons fisiologis positif, seperti denyut jantung yang lebih stabil dan menurunnya tingkat stres secara fisiologis.

Kasus spesifik lain yang menuntut kemampuan komunikasi terapeutik yang tinggi adalah pada pasien yang mengalami nyeri hebat. Nyeri yang hebat tidak hanya menjadi gangguan fisik yang signifikan bagi pasien tetapi juga menyebabkan beban psikologis yang besar seperti kecemasan, ketakutan, atau bahkan

keputusasaan. Komunikasi terapeutik pada pasien yang mengalami nyeri hebat bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, membangun kepercayaan, serta mengurangi kecemasan dan perasaan tidak berdaya yang dirasakan pasien. Petugas kesehatan perlu memiliki sensitivitas tinggi terhadap kondisi emosional pasien, mendengarkan keluhan nyeri secara aktif dan responsif, serta menunjukkan empati yang tulus terhadap penderitaan yang dialami pasien.

Dalam menghadapi pasien dengan nyeri hebat, tenaga medis perlu menggunakan pendekatan komunikasi yang menenangkan dan memastikan pasien merasa didengarkan. Kalimat-kalimat seperti, "Kami mengerti bahwa Bapak/Ibu sedang merasa sangat sakit saat ini, kami akan segera membantu meredakan rasa sakit tersebut," akan membuat pasien merasa dipahami dan didukung sepenuhnya. Di samping komunikasi verbal yang empatik, komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah yang tenang, gerakan tubuh yang lembut, dan sentuhan ringan yang menenangkan juga penting untuk memberikan dukungan emosional kepada pasien. Dengan adanya komunikasi terapeutik yang tepat, pasien akan lebih kooperatif dalam proses pengobatan dan mengalami penurunan intensitas nyeri karena berkurangnya stres psikologis yang dirasakan.

Implementasi komunikasi terapeutik juga sangat penting dilakukan pada keluarga pasien yang sedang dalam kondisi kritis. Dalam situasi gawat darurat, keluarga pasien sering kali mengalami tekanan psikologis dan emosional yang berat, yang dapat menghambat pemahaman mereka terhadap kondisi medis pasien serta meningkatkan risiko munculnya konflik atau ketidakpercayaan terhadap tim medis. Dalam situasi ini, petugas kesehatan perlu mengadopsi pendekatan komunikasi yang informatif sekaligus penuh empati. Penting untuk menyampaikan informasi medis secara jelas, sederhana, namun penuh sensitivitas terhadap perasaan keluarga. Sebagai contoh, ketika menjelaskan tentang kondisi pasien yang kritis dan memerlukan tindakan intervensi mendesak, tenaga kesehatan dapat menggunakan kalimat seperti, "Kami sedang melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan nyawa ayah/ibu Anda. Kondisi beliau kritis dan kami perlu segera mengambil langkah-langkah penting untuk menstabilkan keadaannya. Kami akan terus memberi informasi kepada keluarga secara berkala."

Dalam berkomunikasi dengan keluarga pasien yang sedang menghadapi kondisi kritis, tenaga kesehatan juga harus memperhatikan kemampuan keluarga untuk menyerap informasi di tengah suasana emosional yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi bertahap dengan memberi jeda waktu agar keluarga memahami informasi yang disampaikan, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi, merupakan bagian penting dalam komunikasi terapeutik yang efektif. Di samping itu, tenaga kesehatan juga perlu

menunjukkan dukungan emosional kepada keluarga melalui ekspresi empati seperti, "Kami memahami situasi ini sangat sulit bagi keluarga, tetapi kami ada di sini untuk membantu dan mendampingi Anda melewati situasi ini." Pendekatan ini tidak hanya membantu keluarga lebih memahami kondisi yang dihadapi tetapi juga membangun rasa percaya mereka kepada tim medis yang sedang menangani pasien.

Secara keseluruhan, implementasi komunikasi terapeutik yang efektif dalam berbagai kasus spesifik di ruang gawat darurat memerlukan keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal yang tinggi serta sensitivitas terhadap kondisi psikologis pasien maupun keluarganya. Dengan pendekatan komunikasi yang tepat terhadap pasien yang mengalami gangguan kesadaran, pasien dengan nyeri hebat, serta keluarga pasien dalam kondisi kritis, maka proses penanganan medis dapat berjalan lebih lancar, meningkatkan kerja sama pasien dan keluarga, serta secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di ruang gawat darurat.

F. Etika dalam Komunikasi Terapeutik di Pelayanan Gawat Darurat

Dalam pelayanan gawat darurat, etika menjadi salah satu landasan utama yang harus diperhatikan oleh tenaga kesehatan dalam menerapkan komunikasi terapeutik kepada pasien maupun keluarga. Situasi darurat yang penuh tekanan dan ketidakpastian menuntut tenaga kesehatan untuk senantiasa menjaga sikap profesional dan menghormati prinsip-prinsip etika. Etika dalam komunikasi terapeutik bukan sekadar aspek tambahan, melainkan suatu kebutuhan penting yang menentukan keberhasilan dalam menjaga hubungan baik antara tenaga kesehatan, pasien, serta keluarga pasien.

Salah satu prinsip etika yang paling mendasar dalam komunikasi terapeutik di layanan gawat darurat adalah menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Dalam kondisi kritis, pasien sering kali berada dalam keadaan tidak berdaya dan rentan, sehingga penting bagi tenaga medis untuk menjaga informasi medis pasien agar tidak bocor atau disampaikan kepada pihak yang tidak berhak. Hal ini mencakup segala jenis informasi yang berkaitan dengan identitas pasien, kondisi medis, diagnosis, pengobatan yang diberikan, hingga riwayat pribadi pasien yang mungkin terungkap selama proses perawatan. Tenaga kesehatan perlu menerapkan prinsip kerahasiaan dengan seksama dan bijaksana, hanya membagikan informasi medis pasien kepada pihak yang memang berkepentingan secara langsung dengan proses pengobatan, misalnya sesama anggota tim medis, pasien sendiri jika memungkinkan, serta keluarga dekat yang telah diberikan izin oleh pasien.

Dalam kondisi gawat darurat, menjaga privasi pasien juga termasuk menjaga martabat pasien selama pemeriksaan maupun tindakan medis berlangsung.

Contohnya, tenaga kesehatan harus selalu memastikan bahwa tirai atau pembatas di ruang gawat darurat digunakan secara optimal untuk melindungi pasien dari pandangan publik. Saat berdiskusi mengenai kondisi pasien dengan anggota tim medis lainnya, sangat dianjurkan untuk berbicara dengan volume suara rendah atau melakukannya di area tertutup agar informasi medis pasien tidak tersebar tanpa sengaja. Dengan menerapkan prinsip ini secara konsisten, pasien akan merasa dihormati dan lebih nyaman, meskipun situasi sedang dalam kondisi genting.

Selanjutnya, aspek etika lain yang sangat penting dalam komunikasi terapeutik di unit gawat darurat adalah komunikasi terkait informed consent atau persetujuan tindakan medis. Informed consent pada situasi darurat memiliki tantangan tersendiri karena pasien mungkin tidak mampu memberikan persetujuan secara sadar dan penuh pertimbangan akibat kondisi kritis atau penurunan kesadaran. Dalam situasi demikian, tenaga kesehatan memiliki kewajiban moral untuk segera berkomunikasi dengan keluarga terdekat atau pihak yang bertanggung jawab untuk mendapatkan persetujuan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien.

Komunikasi dalam proses informed consent di unit gawat darurat harus dilaksanakan dengan jelas, lugas, jujur, serta mudah dimengerti oleh keluarga pasien. Tenaga medis harus menjelaskan secara sederhana namun informatif tentang kondisi pasien yang memerlukan intervensi segera, manfaat yang diharapkan dari tindakan tersebut, serta risiko yang mungkin muncul. Selain itu, tenaga kesehatan juga perlu memberi kesempatan kepada keluarga untuk bertanya, mempertimbangkan, atau meminta klarifikasi lebih lanjut. Jika situasi sangat kritis dan tidak memungkinkan persetujuan tertulis secara formal, maka persetujuan verbal dari keluarga harus dicatat secara jelas dalam dokumentasi medis pasien, dengan disaksikan oleh anggota tim medis lainnya sebagai bentuk akuntabilitas profesional. Hal ini penting dilakukan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, transparansi, serta penghormatan terhadap hak otonomi pasien dan keluarganya.

Aspek etika yang tidak kalah penting dalam komunikasi terapeutik di ruang gawat darurat adalah etika dalam penyampaian berita buruk atau sering dikenal dengan istilah *breaking bad news*. Menyampaikan berita buruk kepada pasien atau keluarga pasien merupakan tantangan yang kompleks karena melibatkan faktor emosional dan psikologis yang berat. Berita buruk dalam pelayanan gawat darurat bisa berupa informasi tentang diagnosis penyakit yang serius, prognosis yang buruk, atau bahkan kabar mengenai kematian. Oleh sebab itu, cara tenaga medis menyampaikan berita tersebut harus mengikuti etika dan pendekatan khusus yang sensitif, empatik, serta penuh tanggung jawab.

Dalam penyampaian berita buruk, tenaga kesehatan harus memastikan suasana yang mendukung percakapan yang tenang, nyaman, dan privat.

Penyampaian berita buruk sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru atau di tempat terbuka yang memungkinkan orang lain mendengar. Tenaga medis perlu menggunakan bahasa yang jelas, namun lembut dan penuh empati, serta menunjukkan sikap menghargai perasaan pasien maupun keluarga. Pendekatan komunikasi yang empatik dan manusiawi dalam situasi ini sangat diperlukan, misalnya dengan kalimat seperti, "Kami sangat menyesal harus menyampaikan berita ini kepada Bapak/Ibu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya, namun kondisinya terlalu parah sehingga kami tidak berhasil." Dalam situasi ini, tenaga medis juga harus siap menghadapi berbagai reaksi emosional dari pasien atau keluarga, seperti tangisan, amarah, atau bahkan penolakan, serta memberikan dukungan emosional yang tulus dan sabar kepada mereka.

Selain menyampaikan berita buruk secara empatik, tenaga kesehatan juga harus memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarga untuk mengekspresikan perasaan atau pertanyaan mereka. Komunikasi terapeutik dalam situasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk memberi ruang bagi keluarga atau pasien dalam mengungkapkan perasaan, ketakutan, atau kekhawatiran yang mereka alami. Dalam kondisi tertentu, mungkin diperlukan kehadiran tim pendukung psikologis atau rohaniwan untuk memberikan bantuan tambahan dalam mendampingi keluarga dalam menghadapi situasi emosional yang berat ini.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, menjunjung tinggi informed consent meski dalam situasi darurat, serta menggunakan pendekatan yang penuh sensitivitas dalam penyampaian berita buruk, tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan komunikasi terapeutik yang berkualitas tinggi. Etika dalam komunikasi terapeutik tidak hanya meningkatkan kualitas hubungan antara pasien, keluarga, dan tenaga medis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan gawat darurat yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Dengan demikian, etika menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang tidak hanya profesional dan kompeten secara klinis, tetapi juga manusiawi, bermartabat, serta penuh empati.

G. Strategi Pengembangan Kompetensi Komunikasi bagi Petugas Gawat Darurat

Dalam pelayanan kesehatan gawat darurat, kompetensi komunikasi menjadi keterampilan yang amat penting untuk dimiliki oleh setiap petugas, baik dokter maupun perawat. Pengembangan kompetensi ini memerlukan strategi yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, mengingat situasi di ruang gawat darurat

sering kali melibatkan tekanan tinggi, emosi pasien dan keluarga yang intens, serta kebutuhan akan tindakan yang cepat namun tetap empatik dan manusiawi.

Salah satu strategi utama dalam meningkatkan kompetensi komunikasi bagi petugas gawat darurat adalah melalui pelatihan keterampilan komunikasi terapeutik secara berkala. Pelatihan ini bertujuan agar petugas mampu memahami prinsip-prinsip dasar komunikasi terapeutik, seperti bagaimana menunjukkan empati secara efektif, bagaimana merespons emosi pasien maupun keluarganya, serta cara menyampaikan informasi medis dengan jelas, ringkas, namun tetap menjaga kepekaan emosional pasien. Pelatihan keterampilan komunikasi terapeutik biasanya mencakup berbagai teknik dasar komunikasi, seperti mendengarkan aktif, teknik klarifikasi, teknik paraphrasing, serta teknik pemberian informasi secara terstruktur.

Dalam pelatihan ini, para petugas gawat darurat dilatih untuk dapat memahami berbagai kondisi emosional pasien, mulai dari kecemasan ringan hingga kondisi yang sangat panik dan depresi. Dengan demikian, pelatihan akan membantu petugas untuk mampu melakukan pendekatan secara tepat sesuai dengan kondisi psikologis yang dialami pasien maupun keluarga. Melalui pelatihan ini, petugas juga diajarkan untuk lebih peka terhadap bahasa tubuh pasien, serta mampu mengelola komunikasi nonverbal secara efektif. Hasil yang diharapkan adalah para petugas menjadi lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai tantangan komunikasi di lapangan.

Selain pelatihan yang bersifat teoritis, strategi lain yang sangat efektif dalam mengembangkan keterampilan komunikasi petugas gawat darurat adalah melalui simulasi dan role-playing. Pendekatan ini menempatkan petugas dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata di ruang gawat darurat, sehingga mereka dapat langsung menerapkan teknik komunikasi terapeutik yang telah dipelajari. Dalam simulasi, petugas berlatih menghadapi berbagai skenario yang realistis, seperti menyampaikan berita buruk kepada keluarga pasien, mengelola situasi emosional pasien yang marah atau frustrasi, hingga berkomunikasi dalam situasi kritis dengan waktu yang terbatas.

Role-playing memberikan kesempatan bagi petugas untuk secara aktif mencoba berbagai teknik komunikasi dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Melalui skenario simulasi, petugas dapat mengevaluasi secara langsung efektivitas komunikasi yang mereka lakukan serta menerima umpan balik secara konstruktif dari instruktur maupun rekan sejawat. Dengan pendekatan ini, petugas dapat lebih siap secara mental dan emosional dalam menghadapi situasi nyata di ruang gawat darurat, serta mampu memperbaiki kekurangan yang ditemukan selama proses latihan simulasi berlangsung.

Tidak kalah penting, strategi pengembangan kompetensi komunikasi yang efektif juga perlu dilakukan dengan mengintegrasikan materi komunikasi terapeutik secara lebih sistematis ke dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan keperawatan. Integrasi ini harus dilakukan sejak awal proses pendidikan, agar calon dokter dan perawat telah memiliki dasar-dasar komunikasi terapeutik yang kuat sebelum mereka terjun langsung ke pelayanan kesehatan gawat darurat. Materi yang diajarkan dalam kurikulum ini hendaknya mencakup tidak hanya teori komunikasi terapeutik tetapi juga keterampilan praktis dalam menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan.

Melalui integrasi dalam kurikulum pendidikan formal, mahasiswa keperawatan maupun kedokteran dapat secara kontinu mengasah keterampilan komunikasi terapeutik mereka sejak dini, dan terbiasa menjadikan komunikasi efektif sebagai bagian dari praktik sehari-hari mereka. Kurikulum yang disusun juga perlu melibatkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif keilmuan psikologi, sosiologi, serta ilmu kesehatan, sehingga calon tenaga kesehatan mampu memahami bahwa komunikasi bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi sebagai sarana terapeutik untuk mendukung kesembuhan pasien secara holistik.

Integrasi materi komunikasi terapeutik dalam kurikulum ini juga memungkinkan pengajar untuk mengembangkan metode evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kemampuan komunikasi mahasiswa. Penilaian terhadap kemampuan komunikasi tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, melainkan juga mencakup keterampilan interpersonal yang tampak dalam praktek klinis nyata atau dalam simulasi. Dengan demikian, lulusan pendidikan kedokteran maupun keperawatan diharapkan memiliki kesiapan yang matang untuk menerapkan komunikasi terapeutik dalam lingkungan klinis yang penuh tantangan, khususnya di unit gawat darurat.

Dengan menerapkan ketiga strategi ini secara simultan—pelatihan rutin keterampilan komunikasi, penggunaan metode simulasi dan role-playing, serta integrasi sistematis komunikasi terapeutik dalam kurikulum pendidikan—kompetensi komunikasi terapeutik para petugas gawat darurat dapat ditingkatkan secara signifikan. Pada akhirnya, kemampuan komunikasi yang baik dari petugas akan memberikan dampak positif yang nyata bagi pasien, keluarga, maupun lingkungan kerja, menciptakan suasana yang lebih tenang, kolaboratif, serta mendukung pencapaian kualitas pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

H. Simpulan

Komunikasi terapeutik dalam pelayanan gawat darurat merupakan aspek kritis yang secara langsung berkontribusi pada efektivitas tindakan medis, keselamatan pasien, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dalam situasi yang penuh tekanan, komunikasi terapeutik membantu menciptakan suasana tenang dan terkontrol, mengurangi kecemasan pasien serta keluarganya, dan memperkuat rasa percaya terhadap tim medis yang menangani situasi kritis tersebut.

Prinsip-prinsip dasar komunikasi terapeutik meliputi kemampuan tenaga kesehatan untuk menunjukkan empati dan memberikan dukungan emosional secara tulus, menerapkan keterampilan mendengarkan aktif dan responsif, serta menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal yang jelas dan efektif. Dalam kondisi gawat darurat, prinsip ini membantu pasien untuk memahami kondisinya dengan lebih baik, mengurangi resistensi terhadap tindakan medis, serta meningkatkan kerjasama pasien dan keluarga dalam proses penanganan medis.

Meskipun sangat penting, komunikasi terapeutik di ruang gawat darurat menghadapi berbagai tantangan signifikan seperti hambatan psikologis dan emosional pasien, tekanan waktu akibat situasi yang kritis, serta hambatan lingkungan yang kurang kondusif seperti kebisingan dan minimnya privasi. Tantangan-tantangan ini membutuhkan kemampuan khusus dari tenaga kesehatan untuk tetap berkomunikasi secara efektif dalam situasi sulit tersebut.

Untuk mengatasi tantangan ini, terdapat beberapa strategi yang efektif, seperti penggunaan komunikasi yang singkat, jelas, dan tegas, manajemen krisis dengan komunikasi persuasif, serta pendekatan multidisiplin dalam komunikasi tim gawat darurat. Strategi ini memastikan pesan yang disampaikan kepada pasien, keluarga, maupun antar anggota tim kesehatan tetap akurat, efisien, dan mampu menciptakan kolaborasi yang harmonis.

Implementasi komunikasi terapeutik secara spesifik juga penting dilakukan pada kasus pasien dengan gangguan kesadaran, pasien yang mengalami nyeri hebat, serta keluarga pasien yang berada dalam kondisi emosional tinggi. Setiap situasi ini memerlukan pendekatan komunikasi yang disesuaikan agar pesan dapat diterima dengan optimal dan memberikan efek terapeutik yang positif secara fisik maupun psikologis.

Etika dalam komunikasi terapeutik merupakan komponen penting yang harus senantiasa dijaga, terutama dalam situasi darurat yang penuh tekanan. Prinsip etika ini mencakup menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, menerapkan komunikasi yang jelas dalam proses informed consent, serta menyampaikan berita buruk

dengan pendekatan empatik dan penuh penghormatan terhadap perasaan pasien dan keluarganya.

Terakhir, pengembangan kompetensi komunikasi terapeutik petugas gawat darurat harus dilakukan secara sistematis melalui strategi pelatihan rutin, simulasi dan role-playing, serta integrasi dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan keperawatan. Dengan pendekatan ini, tenaga kesehatan akan lebih siap menghadapi situasi nyata di ruang gawat darurat, mampu memberikan pelayanan yang profesional sekaligus manusiawi, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif, kooperatif, dan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi secara menyeluruh.

I. Referensi

- Abdolrahimi, M., Ghiyasvandian, S., Zakerimoghadam, M., & Ebadi, A. (2017). Therapeutic communication in nursing students: A Walker & Avant concept analysis. *Electronic Physician*, 9(8), 4968–4977. <https://doi.org/10.19082/4968>
- Arnold, E. C., & Boggs, K. U. (2019). *Interpersonal relationships: Professional communication skills for nurses* (8th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Brown, J., & Miller, W. R. (2019). *Communication skills training: A practical guide to improving your social intelligence, presentation, persuasion, and public speaking*. Independently published.
- Curtis, K., Tzannes, A., & Rudge, T. (2018). How to talk to patients and families about adverse events. *Australian Critical Care*, 31(5), 299–305. <https://doi.org/10.1016/j.aucc.2017.10.006>
- Fallowfield, L., & Jenkins, V. (2020). Effective communication skills are the key to good cancer care. *European Journal of Cancer*, 128, 75–81. <https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.01.047>
- Finke, E. H., Light, J., & Kitko, L. (2019). A systematic review of the effectiveness of nurse communication with patients with complex communication needs. *Journal of Clinical Nursing*, 28(7–8), 1157–1176. <https://doi.org/10.1111/jocn.14650>
- Henderson, A. (2019). *Therapeutic communication in nursing: Theory and practice* (4th ed.). Springer Publishing Company.
- Iedema, R., & Piper, D. (2018). *Communicating quality and safety in health care*. Cambridge University Press.
- McCabe, C. (2018). *Nurse-patient communication: An exploration of patients'*

experiences. *Journal of Clinical Nursing*, 27(9–10), e1765–e1776. <https://doi.org/10.1111/jocn.14347>

McCorry, L. K., & Mason, J. (2020). *Communication skills for the healthcare professional: Context, concepts, practice, and evidence* (3rd ed.). Jones & Bartlett Learning.

O'Hagan, S., Manias, E., Elder, C., Pill, J., Woodward-Kron, R., McNamara, T., & Webb, G. (2019). What counts as effective communication in nursing? Evidence from nurse educators and clinicians' feedback on nurse interactions. *Nurse Education Today*, 76, 127–134. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.010>

Pino, M., Parry, R., & Land, V. (2017). The role of empathy in emergency communication: A qualitative study. *Patient Education and Counseling*, 100(6), 1248–1254. <https://doi.org/10.1016/j.pec.2017.01.021>

Riley, J. B. (2019). *Communication in nursing* (9th ed.). Elsevier Health Sciences.

Silverman, J., Kurtz, S., & Draper, J. (2019). *Skills for communicating with patients* (4th ed.). CRC Press.

Webb, L. (Ed.). (2019). *Nursing communication skills in practice: Preparing for practice*. Oxford University Press.

J. Glosarium

Komunikasi Terapeutik: Proses komunikasi interpersonal antara tenaga kesehatan dengan pasien yang secara sengaja dilakukan untuk membantu mengatasi masalah kesehatan secara fisik, psikologis, dan emosional.

Pelayanan Gawat Darurat: Pelayanan medis yang bersifat segera, cepat, tepat, dan efisien dalam menghadapi situasi kritis yang dapat mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan.

Empati: Kemampuan tenaga kesehatan untuk memahami perasaan, pikiran, serta pengalaman yang dirasakan pasien secara mendalam.

Mendengarkan Aktif: Keterampilan komunikasi di mana tenaga kesehatan memberikan perhatian penuh terhadap ucapan, perasaan, serta ekspresi pasien, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan relevan.

Komunikasi Nonverbal: Proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, meliputi ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, sentuhan, dan intonasi suara.

Komunikasi Verbal: Proses penyampaian pesan secara lisan yang dilakukan secara langsung menggunakan kata-kata yang jelas dan mudah dipahami.

Hambatan Psikologis dan Emosional: Gangguan komunikasi yang muncul akibat kondisi psikologis seperti panik, stres tinggi, kecemasan, rasa takut, frustrasi, atau marah yang dialami oleh pasien maupun keluarga.

Tekanan Waktu: Kondisi di mana tenaga kesehatan harus bertindak cepat dan tepat karena keterbatasan waktu dalam situasi darurat yang sangat kritis.

Hambatan Lingkungan: Kendala dalam proses komunikasi yang muncul akibat kondisi fisik lingkungan seperti kebisingan, keterbatasan ruang privasi, serta tingginya aktivitas di ruang gawat darurat.

Clear and Concise Communication: Teknik komunikasi yang menggunakan bahasa sederhana, singkat, padat, jelas, serta langsung ke pokok pesan untuk mencegah kesalahpahaman.

Komunikasi Persuasif: Pendekatan komunikasi yang bertujuan untuk meyakinkan pasien atau keluarga agar bersedia menerima dan memahami pentingnya tindakan medis yang akan dilakukan.

Pendekatan Multidisiplin: Kerja sama antara berbagai profesi kesehatan dalam komunikasi untuk memastikan koordinasi dan kolaborasi yang efektif dalam menangani pasien secara optimal.

Informed Consent: Persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah memperoleh penjelasan yang lengkap, jelas, dan mudah dimengerti tentang kondisi pasien, tindakan medis yang diusulkan, serta manfaat dan risikonya.

Breaking Bad News: Proses menyampaikan berita buruk mengenai kondisi kesehatan atau prognosis pasien dengan pendekatan komunikasi yang empatik, penuh sensitivitas, serta menghargai perasaan pasien dan keluarganya.

Privasi dan Kerahasiaan Pasien: Prinsip etika yang mewajibkan tenaga kesehatan untuk menjaga informasi medis pasien serta menghormati hak pasien untuk privasi dalam setiap tindakan maupun komunikasi.

Pelatihan Komunikasi Terapeutik: Program pendidikan atau pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam menerapkan teknik komunikasi terapeutik secara efektif di berbagai situasi klinis.

Simulasi dan Role-playing: Metode pelatihan yang menempatkan tenaga kesehatan dalam skenario situasi klinis nyata atau semi-nyata untuk melatih keterampilan komunikasi secara langsung dan interaktif.

Integrasi dalam Kurikulum: Upaya memasukkan materi dan keterampilan komunikasi terapeutik ke dalam kurikulum pendidikan formal kedokteran dan keperawatan, agar mahasiswa terbiasa menerapkannya sejak dini.

CHAPTER 10

STUDI KASUS KEPERAWATAN GAWAT DARURAT BERBASIS EVIDENCE-BASED PRACTICE

Drg Arnetty M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Dalam pelayanan kesehatan, khususnya pada bidang keperawatan gawat darurat, studi kasus merupakan pendekatan klinis yang digunakan untuk mengkaji secara mendalam berbagai aspek terkait kondisi pasien, mulai dari identifikasi masalah hingga pengambilan keputusan klinis yang tepat. Secara umum, studi kasus dalam keperawatan gawat darurat bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan mempelajari lebih dalam tentang kasus klinis tertentu yang memiliki karakteristik unik, kompleks, atau langka. Proses ini melibatkan pencatatan secara sistematis atas riwayat pasien, gejala-gejala klinis, hasil pemeriksaan fisik maupun penunjang, diagnosis keperawatan, serta intervensi yang telah dilakukan beserta hasil akhirnya.

Keperawatan gawat darurat merupakan bidang keperawatan yang berfokus pada penanganan pasien dengan kondisi kritis dan membutuhkan tindakan segera guna menyelamatkan jiwa pasien. Dalam konteks ini, studi kasus memiliki posisi yang sangat penting sebagai salah satu cara meningkatkan pemahaman klinis, memperkuat keterampilan berpikir kritis, dan membantu perawat memahami kompleksitas situasi klinis secara mendalam. Melalui studi kasus yang dilakukan secara terstruktur, tenaga keperawatan diharapkan mampu mengenali berbagai kondisi kegawatdaruratan secara lebih cepat, tepat, dan efisien, sehingga intervensi yang dilakukan pun semakin optimal dan hasil akhir yang diperoleh pasien menjadi lebih baik.

Lebih lanjut, pendekatan yang saat ini banyak digunakan dalam studi kasus keperawatan gawat darurat adalah pendekatan berbasis bukti atau yang dikenal sebagai Evidence-Based Practice (EBP). EBP merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai-nilai dan preferensi pasien. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan bukan hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman pribadi semata, melainkan didukung oleh data dan bukti ilmiah terbaru yang telah diuji keabsahannya secara klinis maupun akademis.

Pentingnya pendekatan Evidence-Based Practice dalam studi kasus keperawatan gawat darurat tidak terlepas dari dinamika dan kompleksitas situasi yang terjadi di ruang gawat darurat itu sendiri. Kondisi kritis pasien yang datang ke unit gawat darurat sering kali membutuhkan keputusan klinis yang cepat dan akurat untuk menentukan intervensi yang tepat. Dengan mengadopsi EBP, perawat memiliki dasar yang kuat dan kredibel untuk mengambil keputusan klinis yang penting dalam waktu singkat. Selain itu, penerapan EBP juga mampu meningkatkan kepercayaan diri tenaga keperawatan, karena setiap keputusan yang diambil didasarkan pada bukti ilmiah terkini, bukan sekadar intuisi atau rutinitas yang belum tentu relevan dengan situasi yang dihadapi.

Penerapan EBP dalam studi kasus juga memiliki manfaat besar bagi pengembangan kualitas pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan menerapkan bukti ilmiah terbaru, studi kasus keperawatan gawat darurat menjadi sarana efektif untuk memastikan praktik keperawatan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang terus berubah dan berkembang. Hal ini membantu mencegah stagnasi atau ketinggalan informasi yang sering kali menjadi hambatan dalam pelayanan klinis. Dengan demikian, pasien mendapatkan layanan keperawatan yang lebih aman, efektif, dan efisien, yang secara tidak langsung akan meningkatkan tingkat kepuasan pasien serta keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan.

Selain itu, studi kasus keperawatan berbasis EBP juga memainkan peran penting dalam mendukung pembelajaran berkelanjutan (lifelong learning) bagi tenaga keperawatan. Melalui studi kasus, perawat akan terus didorong untuk melakukan pencarian literatur terbaru, mengidentifikasi penelitian terkini yang relevan, dan menerapkan temuan-temuan tersebut dalam praktek sehari-hari. Hal ini tentunya akan memperkuat kapasitas profesional perawat dalam menangani kasus-kasus kompleks yang sering muncul dalam kondisi kegawatdaruratan. Dalam jangka panjang, budaya praktik berbasis bukti ini akan membantu menciptakan tenaga keperawatan yang memiliki keterampilan analitis yang tajam, sikap kritis yang konstruktif, serta wawasan ilmiah yang terus berkembang sesuai perkembangan ilmu keperawatan modern.

Secara keseluruhan, pemahaman konsep dasar studi kasus serta pentingnya pendekatan EBP dalam keperawatan gawat darurat menjadi landasan kuat yang tidak boleh diabaikan. Perawat gawat darurat dituntut untuk tidak hanya memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, tetapi juga kemampuan untuk berpikir kritis dan analitis dalam menghadapi berbagai situasi klinis. Dengan menerapkan studi kasus yang berbasis pada Evidence-Based Practice, maka diharapkan pelayanan keperawatan di unit gawat darurat dapat menjadi lebih berkualitas, terpercaya, serta

mampu memberikan hasil akhir yang optimal dalam berbagai situasi kegawatdaruratan.

B. Prinsip-Prinsip Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat

Dalam keperawatan gawat darurat, pendekatan berbasis bukti atau yang dikenal dengan istilah Evidence-Based Practice (EBP) memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip utama dalam penerapan EBP sangat relevan karena tuntutan kondisi gawat darurat yang memerlukan tindakan cepat, tepat, dan efektif. Ketiga prinsip utama yang menjadi fondasi dalam penerapan EBP di ruang gawat darurat mencakup integrasi bukti ilmiah terbaru dalam pengambilan keputusan klinis, penilaian kritis terhadap kualitas bukti ilmiah, serta pengakuan terhadap peran penting pengalaman klinis dan preferensi pasien dalam praktik klinis.

Integrasi bukti ilmiah terbaru dalam pengambilan keputusan klinis merupakan prinsip dasar yang pertama dalam EBP di keperawatan gawat darurat. Dalam prinsip ini, setiap keputusan yang diambil oleh perawat maupun tim medis tidak lagi mengandalkan rutinitas atau intuisi semata, tetapi harus didukung oleh bukti ilmiah yang sah dan relevan dengan kasus klinis yang sedang ditangani. Bukti ilmiah yang dimaksud biasanya berupa hasil penelitian terkini, panduan klinis (clinical guidelines) yang sudah divalidasi, atau protokol perawatan terbaru yang dipublikasikan oleh lembaga atau institusi kredibel. Perawat gawat darurat dituntut mampu mengakses sumber-sumber ini dengan cepat dan efisien, sehingga dapat segera menerapkannya di lapangan untuk menangani pasien dalam kondisi kritis. Contohnya, ketika menghadapi pasien dengan serangan jantung akut, perawat dapat menggunakan protokol terbaru yang didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas pemberian obat-obatan tertentu atau tindakan invasif dalam waktu tertentu untuk meningkatkan angka harapan hidup pasien.

Integrasi bukti ilmiah terbaru dalam praktik keperawatan gawat darurat juga menuntut tenaga kesehatan untuk senantiasa mengikuti perkembangan literatur ilmiah. Ini artinya, perawat tidak boleh berhenti belajar setelah lulus dari pendidikan formalnya, melainkan terus meng-update pengetahuan dan keterampilannya. Akses terhadap jurnal medis dan keperawatan yang terindeks secara internasional, berpartisipasi dalam seminar, pelatihan, dan diskusi klinis menjadi rutinitas penting yang membantu perawat tetap selaras dengan kemajuan ilmu kesehatan terkini. Dengan demikian, keputusan klinis yang diambil tidak hanya meningkatkan akurasi diagnosis dan intervensi, tetapi juga mampu menghasilkan hasil klinis yang jauh lebih baik bagi pasien dan keluarganya.

Selanjutnya, prinsip kedua dari EBP adalah penilaian kritis terhadap kualitas bukti ilmiah. Tidak semua penelitian atau literatur ilmiah memiliki kualitas dan relevansi yang sama terhadap praktik klinis. Oleh karena itu, perawat gawat darurat dituntut untuk memiliki keterampilan menilai bukti ilmiah secara kritis sebelum mengaplikasikannya ke dalam praktik. Penilaian kritis ini melibatkan evaluasi terhadap validitas penelitian, desain penelitian, ukuran sampel, metode statistik, serta potensi bias yang mungkin terdapat di dalamnya. Penilaian kritis membantu tenaga keperawatan untuk memilih sumber bukti yang paling dapat diandalkan, sehingga keputusan klinis yang diambil benar-benar berdasar pada bukti ilmiah yang kredibel dan memiliki validitas tinggi.

Sebagai contoh, dalam mengevaluasi sebuah penelitian yang menunjukkan efektivitas obat tertentu dalam mengurangi nyeri akut pada pasien trauma, perawat harus memperhatikan apakah desain penelitian yang digunakan berupa uji coba acak terkendali (Randomized Controlled Trial atau RCT) yang dianggap sebagai standar emas dalam penelitian klinis, apakah jumlah sampelnya cukup besar untuk menghindari bias, serta apakah metode analisis data yang digunakan relevan dan tepat. Jika bukti tersebut terbukti valid, maka hasil penelitian tersebut bisa diterapkan ke dalam protokol pengelolaan nyeri di unit gawat darurat. Sebaliknya, jika kualitas bukti ilmiah tersebut diragukan, maka perawat perlu mencari sumber bukti lain yang lebih meyakinkan sebelum mengambil keputusan klinis.

Prinsip ketiga dalam EBP adalah pengakuan terhadap peran penting pengalaman klinis dan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Meskipun bukti ilmiah merupakan komponen utama dalam EBP, tetapi pengalaman klinis tenaga kesehatan serta preferensi pasien tidak boleh diabaikan. Pengalaman klinis perawat merupakan bentuk keahlian profesional yang didapatkan melalui interaksi langsung dengan berbagai kasus klinis dalam praktik sehari-hari. Keahlian ini meliputi keterampilan mengidentifikasi kondisi pasien dengan cepat, kemampuan melakukan penilaian klinis yang akurat, serta intuisi klinis yang telah terasah melalui pengalaman menangani pasien dalam kondisi kritis secara berulang kali. Pengalaman klinis ini memungkinkan perawat untuk mengadaptasi intervensi berdasarkan konteks spesifik pasien, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat dan efisien.

Di sisi lain, preferensi pasien adalah elemen penting yang juga wajib diperhatikan dalam praktik EBP. Setiap pasien memiliki latar belakang, nilai-nilai, keyakinan, dan preferensi yang berbeda-beda terhadap perawatan medis yang mereka terima. Menghormati preferensi pasien berarti memberikan informasi yang jelas kepada pasien tentang berbagai pilihan terapi yang tersedia, manfaat serta risikonya, kemudian melibatkan mereka secara aktif dalam proses pengambilan

keputusan klinis. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan pasien, memperkuat rasa percaya pasien terhadap tim medis, serta memperbaiki hasil klinis secara keseluruhan. Sebagai contoh, dalam kasus pasien yang menolak tindakan invasif tertentu karena alasan pribadi atau budaya, perawat harus menghargai keputusan tersebut sambil tetap memberikan alternatif lain yang juga berbasis bukti ilmiah.

Secara keseluruhan, ketiga prinsip tersebut—integrasi bukti ilmiah terbaru, penilaian kritis terhadap kualitas bukti ilmiah, serta peran pengalaman klinis dan preferensi pasien—merupakan fondasi penting dalam praktik Evidence-Based Practice dalam keperawatan gawat darurat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, perawat di unit gawat darurat tidak hanya mampu memberikan layanan klinis yang lebih aman, efektif, dan efisien, tetapi juga menciptakan suasana perawatan yang lebih humanis, responsif, serta berorientasi pada pasien dan keluarga mereka. Dengan demikian, penerapan EBP dalam keperawatan gawat darurat mampu membawa manfaat nyata bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun institusi pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

C. Tahapan Implementasi Evidence-Based Practice dalam Studi Kasus Keperawatan Gawat Darurat

Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam studi kasus keperawatan gawat darurat merupakan suatu proses sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan penting. Setiap tahapan dalam implementasi EBP memiliki peran yang saling terkait dan memerlukan ketelitian serta kedisiplinan tenaga keperawatan dalam menjalankannya. Kelima tahapan yang menjadi kunci dalam proses implementasi ini meliputi: identifikasi dan formulasi pertanyaan klinis dengan menggunakan format PICO, pencarian dan pengumpulan bukti ilmiah, penilaian kritis dan seleksi bukti yang relevan, aplikasi temuan EBP ke dalam praktik klinis, dan evaluasi hasil implementasi EBP dalam studi kasus.

Tahap pertama dalam implementasi EBP di keperawatan gawat darurat adalah identifikasi dan formulasi pertanyaan klinis dengan format PICO. PICO adalah singkatan dari Population (populasi atau pasien), Intervention (intervensi yang ingin diuji), Comparison (pembanding), dan Outcome (hasil klinis yang diharapkan). Format ini membantu perawat dalam merumuskan pertanyaan klinis secara jelas, spesifik, dan terarah, sehingga memudahkan pencarian informasi ilmiah yang relevan. Misalnya, jika seorang perawat menghadapi kasus pasien trauma dengan nyeri akut hebat, maka perawat bisa menyusun pertanyaan klinis dalam format PICO seperti berikut: "Pada pasien trauma akut (Population), apakah pemberian analgesik opioid intravena (Intervention) dibandingkan analgesik non-opioid (Comparison) lebih efektif dalam menurunkan intensitas nyeri dalam 30 menit pertama setelah

pemberian (Outcome)?" Dengan adanya pertanyaan klinis yang jelas seperti ini, proses pencarian bukti ilmiah akan menjadi lebih mudah dan terfokus.

Setelah pertanyaan klinis dirumuskan dengan jelas, tahapan kedua adalah pencarian dan pengumpulan bukti ilmiah. Dalam tahap ini, perawat harus secara aktif mencari sumber bukti dari berbagai literatur ilmiah terpercaya seperti jurnal kesehatan internasional, panduan klinis, database penelitian seperti PubMed, CINAHL, dan Cochrane Library. Perawat diharapkan menggunakan kata kunci dari format PICO tadi untuk menemukan artikel ilmiah atau hasil penelitian relevan dengan pertanyaan klinis yang diajukan. Proses ini memerlukan keterampilan khusus dalam menggunakan mesin pencari ilmiah, menentukan kata kunci yang efektif, dan memilih database yang tepat. Misalnya, perawat dapat mencari bukti ilmiah terkait efektivitas analgesik opioid versus non-opioid pada pasien trauma melalui database Cochrane Library dengan kata kunci "acute trauma," "opioid analgesics," "pain management," dan sebagainya. Semakin banyak bukti ilmiah yang ditemukan, semakin kuat pula dasar keputusan klinis yang akan diambil nantinya.

Tahapan ketiga adalah penilaian kritis dan seleksi bukti ilmiah yang relevan. Pada tahap ini, tidak semua bukti yang ditemukan melalui pencarian literatur langsung digunakan dalam praktik klinis. Perawat harus mampu menilai secara kritis kualitas setiap bukti ilmiah yang ditemukan, mempertimbangkan validitas, reliabilitas, relevansi klinis, serta potensi bias dalam penelitian tersebut. Penilaian kritis ini umumnya menggunakan pendekatan sistematis seperti Critical Appraisal Tools (CATs), yang memungkinkan perawat mengevaluasi kualitas metodologi penelitian secara terstruktur dan sistematis. Setelah penilaian dilakukan, perawat kemudian memilih bukti ilmiah dengan kualitas terbaik, seperti hasil penelitian Randomized Controlled Trial (RCT), meta-analisis, atau systematic review yang telah melalui proses peer review ketat. Misalnya, perawat menemukan tiga artikel penelitian tentang efektivitas analgesik opioid pada pasien trauma, namun setelah melakukan penilaian kritis, ternyata hanya satu penelitian yang memenuhi kriteria metodologis tinggi dan relevan dengan kasus yang dihadapi. Artikel inilah yang kemudian dipilih untuk diaplikasikan ke dalam praktik klinis.

Tahapan keempat dalam implementasi EBP adalah aplikasi temuan EBP dalam praktik klinis. Setelah bukti ilmiah terbaik dipilih dan dianggap valid, langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam perencanaan asuhan keperawatan dan intervensi yang akan dilakukan kepada pasien. Pada tahap ini, perawat harus mempertimbangkan pula faktor-faktor klinis di lapangan seperti kondisi pasien secara keseluruhan, pengalaman klinis perawat, ketersediaan sumber daya medis, serta preferensi pasien. Misalnya, bukti ilmiah menunjukkan bahwa analgesik opioid intravena lebih efektif dalam mengontrol nyeri akut pada pasien

trauma, namun perawat juga harus mempertimbangkan apakah kondisi pasien memungkinkan pemberian opioid (misalnya mempertimbangkan risiko efek samping atau alergi), serta apakah pasien setuju dan nyaman dengan intervensi tersebut. Proses integrasi temuan EBP ke dalam praktik klinis ini menuntut kemampuan perawat dalam menyeimbangkan aspek ilmiah dengan aspek praktis dan emosional di lapangan, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya efektif secara klinis tetapi juga nyaman dan dapat diterima oleh pasien.

Tahapan terakhir, yaitu evaluasi hasil implementasi EBP dalam studi kasus, sangat penting dilakukan untuk mengetahui dampak nyata dari penerapan EBP tersebut. Evaluasi ini melibatkan proses pengukuran hasil klinis yang diperoleh pasien setelah intervensi EBP diterapkan, misalnya melalui penilaian tingkat nyeri sebelum dan sesudah pemberian analgesik opioid intravena pada pasien trauma. Evaluasi tidak hanya terbatas pada aspek klinis semata, namun juga melibatkan aspek kepuasan pasien, efisiensi pelayanan, serta potensi efek samping yang mungkin muncul. Evaluasi juga mencakup refleksi dari tim perawat mengenai tantangan, hambatan, serta keberhasilan dalam mengaplikasikan EBP tersebut ke dalam kasus spesifik di ruang gawat darurat. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki atau menyempurnakan penerapan EBP berikutnya. Jika implementasi berhasil menunjukkan hasil klinis yang positif, maka intervensi tersebut dapat diadopsi sebagai bagian dari protokol standar pelayanan di unit gawat darurat. Sebaliknya, jika evaluasi menunjukkan hasil yang kurang optimal, perawat harus melakukan analisis penyebab serta mencari alternatif bukti ilmiah lain yang lebih tepat.

Secara keseluruhan, tahapan implementasi Evidence-Based Practice dalam studi kasus keperawatan gawat darurat merupakan proses sistematis dan terpadu yang memastikan bahwa setiap keputusan klinis didasarkan pada bukti ilmiah yang solid, relevan, serta mempertimbangkan kondisi nyata pasien dan situasi klinis yang dihadapi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan tersebut secara disiplin, tenaga keperawatan gawat darurat dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi risiko kesalahan klinis, serta memberikan asuhan keperawatan yang optimal, efektif, dan berbasis bukti bagi pasien dalam kondisi kritis.

D. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Kegawatdaruratan Medis

Dalam pelayanan keperawatan gawat darurat, penggunaan pendekatan berbasis Evidence-Based Practice (EBP) pada studi kasus menjadi suatu keharusan untuk menjamin keputusan klinis yang diambil benar-benar efektif dan memberikan hasil klinis terbaik bagi pasien. Berbagai kondisi kegawatdaruratan medis yang sering dijumpai di ruang gawat darurat seperti Sindrom Koroner Akut (SKA), Stroke

Akut, Krisis Hipertensi, dan Syok Anafilaktik membutuhkan intervensi keperawatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru. Studi kasus yang mendalam terhadap kondisi-kondisi ini memungkinkan tenaga keperawatan mengambil keputusan klinis dengan lebih tepat, efektif, serta aman bagi pasien.

Salah satu studi kasus penting berbasis EBP dalam pelayanan gawat darurat adalah penanganan pasien dengan Sindrom Koroner Akut (SKA). SKA merupakan kondisi darurat jantung yang mencakup infark miokard akut (serangan jantung) dan angina tidak stabil, yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat untuk mencegah komplikasi serius seperti gagal jantung akut, aritmia, hingga kematian mendadak. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis bukti sangat penting, misalnya terkait penggunaan obat antiplatelet seperti aspirin, pemberian nitrogliserin, analgesik, atau intervensi revaskularisasi segera melalui kateterisasi jantung. Contoh studi kasus berbasis EBP dapat berupa seorang pasien berusia 60 tahun yang datang dengan keluhan nyeri dada hebat selama 30 menit terakhir. Berdasarkan bukti ilmiah terbaru dari guideline American Heart Association (AHA), perawat segera memberikan aspirin 160-325 mg untuk mencegah pembentukan trombus lebih lanjut, memulai pemberian oksigen sesuai kebutuhan, pemberian nitrogliserin sublingual untuk meredakan nyeri dada, serta segera mengaktifkan sistem rujukan ke fasilitas yang memiliki fasilitas kateterisasi jantung. Implementasi langkah-langkah ini, didukung oleh bukti ilmiah terbaru, terbukti secara signifikan mengurangi angka mortalitas dan mempercepat pemulihan fungsi jantung pasien.

Selanjutnya, kondisi Stroke Akut merupakan kegawatdaruratan medis lain yang sangat membutuhkan pendekatan studi kasus berbasis bukti. Stroke akut merupakan kondisi di mana aliran darah ke otak terganggu, baik karena sumbatan (iskemik) atau perdarahan (hemoragik), yang menyebabkan kerusakan jaringan otak dan dapat menimbulkan kecacatan permanen jika tidak segera ditangani. Dalam sebuah studi kasus EBP, misalnya, seorang pasien lansia tiba di unit gawat darurat dengan gejala khas stroke akut berupa kelemahan tubuh separuh, gangguan bicara, serta wajah yang tampak asimetris. Mengacu pada pedoman EBP dari American Stroke Association, perawat segera melakukan pemeriksaan neurologis cepat, memfasilitasi pasien untuk segera mendapatkan pemeriksaan CT Scan kepala, dan memastikan pasien mendapatkan terapi trombolitik (seperti alteplase) jika stroke terbukti bersifat iskemik dan masih berada dalam rentang waktu kritis (kurang dari 4,5 jam dari onset gejala). Dalam kasus ini, penerapan EBP yang cepat dan akurat terbukti mampu mengurangi dampak permanen stroke, meningkatkan pemulihan fungsi neurologis, serta memperpendek lama rawat inap pasien.

Kemudian, kondisi Krisis Hipertensi juga memerlukan pendekatan studi kasus berbasis bukti untuk memastikan intervensi klinis yang tepat. Krisis hipertensi adalah

kondisi di mana tekanan darah pasien meningkat secara drastis hingga berpotensi menyebabkan kerusakan organ target seperti otak, jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Sebagai contoh kasus, seorang pasien datang dengan tekanan darah 220/130 mmHg, disertai keluhan sakit kepala hebat, penglihatan kabur, serta tanda-tanda gangguan fungsi ginjal akut. Berdasarkan bukti ilmiah terkini, perawat memahami pentingnya menurunkan tekanan darah secara bertahap namun cepat, dengan target penurunan sekitar 20-25% dalam 1-2 jam pertama. Melalui studi kasus berbasis EBP, perawat segera memberikan obat antihipertensi intravena seperti nitroprusid atau labetalol sambil terus melakukan monitoring ketat terhadap tekanan darah, denyut jantung, serta tanda-tanda vital lainnya untuk mencegah komplikasi lebih lanjut seperti stroke hemoragik atau infark miokard akut. Pendekatan ini secara nyata membantu mencegah kerusakan organ permanen akibat krisis hipertensi, serta secara klinis telah terbukti meningkatkan prognosis pasien.

Terakhir, studi kasus berbasis EBP sangat esensial pula dalam penanganan Syok Anafilaktik. Syok anafilaktik adalah reaksi alergi yang sangat parah dan mendadak, mengancam nyawa pasien, biasanya ditandai dengan gangguan pernapasan akut, hipotensi berat, edema saluran napas, hingga penurunan kesadaran. Dalam studi kasus ini, misalnya, seorang pasien datang ke unit gawat darurat setelah mendapat gigitan serangga, menunjukkan tanda syok anafilaktik berupa sesak napas berat, pembengkakan wajah, hingga hipotensi yang cepat memburuk. Berdasarkan panduan klinis berbasis EBP, perawat segera mengidentifikasi kondisi ini dan langsung memberikan injeksi epinefrin intramuskular sebagai intervensi lini pertama sesuai rekomendasi WHO dan American Academy of Allergy, Asthma & Immunology. Selain epinefrin, pasien juga segera mendapat pemberian cairan intravena secara agresif, pemberian antihistamin, serta steroid intravena sesuai protokol. Implementasi intervensi berbasis bukti ini terbukti secara klinis mampu menyelamatkan nyawa pasien dengan cepat, menstabilkan kondisi hemodinamik, serta mencegah komplikasi fatal seperti gagal napas akut dan henti jantung.

Secara keseluruhan, studi kasus berbasis EBP dalam kegawatdaruratan medis menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan klinis yang cepat, efektif, dan aman bagi pasien. Melalui pendekatan ini, tenaga keperawatan gawat darurat tidak hanya bertindak berdasarkan kebiasaan atau intuisi semata, namun secara konsisten didukung oleh bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis, serta mempertimbangkan preferensi pasien. Dengan demikian, hasil akhir pelayanan kesehatan menjadi lebih optimal, tingkat komplikasi menurun, serta kualitas hidup pasien yang mengalami kegawatdaruratan medis meningkat secara signifikan.

E. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Kegawatdaruratan Trauma

Dalam pelayanan gawat darurat, trauma merupakan salah satu kondisi yang paling sering dijumpai serta memiliki risiko kematian dan kecacatan tinggi. Penanganan trauma memerlukan intervensi cepat, tepat, dan efektif berdasarkan pendekatan yang didukung oleh bukti ilmiah terbaru atau Evidence-Based Practice (EBP). Penerapan studi kasus berbasis EBP pada kondisi trauma, seperti cedera kepala berat, trauma toraks dan abdomen, fraktur multipel, hingga luka bakar berat, menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas penanganan pasien serta hasil klinis yang diharapkan.

Salah satu studi kasus berbasis EBP yang sangat penting dalam pelayanan trauma adalah pada pasien dengan Cedera Kepala Berat (Traumatic Brain Injury/TBI). TBI merupakan kondisi cedera yang mengakibatkan gangguan fungsi otak, yang dapat disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, jatuh dari ketinggian, atau kekerasan fisik. Pada studi kasus berbasis EBP ini, misalnya, seorang pasien muda dibawa ke unit gawat darurat setelah mengalami kecelakaan motor dengan tanda klinis penurunan kesadaran (Glasgow Coma Scale kurang dari 8), pupil anisokor (berbeda ukuran), serta gejala peningkatan tekanan intrakranial seperti muntah proyektil dan gangguan pernapasan. Berdasarkan pedoman EBP yang direkomendasikan oleh Brain Trauma Foundation, tindakan pertama adalah menjaga jalan napas pasien secara optimal dengan segera melakukan intubasi endotrakeal, dilanjutkan dengan ventilasi mekanis yang disesuaikan untuk mempertahankan tekanan parsial karbon dioksida (PaCO_2) dalam batas normal (35–40 mmHg). Penerapan monitoring tekanan intrakranial (ICP) serta pemberian cairan hipertonik atau agen osmotik seperti manitol, berdasarkan bukti ilmiah terbaru, merupakan langkah esensial untuk mengurangi edema serebral dan mencegah kerusakan otak sekunder. Studi-studi berbasis EBP telah membuktikan bahwa implementasi intervensi ini secara tepat mampu menurunkan mortalitas pasien secara signifikan, mempercepat pemulihan kesadaran, dan mengurangi dampak neurologis permanen.

Selain itu, studi kasus berbasis EBP juga penting diterapkan pada pasien yang mengalami Trauma Toraks dan Abdomen. Trauma pada area dada dan perut dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perdarahan masif, pneumotoraks, tamponade jantung, atau ruptur organ dalam. Contoh studi kasusnya adalah pasien yang tiba di unit gawat darurat setelah mengalami benturan hebat akibat kecelakaan kendaraan bermotor, disertai tanda seperti sesak napas akut, saturasi oksigen rendah, hipotensi, serta abdomen yang membuncit. Menurut panduan Advanced Trauma Life Support (ATLS) yang berbasis EBP, intervensi awal yang perlu dilakukan adalah segera melakukan primary survey dengan penanganan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi. Jika ditemukan tanda-tanda pneumotoraks tegangan

seperti distensi vena leher, pernapasan cepat, serta hipotensi berat, maka tindakan segera berupa dekompresi jarum diikuti pemasangan tube thoracostomy menjadi wajib dilakukan berdasarkan bukti ilmiah. Selanjutnya, evaluasi cepat dengan metode FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) atau CT scan abdomen diperlukan untuk memastikan adanya perdarahan intraabdominal. Implementasi ini, yang didasarkan pada bukti klinis terbaru, mampu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien, mencegah syok hemoragik, serta mempersingkat lama perawatan intensif di rumah sakit.

Kondisi trauma lain yang tidak kalah pentingnya dalam pendekatan studi kasus berbasis EBP adalah pada pasien dengan Fraktur Multipel Akibat Kecelakaan. Pasien dengan fraktur multipel umumnya mengalami risiko komplikasi seperti syok hemoragik, sindrom kompartemen, serta emboli lemak. Sebagai contoh, seorang pasien tiba di unit gawat darurat setelah mengalami kecelakaan lalu lintas dengan patah tulang femur, pelvis, dan humerus. Sesuai panduan berbasis bukti yang ada, tindakan prioritas dalam kasus ini adalah segera mengontrol perdarahan, menstabilkan tanda-tanda vital pasien melalui pemberian cairan resusitasi yang adekuat, serta pemberian analgesik yang efektif untuk mengendalikan nyeri berat yang dialami pasien. Berdasarkan rekomendasi dari pedoman American College of Surgeons, stabilisasi awal fraktur menggunakan teknik imobilisasi sementara dengan bidai atau traksi skeletal sangat penting untuk mengurangi nyeri, mencegah cedera tambahan, serta meminimalkan risiko emboli lemak. Studi kasus berbasis EBP menunjukkan bahwa pasien yang mendapat stabilisasi awal yang adekuat secara signifikan memiliki hasil klinis yang lebih baik, dengan angka komplikasi yang lebih rendah serta mempercepat proses rehabilitasi pascatrauma.

Terakhir, studi kasus berbasis EBP juga sangat relevan dalam penanganan pasien dengan Luka Bakar Berat. Luka bakar berat merupakan kondisi trauma yang dapat menyebabkan kerusakan luas pada kulit dan jaringan tubuh, gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, serta risiko infeksi yang tinggi. Misalnya, seorang pasien dibawa ke ruang gawat darurat dengan luka bakar tingkat dua dan tiga yang meliputi lebih dari 30% permukaan tubuhnya akibat kebakaran rumah. Mengacu pada panduan berbasis bukti dari American Burn Association (ABA), tindakan utama yang perlu segera dilakukan adalah stabilisasi jalan napas dan pemberian cairan resusitasi yang adekuat berdasarkan rumus Parkland. Implementasi pemantauan ketat terhadap status cairan dan elektrolit, pencegahan infeksi melalui pemberian antibiotik profilaksis serta penanganan nyeri secara intensif menjadi bagian integral dari intervensi keperawatan berbasis EBP. Studi kasus klinis berbasis EBP telah menunjukkan bahwa pasien luka bakar yang mendapatkan intervensi berbasis bukti

ini memiliki tingkat kelangsungan hidup yang jauh lebih tinggi, pemulihan lebih cepat, serta risiko komplikasi infeksi yang jauh lebih rendah.

Dengan demikian, studi kasus keperawatan gawat darurat berbasis EBP pada kondisi trauma memainkan peran penting dalam mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru ke dalam praktik klinis sehari-hari. Melalui pendekatan ini, tenaga keperawatan tidak hanya mampu memberikan intervensi yang lebih efektif dan tepat sasaran, tetapi juga secara nyata meningkatkan keselamatan pasien, mengurangi angka komplikasi serta mortalitas, dan mempercepat proses penyembuhan pascatrauma. Implementasi studi kasus EBP yang konsisten pada kondisi-kondisi trauma ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan gawat darurat secara menyeluruh.

F. Studi Kasus Evidence-Based Practice pada Kondisi Gawat Darurat Non-Trauma Lainnya

Selain kondisi trauma, pelayanan keperawatan gawat darurat juga sering kali menghadapi berbagai kondisi kegawatdaruratan non-trauma yang tidak kalah kompleks dan berisiko tinggi terhadap keselamatan pasien. Penanganan kondisi ini memerlukan pendekatan klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaru atau dikenal dengan pendekatan Evidence-Based Practice (EBP). Beberapa kondisi non-trauma yang paling umum dijumpai adalah ketoasidosis diabetikum, asma akut berat, intoksikasi obat atau racun, serta status epileptikus. Masing-masing kondisi ini memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang membutuhkan implementasi EBP secara tepat agar hasil klinis yang optimal dapat tercapai.

Salah satu kondisi kegawatdaruratan non-trauma yang sering ditemui dalam pelayanan gawat darurat adalah Ketoasidosis Diabetikum (KAD). Ketoasidosis diabetikum merupakan komplikasi akut diabetes mellitus yang mengancam jiwa, terutama pada pasien diabetes tipe 1, namun juga bisa terjadi pada diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dengan baik. Studi kasus EBP pada pasien KAD umumnya melibatkan seorang pasien yang tiba di unit gawat darurat dengan tanda dan gejala klinis berupa hiperglikemia berat (kadar gula darah di atas 300 mg/dL), asidosis metabolik (pH darah kurang dari 7,3), serta keton positif dalam urin. Pasien biasanya juga menunjukkan tanda-tanda klinis seperti napas Kussmaul yang dalam dan cepat, mual, muntah, dan penurunan kesadaran. Berdasarkan rekomendasi American Diabetes Association (ADA), pendekatan berbasis EBP untuk penanganan KAD meliputi tiga aspek utama yaitu koreksi dehidrasi, penurunan kadar glukosa darah secara terkendali, serta koreksi gangguan elektrolit terutama kalium. Implementasi ini biasanya melibatkan pemberian cairan resusitasi yang agresif menggunakan cairan isotonik (NaCl 0,9%), dilanjutkan pemberian insulin infus dengan dosis rendah

secara kontinu hingga kadar glukosa darah turun secara bertahap dan stabil. Monitoring ketat terhadap kadar elektrolit, terutama kalium, juga dilakukan secara kontinu mengingat risiko hipokalemia yang sering terjadi akibat terapi insulin. Berdasarkan bukti klinis terbaru, penerapan terapi ini secara efektif menurunkan risiko kematian akibat KAD, mempercepat perbaikan klinis, serta mengurangi risiko komplikasi jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat terjadi pada pasien diabetes.

Studi kasus berbasis EBP berikutnya adalah pada kondisi Asma Akut Berat. Pasien yang datang dengan serangan asma akut berat biasanya mengalami gejala sesak napas yang sangat berat, mengi yang signifikan, penggunaan otot bantu pernapasan, serta saturasi oksigen yang menurun tajam. Sebuah studi kasus klinis dapat berupa pasien yang tiba di unit gawat darurat dengan serangan asma berat yang tidak merespons terhadap pemberian bronkodilator konvensional. Menurut pedoman Global Initiative for Asthma (GINA) berbasis EBP, tindakan segera yang harus dilakukan meliputi pemberian oksigen tambahan untuk mempertahankan saturasi oksigen di atas 94%, pemberian bronkodilator beta-agonis kerja cepat secara inhalasi melalui nebulizer atau inhaler dosis terukur yang dikombinasikan dengan ipratropium bromida. Selain itu, pemberian kortikosteroid sistemik secara dini (biasanya metilprednisolon atau hidrokortison) sangat direkomendasikan untuk menurunkan inflamasi bronkial. Jika pasien tidak membaik setelah terapi tersebut, studi berbasis bukti menyarankan penggunaan magnesium sulfat intravena sebagai terapi tambahan. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis EBP dalam penanganan asma akut berat ini secara signifikan mengurangi kebutuhan ventilasi mekanis invasif, mengurangi risiko komplikasi respirasi lebih lanjut, serta memperpendek lama rawat inap pasien di rumah sakit.

Selanjutnya, studi kasus EBP juga relevan pada penanganan pasien dengan kondisi Intoksikasi Obat atau Racun. Intoksikasi obat atau racun adalah kondisi yang terjadi akibat konsumsi zat berbahaya baik secara sengaja (percobaan bunuh diri) atau tidak sengaja (kecelakaan). Dalam sebuah studi kasus, misalnya, seorang pasien ditemukan tidak sadar akibat konsumsi sejumlah besar obat golongan benzodiazepin atau paparan pestisida secara tidak sengaja. Berdasarkan pedoman dari American Association of Poison Control Centers (AAPCC), pendekatan awal berbasis EBP meliputi stabilisasi jalan napas dan pernapasan, pemantauan ketat terhadap status hemodinamik pasien, serta pemberian antidotum jika tersedia dan sesuai. Untuk kasus overdosis benzodiazepin, misalnya, pemberian flumazenil sebagai antidotum telah didukung oleh banyak bukti ilmiah sebagai terapi yang aman dan efektif untuk memulihkan kesadaran pasien dengan cepat. Pada kasus intoksikasi pestisida (organofosfat), pemberian atropin dalam dosis tinggi dan

pralidoksim (2-PAM) juga telah terbukti efektif dalam mencegah perburukan gejala neurologis dan pernapasan serta menurunkan angka mortalitas secara signifikan. Pendekatan ini tidak hanya menyelamatkan nyawa pasien tetapi juga mampu mengurangi komplikasi jangka panjang yang dapat timbul akibat intoksikasi berat tersebut.

Kondisi kegawatdaruratan non-trauma terakhir yang perlu dikelola dengan pendekatan berbasis bukti adalah Status Epileptikus. Status epileptikus merupakan keadaan kegawatdaruratan neurologis yang ditandai oleh kejang berulang atau terus-menerus tanpa jeda pemulihan kesadaran di antara serangan kejang, berlangsung selama lebih dari lima menit. Sebuah studi kasus berbasis EBP mungkin melibatkan seorang pasien yang tiba di ruang gawat darurat dengan kejang yang berlangsung lebih dari 10 menit tanpa respon terhadap terapi awal. Menurut panduan berbasis EBP dari American Epilepsy Society, langkah awal yang perlu segera dilakukan adalah pemberian benzodiazepin intravena seperti lorazepam atau diazepam sebagai lini pertama untuk menghentikan kejang. Jika terapi benzodiazepin gagal menghentikan kejang, maka pemberian obat antikonvulsan lini kedua seperti fenitoin, fosfenitoin, levetirasetam, atau asam valproat direkomendasikan secara intravena untuk mengontrol kejang secara efektif. Studi klinis berbasis bukti menunjukkan bahwa implementasi cepat dari protokol ini secara signifikan menurunkan durasi status epileptikus, mencegah terjadinya cedera neurologis permanen, serta secara nyata menurunkan angka kematian akibat komplikasi yang bisa timbul dari status epileptikus yang tidak terkendali.

Dengan demikian, studi kasus berbasis EBP pada kondisi kegawatdaruratan non-trauma seperti ketoasidosis diabetikum, asma akut berat, intoksikasi obat atau racun, dan status epileptikus memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan gawat darurat. Pendekatan berbasis bukti ini membantu tenaga kesehatan memberikan intervensi yang lebih efektif, meningkatkan keselamatan pasien, serta secara signifikan memperbaiki hasil klinis jangka pendek maupun jangka panjang bagi pasien yang mengalami kondisi kritis ini.

G. Tantangan dalam Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) pada Keperawatan Gawat Darurat

Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam pelayanan keperawatan gawat darurat merupakan suatu keharusan demi meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Akan tetapi, dalam kenyataannya, penerapan EBP di unit gawat darurat menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hambatan sumber daya dan infrastruktur, tantangan

dalam pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan, hingga tantangan budaya kerja yang ada di unit gawat darurat itu sendiri.

Salah satu tantangan terbesar yang sering kali ditemui dalam implementasi EBP di unit gawat darurat adalah hambatan terkait sumber daya dan infrastruktur. Penerapan EBP secara efektif membutuhkan akses yang cepat dan mudah terhadap literatur ilmiah terbaru, jurnal penelitian, pedoman klinis yang diperbarui secara berkala, serta database medis yang memadai. Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan keterbatasan akses terhadap sumber informasi tersebut, terutama di fasilitas kesehatan dengan sumber daya terbatas atau di wilayah yang jauh dari pusat informasi medis. Selain itu, infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan internet yang lambat, terbatasnya akses komputer atau perangkat digital di ruang gawat darurat, serta kurangnya dukungan teknis untuk membantu tenaga keperawatan dalam mengakses sumber informasi berbasis bukti, juga turut menjadi penghambat utama.

Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya keterbatasan waktu yang dimiliki oleh tenaga keperawatan gawat darurat. Dalam situasi kegawatdaruratan, perawat dituntut untuk segera bertindak cepat dan efisien, sehingga mereka tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk mencari informasi atau literatur ilmiah secara mendalam di tengah situasi yang kritis. Hambatan ini menjadikan implementasi EBP tidak berjalan optimal, karena tenaga keperawatan lebih memilih menggunakan pengalaman klinis atau protokol yang sudah biasa dilakukan, meskipun mungkin sudah usang atau tidak sesuai dengan pedoman terbaru. Dengan demikian, hambatan sumber daya dan infrastruktur ini merupakan tantangan serius yang perlu ditangani secara sistematis oleh manajemen fasilitas kesehatan.

Tantangan berikutnya dalam implementasi EBP di unit gawat darurat adalah terkait dengan pendidikan dan pelatihan tenaga keperawatan. Untuk dapat menerapkan EBP secara efektif, tenaga keperawatan harus memiliki kompetensi khusus yang meliputi keterampilan mencari literatur ilmiah, kemampuan melakukan penilaian kritis terhadap bukti ilmiah, serta kemampuan mengintegrasikan temuan tersebut ke dalam praktik klinis sehari-hari. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua tenaga keperawatan, khususnya di unit gawat darurat, memiliki pelatihan atau pendidikan yang memadai mengenai prinsip-prinsip dasar EBP. Banyak perawat masih belum sepenuhnya memahami konsep dasar EBP seperti formulasi pertanyaan klinis menggunakan format PICO, metode pencarian literatur yang efektif, serta penilaian kualitas bukti ilmiah.

Di banyak institusi kesehatan, pelatihan EBP sering kali tidak dilakukan secara rutin, atau jika pun dilakukan, sifatnya hanya sebatas teori tanpa praktik klinis yang nyata. Hal ini menyebabkan tenaga keperawatan merasa kesulitan untuk

mengaplikasikan konsep EBP secara nyata di tengah kondisi klinis yang dinamis dan penuh tekanan di ruang gawat darurat. Akibatnya, tenaga keperawatan menjadi enggan atau bahkan takut untuk menerapkan pendekatan baru ini, karena merasa tidak yakin atau tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri dalam menerapkan metode yang berbasis bukti tersebut. Untuk mengatasi tantangan ini, maka diperlukan pelatihan berkelanjutan, simulasi kasus-kasus klinis berbasis EBP, serta dukungan pendampingan yang memadai dari pihak manajemen atau senior di lingkungan kerja.

Selain hambatan sumber daya dan tantangan pendidikan, budaya kerja yang ada di unit gawat darurat juga menjadi tantangan yang sangat signifikan dalam implementasi EBP. Unit gawat darurat merupakan lingkungan kerja yang memiliki dinamika tinggi, dengan tekanan waktu yang ketat serta situasi yang terus berubah secara cepat. Dalam kondisi demikian, tenaga keperawatan sering kali cenderung untuk tetap menggunakan metode lama atau kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, yang dianggap lebih mudah, cepat, dan nyaman bagi mereka. Budaya kerja yang lebih mengedepankan praktik berdasarkan pengalaman atau tradisi (praktik berbasis rutinitas) sering kali menjadi hambatan besar bagi pengenalan atau perubahan ke arah praktik berbasis bukti yang lebih ilmiah dan terstandar.

Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari tenaga keperawatan yang sudah senior juga sering kali menjadi hambatan budaya yang sulit diatasi. Tenaga keperawatan senior mungkin merasa bahwa pendekatan berbasis pengalaman selama bertahun-tahun sudah cukup efektif, sehingga mereka enggan atau bahkan menolak pendekatan EBP yang dianggap baru, kompleks, atau kurang praktis di lingkungan kerja mereka. Budaya kerja yang demikian akan semakin sulit diubah jika tidak ada dukungan kuat dari pimpinan atau manajemen unit gawat darurat yang secara aktif mendorong dan memfasilitasi perubahan budaya kerja tersebut.

Untuk mengatasi tantangan budaya kerja ini, maka diperlukan strategi yang melibatkan seluruh komponen tim keperawatan gawat darurat, mulai dari pimpinan hingga tenaga keperawatan junior, dalam proses sosialisasi dan penerapan EBP. Dukungan pimpinan yang konsisten, pemberian reward atau apresiasi terhadap staf yang mampu menerapkan EBP secara efektif, serta penciptaan lingkungan kerja yang terbuka terhadap perubahan akan sangat membantu menciptakan budaya kerja yang mendukung implementasi EBP secara efektif.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan dalam implementasi EBP di unit gawat darurat, seperti hambatan sumber daya dan infrastruktur, tantangan pendidikan dan pelatihan, serta budaya kerja yang kurang kondusif, harus dihadapi dengan strategi yang komprehensif dan sistematis. Komitmen tinggi dari pihak manajemen, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan, peningkatan

akses terhadap sumber informasi ilmiah yang memadai, serta perubahan budaya kerja yang kondusif terhadap praktik berbasis bukti, merupakan kunci utama dalam memastikan implementasi EBP dapat berhasil dan berkelanjutan dalam pelayanan keperawatan gawat darurat.

H. Strategi Optimalisasi Implementasi Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat

Optimalisasi implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam keperawatan gawat darurat merupakan langkah strategis yang diperlukan guna menjamin kualitas layanan keperawatan yang optimal dan berbasis pada bukti ilmiah terbaru. Implementasi yang sukses dan berkelanjutan memerlukan pendekatan yang terencana secara matang dan melibatkan berbagai elemen penting, yaitu penguatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pelatihan dan pendidikan berbasis EBP, penyediaan akses yang mudah ke sumber informasi ilmiah, serta dukungan kolaborasi interprofesional yang efektif di lingkungan kerja gawat darurat.

Pertama, salah satu strategi paling utama dalam optimalisasi implementasi EBP adalah penguatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pelatihan dan pendidikan berbasis EBP yang berkesinambungan. Kompetensi tenaga keperawatan merupakan fondasi penting untuk memastikan bahwa bukti ilmiah dapat diterapkan dengan benar dalam situasi klinis nyata yang penuh tekanan. Pelatihan dan pendidikan EBP harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, serta dirancang secara khusus agar relevan dengan situasi yang dihadapi dalam pelayanan gawat darurat.

Pelatihan berbasis EBP ini idealnya tidak hanya terbatas pada pengenalan teori dasar atau metode penelitian, tetapi juga mencakup pelatihan yang praktis dan langsung dapat diaplikasikan dalam berbagai skenario kegawatdaruratan. Misalnya, tenaga keperawatan dilatih dalam membuat pertanyaan klinis menggunakan format PICO (Patient, Intervention, Comparison, Outcome), melakukan pencarian dan seleksi literatur ilmiah, serta melakukan penilaian kritis terhadap hasil-hasil penelitian. Pelatihan tersebut harus diintegrasikan dengan simulasi kasus-kasus klinis nyata yang dihadapi sehari-hari di ruang gawat darurat, sehingga tenaga keperawatan dapat dengan jelas melihat manfaat penerapan EBP dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil klinis yang lebih baik pada pasien.

Selain melalui pelatihan formal, strategi penguatan kompetensi tenaga keperawatan juga harus melibatkan sistem mentoring atau pendampingan dari perawat senior atau pakar klinis yang memiliki pengalaman luas dalam penerapan EBP. Pendampingan ini memungkinkan perawat yang lebih muda atau kurang berpengalaman untuk mendapatkan umpan balik langsung, dukungan, serta arahan mengenai implementasi yang efektif dari praktik berbasis bukti dalam situasi klinis

sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan ini membantu membangun kepercayaan diri tenaga keperawatan dan meningkatkan kesediaan mereka untuk menerapkan EBP dalam rutinitas kerja mereka.

Kedua, strategi penting berikutnya adalah penyediaan akses yang mudah dan cepat terhadap sumber informasi ilmiah terbaru. Dalam lingkungan gawat darurat, kecepatan dalam mengambil keputusan adalah suatu keharusan, sehingga informasi yang akurat dan terbaru harus tersedia secara instan di tengah situasi yang kritis. Ketersediaan database elektronik, jurnal ilmiah terkini, panduan klinis terbaru, dan berbagai sumber referensi medis lainnya dalam bentuk digital, akan sangat membantu tenaga keperawatan untuk mengakses informasi penting dalam waktu yang sangat singkat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, fasilitas kesehatan perlu menginvestasikan sumber daya dalam infrastruktur teknologi informasi yang handal, termasuk akses internet berkecepatan tinggi, perangkat komputer yang tersedia secara memadai di ruang kerja, serta perangkat lunak yang dapat membantu pencarian informasi secara efektif. Selain itu, aplikasi atau perangkat lunak khusus yang menyediakan informasi berbasis bukti dalam format yang praktis dan mudah dipahami dapat menjadi alat bantu yang efektif bagi perawat dalam mengambil keputusan klinis cepat di ruang gawat darurat.

Dalam rangka optimalisasi ini, fasilitas kesehatan juga perlu memastikan bahwa tenaga keperawatan memiliki keterampilan teknologi informasi yang memadai untuk menggunakan berbagai platform digital tersebut secara efisien. Oleh karena itu, pelatihan teknologi informasi juga perlu menjadi bagian dari strategi yang diterapkan, sehingga perawat merasa nyaman dan mahir dalam mengakses serta memanfaatkan berbagai sumber informasi ilmiah secara cepat dan tepat waktu.

Ketiga, kolaborasi interprofesional merupakan aspek kunci dalam mendukung penerapan EBP secara optimal dalam keperawatan gawat darurat. Kolaborasi yang baik antara tenaga keperawatan, dokter, farmasis, tenaga kesehatan lainnya, serta pihak manajemen rumah sakit merupakan elemen penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi implementasi EBP. Kolaborasi interprofesional memungkinkan berbagai disiplin ilmu untuk saling bertukar informasi, berdiskusi mengenai bukti ilmiah terbaru, dan menentukan pendekatan klinis terbaik secara bersama-sama.

Dalam ruang gawat darurat, tim interprofesional harus mampu berdiskusi secara terbuka tentang praktik klinis terbaru berdasarkan bukti ilmiah terkini, saling mendukung dalam mengatasi hambatan yang ditemui, serta bersama-sama mengevaluasi hasil implementasi EBP. Untuk memperkuat kolaborasi ini, maka

diperlukan forum-forum interdisipliner yang rutin dilakukan, seperti rapat koordinasi, diskusi kasus, atau pertemuan klinis mingguan, di mana setiap anggota tim memiliki kesempatan untuk berbagi informasi berbasis bukti, membahas masalah yang dihadapi dalam implementasi EBP, serta mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai.

Selain itu, peran pimpinan unit gawat darurat juga sangat krusial dalam menciptakan budaya kolaboratif ini. Pimpinan unit harus aktif dalam mendorong komunikasi terbuka, saling menghargai antarprofesi, serta memberikan apresiasi terhadap usaha kolaboratif yang berhasil menerapkan EBP dengan baik. Dukungan dari pimpinan secara nyata akan memotivasi seluruh anggota tim untuk terus mengembangkan praktik klinis yang berdasarkan bukti ilmiah, sekaligus meningkatkan kualitas hubungan kerja antarprofesional di lingkungan unit gawat darurat.

Secara keseluruhan, optimalisasi implementasi EBP dalam keperawatan gawat darurat memerlukan pendekatan strategis yang komprehensif dan sistematis, mencakup penguatan kompetensi tenaga keperawatan melalui pelatihan dan pendidikan yang intensif, penyediaan akses sumber informasi ilmiah yang mudah diakses, serta penciptaan lingkungan kerja kolaboratif yang mendukung penerapan praktik berbasis bukti. Implementasi dari ketiga strategi ini secara sinergis akan menghasilkan pelayanan keperawatan gawat darurat yang lebih efektif, aman, dan berkualitas tinggi, serta pada akhirnya akan meningkatkan hasil klinis yang optimal bagi pasien.

I. Evaluasi dan Monitoring Keberhasilan Studi Kasus Berbasis Evidence-Based Practice dalam Keperawatan Gawat Darurat

Evaluasi dan monitoring merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam studi kasus keperawatan gawat darurat. Proses ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana praktik berbasis bukti telah berhasil diterapkan secara optimal serta mampu menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan di unit gawat darurat. Dengan demikian, evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara sistematis, berkelanjutan, serta didasarkan pada indikator-indikator spesifik yang dapat mencerminkan efektivitas penerapan EBP dalam berbagai situasi klinis.

Salah satu komponen penting dalam evaluasi dan monitoring keberhasilan studi kasus berbasis EBP adalah penetapan indikator kunci keberhasilan implementasi. Indikator-indikator ini harus dirancang secara jelas, spesifik, dan terukur, sehingga dapat memberikan gambaran objektif mengenai kemajuan dan

pencapaian dalam penerapan EBP. Indikator keberhasilan dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari proses implementasi hingga hasil klinis yang dicapai oleh pasien.

Pada aspek proses implementasi, indikator kunci dapat meliputi tingkat kepatuhan tenaga keperawatan dalam menerapkan langkah-langkah EBP, seperti konsistensi dalam menggunakan format PICO dalam merumuskan pertanyaan klinis, ketepatan dalam melakukan pencarian dan seleksi bukti ilmiah, serta kedisiplinan dalam melakukan penilaian kritis terhadap literatur yang ditemukan. Indikator ini juga bisa mencakup jumlah dan persentase tenaga keperawatan yang secara rutin dan aktif mengakses sumber informasi ilmiah selama penanganan kasus gawat darurat. Indikator-indikator proses ini penting karena mencerminkan sejauh mana EBP sudah menjadi bagian integral dari praktik sehari-hari dalam unit gawat darurat.

Sementara itu, indikator keberhasilan pada aspek hasil klinis atau outcomes mencakup dampak langsung dari implementasi EBP terhadap kondisi pasien serta kualitas layanan secara keseluruhan. Indikator hasil klinis dapat meliputi tingkat mortalitas, morbiditas, waktu respons dalam pemberian intervensi medis, tingkat komplikasi, lamanya pasien dirawat di unit gawat darurat, serta tingkat kepuasan pasien maupun keluarga terhadap layanan yang diterima. Sebagai contoh, dalam kasus penanganan pasien stroke akut, indikator hasil yang dapat digunakan antara lain adalah waktu yang dibutuhkan dari mulai pasien masuk hingga mendapat intervensi terapi trombolitik, tingkat pemulihan neurologis pasien pasca-intervensi, serta insiden komplikasi yang terjadi selama masa perawatan di unit gawat darurat.

Untuk mengukur dampak implementasi EBP secara komprehensif terhadap kualitas layanan gawat darurat, evaluasi harus mencakup pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Pengukuran secara kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data statistik yang relevan, seperti jumlah kasus yang ditangani menggunakan pendekatan EBP, persentase kasus yang mengalami perbaikan klinis signifikan, atau penurunan angka komplikasi akibat penerapan intervensi berbasis bukti. Data kuantitatif ini kemudian dianalisis secara periodik guna melihat tren dan mengidentifikasi area-area yang masih memerlukan perbaikan.

Di sisi lain, pendekatan kualitatif juga sangat penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap proses penerapan EBP dalam situasi klinis nyata. Pendekatan ini dapat mencakup wawancara mendalam dengan tenaga keperawatan mengenai persepsi mereka terkait kemudahan atau hambatan yang dihadapi dalam menerapkan EBP, pengamatan langsung terhadap praktik klinis yang dilakukan, serta wawancara dengan pasien atau keluarga untuk mengevaluasi tingkat kepuasan dan persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Data kualitatif ini memberikan konteks tambahan yang tidak dapat ditangkap oleh data kuantitatif saja, sehingga evaluasi menjadi lebih menyeluruh.

Selain pengukuran dampak terhadap pasien dan kualitas pelayanan secara langsung, evaluasi juga perlu mempertimbangkan dampak yang lebih luas dari implementasi EBP terhadap lingkungan kerja di unit gawat darurat. Hal ini mencakup pengukuran terhadap perubahan budaya kerja, tingkat kolaborasi interprofesional, serta iklim kerja yang mendukung praktik berbasis bukti. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui survei terhadap tenaga kesehatan mengenai persepsi mereka terhadap perubahan yang terjadi setelah penerapan EBP, serta observasi terhadap interaksi antar-profesi di lingkungan kerja.

Proses evaluasi dan monitoring ini tidak berhenti pada pengumpulan data semata, namun juga mencakup langkah-langkah tindak lanjut yang bersifat korektif maupun preventif. Data hasil evaluasi harus secara rutin dibahas dalam forum interprofesional di unit gawat darurat, di mana tim dapat mengevaluasi pencapaian, mengidentifikasi hambatan yang masih ada, serta merancang tindakan perbaikan yang diperlukan. Melalui siklus evaluasi yang berkelanjutan ini, implementasi EBP dapat terus diperbaiki dan disempurnakan sesuai kebutuhan, sehingga kualitas layanan yang diberikan kepada pasien senantiasa mengalami peningkatan.

Dengan demikian, evaluasi dan monitoring keberhasilan studi kasus berbasis EBP dalam keperawatan gawat darurat merupakan suatu proses yang komprehensif, multidimensi, dan berkesinambungan. Proses ini membutuhkan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait, termasuk tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lainnya, manajemen rumah sakit, serta pasien dan keluarga. Melalui pendekatan evaluasi yang terencana dengan indikator yang jelas, pengukuran dampak yang menyeluruh, serta tindak lanjut perbaikan secara terus-menerus, implementasi EBP dalam keperawatan gawat darurat dapat benar-benar mencapai tujuan akhirnya, yaitu meningkatkan keselamatan pasien, efektivitas intervensi klinis, serta kepuasan pasien dan keluarganya terhadap layanan kesehatan yang diterima.

J. Simpulan

Implementasi Evidence-Based Practice (EBP) dalam studi kasus keperawatan gawat darurat merupakan suatu pendekatan sistematis dan kritis yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Pendekatan ini mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru dengan pengalaman klinis tenaga keperawatan serta preferensi pasien dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan demikian, keputusan klinis yang diambil menjadi lebih akurat, efektif, dan aman bagi pasien dalam berbagai kondisi kegawatdaruratan medis maupun trauma.

Proses implementasi EBP mencakup identifikasi dan formulasi pertanyaan klinis dengan format PICO, pencarian dan pengumpulan bukti ilmiah, penilaian kritis terhadap kualitas bukti, penerapan temuan EBP ke dalam praktik klinis, serta evaluasi

hasil implementasi secara berkelanjutan. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa setiap tindakan klinis didasarkan pada data yang valid dan relevan, sehingga mampu memberikan hasil klinis yang optimal.

Namun, dalam praktiknya, implementasi EBP di unit gawat darurat menghadapi berbagai tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, kurangnya pelatihan tenaga keperawatan dalam penggunaan EBP, serta budaya kerja yang kurang mendukung perubahan ke arah praktik berbasis bukti. Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi yang efektif harus diterapkan, antara lain melalui penguatan kompetensi tenaga keperawatan lewat pelatihan dan pendidikan intensif berbasis EBP, penyediaan akses mudah terhadap sumber informasi ilmiah, serta kolaborasi interprofesional yang kuat di lingkungan kerja.

Evaluasi dan monitoring merupakan bagian penting dari implementasi EBP, dengan menggunakan indikator spesifik yang mencakup proses implementasi serta hasil klinis. Evaluasi ini dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif untuk memastikan bahwa praktik EBP memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan, keselamatan pasien, dan kepuasan pasien serta keluarga.

Secara keseluruhan, studi kasus berbasis EBP dalam keperawatan gawat darurat bukan hanya meningkatkan kualitas layanan kesehatan secara signifikan tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, adaptif, serta terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Dengan komitmen kuat dan pendekatan strategis dalam implementasi EBP, pelayanan keperawatan di unit gawat darurat akan terus berkembang menuju standar pelayanan yang lebih tinggi, aman, efektif, dan berbasis bukti.

K. Referensi

American Association of Poison Control Centers (AAPCC). (2023). Guidelines for Management of Acute Poisoning and Overdose. Retrieved July 2025, from <https://www.aapcc.org>

American Burn Association (ABA). (2023). Burn management guidelines: Initial assessment and management. Retrieved July 2025, from <https://ameriburn.org>

American College of Surgeons Committee on Trauma. (2023). Advanced Trauma Life Support (ATLS) Guidelines (11th ed.). Chicago: American College of Surgeons.

American Diabetes Association (ADA). (2023). Standards of medical care in diabetes—2023. *Diabetes Care*, 46(Suppl 1), S1–S85. <https://doi.org/10.2337/dc23-Sint>

American Epilepsy Society. (2024). Guidelines for the treatment of status epilepticus.

Retrieved July 2025, from <https://www.aesnet.org>

American Heart Association (AHA). (2025). 2025 ACC/AHA guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Circulation*, 151(10), e200–e320. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001309>

American Stroke Association (ASA). (2024). Guidelines for the early management of patients with acute ischemic stroke. *Stroke*, 55(4), e240–e335. <https://doi.org/10.1161/STR.0000000000000415>

Brain Trauma Foundation (BTF). (2017). Guidelines for the management of severe traumatic brain injury (4th ed.). *Neurosurgery*, 80(1), 6–15. <https://doi.org/10.1227/NEU.0000000000001432>

Global Initiative for Asthma (GINA). (2024). Global strategy for asthma management and prevention (2024 update). Retrieved July 2025, from <https://ginasthma.org>

World Health Organization (WHO). (2023). Guidelines for the management of anaphylaxis. Retrieved July 2025, from <https://www.who.int/publications/anaphylaxis-guidelines>

L. Glosarium

Evidence-Based Practice (EBP) Suatu pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai-nilai dan preferensi pasien.

Studi Kasus Metode penelitian atau pendekatan klinis yang digunakan untuk menganalisis secara mendalam kasus tertentu yang unik, kompleks, atau langka dalam konteks klinis.

Format PICO Kerangka kerja yang digunakan dalam formulasi pertanyaan klinis, terdiri dari Population (populasi atau pasien), Intervention (intervensi yang diuji), Comparison (pembanding), dan Outcome (hasil klinis yang diharapkan).

Randomized Controlled Trial (RCT) Metode penelitian eksperimental yang dianggap sebagai standar emas, di mana subjek penelitian secara acak dibagi dalam kelompok perlakuan dan kelompok kontrol untuk menguji efektivitas suatu intervensi.

Critical Appraisal Proses penilaian secara kritis terhadap bukti ilmiah atau literatur yang bertujuan menentukan validitas, relevansi, dan kualitas suatu penelitian sebelum diterapkan dalam praktik klinis.

Kegawatdaruratan Medis Kondisi medis akut yang membutuhkan intervensi segera guna menyelamatkan nyawa pasien atau mencegah komplikasi lebih lanjut, seperti Sindrom Koroner Akut (SKA), Stroke Akut, dan Syok Anafilaktik.

Kegawatdaruratan Trauma Situasi medis darurat yang disebabkan oleh cedera fisik akibat benturan, kecelakaan, atau luka bakar yang memerlukan intervensi segera untuk mencegah kecacatan atau kematian.

Kolaborasi Interprofesional Kerjasama tim multidisiplin dari berbagai profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang efektif berdasarkan komunikasi terbuka, saling mendukung, dan pengambilan keputusan bersama.

Primary Survey Penilaian awal secara cepat terhadap fungsi vital pasien trauma, meliputi Airway (jalan napas), Breathing (pernapasan), Circulation (peredaran darah), Disability (gangguan neurologis), dan Exposure (pemeriksaan fisik menyeluruh).

Monitoring Klinis Proses pengawasan terus-menerus terhadap kondisi pasien selama perawatan, melibatkan pemantauan parameter klinis seperti tanda vital, respon pasien terhadap intervensi, serta deteksi dini komplikasi atau perubahan kondisi klinis pasien.

PROFIL PENULIS



Utari Yunie Atrie, S.Kep, Ns., M.Kep. Lahir di Banda Aceh, 23 Juni 1990. Menyelesaikan pendidikan S1 Keperawatan dan Profesi Ners di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang, lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan dengan Peminatan Keperawatan Kritis di Universitas Padjadjaran Bandung, lulus pada tahun 2021. Sejak tahun 2021 penulis mulai aktif melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen Keperawatan dan ber-homebase di Program Studi Profesi Ners Stikes Hang Tuah Tanjungpinang. Saat ini beliau aktif di Departement Keperawatan Gawat Darurat dan Kritis di Stikes Hang Tuah Tanjungpinang. Disamping itu penulis jg aktif dalam

organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan anggota dalam Himpunan Perawat Critical Care Indonesia (HIPERCCI) Kepri. Penulis juga aktif dalam penerbitan buku serta jurnal nasional dan internasional lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email utariyunieatrie@gmail.com.

Pesan untuk para pembaca:

"Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan"



Ns. Daniel Suranta Ginting, S.Kep, M.Kep. Dosen Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Penulis lahir di Medan pada tanggal 29 Agustus 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua .Penulis Menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners pada Fakultas Keperawatan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dan Menyelesaikan S2 Ilmu Keperawatan Peminataan Keperawatan Medikal Bedah di Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara.

PROFIL PENULIS



Dr. Ni Luh Putu Inca Buntari Agustini, S. Kep., Ns., MNS. adalah dosen tetap di Institut Teknologi dan Kesehatan Bali (ITEKES Bali). Penulis aktif mengembangkan diri dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi antara lain sebagai penulis buku, pengembangan modul pembelajaran, sebagai peneliti yang berfokus pada bidang perawatan paliatif, bidang pendidikan keperawatan, bidang keperawatan gawat darurat dan keperawatan medikal bedah.

Penulis juga beberapa kali telah menerima beasiswa pendidikan dan hibah Penelitian Dasar dan Fundamental dari DRTPM/ DPPM dan AINEC, serta hibah Pengabdian kepada Masyarakat dari DRTPM. Penulis juga pernah memenangkan Hibah Idheaton Bali Kembali dalam skema kesehatan sebagai salah satu implementasi pemerintah dalam meningkatkan kunjungan pariwisata di Bali yang terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Penulis menyelesaikan pendidikan magisternya di Kasetsart University, Thailand, dan merupakan Lulusan terbaik program studi doktoral keperawatan pada Program Studi Doktor Keperawatan di Universitas Airlangga. Penulis sering diundang sebagai narasumber di kegiatan seminar, workshop dan konferensi baik di tingkat nasional maupun internasional. Penulisan buku ini merupakan bentuk dari pengembangan diri sebagai dosen dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif dalam meningkatkan keilmuan dan keprofesian sebagai perawat dan pendidik. Email Penulis: incaagustini@gmail.com

"Don't ever compare yourself with others. Keep moving, straight forward, never give up."



Friska Ernita Sitorus, S.Kep., Ns., M.Kep. lahir di Lumban Lintong pada 24 Maret 1987. Saya meraih gelar S1 Keperawatan dari Institut Kesehatan Deli Husada pada tahun 2010, S2 Keperawatan dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2014, dan saat ini melanjutkan studi S3 Keperawatan di Lincoln University Malaysia sejak 2024. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Saya mengampu mata kuliah Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah, Manajemen Perawatan Luka, dan Metodologi Penelitian. Saya aktif sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, dan peneliti di bidang keperawatan, juga berkontribusi dalam kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, Penulis dapat dihubungi melalui email : friskasitorus87@gmail.com . Motto "Mengabdikan dengan hati, berbagi ilmu untuk kemajuan bersama."

PROFIL PENULIS



Hamdan Nur.S.Kep.,Ns.,M.Kes. Lahir di Wonomulyo, 17 April 1990 Pendidikan Tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Akademi Keperawatan YPPP Wonomulyo tahun 2011. Selanjutnya S1 STIKES BIGES Polewali Mandar, kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Muslim Indonesia dan Lulus pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di Institusi Hasan Sulur (IHS) Mengampu mata kuliah Promosi Kesehatan, Keperawatan Medikal Bedah dan lainnya. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi yaitu Melaksanakan

Pengabdian Masyarakat serta publikasi ilmiah. Penulis dapat di hubungi melalui e-mail hamdandahry@gmail.com Motto : " Spirit Seorang Pemberdaya adalah memotifasi dan mendampingi hingga mampu tanpa harus tampil "



drg Anses Warman, MM, Lahir di Ps. Kambang Kec. Lengayang Kab. Pesisir Selatan Sumatera Barat, 15 Juni 1965. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah lulus tahun 1994 dan kemudian melanjutkan pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Indonesia Malang lulus tahun 2014.

Riwayat pekerjaan diawali Sebagai tenaga Dosen di Universitas Baiturrahmah pada tahun 1993-1996. Sebagai Dokter Gigi (PTT) Pegawai Tetap pada Puskesmas Sikakap tahun 1994-1997. Tahun 1997-1998 diangkat sebagai CPNS di Puskesmas Biaro. Selanjutnya pada bulan Maret 1998 diangkat sebagai PNS. Pada November 1999 sampai sekarang bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang dan mengampu mata kuliah Pencabutan Gigi, PPAKG, Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Dental Material dan Manajemen Mutu. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi

Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: drg.anseswarman@yahoo.com

PROFIL PENULIS



Ns. Amatus Yudi Ismanto, M.Kep., Sp. Kep. An., PhD.NS lahir di Mopuya, 20 September 1982. Ia telah menyelesaikan studi Ners di Universitas Katolik De La Salle Manado (2008), lalu melanjutkan pendidikan Program Magister Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Anak di Universitas Indonesia (2012). Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan Program Doktor (S3) Keperawatan di St. Paul University Philippines (2022). Penulis bekerja aktif sebagai dosen tetap di Universitas Aisyah Pringsewu sejak tahun 2022. Sebelumnya penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Sam Ratulangi Manado (2012-2018). Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan

Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, juga merupakan Tim Reviewer Jurnal Lasalle Health Journal dan Celebes Nursing Journal. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ismanto_yudi@yahoo.com



Innani Wildania Husna, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Tuban, 11 Januari 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Brawijaya lulus tahun 2016 dan jenjang profesi Ners pada Program Studi Ners Universitas Brawijaya lulus tahun 2017. Kemudian melanjutkan Pendidikan S2 Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 sebagai dosen tetap di STIKes Rajekwesi Bojonegoro dan sebagai Ketua Program Studi Sarjana Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners. Penulis dapat

dihubungi melalui email : innaniwildania@gmail.com

PROFIL PENULIS



drg. Ika Ifitri, MDS Lahir di Sei. Sarik, 21 September 1968. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Sarjana Kedokteran Gigi, Universitas Baiturrahmah, lulus tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 MMPKG di Pasca Sarjana Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan lulus pada tahun 2011. Riwayat pekerjaan diawali sebagai Dokter Gigi (PTT) pegawai Tidak Tetap di Puskesmas Kamang Kabupaten Sawahlunto Sijunjung tahun 1998-2002. Tahun 2002 diangkat sebagai CPNS di Kemenkes Poltekkes Padang sampai sekarang di Jurusan Kesehatan Gigi. Mengampu mata kuliah Dental Morfologi, Penggunaan dan Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi, Konservasi, Penatalaksanaan Konservasi, PKKB, IKGA, dan Penatalaksanaan Pengendalian Infeksi Silang. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ika_ifitri@yahoo.com
Motto: "All you need is to give all you have"



drg. Arnetty, M.Kes. Lahir di Kota Bukittinggi, Sumbar 24 Juli 1967 Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah tahun 1994 dan Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kesehatan Masyarakat pada FK Universitas Andalas Padang dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995 sebagai Dokter Gigi Pegawai Tidak Tetap pada Puskesmas Kumani Sawahlunto Sijunjung pada tahun 1995. Pada tahun 1998 sebagai Dosen pada Universitas Baiturrahmah Padang. Sebagai Dokter Gigi di RS Bayangkara Padang Pada Tahun 1998. Saat ini penulis bekerja di Kemenkes Poltekkes Padang mengampu mata kuliah Histologi Anatomi Fisiologi, Mikrobiologi, Penyakit Gigi Dan Mulut, Farmakologi, Manajemen Mutu. Saat ini penulis juga aktif sebagai Pengurus Organisasi Profesi Dokter Gigi PDGI tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten Kota. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: arnetty0724@gmail.com

Motto: "A Good Teacher Opens The Mind, But A Great Teacher Also Opens The Heart"

Sinopsis

Buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" merupakan referensi penting bagi perawat dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kegawatdaruratan. Disusun secara sistematis dengan pendekatan berbasis bukti, buku ini menghadirkan beragam topik penting yang mencakup prinsip dasar keperawatan gawat darurat, teknik-teknik intervensi terbaru, serta kolaborasi interprofesional yang efektif dalam situasi kritis.

Materi dalam buku ini disusun oleh para ahli di bidang keperawatan gawat darurat, dengan pendekatan yang aplikatif dan dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian terkini. Setiap babnya menyajikan berbagai kasus klinis nyata yang membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Selain itu, buku ini juga membahas secara rinci penerapan prinsip ABCDE, strategi triase pasien, hingga teknik komunikasi yang efektif antar tim medis.

Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai panduan praktis di lapangan, tetapi juga sebagai sumber acuan akademis untuk pembelajaran dan pelatihan keperawatan di lingkungan pendidikan. Dengan penyajian yang jelas dan terstruktur, pembaca dapat dengan mudah mengintegrasikan konsep-konsep evidence-based practice dalam praktek sehari-hari, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam situasi kegawatdaruratan.

Buku "Bunga Rampai Asuhan Keperawatan Gawat Darurat: Panduan Komprehensif Berbasis Evidence-Based Practice" merupakan referensi penting bagi perawat dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kegawatdaruratan. Disusun secara sistematis dengan pendekatan berbasis bukti, buku ini menghadirkan beragam topik penting yang mencakup prinsip dasar keperawatan gawat darurat, teknik-teknik intervensi terbaru, serta kolaborasi interprofesional yang efektif dalam situasi kritis.

Materi dalam buku ini disusun oleh para ahli di bidang keperawatan gawat darurat, dengan pendekatan yang aplikatif dan dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian terkini. Setiap babnya menyajikan berbagai kasus klinis nyata yang membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Selain itu, buku ini juga membahas secara rinci penerapan prinsip ABCDE, strategi triase pasien, hingga teknik komunikasi yang efektif antar tim medis.

Buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai panduan praktis di lapangan, tetapi juga sebagai sumber acuan akademis untuk pembelajaran dan pelatihan keperawatan di lingkungan pendidikan. Dengan penyajian yang jelas dan terstruktur, pembaca dapat dengan mudah mengintegrasikan konsep-konsep evidence-based practice dalam praktek sehari-hari, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam situasi kegawatdaruratan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-90-6



9

786347

294906